Hospital De Niños Ricardo Gutiérrez
Departamento De Enfermería
Sección Docencia

MANUAL DENORMAS Y PROCEDIMIENTOS HNRG-2020

Sub-Gerente de Enfermería: Lic. Carrasco Candia, Aydeé
Sub-Jefa Dpto. de Enfermería: Lic. Saavedra Quisbert, Edith

La Subgerencia de enfermería Agradece a:

Los Jefes de División, Jefes de Sección y Especialmente a los Enfermeros Asistenciales, que han puesto de manifiesto su conocimiento e idoneidad profesional en la realización de estas normas, Así también a los Profesionales de otras diciplinas que conforman el equipo de salud que participaron en la confección de las normas.
Sin su colaboración, ningún logro sería posible.

PRESENTACIÓN

El Manual De NormasyProcedimientos, para el personal de enfermería del Hospital De Niños Ricardo Gutiérrez, fue realizado con la finalidad de unificar criterios para la práctica asistencial. Es la principal Herrramienta para la toma de decisiones responsables.
Con el objetivo de:

- Mejorar la calidad y efectividad de los diferentes procedimientos.
- Brindar cuidados seguros y de calidad.
- Optimizar la utilización los recursos, humanos, físicos y materiales.
- Facilitarlasrelaciónes interpersonalescon el equipo de salud, el niño y la familia.
- Es un Instrumento destinado a los servicios, para su cumplimiento.

INTRODUCCIÓN

Las intervenciones de enfermería en el ámbito pediátrico, generalmente, son una experiencia difícil; tanto para el niño y sus padres, como para los profesionales del Equipo de Salud.
Para favorecer el éxito en la realización de los procedimientos y facilitar una interelación positiva con el niño y su familia, es necesario un profesional capaz de desarrollar e integrar conocimientos, habilidades y actitudes específicas propias del ámbito pediátrico.
Durante el desarrollo del presente manual de normas, se describen, los procedimientos que mas se efectuan en los diferentes servicios del Hospital de Niño Ricardo Gutiérrez.

ÍNDICE

Agradecimiento	**2**
Presentación	**3**
Introducción	**4**
Índice	**5**
Administración de Medicamentos	**6**
Analgesia	**19**
Analgesia y Sedación	**23**
Alimentación Enteral	**28**
Alimentación Parenteral	**30**
Balance de Ingresos y Egresos	**35**
Catéter Implantable	**38**
Catéter Venoso Central	**41**
Colocacion de Sonda Nasogastrica	**50**
Colocacion de Sonda Vesical	**55**
Control de Signos Vitales	**60**
Cuidados al Paciente con Derrame Pleural	**63**
Cuidadosal Paciente con Diálisis Peritoneal	**65**
Cuidados al Paciente con Hemofiltracion	**73**
Cuidados de Pacientes Pre-quirúrgicos	**82**
Cuidados al Paciente Pos-quirúrgico	**88**
Cuidado al Paciente Traquostomizado	**94**
Cuidados al Paciente con TEC/PIC	**98**
Higiene de Manos	**105**
Higiene de Paciente en Cama	**107**
Induccion al Paciente de reciente ingreso	**112**
Manejo de ropa de cama Paciente en tratamiento conCitostaticos	**115**
Oxigenoterapia	**118**
Pase De Guardia	**124**
Preparacion y Mantenimiento del carro de paro	**126**
Reanimacion Cardio Pulmonar	**132**
Recepcion del paciente al ingreso en sala	**137**
Registros de Enfermeria	**139**
VentilacionMecanica	**143**
Tecnica de Tendido de Cama	**154**
Anexo	**159**

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS

ASEPSIA Y ANTISEPSIA
DEFINICION:
Es la desinfección, del lugar donde se realizara el procedimiento de preparación de medicación, para una administración segura.
Es responsabilidad del personal de enfermería, preparar y administrar la medicación al paciente; aplicando las normas de protección frente a sustancias químicas, que han de ingresar al organismo de una persona, haciendo uso de las normas de Infectologia de la institución
Deben extremarse las medidas de asepsia en la preparación y administración de medicación endovenosa, como así también en los planes de hidratación, sedoanalgesia, inotrópicos y diferentes procedimientos, para evitar contaminacion.

OBJETIVOS
- Asegurar que el ambiente donde se preparen los medicamentos cumpla con las normas y técnicas de asepsia y antisepsia.
- Asegurar la administración de medicamentos por las diferentes vías, en forma segura.
- Preparar y administrar al paciente el tratamiento prescrito por el médico en la dosis y el horario indicados a través de las diferentes vías de administración.

LEGISLACION VIGENTE
Ley 24004-Normativa para el ejercicio de la Enfermería- Art.3 Inciso. 18.
Ley Seguridad E Higiene En El Trabajo 19557-Art.118 Al 203.

PERSONAS HABILITADAS
Lic. En Enfermería
Enfermeros Profesionales

MATERIALES
- Amuchina
- Alcohol al 70%
- Recortes de gasa
- Bandejas
- Unidireccionales
- Solución fisiológica, dextrosa al 5%, agua destilada
- Torundas de algodón
- Jeringas y agujas

PROCEDIMIENTO
Antes de Preparar la medicación:
Realizar la Limpieza de la mesada, estructura metálica, vidrios, con Amuchina al 50% o hipoclorito de Na+ al 1%, con recortes de gasas los que luego serán descartados (o rejilla exclusiva para la mesada).
- Desinfectar la mesada con alcohol al 70% con técnica de arrastre, realizado por el personal de enfermería previo a la preparación de medicación y planes de hidratación.
- Limpiarlas bandejas con alcohol al 70% con técnica de arrastre.
- Lavado de sachet de soluciones parenterales, bajo chorro de agua y luego desinfectar los mismos con alcohol al 70% con técnica de arrastre.
- Apertura de los Baxter y colocación de los unidireccionales (se cambian cada 24hs)Rotular, respetar normas infectologicas.

- Higiene de manos según normas infectologicas.
- Desinfectar las ampollas con alcohol al 70%.
- Decontaminarlosbionectores de los unidireccionales previo a la extracción de la solución.
- Desechar las ampollas una vez abiertas en el descartador correspondiente.
- Rotular los frascos ampolla con fecha, hora y modo de dilución.

Una vez finalizada la preparación de la medicación, guardar en la heladera, las bandejas, y demás elementos ubicarlos en los lugares designados para dejar la mesada en óptimas condiciones (despejada, limpia y ordenada)
Higiene de manos con antiséptico para proceder a su administración.
Respetar Normas de Infectologia- HNRG
Recomendaciones

- Recoger el cabello.
- No utilizar joyas.
- Utilizar los elementos de barrera de acuerdo al tipo de aislamiento.

REALIZADO POR:
Lic. Rouch, Silvia, JefeDeDivisión-Turno Mañana
Lic. Torreiro, Lorena; Jefe Sección UTIP
Lic.Cabrera, Mariela, Enf. ECI

BIBLIOGRAFIA

- Dra. Gentile Angela- Licbeltran, Elizabeth-Lic Cabrera, Mariela .Normas Practicas Para El Control De Infecciones 2017,HNRG –Servicio De Epidemiologia
- Verri Espinosa, Alejandra. Manual De Procedimientos De Enfermería Del Niño Y Del Adolescente, Escuela De Enfermería Sede Chillan, 2012.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

DEFINICION

La administración de medicamentos, es una acción interdependiente de enfermería, que se realizaen forma conjunta con la prescripción médica, para lo cual; se deben reafirmar los conocimientos y aptitudes necesarias, saber evaluar los factores fisiológicos, mecanismos de acción y las variables individuales que afectan la acción de las drogas, los diversos tipos de vías de administración, así como los aspectos legales que involucran una mala práctica de la administración de medicamentos.

OBJETIVO

- Lograr una acción específica mediante la administración de un medicamento, ya sea con fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos.
- Mejorar la seguridad en la administración de los medicamentos.
- Contar con políticas y procedimientos para mejorar la seguridad de los medicamentos, que representan un alto riesgo.

LEGISLACION VIGENTE

Ley 24004-Normativas para el Ejercicio de la Enfermería - Art 3 Inciso. 18.

PERSONAS HABILITADAS

Lic. En Enfermería
Enfermeros Profesionales

REGLAS PARA LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS

El Personal de Enfermería es responsable de la administración de los medicamentos.
Es fundamental tener en cuenta las 10 recomendaciones de la OMS.
Paciente correcto.
Medicamento correcto.
Dosis correcta.
Vía Correcta.
Hora correcta.
Verificar la fecha de vencimiento del medicamento.
Educación al paciente sobre el medicamento.
Registro del medicamento aplicado.
Conocimiento sobre los efectos adversos del medicamento.
Preparar, administrar y registrar por un/a misma el medicamento.
No aplicar un medicamento que no hayamos preparado.
Cuatro yo:
Yo Preparo-Yo administro-Yo registro-Yo respondo

OBSERVACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS:

- Los medicamentos se administran con una diferencia no mayor de 30 minutos.
- Los antibióticos y agentes quimioterapéuticos se deben administrar a la hora exacta para que los niveles en la sangre permanezcan constantes.
- Los medicamentos de órdenes inmediatas o preoperatorias deben administrarse exactamente a la hora prescrita por el médico.
- La enfermera /o que prepara el medicamento debe también administrarlo y hacer el registro en el expediente clínico para evitar confusiones y problemas de índole legal**.**

Respetar los horarios establecidos en cada sector para la administración de medicamentos,los mismos serán modificados según indicaciones medicas especificas,registradas en la hoja de indicaciones medicas.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ORAL

Definición

Es el procedimiento por medio del cual un medicamento es administrado por la boca y se absorbe en la mucosa gastrointestinal, entre estos medicamentos podemos citar: Tabletas, cápsulas, jarabes, aceites, líquidos, suspensiones, polvos, granulados, etc.

Ventajas: Es de fácil administración.

Desventajas: No se administra en pacientes inconscientes, con náuseas y vómitos, o con movilidad intestinal disminuida, algunos medicamentos irritan la mucosa gástrica o pueden estropear los dientes.

Objetivos

- Lograr la absorción de las sustancias en el tracto digestivo.
- Favorecer el tránsito del medicamento.

Principios

- Las papilas gustativas y las terminaciones nerviosas del sentido del gusto son más numerosas en la punta y borde de la lengua.
- Los medicamentos se absorben en el estómago e intestino delgado, y cuando más diluidos estén, más rápida será la absorción.

Precauciones Especiales

- **La administración de un medicamento por vía oral, siempre requiere de una prescripción médica por escrito.**
- **Verificar "Las recomendación de la OMS,para una administracion de medicamentos libre de riesgo".**
- **Asegurarse de que el paciente ingiera el medicamento.**

Equipo

- Bandeja para administración de medicamentos.
- Medicamento prescrito: Cápsulas, tabletas, jarabe, grageas, suspensión, etc.
- Vaso con agua.
- Vasito o recipiente para colocar el medicamento**.**

Procedimiento

- Lavarse las manos antes de preparar los medicamentos, según normas infectologicas de la institución.
- Trasladar la bandeja con medicación, a la habitación del paciente, y al mismo tiempo verificar datos del paciente.
- Presentarse con el paciente.Colocarloen posición Fowler (si no existe contraindicación).
- Explicar al paciente el objetivo de tomarse el medicamento prescrito.
- Verificar la indicación médica, horario, si corresponde el medicamento, nombre del paciente, número de cama, medicamento prescrito y dosis a administrar. Llamar por su nombre al paciente.
- Administrar el medicamento al paciente. Si está en condiciones de tomarlo por él mismo, ofrecer el medicamento, ya sea que se le proporcione agua, leche o jugo de fruta de acuerdo a su diagnóstico.
- **Si un familiar realizara la administración, quedarse al lado del paciente hasta que lo haga.**
- **Desechar el vasito o recipiente que contenía el medicamento.**
- Colocar al paciente en posición cómoda una vez que ha ingerido el medicamento.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA SUBLINGUAL

Definición

Es la administración del medicamento, debajo de la lengua, lo cual permite una absorción rápida y directa hacia el torrente sanguíneo. Vía en la cual el medicamento no debe ser ingerido**.**

Ventajas: Además de las ventajas que presenta la vía oral, en esta vía la absorción se realiza rápidamente en el torrente circulatorio.

Desventajas: Si el medicamento se traga puede causar irritación gástrica. Se tiene que mantener bajo la lengua hasta que se disuelva y absorba**.**

Objetivo

- Proporcionar una vía rápida y un método más eficaz de absorción, que la via oral.

Principio

- La absorción del medicamento es rápida, se realiza a través del epitelio, (capa de tejido delgada) debajo de la lengua, ayudada por una amplia red de capilares.
- Bandeja para la administración de medicamentos.
- Medicamento indicado.
- Equipo para tomar signos vitales.

Procedimiento

Realizar los mismos procesos para administrar medicamentos por vía oral, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Explicar al paciente que no debe deglutir el medicamento ni ingerir líquido, sino mantenerlo debajo de la lengua hasta que sea asimilado completamente.
- Colocar el medicamento debajo de la lengua del paciente, si el paciente está en condiciones de realizar este proceso, verificar que lo realice adecuadamente.
- Evaluar la reacción del paciente ante la administración del medicamento, observar si presenta reacciones secundarias, sobre todo si éstas son de consideración.
- Tomar la presión arterial y temperatura 10 minutos después de administrado el medicamento.

Complicaciones

- Si el medicamento es ingerido, puede producir irritación de la mucosa gástrica.
- Una administración de medicamento equivocado o caduco puede provocar, Sensación de hormigueo, ulceraciones locales o shock.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA PARENTERAL

Se dividen según su tipo de administración: Intradérmica, subcutánea, intramuscular e intravenosa cada una tiene sitio de inyección y objetivo de aplicación.

Preparación de los medicamentos parenterales

La técnica para administración de medicamentos parenterales requiere de una considerable destreza manual, pero sobre todo del empleo de una técnicaestéril**,** tanto para la preparacióndel medicamento como para su aplicación.

- Verificar la indicación médica y datos del paciente.
- Lavarse las manos antes de preparar el medicamento, según normas infectologicas de la institución.
- Limpiar el lugar donde se prepara la medicación
- Preparación del equipo:
- Bandeja con jeringa adecuada y rotulada
- Torunda de algodón o gasa
- Alcohol

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA SUBCUTÁNEA

Definición

Es la introducción de un medicamento (sustancias biológicas o químicas) en el tejido subcutáneo.

Ventajas: Tiene un efecto más rápido que en la administración por vía oral.

Desventajas: Únicamente se pueden administrar pequeñas cantidades de solución. Es más lenta que la absorción de la administración intramuscular.

Objetivo

- Lograr una absorciónmaslenta en el tejido subcutáneo,que en el tejido Muscular, para que la acción del medicamento se realice adecuadamente.

Principio

- El efecto de la medicación subcutánea se absorbe rápidamente e inicia sus efectos después de media hora de haberse suministrado.

Equipo

- Bandeja para medicamentos.
- Jeringa de 1 ml (graduada en UI).
- Solución antiséptica.
- Gasas o torunda de algodón.
- Guantes. (Ver Normas de Infectologia 2017)

Procedimiento

- Trasladar la bandeja con los medicamentos a la unidad del paciente y verificar el número de cama.
- Verificar la identificación del paciente y la hoja de indicaciones médicas. Llamar al paciente por su nombre.
- Explicar al paciente el objetivo de administrar el medicamento, asimismo, la sensación que va a presentar al suministrarlo.
- Proporcionar un ambiente de privacidad cuando el sitio de aplicación del medicamento sea distinto a la administración en el brazo.
- Lavarse las manos antes de preparar el medicamento, según normas infectologicas.
- Seleccionar el sitio de Punción: Parte externa del brazo, cara anterior del muslo, tejido subcutáneo del abdomen y región escapular, alternando los puntos de Punción cuando se administren inyecciones múltiples, cuidando que en el área no exista lesión, equimosis, signos de infección o cambios de coloración de la piel.
- Poner al paciente en la posición correcta de acuerdo a la selección del sitio de inyección.
- Colocarse los guantes (según las normas de la institución). Tener en cuenta las precauciones universales.
- Realizar la asepsia del área (seleccionada) aproximada de 5 cm alrededor de la punción utilizando las reglas básicas de asepsia con un antiséptico de amplio espectro antimicrobiano, de la familia de los productos clorados, hipoalergénica y que además permita visualizar el sitio de inyección.
- Retirar el protector de la aguja con cuidado de no contaminarla y dejar libre de burbujas la jeringa.
- Formar un pliegue con el dedo pulgar e índice. Esta maniobra asegura la introducción del medicamento al tejido subcutáneo.
- Sujetar la jeringa con el dedo índice y pulgar (mano derecha).
- Introducir la aguja en un ángulo de 45, una vez introducida dejar de formar el pliegue.
- Aspirar la jeringa con el fin de detectar si se punzo algún vaso sanguíneo. Proceder a introducir el medicamento. En caso de presentar punción de un vaso sanguíneo será necesario volver a preparar el medicamento, o bien cambiar la aguja de la jeringa e iniciar el procedimiento.

- Retirar la aguja y presionar en el sitio de inyección.
- Colocar al paciente en una posición cómoda.
- Desechar la jeringa en el recipiente especial para material punzocortante.
- No se debe aspirar antes de inyectar la heparina, ni dar masaje posterior a su aplicación, ya con esto se pueden ocasionar lesiones en los tejidos.
- Para la administración de heparina es necesario tener verificado el tiempo parcial de tromboplastina (TPT). Si resulta que es un registro mayor del doble de lo normal, consultar al médico antes de aplicar la inyección de heparina.
- Educar al paciente sobre de la graduación de la jeringa de insulina, presentación del medicamento, técnica de administración vía subcutánea, asimismo, sobre el examen de glucemia y glucocetonurias.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA INTRAMUSCULAR

Definición

Acción de sustancias químicas o biológicas en el tejido muscular por medio de una jeringa y aguja.

Ventajas: El medicamento se absorbe rápidamente. Se pueden administrar mayores cantidades de solución que por la vía subcutánea.

Desventajas: Rompe la barrera protectora de la piel. Puede producir cierta ansiedad al paciente.

Objetivo

- Lograr la introducción de sustancias donde existe una gran red de vasos sanguíneos, para que se puedan absorber con facilidad y rapidez**.**

Material y equipo

- Bandeja para medicamentos.
- Jeringa de 3 ó 5 ml con aguja 21 / 8
- Solución antiséptica.
- Gasas ó torunda de algodón.
- Guantes (es recomendable utilizarlos, sin embargo se circunscribe a las normas de la institución).Ver manual de Infectologia 2017

Procedimiento

- Trasladar la bandeja de medicamentos a la unidad del paciente y verificar la identificación del paciente y las indicaciones médicas. Llamar al paciente por su nombre.
- Explicar al paciente el objetivo de administrar el medicamento, asimismo, la sensación que va a presentar al suministrarlo.
- Proporcionar un ambiente de privacidad cuando el sitio de aplicación del medicamento sea distinto a la administración al músculo deltoides.
- Lavarse las manos antes de preparar el medicamento, según normas infectologicas.
- Seleccionar el sitio de inyección la zona que generalmente se utiliza y primera elección es el cuadrante superior externo de ambos glúteos, cara anterior externa del muslo, en el brazo la

Región del deltoides, alternando los puntos de inyección cuando se administren inyecciones Múltiples, cuidando que en el área no exista lesión equimosis datos de infección o cambios de Coloración de lapiel. En los menores de 1 año Utilizar la zona del musculo recto anterior, en Miembro inferior

- Colocar al paciente en la posición correcta de acuerdo a la selección del sitio de inyección.
- Colocarse los guantes (según las normas de la institución). Tener en cuenta como una de las precauciones universales.
- Realizar la asepsia del área (seleccionada) aproximada de 5 cm alrededor de la punción

Utilizando las reglas básicas de asepsia según normas infectologicas.

- Retirar el protector de la aguja con cuidado de no contaminarla.

- Estirar la piel con el dedo índice y pulgar. Formar un pliegue con el dedo pulgar e índice en pacientes pediátricos y geriátricos, con el propósito de aumentar la masa muscular asegura la introducción del medicamento al tejido muscular evitando pinchar el hueso.
- Sujetar la jeringa con el dedo índice y pulgar (mano derecha).
- Introducir la aguja en un ángulo de 90 en forma directa con un solo movimiento rápido y seguro. De esta forma ayuda a reducir el dolor de la punción.
- Aspirar la jeringa con el fin de detectar si se puncionó algún vaso sanguíneo.
- Proceder a introducir el medicamento lentamente, esto permite que el medicamento se disperse a través del tejido.
- En caso de presentar punción de un vaso sanguíneo será necesario volver a preparar el medicamento, o bien cambiar la aguja de la jeringa e iniciar el procedimiento**.**

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAVENOSA

Definición

Es la introducción de una sustancia medicamentosa directamente al torrente sanguíneo a través de la vena utilizando jeringa y aguja o por medio de venoclisis.

Ventajas: Rápido efecto.

Desventajas: La administración del medicamento puede estar inhibida por problemas circulatorios**.**

Objetivo

- Introducir dosis precisas de un medicamento al torrente circulatorio para lograr una absorción rápida.

Principios

- La venopunción es un procedimiento invasivo en el que la piel no constituye una barrera de protección contra el acceso de microorganismos patógenos.

Consideraciones especiales

- Preguntar al paciente si es alérgico a algún medicamento.
- No contaminar el equipo durante su preparación o antes y durante su aplicación
- No aplicar medicamentos sin orden escrita, únicamente en extrema urgencia y posteriormente pedir que se anote la indicación en el expediente clínico.
- No administrar medicamentos en una zona donde exista edema, flebitis o que se encuentre infectada.
- Evitar la punción sobre terminaciones o trayectos nerviosos.
- No administrar un medicamento de apariencia dudosa (fecha de caducidad borrosa o sin etiqueta, cambio de color, etc.).
- No introducir aire al torrente circulatorio (purgar bien la jeringa).
- No introducir rápidamente el medicamento.

Equipo

- Cateter para venopuncion , si no lo tuviera, Jeringa de 5 ó 10 ml
- Medicamento indicado.
- Lazo
- Gasas chicas o torundas.
- Solución antiséptica.
- Guantes.
- Solución inyectable (se recomienda diluir el medicamento para evitar flebitis**).**

Procedimiento

- Trasladar la bandeja de medicamentos a la unidad del paciente y verificar la identificación del paciente y la prescripción médica.
- Lavarse las manos antes de preparar el medicamento, según normas infectologicas de la institución.

- Explicar al paciente el objetivo de administrar el medicamento, asimismo, la sensación que va a presentar al suministrarlo (sensación de calor en el momento que entra el medicamento al torrente circulatorio). La explicación ayuda a disminuir la ansiedad del paciente.
- Colocar al paciente en decúbito dorsal o sentado, apoyando el brazo sobre una superficie resistente (mesa puente**)**
- Seleccionar la vena que se va a punzar.Generalmente se realiza punción en el brazo: Vena cefálica o basílica.En la mano, venas superficiales del dorso y cara lateral**.**
- Colocar el lazo a 10 cm arriba del sitio seleccionado para realizar la punción de la vena.
- Ponerse guantes.
- Realizar la asepsia del área aproximada de 10 cm alrededor de la punción utilizando las reglas básicas de asepsia con un antiséptico, se recomienda uno de amplio espectro antimicrobiano, de la familia de los productos clorados, hipoalergénico y que además permita visualizar la vena.
- Realizar venopuncion con catéter flexible, corto y de longitud media.
- Tomar el cateter con los dedos índice y pulgar de la mano derecha, apuntando el bisel hacia arriba y sujetar la vena con el dedo índice de la mano izquierda para evitar que se mueva en el momento de la punción.
- Punzar la vena, introduciendo el bisel hacia arriba, tomado la vena por un lado formando un ángulo de 30, entre la jeringa y el brazo del paciente. Aspirar la jeringa una décima de cm para cerciorarse que el cateter se encuentra dentro de la vena.
- Soltar el lazo.
- Introducir muy lentamente la solución fisiologica para comprobar permeabilidad y luego conectar a la tubuladura de la solucion parenteral a administrar.
- En caso de quedar intermitente administrar el medicamento, haciendo aspiraciones. periódicas de la jeringa y cerciorase que aún se encuentra el cateter dentro de la vena.
- Tomar la jeringa con el medicamento previamente identificado y purgarla (quitarlas burbujas de aire), dando pequeños golpecitos con la uña al cuerpo de la jeringa y empujar el émbolo con el dedo pulgar.
- Observar y preguntar al paciente si siente alguna molestia. En caso de que presente algún síntoma o signo adverso, suspender inmediatamente la aplicación, o bien, en caso de que no se encuentre dentro de la vena, suspender la aplicación e iniciar el procedimiento.
- Al finalizar la administracion del medicamento, lavar con solución fisiologico y clampear, para evitar retorno venoso.
- Observar si existe alguna reacción adversa en el paciente, informarle que si presenta alguna reacción llame al medico. Dejarlo cómodo y tranquilo.
- Desechar la jeringa en recipiente especial para material punzocortante.

CATETERES INTRAVASCULARES DE CORTA DURACION

Tipo de cateter	**Insercion**	**Complicaciones**
Catéteres venosos periféricos cortos	Generalmente en miembros superiores, especialmente en manos y antebrazo.	Flebitis (físico, química y mecánica) Asociada con el uso prolongado. Escasa frecuencia de bacteriemias.
Catéteres venosos periféricos medianos	Se insertan en la fosa antecubital, dentro de la basílica proximal o la vena cefálica. No ingresan a venas centrales.	Se recomiendan de silicona o poliuretano – hidrogel elastómero. Tienen menos porcentajes de flebitis que los catéteres venosos centrales (0.8 por cada 1000 días de uso).
Catéteres arteriales periféricos	se insertan en arteria radial, arteria braquial, arteria tibial posterior o femoral.	Tienen bajo riesgo de infección. La posibilidad de colonización es menor debido a la alta presión vascular.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA TÓPICA

Definición

Los medicamentos tópicos se aplican directamente sobre la superficie de la piel o las mucosas. Por lo tanto, la vía de administración tópica incluye los medicamentos dermatológicos, irrigaciones e instilaciones, y comprenden: Lociones, pastas, ungüentos, cremas, polvos, atomizadores. Su absorción depende de la vascularización del sitio de aplicación, por lo que se aplica para efectos locales y no sistémicos, excepto la nitroglicerina y suplementos hormonales.

Consideraciones especiales

- La administración de un medicamento por vía tópica siempre requiere de una prescripción médica por escrito.
- Verificar "Los Diez Puntos Correctos"y los Cuatro yo.
- Verificar la caducidad del medicamento.
- Verificar si el paciente padece alguna alergia.
- Realizar la técnica en forma aséptica.
- Registrar la administración del medicamento en la hoja de enfermería.

Equipo

- Bandeja para medicamentos.
- Medicamento prescrito.
- Solución para irrigación.
- Gasas de 5 x 5.
- Guantes (es recomendable utilizarlos, sin embargo se circunscribe a las normas de la institución y según las condiciones del paciente).Ver manual de Infectologia 2017
- Hisopos y Baja lengua**.**

Procedimiento inicial para administrar medicamentos vía tópica

- Trasladar la bandeja con los medicamentos a la unidad del paciente y verificar el número de cama, corroborar la identificación del paciente y las indicaciones médicas. Llamar al paciente por su nombre.
- Lavarse las manos antes de preparar el medicamento, según normas infectologicas.
- Explicar al paciente el objetivo de administrar el medicamento, asimismo, la sensación que va a presentar al suministrarlo. La explicación ayuda a disminuir la ansiedad del paciente.

ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO VÍA OFTÁLMICA

Definición

Es la aplicación de un medicamento sobre el surco conjuntival anterior (pomada), en la cavidad conjuntival (colirios), con fines de tratamiento, diagnóstico y lubricación ocular.

Objetivo

- Lograr la absorción del medicamento y ejercer una acción local.

Procedimiento

- Colocar al paciente con la cabeza hacia atrás (en esta posición ayuda a que el medicamento fluya por gravedad). Indicar al paciente que mire hacia arriba en un punto fijo. En pacientes pediátricos o temerosos es recomendable colocarlos en posición decúbito dorsal.
- Limpiar la zona parpebral con una gasa humedecida con solución para irrigación iniciando del ángulo interno del ojo hacia el externo.
- Colocar el dedo índice en el pómulo del paciente y tensar suavemente la piel hacia abajo para descubrir el saco conjuntival.
- Colocar en la mano derecha (dominante) el gotero del medicamento que se va administrar por encima del ojo y presionar, dejando caer la cantidad de gotas prescritas. Dejar caer el medicamento siempre del ángulo interno al externo, nunca directamente a la córnea, para evitar posibles lesiones. Con una gasa estéril oprimir suavemente el canto interno del ojo para impedir

que el medicamento se drene al orificio lagrimal. Evitar tocar cualquier estructura del ojo con el frasco del medicamento para impedir que se contamine.

- Dejar de tensar sobre el párpado y pedirle al paciente que parpadee para que se distribuya el medicamento por todo el ojo.
- Limpiar con una gasa estéril los residuos del medicamento.
- Observar si existe alguna reacción adversa en el paciente. Dejarlo cómodo y tranquilo.
- Desechar material (gasas).
- Lavarse las manos (antes de atender a otro paciente como una medida seguridad para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias).
- Registrar en el hoja de enfermeria el medicamento administrado hora, fecha y si hubo reacciones especiales en el paciente.
- **Nunca se debe aplicar en los ojos un medicamento que no sea específico de oftalmología.**
- **No siempre hay que aplicar el mismo medicamento en ambos ojos. Por ejemplo, en glaucoma primario de ángulo cerrado, suele indicarse en el ojo operado un medicamento midriático, si se aplicara en el ojo no operado podría desencadenar un ataque agudo de glaucoma.**

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO VÍA ÓTICA

Definición

Es la aplicación de un medicamento por instilación a través del conducto auditivo externo**.**

Objetivo

- Lograr la absorción del medicamento y ejercer una acción local**.**

Procedimiento

- Colocar al paciente en posición Fowler flexionando la cabeza hacia el lado contrario al oído dañado, o bien recostado, descansando la cabeza hacia el lado sano.
- Tomar el pabellón auricular con los dedos índice y pulgar y tirar de él hacia arriba y hacia atrás para exponer el canal auditivo, si se trata de un paciente pediátrico proyectarlo hacia abajo y hacia atrás.
- Tomar con la otra mano el frasco que contiene el medicamento y presionarlo para que salga el medicamento. Instilar la cantidad de gotas prescritas, dirigiéndolas hacia la superficie lateral del canal auditivo. Evitar tocar el oído con el frasco del medicamento para impedir que pueda contaminarse.
- Sujetar el pabellón auricular hasta que el medicamento se haya introducido por completo.
- Mantener al paciente en esa posición durante unos minutos a fin de que el medicamento llegue a todas las zonas del canal auditivo. (No utilizar gasas o torundas como tapón, ya que absorbería el medicamento).
- Observar si existe alguna reacción adversa en el paciente, informarle que si presenta alguna reacción llame por el timbre. Dejarlo cómodo y tranquilo
- Lavarse las manos, antes de atender a otro paciente.

- **Consideraciones especiales**
  - Las gotas administradas en el conducto auditivo externo deben estar a temperatura corporal: 37C, ya que el tímpano es muy sensible al frío.
  - Evitar administrar más de 3 gotas en cada oído.
- Los lavados óticos para la extracción de tapones de cerumen deben ser realizados por personal experto y jamás introducir instrumentos punzantes en el conducto auditivo, ya que pueden perforar el tímpano.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA NASAL

Definición

Es la aplicación de un medicamento en forma de gotas o aerosol a través de los orificios nasales.

Objetivo

- Lograr la absorción del medicamento y ejercer una acción local.

Procedimiento

- Colocar al paciente con el cuello en hiperextensión.
- Limpiar los orificios nasales con un hisopo.
- Presionar suavemente la punta de la nariz y colocar el frasco o gotero en el orificio nasal, evitando que toque la nariz, y así impedir que pueda contaminarse.
- Dirigir la punta del frasco o gotero hacia la línea media del cornete superior, para que el medicamento penetre a la parte posterior de la nariz y no a la garganta.
- Instilar el medicamento, pidiendo al paciente que respire por la boca y no por la nariz, para disminuir la sensación de estornudo, con lo cual podría impulsar el medicamento hacia los senos paranasales.
- Mantener al paciente en hiperextensión por cinco minutos una vez administrado el medicamento.
- Observar si existe alguna reacción adversa en el paciente, informarle que si presenta alguna reacción llame por el timbre. Dejarlo cómodo y tranquilo.
- Desechar material (gasas)
- Lavarse las manos (antes de atender a otro paciente como una medida de seguridad para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias).

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO VÍA CUTÁNEA

Definición

Es la aplicación de un fármaco directamente sobre la piel.

Objetivo

- Lograr la absorción del medicamento y ejercer una acción local.

Procedimiento

- Colocar al paciente en la posición correcta y cómoda de acuerdo al área en la cual se va a administrar el medicamento.
- Realizar la asepsia con solución antiséptica siguiendo las reglas básicas (consultar el apartado sobre curación de heridas en este manual). De acuerdo a las indicaciones médicas, aplicar posteriormente solución para irrigación.
- Colocarse los guantes.
- Aplicar directamente sobre la piel del paciente.
- Observar si existe alguna reacción adversa en el paciente, informarle que si presenta alguna reacción llame por el timbre. Dejarlo cómodo y tranquilo.
- Desechar material (gasas y guantes)
- Lavarse las manos (antes de atender a otro paciente como una medida de seguridad para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias).

Registrar en la hoja de enfermería el medicamento administrado, hora, fecha y si hubo reacciones especiales en el paciente.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO POR VÍA RECTAL

Definición

Es la administración de un medicamento a través del recto con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos.

Ventajas: Proporciona efectos locales y tiene pocos efectos secundarios.

Desventajas: La dosis de absorción es desconocida.

Objetivo

- Lograr la absorción del medicamento, estimular el peristaltismo y la defecación, aliviar el dolor, vómito, hipertermia e irritación local.

Procedimiento

- Colocar al paciente en posición de Sims (decúbito lateral izquierdo con la pierna derecha flexionada).
- Colocarse los guantes.
- Sacar el medicamento de su envoltura.
- Separar los glúteos (para visualizar el orificio anal del paciente y pedirle que se relaje).
- Introducir el medicamento (supositorio) por el orificio anal, a una profundidad aproximada de 5 cm, haciéndolo avanzar con el dedo índice.
- Pedir al paciente que mantenga la contracción de los glúteos hasta que desaparezca el estímulo de defecar. En pacientes pediátricos presionar los glúteos durante 5 minutos (aproximadamente).
- Quitarse los guantes y desecharlos.
- Colocar al paciente en posición cómoda.
- Lavarse las manos (antes de atender a otro paciente como una medida de seguridad para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias).

SIEMPRE QUE SE ADMINISTRE UN MEDICAMENTO POR CUALQUIER TIPO DE VIA SE DEBE:

- **Registrar En La Hoja De Enfermería, La Administración Del Medicamento,**
- **Apellido Nombre Del Paciente,**
- **Medicamento,**
- **Dosis, Horario De Administración Y Si Hubo Reacciones Especiales En El Paciente,**
- **Firma Y Sello Del Enfermero Interviniente.**

ACTUALIZACION REALIZADO POR:

Lic. Aguirre Estela ,;Jefe Sección Docencia e investigación.

BIBLIOGRAFIA

- Normas de Enfermería, HNRG,CABA, 2017.
- Verri Espinosa, Alejandra. Manual De Procedimientos De Enfermería Del Niño Y Del Adolescente, Escuela De Enfermería Sede Chillan,2012.

ANALGESIA EN PACIENTES QUIRURGICOS

DEFINICION
El dolor es definido por la IASP (International AssociationfortheStudyofPain) como una experiencia sensorial y emocional no placentera, asociada con daño tisular real o potencial.
El óptimo tratamiento del dolor es imprescindible para conseguir una pronta movilización y rehabilitación, una completa recuperación y una reducción de la morbilidad.

OBJETIVOS

- Lograr al finalizar el evento quirúrgico una recuperación rápida y sin dolor del paciente.
- Conseguir el control adecuado del dolor durante todo el postoperatorio del niño.

LEGISLACION VIGENTE
Ley 24004-Normativa para el Ejercicio de la Enfermería-Art. 3Inciso.18

PERSONAS HABILITADAS
Lic. En enfermería
Enfermeros profesionales

INSTRUMENTOS PARA VALORAR EL DOLOR AGUDO QUIRÚRGICO EN EL NIÑO

- Permiten que el niño operado proporcione información directa y objetiva sobre la gravedad, localización,
- Duración e intensidad del dolor. Existe una variedad de escalas
- Escala numérica (uso exclusivo en niños > de 10 años)
- El paciente selecciona y describe el nivel de dolor que experimenta al momento de evaluación, de acuerdo a la intensidad en números, donde 0 es nada de dolor y 10 es el peor dolor-
- Escala de autoevaluación del dolor con caras (uso exclusivo en niños < de 10 años)

- Se pide que el niño señale cuál de estos rostros se asemeja más a la intensidad del dolor que tiene en el momento actual, se le asigna el puntaje de acuerdo a la selección.

Plan De Analgesia Para Cirugía De Mediano Y Alto Impacto Al Dolor
Lo más importante es tener en cuenta el concepto de analgesia balanceada o multimodal.
El anestesiólogo, antes de despertar al paciente, le realiza la dosis de carga de opioides, AINES, Antieméticos y corticoides (sumamente importante por el componente inflamatorio del dolor postoperatorio generado por el uso del electrobisturí).

1° Día postoperatorio
Dosis de mantenimiento
Se prepara la dosis de mantenimiento para 24 horas del primer día del postoperatorio.
Es una infusión endovenosa continua en 500 ml de solución salina (solución fisiológica) que contiene:

- Morfina: 0,4 mg/kg/día (pectuscarinatum o toracoscopía) o 0,6 mg/kg/día (pectusexcavatum o toracotomía).
- Dipirona o Ibuprofeno: 40mg/kg/día.
- Dexametasona: 0,6 mg/kg/día.
- Metroclopramida: 0,3 mg/kg/día.

A pasar a 21 ml/hora(500 ml), o 10,5 ml/hora (250 ml) o 4 ml/hora (100 ml).
Nota: para los pacientes de menos de 20 kg el volumen de solución salina 1 N será de 250 ml.
Para los pacientes demenos de 10 kg el volumen de solución salina 1 N será de 100 ml.
Y se dejan indicadas las dosis de rescate.
Morfina: 10% de la dosis de mantenimiento diaria.
Por ejemplo si un paciente pesa 50 kg y recibe de mantenimiento 0,4 mg/kg/día (20mg/día) la dosis de rescate será de 2 mg.

2° Día postoperatorio
Para el segundo día del postoperatorio, y si no requirió más de 3 dosis de rescates en 24 horas, se desciende la dosis de opioides un 25% con respecto al día 1º, se deja el aine a igual dosis y se retiran la metroclopramida y la dexametasona.
En 500 de solución fisiológica.
- Morfina: 0,3 mg/kg/día (pectuscarinatum o toracoscopía) y 0,45 mg/kg/día (pectusexcavatumotoracotomía).
- Dipirona o Ibuprofeno: 40 mg/kg/día.

A pasar a 21 ml/hora (500 ml), o 10,5 ml/hora (250 ml) , o 4 ml/hora (100 ml).
Rescates: morfina que serán de 1,5 mg o 2,25 mg (o 2 mg, más práctico).

3° Día postoperatorio
Para el tercer día del postoperatorio, se baja la morfina otro 25% con respecto a la dosis del primer día.
- Morfina 0,2 mg/kg/día (carinatum) o 0,3 mg/kg/día (excavatum).
- Dipirona o Ibuprofeno: 40 mg/kg/día.

A pasar a 21 ml/hora (500 ml), o 10,5 ml/hora (250 ml) o 4 ml/hora (100 ml).
Rescates: morfina que serán 1 mg (carinatum) o 1,5 mg (excavatum).

4° Día Postoperatorio
El cuarto día del postoperatorio, en general, al paciente se le da el alta, y para esta instancia pasamos a medicación por vía oral.
El opioides elegido será el tramadol, que es 10 veces menos potente que la morfina, por lo tanto, si el tercer día está recibiendo 10 mg de morfina en 24 horas:
La dosis de mantenimiento de tramadol será de 100 mg en 24 horas, que se repartirán en 4 dosis. 0 sea, 25mg (10 gotas) cada 6 horas.
La dosis de rescate será del 10% de la dosis de mantenimiento diaria, o sea, 10 mg (4 gotas)/dosis.
- Ibuprofeno 1 comprimido de 400 o de 600 mg, dependiendo el peso del paciente, o 10 mg/kg/dosis cada 6 hs
- Metroclopramida entre 20 gotas cada 6 horas, o 0,1 mg/kg/dosis, cada 6 hs.

Para favorecer la comodidad del paciente le podemos decir que en el mismo vaso en el que pone el tramadol, ponga las 20 gotas de metroclopramida y que con ello tome el comprimido de Ibuprofeno.
El quinto día se deja reglado el AINE, y el tramadol pasa como rescate a la dosis a la que se usó eltramadol durante el cuarto día.

Tener en cuenta que estos planes pueden utilizarse para cirugías que presentan DPO moderado a intenso.
En cirugías en las que se espera dolor moderado, la dosis de mantenimiento de opioides sería:

- Morfina: 0,4 mg/kg/día. o,
- Tramadol: 6 mg/kg/día.

Ejemplos:

- Correctiva de pectuscarinatum.
- Toracoscopías.
- Colocación de tubo de drenaje pleural.
- Escoliosis por vía posterior.
- Cirugía de hemiabdomen inferior.
- Cirugía correctiva de pie bot.
- Neurocirugía. Etc

En cirugías en las que se espera dolor intenso, la dosis de mantenimiento opioides sería:

- Morfina: 0,6mg/kg/día.

Ejemplos:

- Correctivas de pectusexcavatum.
- Toractomías.
- Escoliosis por vía anterior.
- Lumbotomías.
- Cirugía de Hemiabdomen superior.
- Reemplazo de rodilla.
- Amputación.*Etc.

*En caso de amputaciones, si lo sabemos con antelación, conviene evaluar al paciente y colocar uncatéterperidural dos días antes de la cirugía y continuarlo luego de la misma por lo menos por 72 hs.
Siesto no fuera posible, se puede utilizar el plan antes mencionado sumando ketamina y clonidina.

- Ketamina: 5 mg/kg/día que corresponde aproximadamente a 200 mcg/kg/hora.
- Clonidina: 3 mcg/kg/día. (microgramo)

La clonidina se encuentra en una clase de medicamentos llamados agentes hipotensores alfa-agonistas de acción central, trata la hipertensión arterial mediante la disminución de la frecuencia cardíaca y la relajación de los vasos sanguíneos para que la sangre pueda fluir más fácilmente a través del cuerpo. Se usan solas o en combinación con otros medicamentos, como parte de un programa de tratamiento para controlar los síntomas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad

TERMINOLOGÍA

Nociceptivo: La nocicepción (también conocida como nociocepción o nocipercepción) es el proceso neuronal mediante el que se codifican y procesan los estímulos que causan dolor, que es iniciada por los receptores periféricos del dolor. La nocicepción activa diversas respuestas autónomas que conducen a la experiencia del dolor en los seres vivos que tienen sistema nervioso.
Analgesia multimodal: El concepto de analgesia multimodal implica que el adecuado control del dolor postoperatorio, que permita una recuperación temprana de las actividades

normalesdelpaciente, no se puede lograr con un simple fármaco, sino que es necesario la acción sinérgica de varios grupos de fármacos.

Dolor postoperatorio: La anestesia general y el inadecuado control del dolor postoperatorio dan lugar a una serie de cambios en la función pulmonar: disminución del volumen tidal, aumento de la frecuencia respiratoria, reducción de la capacidad vital o reducción del volumen de reserva residual funcional, lo que clínicamente se traduce en un aumento de la frecuencia de atelectasias y acúmulo de secreciones bronquiales favoreciendo la aparición de hipoxemia, neumonías y fracaso respiratorio.

Antiinflamatorios no esteroideos: Su efecto analgésico se realiza por inhibición de la producción de prostaglandinas inflamatorias en el sitio lesionado, por inhibición de prostaglandinas centrales, o por otros efectos a nivel central.

Opioides: Los opioides son medicamentos que alivian el dolor. Reducen la intensidad de las señales de dolor que llegan al cerebro y disminuye los efectos de un estímulo doloroso.

Bloqueos nerviosos. Conjunto de técnicas utilizadas para administrar fármacos analgésicos con el fin de suprimir la transmisión nociceptiva mediante el bloqueo de la conducción y / o generación del impulso nervioso Los bloqueos nerviosos representan el alivio del dolor agudo y el dolor crónico.

REALIZADO POR:

Lic. Diaz, Evelina, JefeSeccion, U 12-16

BIBLIOGRAFIA

- Dra. Silvana Cavallieri B. Dr. Piero Canepa L Dr. Claudio Ricke,.Dolor Agudo Post-Quirúrgico En Pediatría Evaluación Y Tratamiento. Departamento De Anestesiología. Clínica Las Condes.*Unidad De Anestesiología Hospital Luis Calvo Mackenmª.
- J. Quiles1, 2, C. J. Van-Der Hofstadt1,2 E Y. Quiles2na. Instrumentos De Evaluación Del Dolor En Pacientes Pediátricos: Una Revisión (2ª Parte) Rev. Soc. Esp. Dolor 11: 360-369, 2004

ANALGESIA Y SEDACIÓN

DEFINICION

- Dolor: experiencia sensorial subjetiva y emocional desagradable relacionada con una lesión presente o potencial, varia de una persona a otra y tiene diferentes dimensiones: sensorial, emocional, cognitiva, psicológica y de comportamiento o conductual.
- Analgesia: Eliminación de la sensación de dolor mediante el bloqueo artificial de las vías de transmisión del mismo y/o de los mediadores dolorosos, o por desconexión de los centros del dolor. Ausencia de toda sensación dolorosa.
- Sedación: estado en el cual el paciente tolera procedimientos /situaciones desagradables, mientras mantiene una adecuada función respiratoria y su capacidad de respuesta ante una orden verbal o estimulación táctil.

LEGISLACION VIGENTE

Ley 24004-Normativa Para El Ejercicio De La Enfermería-Art. 3/Inciso.18

PERSONAS HABILITADAS

Lic. En enfermería
Enfermeros profesionales
Médico Intensivista
En colaboración con el grupo: el equipo de tóxico, farmacia y paliativos.

OBJETIVO

Implementar a través del juicio crítico medidas farmacológicas y no farmacológicas para la adecuada sedación y analgesia en la UTIP del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
El Objetivo del procedimiento en el paciente es:

- Proporcionar un nivel óptimo de comodidad con seguridad, reduciendo la ansiedad y la desorientación, facilitando el sueño y controlando adecuadamente el dolor.
- En ventilación mecánica: evitar la asincronía con el respirador, buscando el rápido destete de este.
- Confort del paciente.
- Disminuir el miedo y la ansiedad.
- Evitar la agitación.
- Facilitar la cooperación del paciente.
- Potenciar la analgesia.
- Reducir las demandas metabólicas de oxígeno.
- Facilitar la ventilación mecánica.

INDICACIONES

Todo paciente que ingrese a la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos de acuerdo a su condición clínica que requiera ventilación mecánica.

TENER EN CUENTA ALGUNAS SITUACIONES ESPECIALES

Ejemplos

- Hipertensión endocraneal (TEC), edema cerebral, etc.
- Procedimientos invasivos.
- Debridación de heridas.
- Las primeras 48 hs de una traqueotomía.
- Drenaje pleural.
- Endoscopia diagnóstica.

RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR
Bomba de infusión.
Monitor cardíaco.
Ventilador Mecánico.

MATERIAL DESCARTABLE
Bandeja conteniendo
Jeringa de 3, 5, 10 y 20 ml.
Alcohol al 70%.
Gaza o algodón
Manoplas,
Cloruro de Na 0.9%.
Droga analgésica a usar

FENTANILO
Dosis rescate = 2gammas/kg
Droga sedante a usar
MIDAZOLAM
Dosis rescate= 0.1 mg/kg
DOLOR INCIDENTAL
Es el dolor causado por: intervenciones de enfermería, médicos, kinesiología.
Dosis de rescate a administrar: Midazolám 0.1 mg/kg
Ketamina 0.5 o 1 mg/kg
VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR
Evaluar de forma individual y de manera diaria los equivalentes somáticos y fisiológicos del dolor (expresión facial, movimientos y posturas), signos fisiológicos como taquicardia, hipertensión, taquipnea, asincronia con el respirador.
Para ello se utiliza la Escala FLACC (para niños de 1 mes a 4 años y mayores no colaboradores.

	0	1	2
CARA	Cara relajada Expresión neutra	Arruga la nariz	Mandíbula tensa
PIERNAS	Relajadas	Inquietas	Golpea los pies
ACTIVIDAD	Acostado y quieto	Se dobla sobre el abdomen , encogiendo piernas	Rígido
LLANTO	No llora	Se queja , gime	Llanto fuerte
CAPACIDAD DE CONSUELO	Satisfecho	Puede distraerse	Dificultad para consolarlo

0: no dolor; 1-2: dolor leve; 3-5: moderado; 6-8: intenso; 9-10: máximo dolor imaginable.

Rescates:

Drogas	Dosis	Rescates			
Fentanilo					
Morfina					
Otros					
	scores				

MANEJO DEL DOLOR Y ANALGESIA

Dosis rescates o bolos rescate:

Según valoración atraves de score del dolor y según indicación médica diaria.

Drogas a utilizar: fentanilo, morfina, Dipirona, metadona. Verificar dosis y vía administración.

Preparación: en bandeja al pie de cama para administración endovenosa.

Jeringa prellenada con dosis pura, estabilidad 6 hs.

Jeringa prellenadadiluida, estabilidad 6 hs.

Todas las bandejas deben contener una jeringa con cloruro de sodio 0,9% para lavado previo administración de analgésico y post administración.

Monitorizar y evaluar efectos en el paciente.

CADA JERINGA DEBE ESTAR ROTULADA :

NOMBRE DEL MEDICAMENTO,DOSIS, DILUCION Y CONCENTRACION POR CM, FECHA Y HORA DE PREPARACION.

Infusión de analgesia continúa (dosis mantenimiento):

Fentanilo (2 gammas/kg/h), completando con dilución de 24 ml totales de dextrosa 5% o cloruro de sodio 0,9%.

Morfina (0,3 mg/kg/h) completando con dilución de 24 ml totales de dextrosa 5% o cloruro de sodio 0,9%.

Valoración del estado de conciencia:

La mayoría de los pacientes pueden estar calmados, lucidos y sin dolor, cooperar e interactuar. El uso de escalas de sedación es fundamental para protocolos de adaptación del paciente con AVM, una minoría de pacientes requieren de sedación profunda (falla respiratoria severa, tec, status epiléptico refractario, necesidad de relajación muscular).

Existen varias escalas:Escalas Ramsay; Richmond AgitationSedationScare (RASS), Sedation –Agitation-Scare (SAS) Y BIS (índice biespectral) solo para evitar infra y sobresedacion en pacientes que requieran bloqueo neuromuscular.

En la UTIP-HNRG se utilizan RASS y RAMSAY.

RASS (RichmondAgitationSedactionScare):Evalúa el grado de sedación y agitación de un paciente en estado crítico o que está bajo agitación psicomotora.Utiliza como parámetro el tiempo que se mantiene el contacto visual con el paciente para medir el nivel de sedación.

+4 combativo	**Combativo, violento,emigro inmediato para el grupo.**	**-1 somnoliento**	**No está plenamente alerta pero se mantiene despierto más de 10 seg.**
+3 muy agitado	**Agresivo , se intenta retirar tubos o drenajes**	**-2 sedación leve**	**Despierta brevemente a la voz, mantiene contacto visual hasta 10 seg.**
+2 agitado	**Movimientos frecuentes sin propósito, lucha con el respirador.**	**-3 sedación moderada**	**Movimiento o apertura ocular a la voz, sin contacto visual.**
+1 inquieto	**Ansioso sin movimientos agresivos o violentos**	**-4 sedación profunda**	**Sin rta a la voz, con movimiento o apertura ocular al estimulo físico.**
0 despierto y tranquilo		**-5 sin rta**	**Sin rta a la voz o estimulo físico.**

Escala de Ramsay

1	**Paciente despierto, ansioso, agitado o inquieto**
2	**Paciente despierto, cooperador, orientado y tranquilo.**
3	**Paciente dormido con respuesta a órdenes.**
4	**Paciente dormido con respuestas breves al sonido.**
5	**Paciente dormido responde solo al dolor.**
6	**El paciente no responde a ningún estimulo (luz, sonido o dolor) .**

VM Entre 3 a 4 puntos. Sedación profunda 5 a 6.
Los niveles de sedación serán diferentes para cada paciente y adaptados a su patología y al momento de la evolución en que se encuentren. Se recomienda un Ramsay entre 2 y 4 ó un RASS entre 0 y -2. (Utilización a partir de 2 meses)
Manejo de sedantes:
Preparación estándar de sedantes de infusión continúa:
Midazolam (0,1mg/kg/h) completando con dilución de 24 ml total de dextrosa al 5% o cloruro de sodio al 0.9%.
Dosis rescates:
Según evaluación utilizando escala y indicación médica.

Drogas	Dosis	Rescate			
Midazolam					
Lorazepam					
otras					

Midazolam(o,1mg/kg) en jeringa según peso del paciente ,será diluida o pura , tener preparada en bandeja en pie de cama junto con cloruro de sodio 0,9% para su respectivo lavado , no olvidar rotular dosis por cm, fecha y hora de preparación , tener en bandeja gasa con antiséptico para realizar previa desinfección del sitio de administración.Estabilidad diluido 6 hs.
Lorazepam(0,05mg/kg) según indicación médica ,conservar ampolla en la heladera , no se conserva diluida a temperatura ambiente.
Incorporación de 3ra droga: Dexmedetomidina.

Con infusiones de fentanilo 6γ/kg/h y midazolam 0,25mg/kg/h, antes de incorporar una 3ra droga se rota a morfina 0,3mg/kg/h.
Incorporación de dexmedetomidina disminuye la incidencia del delirio, es un sedante y analgésico, que no causa depresión respiratoria e induce un nivel de sedación donde el

paciente puede abrir los ojos a la estimulación verbal. Se asocia a una menor incidencia de delirio, de gran utilidad en la sedación para pacientes con ventilación no invasiva.
Infusión continua, dexmedetomidina 200mcg en cloruro de sodio 0.9% o dextrosa 5% hasta 50 ml.
NO SE ADMINISTRA EN DOSIS RESCATE.
Relajante muscular, solo si el paciente lo requiere y con indicación médica se utilizara el Vecuronio en infusión continua o rescate.
Preparación reconstituir en agua para inyectables, presentación 10 mg, diluir en dextrosa al 5% o cloruro de sodio 0,9% hasta 24 ml, dosis recomendada para infusión continua 0,1 mg-0.2 mg/ml, dosis rescate 1mg/ml-2 mg/ml.
ROTULAR:
NOMBRE DEL PACIENTE, MEDICAMENTO, CON DOSIS CORRESPONDIENTE, FECHA Y HORA DEPREPARACION.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Vía de administración
Endovenosa: por CVC (catéter venoso central y/o venoso periférico)
La administración deberá realizarse por una línea de acceso venoso periférico o central por donde solo este perfundiendo PHP o Sol Fisiológica al 0.9% limpia.
Lavar la línea con sol fisiológica al 0.9% antes y después de administrar la dosis rescate.
PREPARACIÓN PARA DOSIS O BOLOS DE RESCATE.

a) **En bandejas al pie de la cama del pte.**
b) **En jeringas prellenadas con la dosis pura. (estabilidad 6hs)**
c) **En jeringas prellenadas con la dosis diluida.(estabilidad 6hs)**
d) **Todas las bandejas deben contener una jeringa con Sol. Fisiol. 0.9% de 20cm p/lavado**

Cada jeringa debidamente rotulada con:

- **Nombre de la medicacion**
- **Dilución por cm.**
- **Fecha de preparación y el horario.**

EL RECAMBIO DE LAS JERINGAS PRECARGADAS SE REALIZARACADA 6HS.

REALIZADO POR:
Lic.Torreiro Lorena, JefeSección UTIP
Lic.Vera,Sabrina,Enfermera de UTIP

BIBLIOGRAFIA

- **Dra. Silvana Cavallieri B. Dr. Piero Canepa L Dr. Claudio Ricke,.Dolor Agudo Post-Quirúrgico En Pediatría Evaluación Y Tratamiento. Departamento De Anestesiología. Clínica Las Condes.*Unidad De Anestesiología Hospital Luis Calvo Mackenmª.**
- **J. Quiles1,2, C. J. Van-Der Hofstadt1,2 E Y. Quiles2na. Instrumentos De Evaluación Del Dolor En Pacientes Pediátricos: Una Revisión (2ª Parte) Rev. Soc. Esp. Dolor 11: 360-369, 2004**

ALIMENTACION ENTERAL

DEFINICIÓN:
La nutrición enteral son las acciones que se realizan para mantener el estado nutricional adecuado,a través de una sonda ,insertada en un tramo del tubo gastrointestinal ,cuando no es posible la alimentación por via oral .
Teniendo como condición indispensable que el intestino conserve parcial o totalmente su capacidad funcional de absorción.

OBJETIVOS:
Satisfacer los requerimientos nutricionales del paciente.

LEGISLACIÓN VIGENTE:
Ley 24.004-Normas Para El Ejercicio De La Enfermería. Capítulo I: Art.4/Art. 3.Inciso 18

PERSONAS HABILITADAS
Lic. En Enfermería
Enfermeros Profesionales

VIGILANCIA Y RECONMENDACIONES:
- No iniciar la infusión de la alimentación sin verificar que la sonda y el sistema a utilizar se encuentren en forma optima.
- Evaluar la actividad intestinal, escuchando los ruidos intestinales antes de iniciar la infusión de la dieta.
- Valorar datos de síndrome de vaciamiento rápido (nauseas, vómitos, diarrea, calambres, palidez, taquicardia, desvanecimiento). Se presenta en pacientes con yeyunostomía
- Valorar la presencia de diarrea, estreñimiento, flatulencias, regurgitación, sensación de saciedad.
- Valorar el estado de hidratación.
- Comprobar que la dieta sea la prescripta en la indicación médica, verificando con la identificación del paciente.
- Identificar guía con fecha y turno que se coloca.Triple rotulo
- Purgar bien el set de la bomba de Infusión.

MATERIAL Y EQUIPO:
- Sonda nasogastrica (En general se usa la K30 ó 31, de silastic dependiendo de la edad y talla del paciente).
- Jeringa de 20 ó 30ml.
- Jeringa de 10ml.
- Estetoscopio.
- Bomba infusora y su guía correspondiente.
- Tela adhesiva para marcar la sonda.
- Botella con formula nutricional.
- Lidocaína jalea.

PROCEDIMIENTO:
Pre-Colocacion de Sonda
- Corroborar indicaciones medicas
- Explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar.
- Colocar al paciente en poción Fowler con la cabecera a 30, 40 º.

Colocacion de sonda

- Medir por fuera la sonda y señalar con tela adhesiva hasta donde debe ser introducida.
- Introducir la sonda, lentamente con lidocaína jalea para facilitar el acceso y disminuir molestias al paciente durante la entrada tracto digestivo(Muchas veces se le pide al paciente que trague saliva, o se le administra con centímetros con una jeringa de 10ml con el fin de ayudar al procedimiento).

Pos-Colocacion de sonda

- Comprobar que este bien situada, de la siguiente manera: introduciendo por la sonda 10cc de aire y auscultar colocando el estetoscopio en la zona abdominal, la difusión de este.
- Aspirar la sonda con el fin de obtener contenido gástrico.
- Fijarle la sonda en una la mejilla colocando un apósito protector, para prevenir ulceras, luego colocar sobre la sonda un apósito transparente.
- Se puede sujetar también la sonda a la batata a las ropas del paciente con telas adhesiva para evitar riesgos de que se salga de su sitio, evitar molestias en fosas nasales por movimientos bruscos.

TECNICAS Y CUIDADOS DE ENFERMERIA

- Si el paciente tiene puesta la sonda, revisar permeabilidad y posición, antes de iniciar la infusión de la alimentación..
- Revisar la indicación médica e identificación del paciente.
- Aspirar suavemente con la jeringa al dispositivo de entrada a la sonda alimenticia con el propósito de verificar la alimentación residual y confirmar la correcta colocación de la sonda.
- Verificar que se mantenga la velocidad de la infusión según la indicación médica.
- **Es recomendable cambiar el equipo de infusión cada 24 horas.Respetar normas infectologicas**

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

- **Comprobar que la formula nutricional a administrar,tenga las característica adecuadas ,temperatura ambiente , dilución y homogeneidad conservadas y que corresponda al paciente. Según indicación medica.**
- **Registrar en la hoja de enfermería el procedimiento efectuado, con firma y sello del personal interviniente.**

REALIZADO POR:

Lic. Rearte, Juana.Jefe de Seccion U 5

BIBLIOGRAFIA

- Revista Cubana De Enfermería V.22 N. 4 Ciudad De La Habana Septiembre De 2010. Utilización Clínica De La Nutrición Enteral
- J Álvarez Hernández, N Peláez Torres - Nutrición 2006 – Scieloespana.ImportanciaDe Las Características Físico-Químicas De Los Fármacos Para Su Administración Por Sonda Nasoentérica O Enterostomía
- M Gámez Lechuga, A Clopés Estela, D Cardona Pera - Farm. Hosp, 1998 - Sefh.E Incompatibilidades Fármaco-Nutrición Enteral: Recomendaciones Generales Para Su Prevención
- N Izco, N Creus, J Massó, C Codina, J Ribas - Farmhosp, 2001 - Sefh.E

ALIMENTACION PARENTERAL

DEFINICION:
La alimentación parenteral es una técnica de soporte nutricional artificial, cuyo objetivo es mantener el estado nutricional correcto del paciente cuando la vía enteral es inadecuada o insuficiente.

OBJETIVOS:

- Mantener o restaurar el estado nutricional del paciente.
- Seleccionar el acceso venoso adecuado a la durabilidad de la NPT y el estado del paciente.
- Conservar y administrar la fórmula de NPT según normas.

LEGISLACION VIGENTE:
Ley 24004.-Normas Para El Ejercicio De La Enfermería. Capítulo I: Art. 4/Art. 3. Inciso 18

PERSONAS HABILITADAS
Lic. En Enfermería
Enfermeros/as Profesionales

VIGILANCIA Y RECOMENDACIONES:
El paciente pediátrico con NPT requiere de un personal especializado y conocedor tanto de la técnica como de las complicaciones que se puedan producir durante su ejecución.
Es competencia del enfermero/a la evolución diaria del paciente, el cuidado del acceso venoso, por situaciones que supondrían un riesgo importante para el paciente.
Todas las actividades relacionadas en el proceso de la NPT deben registrarse en la hoja de enfermería, evolución, con firma y sello.

- Controles de signos vitales.
- Balance de ingresos y egresos por turno.
- **Observar y registrar en la hoja de Enfermería, signos de hidratación, pliegue cutaneo.**
- **Edemas, color de piel, Temperatura.**

PROCEDIMIENTO:

- Si la solución a infundir se encuentra muy fría, dejar media hora temperatura ambiente, antes de ser administrada.
- Comprobar que la identificación coincida con los datos del paciente y el volumen final de toda la composición.
- Observar las características de la solución que no haya precipitado.
- Limpiar la mesa con alcohol al 70% con técnicas de arrastre (ver normas infectologicas).
- Lavado de manos, (ambos operadores según normas infectologicas).
- Colocarse gorro y barbijo (los dos operadores).
- Colocar campo estéril donde se dispondrá todo el material descripto y necesario para la conexión del equipo.
- El operador ayudante colaborara en alcanzar el material y en cortar el envoltorio protector que recubre la bolsa y depositarla sobre el campo estéril.
- Colocar la bolsa colgada en el pie de suero o bien sobre el campo estéril, conectar la tubuladura con la guía cerrada, abrir lentamente purgando el equipo y procurando que no quede ninguna burbuja de aire en el sistema.
- No Proteger la unión de la guía a la bolsa con gasas estériles.

- Clampear el lumen del catéter por el cual vamos a infundir la NPT para evitar la entrada de aire y retorno venoso.
- El operador ayudara a colocar la guía a la bomba infusora, y programará el volumen indicado, retirara la guía y bolsa de alimentación anterior, si la hubiere.
- El operador colocará la guía de la NPT al lumen del catéter por el cual infundir. **IMPORTANTE**: Retirar el clamp.
- Registrar en la hoja de enfermería: Hora de inicio o cambio de solución, vía de administración, lumen, volumen a infundir y goteo programado, esta última dependerá si se tiene un goteo de 24, 12 hs o de un goteo cíclico.

RECORDAR: Farmacia entrega la NPT a las 19 hs. Momento en el que se realizara el cambio. Los casos especiales, se indicaran por escrito y se registraran.

MATERIALES A UTILIZAR

- **Camisolin, Gorro, Barbijo, guantes esteriles.**
- **Campo esteril para cubrir el lugar de preparación.Bomba de infusión volumétrica para administrar volumen de fluidos determinados a velocidad constante.**
- **Guias adecuadas , según bomba a utilizar.**
- **Llave de tres vías**
- **Parche de clorhexidina trasparente**
- **Bionectores, Jeringas de 10 cc. Y de 5 cc.**
- **Gasas Esteriles**
- **Tijeras**
- **Filtro recomendado, para la retención del aire y/o bacterias.**
- **Solucion de clorhexidina al 2%hidroalcoholica para limpiar conexiones, Respetar Normas Infectologicas**

PROCEDIMIENTO:

Pre-Colocaciòn:

- Si la solución a infundir se encuentra muy fría, dejar media hora afuera de la heladera antes de ser administrada.(Temperatura ambiente)
- No almacenar la bolsa de la solución de NPT atemperatura ambiente porque favorece el crecimiento bacteriano.
- No congelar.
- Comprobar que la identificación coincida con los datos del paciente y el volumen final de toda la composición.
- Observar las características de la solución que no haya precipitado.
- Limpiar la mesa con alcohol al 70% con técnicas de arrastre (Ver norma).
- Lavado de manos, (ambos operadores) según normas establecidas.
- Colocarse Camisolin,gorro y barbijo (los dos operadores).
- Colocar campo estéril donde se dispondrá todo el material descrito y necesario para la conexión del equipo.

Colocaciòn;

- El operador ayudante colabora en alcanzar el material y en cortar el envoltorio protector que recubre la bolsa y depositarla sobre el campo estéril.
- Colgar la bolsa en el pie de suero o apoyarla sobre el campo estéril, conectar la tubuladura con la guía cerrada, abrir lentamente purgando el equipo y procurando que no quede ninguna burbuja de aire en el sistema
- Clampar el lumen del catéter por el cual vamos a infundir la NPT para evitar la entrada de aire y retorno venoso.
- El operador ayudará a colocar la guía a la bomba infusora, y programará el volumen indicado, retirado la anterior si la hubiere.

- El operador colocará la guía de la NPT al lumen del catéter por el cual infundir.
- **Post-Colocaciòn:**
- Retirar el clamp.
- Programar bomba infusora según indicaciònmedica y dar inicio.
- Registrar en la hoja de enfermería: Hora de inicio o cambio de solución, vía de administración, lumen, volumen a infundir y goteo programado, esta última dependerá si se tiene un goteo de 24, 12 hs o de un goteo cíclico.
- Se debe informar en forma escrita y oral el procedimiento efectuado, firmado
- por el personal interviniente.

TECNICAS Y CUIDADOS DE LA VIA DE ADMINISTRACION DE NPT

- Todo el procedimiento debe realizarse bajo rigurosa asepsia.Utilizar técnica Esteril.
- Comprobar permeabilidad de catéter.
- Dos operarios ,colaborador limpio para alcanzar material.
- Un Operador Esteril, para la preparación de la NPT .
- Utilizar una vía única para lenta infusión de NPT.
- Si es imprescindible administrar por un segundo lumen, comprobar compatibilidad entre los componentes.
- La manipulación para el cambio se realiza en forma estéril entre dos personas.
- Utilizar apósito transparente. El tipo de apósito y la frecuencia dependerá del protocolo, será impermeable a la humedad, ligero y con las mínimas molestias para el paciente, donde el punto de inserción quede visible para la óptima valoración diaria.

Cambio del apósito trasparente:

- En niños pediátricos se realizara 1-2 veces por semana dependiendo de la necesidad. (Ver Normas de Infectologia)
  - Cuando este suelto,Sucio o mojado.
  - Si el catéter no es permeable y te obliga a revisarlo.
  - Cuando parte del catéter externo se haya deslizado accidentalmente.
  - Inspeccionar el punto de inserción para observar posibles signos inflamatorios sugestivos de Infección, lo que obligaría a retirar el catéter y realizar cultivos del mismo.
  - Se debe tener en cuenta que la permanencia de más de tres semanas del catéter aumenta notablemente el riesgo de infección relacionada en el catéter. Al finalizar el tratamiento se deberá cultivar todo catéter por donde haya pasado NPT
  - Administrar a temperatura ambiente.

Se recomienda:

- No añadir otros medicamentos a la bolsa de parenteral bajo riesgo de precipitación contaminación o incompatibilidad.
- No administrar la solución si se observar alguna alteración en la mezcla que indique precipitación (capa marrón en las mezclas ternarias que indica que los lípidos se han separado de la solución).
- Si es posible evitar catéter múltiples lúmenes.
- No realizar medicación por el mismo lumen que pasa la NPT, ni transfusiones de sangre ni hemoderivados, también evitar las extracciones de sangre para laboratorio.

Si es imprescindible administrar alguna medicación en paralelo comprobar antes:

- la compatibilidad con todas las sustancias y tener en cuenta que aumenta considerablemente el riesgo de infección.
- Si UN paciente con NPT presenta signos y sintomas de infeccion, siempre sospechar de sepsis relacionada al catéter. Y seguir el protocolo que sea ha estipulado según el servicio.

REALIZADO POR:

Lic. Rearte Juana, Jefe de Sección U5

BIBLIOGRAFÍA

- Enteral, A (2005). Normas De Prevención De Infecciones Intrahospitalarias En El Proceso De Alimentación Enteral Y Parenteral En La Ucin. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá, 24 (4), 4.
- Balboa Cardemil, P., Durán, C. (2011). Factores De Riesgo De Infecciones Del Tracto Sanguíneo Asociadas A La Alimentación Parenteral En Pacientes Pediátricos .Nutrición Hospitalaria, 26(6), 1428-1434.
- Miranda .D, Castillo, C., & De Pablo, S. (2007). Alimentación Parenteral: Factores Ambientales Y Químicos Asociados A Su Estabilidad. Revista Chilena De Pediatría 78 (3), 277-283.
- De Normas, C. (2001). Acreditacines, Aanep Asociación Argentina De Nutrición Enteral Y Parenteral .Guía De Práctica Clínica De Nutrición Enteral Y Parenteral. Guía De Práctica Clínica De Nutrición Enteral Domiciliaria. Publicación Rnc Sobre Nutrición Clínica, 10, 6-17.
- Mora, Rj. (2002). Soporte Nutricional Especial. Ed. Médica Panamericana. Burillo, N. G. Actuación De Enfermería Ante Las Complicaciones De La Nutrición Enteral.

LOCK THERAPY

La locktherapy es una técnica que consiste en la aplicación en el lumen del catéter de una alta concentración de antibióticos, por varias horas, con el objeto de erradicar las bacterias presentes en el endolumen y así prolongar la vida útil del catéter, reduciendo la morbimortalidad y los costos asociados a una infección relacionada con el CVC.

EQUIPO

- Desinfectante.
- Alcohol al 70%
- Recortes de gasa
- Bandejas
- Unidireccionales
- Solución fisiológica, dextrosa al 5%, agua destilada
- Medicacion prescripta
- Torundas de algodón
- Jeringas y agujas

PROCEDIMIENTO

El mismo debe debe realizarse según los siguientes pasos

- **Diluir el antibiótico indicado,(ejemplos más usados son Vancomicina y Amikacina)en 10ml de solución Fisiologica**
- **Tomar 0,1 ml ó 0,3 ml (tener en cuenta siempre indicación médica que para cada caso es distinta) llevarlo a 3 ml con solución fisiológica.**
- **Colocar en catéter la solución y sellarlo con un bionector**.

SELLADO CON HEPARINA:

- **Sacar 0,1 ml. de heparina de un frasco estéril de 5000 U.**
- **Se lleva a 10 ml. con solución fisiológica.se obtendrán 50 UI por ml.**
- **Se administran 3 ml.en cada rama del catéter.(ver normas de manejo de catéter venoso central)**
- **Sellado con bionector.**

TECNICA PARA TRATAMIENTO DE OBSTRUCCION DE CATETER EL CVC

Para destapar el catéter, en caso de que esto ocurriera lo cual es muy probable, se utiliza 3 ml de vitamina C se inyecta y se la deja actuar por unos 10 minutos aproximado, luego se aspira el ml de vitamina inyectado.

REALIZADO POR:

Lic.Rearte, Juan Alicia,Jefe Sección U5

BIBLIOGRAFIA

- Clinical Infectiousdiseases 2007; 44827-9 By Infectious Diseases Society Of America, All Rightist Reserved.EditorialCommenttary: Cid
- Dra. Gentileangela-Licbeltran, Elizabeth-Lic Cabrera, Mariela .Normas Practicas Para El Control De Infecciones 2017,Hnrg –Servicio De Epidemiologia
- Verri Espinosa, Alejandra.Manual De Procedimientos De Enfermería Del Niño Y Del Adolescente, Escuela De Enfermería Sede Chillan,2012.
- Dra Pascual Carolina-Jefa Medica Unidad U5

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS.

DEFINICION
Es la relación cuantificada de los ingresos y egresos de líquidos que se produce en el cuerpo humano en un tiempo específico, incluyendo pérdidas insensibles.

OBJETIVOS:
Que el enfermero logre:

- Proveer un registro que facilite la confección adecuada a ingresos y egresos.
- Conocer y valorar los ingresos y egresos del paciente
- Posibilitar el control de la reposición de líquidos y electrolitos.

La hoja de balance hídrico tiene como finalidad dejar constancia escrita de los ingresos y egresos de líquidos del paciente en 24 horas, del cumplimiento de las indicaciones del tratamiento médico y del estado hídrico - electrolítico del paciente

LEGISLACION VIGENTE

- Ley 24004-Normativa para el ejercicio de la Enfermería- Art.3 Inciso. 18.
- Ley 26529: Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado.Incluye en la historia clínica todos los documentos que hagan referencia a información de salud del paciente; incluyendo los consentimientos informados, hojas de indicaciones, hojas de Enfermería, estudios complementarios, prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas.
- La historia Clínica constituye responsabilidad profesional de carácter técnico legal y administrativo.

PERSONAS HABILITADAS
Lic. en Enfermería - Enfermeros Profesionales

PROCEDIMIENTOS:

- Identificar el registro con los datos del paciente.
- Colocar la fecha y hora de su confección

En la columna de ingresos se registrara:

- Hora de comienzo de la solución administrada.
- Cantidad inicial.
- Ritmo.
- Tipo de solución
- Se asentara el volumen total pasado en el lapso de una hora, en caso de infusión de volúmenes altos, en planes bajos o de mantenimiento se registrara cada tres o más horas .

Si se interrumpe por infiltración, administración de medicamentos sangre u otros o cambio de plan, se anotara el total administrado.
Si se infunde con Bomba, la misma se pondrá en cero al realizar el balance parcial en cada turno, una hora antes de entregar la guardia.

- Fluidos Enterales : anotar cantidad exacta ingerida, tipo de líquidos suministrado, se describirá también la vía utilizada.Oral.,S.N.G.,Gastroclisis,BotonGastrico, otros

Se debe balancear:
1-Ingresos: planes de hidratación, volúmenes de transfusiones y hemoderivados, planes de alimentación parenteral y enteral, administración de mediación diluida en paralelos, o no, medicación administrada por sonda nasogástrica, ingesta oral del paciente (todos los liquidos que ingresan al organismo, por todas las vías)
2. Egresos se hará constar todas las perdidas:

- Vómitos.

- Material drenado por : S.N.G. Drenaje pleural u otros .
- Orina contabilizar cantidad exacta, pesar pañales.
- Catarsis (DeposicionesFecales) .
- Debito de drenajes, sonda nasogástrica, sonda vesical y planes de lavado vesical, Sangrados (todo lo que sale)

Cierre parcial se realizara en todos los turnos, sumando el total de ingresos y egresos.
Cierre total o general se realizara cada 24 hs tomando como norma las 05 hs/ 06 hs(según área).momento en Que la bomba se pondrá en cero (0).
Se sumaran todos los ingresos y los egresos (acumulativo,balance parcial) se restaran ambos totales darán como resultado el balance total de 24hs.
Este podrá ser positivo o negativo.
Dejarlo registrado, en forma clara, sin tachones, ni borrones o sobre escrituras.
Enfermería deberá realizar el balance a los pacientes sin necesidad de indicación médica.
Los registros de ingresos y egresos hechos por enfermeria son un elemento fundamental de diagnostico, para poder establecer la reposición de líquidos y electrolitos.
Se deberá confeccionar una hoja por 24 horas.
Los horarios de Cierre de los balances parciales son los siguientes:

Áreas Abiertas
Turno mañana: 13.00 hs.
Turno tarde: 20.00 hs
Turno noche: 6.00 hs.

Áreas Cerradas
Turno mañana: 11.00 hs.
Turno tarde: 17.00 hs
Turno Vespertino:23 hs.
Turno noche: 5.00 hs.

SADOFE

Áreas Abiertas
Turno mañana: 13.00 hs.
Turno tarde: 20.00 hs
Turno noche: 6.00 hs.

Áreas Cerradas
Turno mañana: 11.00 hs.
Turno tarde: 17.00 hs
Turno Vespertino:23 hs.
Turno noche: 5.00 hs.

El cierre de los balances parciales una hora antes del pase de guardia tiene por objetivo su correcta confección y controlar el estado de las venoclisis y los Baxter de soluciones enterales y parenterales, previo al cambio de turno.
El turno noche será el responsable de efectuar el balance total de las 24hs. Y de colocar la nueva hoja de balance aclarando el volumen de la solución restante, es decir, la cantidad de solución que queda pasando.
Cada turno separara su balance parcial al cerrarlo con una línea recta horizontal.
En la hoja se incluirá el número de frasco que se está administrando, aclarando el contenido del frasco, en la hoja de enfermería.
El uso y confección de la hoja de balance hídrico tiene carácter de obligatoriedad para el personal de enfermería de toda la Institución.
Su realización no requiere orden ni solicitud médica.

En los casos de pacientes críticos se efectuara la hoja de balance parcial cada dos horas y se sacara ritmo diurético, en el caso de las Salas de Clínicas, se realizará balance parcial por turno, evaluando la necesidad del paciente.
En caso de errores u omisiones está terminantemente prohibido el uso de corrector líquido, efectuar borrones y tachaduras, se deberá trazar una línea aclarando "error" o anotación incorrecta" o bien la sigla "A.I".Letra Clara y Legible
Debe llevar la firma y Matricula Habilitante o Ficha Censal del enfermero/a responsable de cada turno.
Ver, Norma de Registros de enfermería.

REALIZADO POR:
Lic. Segovia Nora, Jefa Sección U 13

BIBLIOGRAFIA
Normas de Enfermería, HNRG, CABA, 2017.
Verri Espinosa, Alejandra. Manual De Procedimientos De Enfermería Del Niño Y Del Adolescente, Escuela De Enfermería Sede Chillan,2012.

CATETER IMPLANTABLE

DEFINICION:
Se denominan accesos Implantables,porqueel reservorio se colocan por debajo de la piel en su totalidad con acceso de una vena central.
Consta de una cámara de metal o silicona y un catéter de poliuretano radiopaco, la cámara presenta forma de cono truncado con una base mayor y perforaciones en la periferia para su anclaje en el tejido celular subcutáneo y una base menor formada por el septum autosellante de siliconas, radiopaca, que impide la extravasación .
Esta cámara se conecta con catéter a través del pico de salida y se ubica preferentemente en el tórax.
Estos sistemas constan de sus propias agujas, bisel huber, descartables con prolongador y broche de seguridad, ya que otro tipo de aguja podría dañar la silicona del portal.

OBJETIVOS
- Disminuir las punciones venosas periféricas, favoreciendo el confort del niño y disminuyendo su ansiedad(Extracciones sanguíneas para estudios de laboratorio)
- Transfundir sangre o hemoderivados.
- Administrar planes de hidratación y ATB.
- Mantener un acceso venoso seguro de larga duración.

LEGISLACION VIGENTE
Ley 24004.Normativas para el ejercicio de la enfermería. Articulo 3 incisos 18, de la reglamentación incumbencias del nivel profesional, controlar catéteres centrales
Participar en tratamientos de quimioterapia.

PERSONAS HABILITADAS
Enfermeras técnicas profesionales
Licenciadas en enfermería

INDICACIONES
Este indicado para el paciente que necesita tratamiento prolongado de quimioterapia, antibiótico, frecuente administración de sangre o hemoderivados.

SE DEBE VIGILAR, EN EL PACIENTE:
Dolor, eritema, hematomas.
Signos y síntomas de infección.(Enitema, tumefacción e aumento temperatura local en zona de Puncion)

SE DEBE VIGILAR DEL CATETER:
La fijación, para evitar desplazamientos, de la aguja Huber.
Detectar tumefacción y extravasamiento
Observar Signos y síntomas de infección.

MATERIAL NECESARIO
Para la apertura
Gorro-barbijo
Guantes estériles
Compresa lisa y fenestrada
Aguja bisel huber 19/21 g

Llave de tres vía con prolongador
Jeringas de 10cc.Agujas EV
Solución fisiológica ampollas
Solución antiséptica
Solución a infundir. Set de infusión cinta adhesiva-Apósito transparente
Gasas
Descartador de punzantes

MATERIAL PARA EL CIERRE

- Gorro-Barbijo
- Guantes Estériles Compres Lisa Y Fenestrada
- Jeringas 10cc.Jeringa de 5cc.Jeringa De 1cc
- Agujas EV
- Heparina Frasco Cerrado
- Solución Antiséptica
- Gasas
- Descartador De Punzantes

MESA DE PROCEDIMIENTOS
Decontaminar con soluciones enzimáticas (alcohol 70%)

PROCEDIMIENTO

- El procedimiento se realizara entre dos operadores; De Ser posible.
- Lavado de manos con jabón antiséptico.
- Colocar los barbijos (paciente, operador o familiares asistentes).
- Evaluar la integridad del reservorio y catéter antes de cualquier manipulación. (Observando, examinando y palpando el bolsillo del reservorio en busca de eritema, edema, inflamación, sensibilidad excesiva o signos de infección).
- El asistente deberá desinfectar la zona de punción con antisépticos de preferencia clorhexidina alcohólica 2 % o acuosa, en forma de espiral dejando actuar al menos un minuto hasta secar.
- El operador deberá repetir el procedimiento con una nueva gasa estéril usando el mismo antiséptico.
- Fijar la aguja en forma segura, con apósito autoadhesivo, según sea conveniente. Este paso es de suma importancia en forma preventiva, considerando que muchos de los pacientes que poseen este tipo de catéteres reciben citostaticos, pudiendo ser irritantes y/ o vesicantes.
- Si la aguja se desplazara al tejido subcutáneo, se pueden producir serias lesiones en la zona, tales como necrosis tisular.
- No olvidar el triple rotulo de Baxter, tubuladura y zona de inserción, con fecha, hora y operario, a fin de contar con el periodo de recambio.
- **La aguja Huber se cambiará cada 07 días.Las Tubuladuras Cada 72Hs.**
    - **Controlar la permeabilidad del sistema**
    - **Mantener un goteoque impida el retorno venoso de 3 a 10 ml/hs, para evitar obstrucción del cateter.**
- **Tener presente las normas Infectologicas de la institución**

SELLO HEPARINICO

- Sacar 0,1 ml. de heparina de un frasco estéril de 5000 U.
- Se lleva a 5 ml. con solución fisiológica. De esta forma obtendremos una concentración de 100 U/I ml.
- Se administran 3 ml.al sistema.
- Clampear mientras sé está ejerciendo presión positiva.
- Retirar aguja ejerciendo presión sobre el portal

ADVERTENCIA

No limpiar el sistema con dextrosa, ya que esta favorece la proliferación de microorganismos
Utilizar solo solución fisiológica

OBSTRUCCIÓN DE CATETER

PRIMERA MEDIDA

Bloqueo por oclusión trombotica
Utilizar jeringa con solución fisiológica + 1 cc
Inyectar y aspirar
Lavar con solución fisiológica

SEGUNDA MEDIDA

Diluir 25000 UI de uroquinasa en 5 cc de solución fisiológica, obtendremos 5000 u x ml.
Pasar por el portal dejando 2 o 3´y aspirar para extraer el coagulo
Lavar con solución fisiológica
Se puede repetir esta maniobra 4 o 5 veces

TERCERA MEDIDA

Diluir 250000 u de estreptokinasa en 10cc de solución fisiológica tendremos 25000 UI x ml, de esto tomamos 1 cc y le agregamos 9 cc de solución fisiológica y obtendremos 2500 UI de estreptokinasa x ml.
Debemos pasar por el portal 1 a 2 cc de esta dilación se espera 5 a 10´, luego se aspira, se puede repetir esta maniobra de 2 a 4 veces

Se Debe Informar En Forma Escrita Y Oral El Procedimiento Efectuado Con Fecha Y Hora Del Mismo Firma y Sello del Personal Interviniente.

REALIZADO POR:

Lic. Marcela Melian, Jefa Division Turno Noche
Lic. Marcos Saravia, Jefe Sección Oncología

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

- Apuntes Jornadas Interdisciplinaria Del Hospital Garrahan
- Apuntes Del Curso De Actualización Oncológica.UBA-Htal.Roffo.Auspiciado Por Roche
- Fichas Técnicas Realizadas Por El Personal De Enfermería Del Servicio De Pediatría De La Maternidad Suizo Argentina
- Shirley E. Otto: Enfermería Oncológica Tomo II Capitulo 20-21

CATÉTER VENOSO CENTRAL SEMI IMPLANTABLE
DEFINICION
Inserción de un catéter en el espacio intravascular central.
Son catéteres fabricados con materiales biocompatibles, con polímeros siliconados logrando de esta forma, disminuir la incidencia tanto de flebitis química, como de trombosis.
Constituye uno de los procedimientos más eficaces en el tratamiento de enfermedadesCronicas.
TIPOS DE CATETER VENOSO CENTRAL

Catéteres venosos centrales (no tunelizados)	**Pueden insertarse en vena yugular interna o en vena subclavia o femoral.**	**El 90 % de todas las infecciones relacionadas a catéteres ocurren en pacientes con este tipo de catéteres**
Catéteres arteriales pulmonares	**Se insertan a través de un introductor de teflón en una vena central (subclavia, yugular o femoral).**	**Usualmente recubiertos con heparina, tienen porcentajes de infección similares a los CVC. La vena subclavia presenta menores riesgos de infección.**
Catéteres umbilicales	**Se insertan dentro de la vena o arteria umbilical.**	**Los riesgos de bacteriemias relacionadas son similares para los colocados tanto en vena**

CATETERES INTRAVASCULARES DE LARGA DURACION

Catéteres venosos centrales tunelizados (Semimplantables) (Ej. Hickman, Broviac)	**Se implantan quirúrgicamente dentro de vena subclavia, yugular interna o femoral.**	**Tienen una porción tunelizada y un bolsillo de dacrón (manguito) ubicado justo encima del sitio de salida del catéter que inhibe la migración de microorganismos. Porcentajes de infección relativamente bajos.**
Catéteres totalmente implantables (Ej. Port –A-Cath)	**También son tunelizados bajo la piel, tienen un portal subcutáneo o reservorio, al que se accede mediante punción.**	**Evitan los cuidados rutinarios del sitio de salida del catéter. Se utilizan para terapias de largo tiempo. Bajos porcentajes de infección.**

OBJETIVO
Prevenir complicaciones asociadas al catéter venoso central, permitiendo su óptimo uso durante todo el proceso de trasplante hematopoyético.-

LEGISLACION VIGENTE
LEY24004.Normativas para el ejercicio de enfermería-Art.3 Inciso 18

PERSONAS HABILITADAS
Lic. En Enfermería
Enfermeros Profesionales

MATERIALES:

- Barbijo
- Campo estéril (equipo con campo y compresa fenestrada)
- Guantes estériles
- Gasas estériles
- Jeringa de 1ml.
- Jeringas 5 ml
- Jeringas 10 ml
- Agujas 21G.
- Solución fisiológica ampollas.
- Frasco de Heparina Sódicaestéril.
- Solución de pervinox o alcohol al 70%.
- Tubos de ensayo para las distintas muestras solicitadas.
- Descartador.

EQUIPO:
EnfermeroOperador:

- Gorro
- Antiparras
- Barbijo
- Guantes estériles
- Camisolín

Operador auxiliar:

- Camisolín - Barbijo
- Antiparras
- Guantes limpios o manoplas

PROCEDIMIENTO:

- Ingresar a la habitación del paciente correctamente vestidos con Barbijo, Camisolín, Gorra Botas y la bandeja conteniendo todo el material.
- Explicar el procedimiento al pacientey/o al adulto a cargo.
- Desinfectar la mesa del paciente, donde se realizara el procedimiento, con alcohol al 70% con uso correcto de técnica de barrido y secado.-
- Tanto el Enfermero operador como el Operador Auxiliar deberán Efectuar una óptima higiene de manos con solución jabonosa antiséptica, según las normas infectológicas vigentes en la institución.-
- Colocar barbijo al pacientey al Operador Auxiliar.-

- El operador Auxiliar realizará la primera limpieza con solución antiséptica y ofrecerá la punta del catéter distal al Enfermero Operador para una segunda limpieza.
- El enfermero operador deberá realizar la segunda limpieza con soluciónantiséptica y colocará los campos estériles necesarios para dar inicio al procedimiento en sí.
- Retirar bionector de vía distal con técnica aséptica, manteniéndolo sobre el campo estérily colocar la jeringa seca para la primera extracción.
- Abrir el Clamp.-El Operador Auxiliar, en este momento deberá abrir el Clamp del Lumen distal, realizando este procedimiento por debajo de las compresas ya armadas sobre el paciente.
  - Tomar muestra de laboratorio si fuese necesario, según normas infectologicas,concensuado con Bacteriologia**.** Ver, Utilizacion del cateter venoso central semimplantable para obtencion de muestras para retrocultivos.-
- Cambiando jeringa tomar los ml requeridos para las muestras según indicación médica, previa verificación de los tubos donde deben ser enviadas las mismas.
- Llenar los frascos requeridos con la ayuda del Operador auxiliar.
- Lavar con Solución Fisiológica realizando frenado del embolo para producir turbulencia, respetando el peso del paciente de la siguiente forma menos de 15 Kg. Usar 10 ml de solución fisiológica mayores de 15 Kg 20 ml de solución fisiológica.-
- Cerrar Clamp del catéter (acción realizada por operador auxiliar) en presión positiva a fin de evitar retornos sanguíneos del lumen utilizado, evitando el retorno sanguíneo al mismo. Se recolocará bionector.-
- Realizar muestra de glucosa en sangre con una gota en tira reactiva.
- Ejecutar la limpieza y descartar todo material usado en el procedimiento.
- Registraren hoja de evolución de Enfermeria.

Utilización de catéter venoso central para la obtención de muestras de laboratorio.-

UTILIZACION DEL CATETER VENOSO CENTRAL SEMIMPLANTABLE PARA OBTENCION DE MUESTRAS PARA RETROCULTIVOS.-

Este procedimiento consistente en tomar una muestra de sangre del paciente a través de un catéter venoso central.- Deben realizarse antes de la administración de la terapia antimicrobiana sistémica.

MATERIALES:

- Guantes estériles.
- Campo estéril.
- Gasas estériles.
- Alcohol al 70%.
- Jeringas de 3ml.
- Jeringas de 10ml.
- Agujas 21G.
- Solución fisiológica ampollas
- Medio de cultivo.

EQUIPO:

- **Enfermero Operador:**
  - Barbijo
  - Antiparras
  - Gorro

- Camisolín
- Guantes estériles

- **Operador auxiliar**
  - Barbijo
  - Antiparras
  - Camisolín
  - Guantes limpios o manoplas

PROCEDIMIENTO:

- Ingresar a la habitación del paciente correctamente vestidos con Barbijo, Camisolín, Gorra Botas y la bandeja conteniendo todo el material.-
- Explicar el procedimiento al pacientey/o al adulto a cargo.-
- Desinfectar la mesa del paciente, donde se realizara el procedimiento, con alcohol al 70% con uso correcto de técnica de barrido y secado de loslíquidos usados.
- Tanto el Enfermero operador como el Operador Auxiliar deberánefectuar una óptima higiene de manos con solución jabonosa antiséptica, según las normas infectologicas vigentes en la institución.-
- Colocar barbijo al pacientey al Operador Auxiliar.-
- El operador Auxiliar realizará la primera limpieza con solución antiséptica y ofrecerá,sin tocar, la punta del lumen distal y luego el punto de conexión del lumen proximal, de a uno por vez al Enfermero Operador para una segunda limpieza.
- El enfermero operador deberá realizar la segunda limpieza con solución antiséptica y colocará los campos estériles necesarios para dar inicio al procedimiento en sí.
- Retirar bionector de vía distal con técnica aséptica, manteniéndolo sobre el campo estéril y colocar la jeringa seca para la primera extracción.
- **El Operador Auxiliar, deberá abrir el Clamp del Lumen distal y proximal de a uno por vez, realizando este procedimiento por debajo de las compresas ya armadas sobre el paciente.**
- **De ambos lúmenes se obtendrán los PRIMEROS 3,5ml los cuales serán introducidos al medio de cultivo,en forma invertida para disminuir la contaminacionde la muestra con agentes aerobios, el volumen minimo a cultivar es de 2 ml de sangre por cada lumen**
- **Se realizara el lavado, de cada lumen cultivado con 10 ml de solución fisiológica en niños con peso menor a 15kg y de 20 ml en niños con peso mayor a 15kg.-**
- **Reconectar vía con infusión y/o proceder a recolocar bionector, ambos mantenidos en forma aséptica, durante el procedimiento de toma de muestra.-**
- **Colocar Bionectoresterilen el lumen Distal y en el proximal.-**
- **Cerrar Clamp del lumen Distal (realizado por operador auxiliar).**
- **Ejecutar la limpieza y descartar todo material usado en el procedimiento.**
- **Identificar cada medio de cultivo con:**
- **Nombre Y Apellido, Unidad,Especificación Lumen Cultivado, Ml De Sangre Administrados En El Medio,Fecha Y Hora.-**
- **Registrar en hoja de seguimiento infectológico**.-

CURACION DE SITIO DE INSERCION.-

MATERIALES:

- Adhesivo hipoalergénico con gluconato de clorhexidina.
- Guantes estériles.
- Campo estéril.
- Solución de gluconato de clorhexidina al 2% en alcohol.
- Gasas estériles.
- Hisopos.
- Barbijo.
- Gorro.
- Camisolín.

PROCEDIMIENTO:

- Ingresar a la habitación del paciente correctamente vestidos con Barbijo, Camisolín, Gorra, Botas y la bandeja conteniendo todo el material.
- Explicar el procedimiento al pacientey/o al adulto a cargo.
- Prever la asistencia de operador auxiliar, previa evaluación de la situación emocional de niño, el cual podría infligir en movimientos involuntarios que afectaran el procedimiento aséptico.
- Desinfectar la mesa del paciente, donde se realizara el procedimiento, con alcohol al 70% con uso correcto de técnica de barrido y secado.
- Tanto el Enfermero operador como el Operador Auxiliar deberán efectuar una óptima higiene de manos con solución jabonosa antiséptica, según las normas infectológicas vigentes en la institución.
- Colocar barbijo al pacientey al Operador Auxiliar.
- Realizar una primera limpieza con antiséptico, sobre parche hipoalergenico con técnica de zig-zag.
- Retira curación anterior, teniendo especial cuidado de seguir las instrucciones del parche para tal procedimiento a fin de evitar lesiones en piel, sitio de inserción y/o puntos de sujeción.
- Observar sitio de inserción para detectar cualquier indicador de: infección, eritema, edema, fijación de puntos de sujeción, lesiones en piel.
- Colocación de guantes estériles, con previo acondicionamiento de material a trabajar en campo estéril.
- Limpiar el área con la solución de clorhexidina alcohólica al 2% en forma zig-zag, de adentro hacia afuera, sin pasar 2 veces por el mismo lugar. La misma se podrá realizar con hisopos en sitio de inserción y/ o gasas estériles.-
- Colocación de adhesivo haciendo coincidir el tramo con gluconato de clorhexidina en el sitio de inserción del catéter.-

CONSIDERACIONES.-

- **Si el paciente fuese intolerante a la clorhexidina se usará Yodo Povidona, previo a desengrasar la piel con una gasa embebida en alcohol a 70% y subsiguiente secado.**
- **Lasolución de Yodo Povidonadebe permanecer en la piel por lo menos un minuto permitiendo así que se libere el YODO necesario para la desinfección.-También podría optarse por parche adhesivo hipoalergénico sin Gluconato de Clorhexidina.**
- **Registrar en Hoja De SeguimientoInfectológico: fecha, hora, nombre del enfermero operador y aspectos presentados en el procedimiento, que deseen destacar.**
- **Colocar triple rotulo,respetar normas de infectologia**

ADMINISTRACION DE HEMODERIVADOS A TRAVES DE CATETER VENOSO CENTRAL.

MATERIALES:

- Guantes estériles.
- Campo estéril.
- Gasas estériles.
- Alcohol al 70%.
- Jeringas de 5 ml.
- Agujas 25G.
- Solución fisiológicaampollas
- Bionector
- Unidad de hemoderivados. Comprobar que los datos correspondan al paciente a transfundir.

EQUIPO:

- **Enfermero Operador:**
  - Barbijo
  - Antiparras
  - Gorro
  - Camisolín
  - Guantes estériles
- **Operador auxiliar**
  - Barbijo
  - Antiparras
  - Camisolín
  - Guantes limpios o manoplas

PROCEDIMIENTO:

PRIMERA ETAPA.-

- Ingresar a la habitación del paciente correctamente vestidos con Barbijo, Camisolín, Gorra Botas y la bandeja conteniendo todo el material.-
- Explicar el procedimiento al pacientey/o al adulto a cargo.-
- Desinfectar la mesa del paciente, donde se va a realizar el procedimiento, con alcohol al 70% con el uso correcto de barrido y secado de los líquidos usados.
- Tanto el Enfermero operador como el Operador Auxiliar deberánefectuar una óptima higiene de manos con solución jabonosa antiséptica, según las normas infectológicas vigentes en la institución.
- Purgar los hemoderivados con la tubuladura, administrada por el servicio de Hemoterapia, en la habitación del paciente con técnica estéril.
- La administración de los hemoderivados se realizará por lumen de mayor calibre **(VIA DISTAL).**

- El enfermero operador deberá realizar la primera limpieza con soluciónantiséptica al bionector del lumen a utilizar y colocará los campos necesarios para dar inicio al procedimiento en si.-
- Abrir el Clamp.-(realizado por el operador auxiliar)

- Aspirar entre 2 ml de la solución fisiológica que permaneció en el lumen distal, para evitar tapón hemático. Lavar con Solución fisiológica previo a la conexión del hemoderivado.-
- Se procederá a la conexión delhemoderivado programando el goteo manual velocidad de infusión según indicación médica.

SEGUNDA ETAPA.-

- Luego de terminada la infusión ingresar a la habitación del paciente correctamente vestidos con Barbijo, Camisolín, Gorra Botas y la bandeja conteniendo todo el material necesario restante para heparinizar y sellar el lumen empleado(Según Normas)
- Explicar el procedimiento al pacientey/o al adulto a cargo.
- Desinfectar la mesa del paciente, donde se va a realizar el procedimiento, con alcohol al 70% con el uso correcto de barrido y secado de los líquidos usados.
- Tanto el Enfermero Operador como el Operador Auxiliar deberán efectuar una óptima higiene de manos con solución jabonosa antiséptica, según las normas infectológicas vigentes en la institución.-
- Se procederá al lavado del lumen utilizado con solución fisiológica,en forma de turbulencia, en niños con peso menor a 15kg se infundirá 10 ml y en niños con peso mayor a 15kg 20 ml de solución fisiológica, culminando así el sellado colocandobionector nuevo.
- Cerrar Clamp del catéter (acción realizada por operador auxiliar) en presión positiva a fin de evitar retornos sanguíneos del lumen utilizado.-
- Registro de: Complicaciones si las hubiera pre- intra y post transfusión, Volumen infundido, hora de comienzo y finalización de transfusión y consideraciones que desee destacar.**Colocar triple rotulo**

CAMBIO DE TUBULADURAS EN CATETERES VENOSOS CENTRALES

- **El reemplazo de la tubuladuras se realizara cada 72hs.-**
- **El reemplazo de tubuladuras de NPT cada 24hs.**
- El sistema de purgado de las tubuladuras se hará en la habitación del paciente con técnica aséptica.

MATERIALES:

- Guantes estériles.
- Campo estéril con compresa fenestrada
- Gasas estériles.
- Jeringas de 10 ml.Aguja 25G.
- Solución Fisiológica ampollas
- Alcohol al 70%.
- Tubuladuras
- Solución a infundir.
- Bionector

EQUIPO:

- **Enfermero Operador:**
  - Barbijo
  - Antiparras
  - Gorro
  - Camisolín
  - Guantes estériles
- **Operador auxiliar**
  - Barbijo
  - Antiparras
  - Camisolín
  - Guantes limpios o manoplas

PROCEDIMIENTO:

- Ingresar a la habitación del paciente correctamente vestidos con Barbijo, Camisolín, Gorra Botas y la bandeja conteniendo todo el material.
- Explicar el procedimiento al pacientey/o al adulto a cargo.
- Desinfectar la mesa del paciente, donde se va a realizar el procedimiento, con alcohol al 70% con el uso correcto de técnica de barrido y secado de líquidos usados.
- Tanto el Enfermero Operador como en Operador auxiliar deberánefectuar una óptima higiene de manos solución jabonosa antiséptica, empleando la técnica según normas de infectológicas de la institución.-
- Colocar barbijo al pacientey al Operador Auxiliar.
- Realizar el purgado de la tubuladura, con la solución a infundir; con técnicaestéril y cubrir momentáneamente su extremo con gasa estéril, dejando la misma sobre el campo aséptico.-
- El Operador Auxiliar realizará la primera limpieza con solución antiséptica del lugar de la conexión de la tubuladura con el lumen Proximal y ofrecerá, sin tocar, el punto de conexión entre la boca del lumen distal y la tubuladura al Enfermero Operador para una segunda limpieza.
- El Enfermero Operador deberá realizar la segunda limpieza con soluciónantiséptica y colocará los campos estériles necesarios para dar inicio al procedimiento.
- Mediante el uso de Jeringas comprobara retorno sanguíneo de los dos lumen y se procederá al lavado en forma de turbulencia, con solución fisiológica, según peso, el lumen Distal que permanecerá cerrado, con cambio de bionector,y el lavado con solución fisiológica del lumen Proximal,que permanecerá con una infusión continua. (Leer permeabilidad de catéter venoso central)
- Rotular e identificar tubuladuras con fecha turno, nombrando el lumen al que pertenece.
- Programar la bomba de infusión; por donde se administrara la solución(lumen Proximal)
- Registrar en la hoja respectiva.

PERMEABILIDAD DEL CATETER VENOSO CENTRAL-

Para mantener la permeabilidad del catéter y evitar que se obstruya se procederá a realizar lavado, en forma de turbulencia, con 10 ml de solución fisiológica, en niños con peso menor a 15 kg y 20 ml en niños con peso mayor a 15 kg.- Cerrando el Clamp utilizado en presión positiva para evitar retornos sanguíneos.- Cada vez que se Utilice.

SOLUCION HEPARINIZADA EMPLEADA EN PACIENTES PEDIATRICOS CON CATETERES VENOSOS CENTRALES.-

En pacientes pediátricos, para la heparinizacion de catéteres venosos centrales, se utilizara 100UI/ ml de SOLUCION HEPARINIZADA y se administraran 2 ml. por cada rama de catéter**.-**

FORMA DE DILUCION:

- Sacar 0,1 ml. de heparina de un frasco estéril de 5000 U.
- Se lleva a 5 ml. con solución fisiológica. De esta forma obtendremos una concentración de 100 U/I ml.
- Se administran 2 ml.En cada Rama del Cateter.
- Realizar el proceso de dilución con técnica aséptica.
- Dejar sobre campo estéril dicha dilución hasta ser utilizada.
- Clampear mientras sé está ejerciendo presión positiva.
- Registrar el procedimiento.Colocar triple rotulo.Respetar normas infectologicas
- **En casos específicos que se realice una concentración diferente de heparina Registrar en Hoja DeEnfermeria y/o SeguimientoInfectológico: fecha, hora, nombre del enfermero operador y aspectos presentados en el procedimiento, que deseen destacar.**

REALIZADO POR:

Lic. Franco, Silvina, Jefe Sección TMO

BIBLIOGRAFIA:

- Clinical Infectiousdiseases 2007; 44827-9 By Infectious Diseases Society Of America, All Rightist Reserved.EditorialCommenttary: Cid
- Dra. Gentileangela-Licbeltran, Elizabeth-Lic Cabrera, Mariela .Normas Practicas Para El Control De Infecciones 2017,Hnrg –Servicio De Epidemiologia
- Verri Espinosa, Alejandra.Manual De Procedimientos De Enfermería Del Niño Y Del Adolescente, Escuela De Enfermería Sede Chillan,2012.

COLOCACION DE SONDA NASOGÁSTRICO Y/O OROGÁSTRICO

DEFINICIÓN

Es la introducción de un tubo flexible (silicona, poliuretano) en el estómago del paciente a través de las fosas nasales (Sonda nasogástrica) o a través de la boca (Sonda orogástrica**).**

OBJETIVO

- Administración de alimentación enteral.
- Administración de medicación.
- Realizar lavados gástricos.
- Aspirar el contenido gástrico para:
  - Prevenir broncoaspiración en pacientes intubados o con disminución del nivel de conciencia.
  - Descomprimir o retirar el aire o líquido del estómago.
  - Prevenir un fallo en la sutura en pacientes sometidos a resección gástrica.
  - Controlar la evolución de HDA(hemorragia digestiva alta).
  - Análisis de contenido gástrico en el laboratorio.

CONTRAINDICACIONES Y CONSIDERACIONES

- En caso de fractura de base de cráneo, rotura de huesos de la cara y taponamiento nasal, está contraindicada la inserción de la sonda por la nariz. En estos casos se utilizará la víaorogástrica.
- En niños sometidos a cirugía esofágica o gástrica.
- Si el paciente presenta alguna alteración nasal como tabique desviado, que impide introducir la sonda por esta vía, ponedla por la boca tras retirada de prótesis dental y/o piercing.

LEGISLACION VIGENTE

Ley24004- Enfermería. Normas para su ejercicio de la.Art.3 Inciso18

PERSONAS HABILITADAS

Lic.en Enfermería
Enfermería Profesional

EQUIPO Y MATERIAL

1. **RECURSOS MATERIALES**
   - Sonda nasogástrica.
   - En su elección consideraremos:
     - diámetro externo o calibre
     - longitud
   - Guantes limpios
   - Gasas
   - Lubricante hidrosoluble
   - Linterna
   - Bajalengua
   - Jeringa de alimentación
   - Estetocopio
   - Cinta adhesiva o apósito transparente, etc.material para fijación para sonda

- Bolsa de drenaje
- Aspirador
- Vaso con agua

PROCEDIMIENTO

PREPARACIÓN DEL ENFERMO

Si el niño está consciente y con capacidad de comprensión, explicaremos el procedimiento, se informara también a su acompañante. En caso de neonatos o lactantes, informar del a los padres. Es un procedimiento molesto, difícil de realizar sin la colaboración del niño su familia y /u otro operador.Puede producir ansiedad en los padres si no conocen el procedimiento.
Inspeccionar la cavidad nasal y oral del niño.
Si el niño está consciente pedirle que se relaje y respire con normalidad mientras se tapa un orificio nasal; repetir con el otro orificio. Escoger aquel por donde pase un mayor flujo de aire.
Si está inconsciente, explorar con una linterna las narinas en busca de irritaciones, obstrucción y/o deformidad (ej. Desviación del tabique nasal)
La sonda pasará con mayor facilidad por el orificio nasal más permeable.
Palpar el abdomen del niño.Conocer el grado de distensión abdominal previo, para ir valorando la evolución.
En caso de existencia de prótesis dental o piercing, retirada de éstos.Evitar desplazamientos durante la inserción de la SNG.
Colocaremos al paciente en posición de Fowler elevado con almohadas detrás de cabeza y hombros. Se solicitara colaboración,para mantener la posición. Pero en caso de intoxicación lo pondremos en decúbito lateral izquierdo en trendelemburg.
Se facilita la capacidad de tragar y la fuerza de la gravedad ayuda a pasar la sonda.
En las intoxicaciones, la posición indicada evita que el tóxico pase al duodeno.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Elegir el diámetro de la sonda adecuado al paciente.Viene medido en French.1 french/ 0.33 mm.
Lavado de manos y colocación de guantes.Reduce la transmisión de microorganismos.
Determinar la longitud de sonda que hay que introducir. Para ello hay dos métodos:

- Distancia entre la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y de ahí a la apófisis xifoides en caso de SNG. Si fuese orogástrica, sería la distancia entre la comisura bucal y la apófisis xifoides pasando por el lóbulo de la oreja.
- Método Hanson: marcar primero un punto a 50 cm de la sonda; luego se realiza el método tradicional. Se debe introducir la sonda hasta el punto medio entre 50 cm y la marca tradicional
- La longitud es distinta para cada niño.
- Marcar la longitud obtenida con una cinta o marcador.
- Evitar errores de medidas.
- Preparar el tipo de Fijación de la sonda. Si es con cinta, dividirlo longitudinalmente hasta la mitad.Evitar retirada accidental.
- Enrollar la parte final de la sonda alrededor de la mano.Para disminuir la rigidez del tubo.

Si se desea conseguir mayor flexibilidad se puede introducir la sonda en agua templada. Si lo que se quiere es una mayor rigidez se introducirá en agua fría o con hielo.Lubricar la sonda con lubricante hidrosoluble. Preparar la jeringa y el estetoscopio.

DESARROLLO DE LA TÉCNICA

- Colocarse en el lado derecho si es diestro o en el izquierdo si es zurdo. Facilita la manipulación de la sonda.
- Introducir la sonda por el orificio elegido.
- Si el niño colabora, pedirle que hiperextienda el cuello para introducir suavemente la sonda por el suelo del orificio nasal hacia abajo y hacia la oreja de ese lado.
- Disminuye el malestar que produce el roce de la sonda contra los cornetes.
- Se notará una pequeña resistencia.
- Aplicar una ligera presión hacia abajo para hacer avanzar la sonda; si no avanza rotar la SNG y si aún así persiste la resistencia, no forzar y retirar la sonda.
- Si se fuerza la introducción, se puede lesionar las mucosas nasales.
- Flexionar la cabeza del paciente hacia el pecho y dejar que el paciente se relaje un momento.
- Se facilita el paso hacia la faringe posterior pues cierra la glotis, reduciendo la posibilidad de que la sonda penetre en tráquea.
- Estimular al paciente para que trague, dándole pequeños sorbos de agua si no está contraindicado.
- Si lo está, pedirle que trague saliva. Ir avanzando la sonda a medida que el paciente traga.
- Al tragar se facilita el avance de la sonda.
- Si aparece tos, disnea o cianosis; retirar la sonda. Accidentalmente se habrá introducido en la tráquea.
- Si se presentan nauseas repetida y la SNG no avanza con la deglución, inspeccionar la garganta con el depresor y la linterna.
- La sonda puede estar en la garganta y estimular el reflejo nauseoso.

COMPROBAR LA COLOCACIÓN DE LA SONDA

- Si el paciente está consciente pedirle que hable.
- Si la sonda ha pasado por las cuerdas vocales, el paciente no podrá hablar.
- Aspirar el contenido gástrico, valorando el color.
- El color suele ser verde turbio. También puede ser blanquecino o de color marrón.
- Medir el PH del líquido aspirado.
- PH del contenido gástrico es de 4 o inferior
- PH de secreciones intestinales es de 7.5 a 8
- PH del líquido pulmonar está entorno a 7.6.
- Insuflar aire por la sonda, colocando el estetocopio en epigastrio.
- La cantidad de aire insuflado variará con la edad del niño.
- Se oirá un ruido sibilante o gorgoteante. Si no es así podrá estar en esófago, tráquea o bronquio. No se considera un método fiable de comprobación.
- Colocar el extremo de la SNG en un vaso de agua.Si hay burbujas es que está colocada en el árbol bronquial.

- Comprobación radiológica, de ser necesario
- Limpiar y secar la nariz del paciente, Para que la fijación no se afloje.
- Fijar la sonda con cinta adhesiva o apósito transparente según disponibilidad, dependiendo de la edad del niño y de la zona de introducción de la misma.
- Si el niño presenta lesiones en la piel o quemaduras, sujetar la sonda utilizando una cinta o venda.
- Si el paciente está agitado, fijar también la sonda detrás de la oreja.
- La sonda se puede fijar al tubo endotraqueal.
- No debe fijarse en la frente, pues puede producir úlcera por presión sobre la nariz.
- Mantener al niño con el tórax elevado de 30 a 45º. Prevenir la neumonía por aspiración.
- Conectar el extremo de la sonda abierta a bolsa colectora, conectada a nutrición o pinzarla.
- Quitarse los guantes y lavarse las manos.

REGISTRO DE ENFERMERÍA

En este registro se debe anotar el tipo de sonda, el nº de sonda, la marca y las posibles complicaciones surgidas durante la técnica.

COMPLICACIONES

- Erosión de la mucosa nasal-epistaxis.
- Erosión de la mucosa gástrica: hemorragia gástrica.
- Neumonía por aspiración.
- Hiperventilación por aumento de la ansiedad en pacientes conscientes.
- Bradicardia por estimulación de los reflejos vagales.
- Hipopotasemia o alcalosis metabólica por pérdida de electrolitos si el drenado gástrico es muy abundante.
- Obstrucción de la sonda.
- Erosión esofágica.
- Esofagitis por reflujo.
- Ulceras por presión.
- Nauseas en exceso.

RETIRAR LA SONDA

DEFINICIÓN

Extracción de sonda naso-orogástrica, bien porque se ha obstruido o porque no sea necesaria**.**

EQUIPO Y MATERIAL

Recursos Humanos

- Lic En Enferemeria
- Enfermera

Recursos Materiales

- Toalla
- Gasas no estériles
- Guantes no estériles
- Pinzas o tapón de sonda

PROCEDIMIENTO

- Explicar el procedimiento al paciente.
- Lavarse las manos y ponerse guantes no estériles.
- Colocar al paciente en posición de semi-Fowler.Evitar la aspiración de contenido gástrico.
- Situarse al lado derecho del enfermo si se es diestro o al lado izquierdo si se es zurdo. Permite un manejo más fácil de la sonda.
- Desconectar la sonda. Pinzar la sonda.Evitar que el contenido gástrico que quede en la sonda, drene al retirarla y entre en la vía respiratoria.
- Retirar la fijación de la sonda.
- Si el enfermo está consciente pedirle que inspire profundamente y extraer la sonda con suavidad y rapidez durante la espiración del paciente. Si el enfermo está intubado, asegurarse de la correcta presión antes de retirarla.
- Efectuar la higiene de las fosas nasales y de la boca.
- Quitarse los guantes y lavarse las manos.

Registrar el procedimiento y si existieron complicaciones durante su realización. Colocar rotulo a la SNG según normas infectologicas

COMPLICACIONES

- Bronco aspiración de líquido contenido en la sonda si está mal pinzada.
- Distensión abdominal y/o vómitos si no se ha reanudado el tránsito intestinal.

MEDIDA DE SONDAS GÁSTRICAS

EDAD	CALIBRE
Neonatos y lactantes (hasta 18 meses)	**5-8 French**
18 meses -7 años	**8-10 French**
7 años -10 años	**10-14 French**
11 años - 14 años	**12-16 French**

Dependiendo de la edad del niño, usaremos un calibre que oscile entre los 5-12 French, teniendo la precaución de utilizar la más pequeña posible.

RECAMBIO DE SNG

Se recomienda cambiar SNG, según normas Infectologicas
Poliuretano-7 días
Siliconada-30 días

REALIZADO POR:

Lic. Rearte Juana, Jefa Sección U 5
Colaboracion :
Dra. Pascual Carolina,Jefamedica a cargo U5

BIBLIOGRAFIA

- Abad-Sinden A, Sutphen J. Enteral Nutrition. En, WA Walker Et Al. (Eds), Pediatric Gastrointestinal Disease, 4ª Ed. Ontario: BC Decker Inc. Hamilton, 2004. P. 1981-1994.
- Manual De Norma De Procedimientos-HNRG-CABA 2015

COLOCACION DE SONDA VESICAL
DEFINICION
Tecnica Invasiva Consiste en la introducción deun catéter o una sonda a través de la uretra hasta en la vejiga.
Este puede ser:**Temporal**,**Permanente**.**Intermitente**
OBJETIVO

- Acceder a la vegija con fines de diagnosticoy/o terapeuticos
- Obtener una muestra estéril de orina.
- Facilitar la evacuación de la orina.
- Controlar el flujo de orina.
- Irrigar la vejiga.
- Introducir medicamentos.
- Determinar la cantidad de orina residual.
- Prevenir la tensión en la pelvis o heridas abdominales por la vejiga distendida.
- Controlar los microorganismos en la piel para prevenir la infección.
- Reducir al mínimo el traumatismo de las vías urinarias.

LEGISLACION VIGENTE
Ley24004- Enfermería .Normas para su ejercicio de la.Art.3 Inciso18
PERSONAS HABILITADAS
Lic.en Enfermería
Enfermería Profesional
MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE UN SONDAJE VESICAL
Preparación del paciente

- Explique el procedimiento al enfermo y solicite tanta cooperación como sea posible.
- Protéjalo de mampara y sábanas para favorecer la intimidad del paciente.
- Si el cateterismo tiene por objeto determinar la cantidad de orina residual, pida al paciente que orine antes de insertar la sonda.
- Si el objeto es obtener una muestra estéril, asegúrese que el paciente no haya orinado durante 30 minutos antes del procedimiento.
- Revisar todo el equipo antes de acercarse al paciente.

Equipo

- Bandeja de cateterismo
- Guantes estériles. Guantes no estériles
- Camisolin
- Barbijo quirurgico
- Solucion antiséptica
- Solución antiséptica jabonosa/ agua tibia
- Compresas Fenestrada y lisa, estéril.
- Lubricante urológico (xilocaina al 2%)
- Agua destilada
- Jeringa de 5 ml-10 ml.Aguja 21G
- Recipiente estéril para muestra de laboratorio
- Sonda apropiada.(calibre y tipo)
- Sistema de drenaje adecuado.

- Material para fijar la sonda según disponibilidad.
- Cinta adhesiva o aposito trasparente
- Tijera
- Descartador
- Biombo

PROCEDIMIENTO

Se necesitan dos operadores: 1- EPP esteril , 2 –EPP limpios

Se realizará con un enfermero operador que llevará barbijo quirúrgico, camisolín, guantes estériles, y un asistente que llevará barbijo quirúrgico, camisolín y guantes limpios o manoplas.

- ❖ Coloque a la niña en decúbito supino, con las rodillas flexionadas y separadas en posición ginecológica.
- ❖ Coloque al varón o niño en posición decúbito supino, con las extremidades ligeramente separadas.
- ❖ Lavarse las manos antes del procedimiento (según normas de Infectología HNRG 2017 coloque los guantes)
- ❖ Realizar higiene de genitales, con guantes no estériles, con solución jabonosa antiséptica.
- ❖ Establezca un campo estéril con guantes estériles sobre el carro a preparar el material para el cateterismo.
- ❖ Vaciar la solución antiséptica de pervinox o clorhexidina en campo estéril.
- ❖ Jeringa cargada con agua destilada según cantidad indicada.
- ❖ Sonda Foley si se va a insertar sonda permanente.
- ❖ Pruebe el balón de la sonda con aire para corroborar su buen estado.
- ❖ Jeringa con lidocaína al 2% jalea de 10cc.
- ❖ Frasco estéril.
- ❖ Aplique lubricante estéril en el extremo distal de la sonda.
- ❖ Lavado de manos.
- ❖ Delimite la zona genital con campo fenestrado y a continuación de esta disponga el campo liso.

Mujeres – niñas:

Colocar guantes estériles. Separe la vulva con el pulgar e índice, entre los labios menores, hasta visualizar el meato urinario. Limpiar con solución antiséptica (pervinox o clorhexidina) partiendo del clítoris hasta la vagina, usando un solo movimiento descendente.

Varones – niños:

Elevar el pene. Retirar el prepucio. Limpiar el glande con solución antiséptica desde el medio en círculo hasta la base peneana, proteger el pene con gasa.

Procedimiento para introducir la sonda

La mano contaminada no puede introducirse de nuevo en el campo estéril. Usando la mano estéril agarre la sonda.

Mujer – niña:

Se separan los labios vaginales. Inserte lentamente el catéter en el meato que se encuentra en entre el introito vaginal y el clítoris (en ocasiones está en el pliegue del introito y se cambia de sonda si se introduce en la vagina) unos 5 a 7 cm hasta que comience a fluir orina, luego se continua introduciendo,hasta la bifurcación de la sonda , alentarlo a respirar profundamente a medida que se inserta, y si es muy pequeña, esperar o distraerla para que deje de llorar) y se insufla el balón con agua destilada.

Varón – niño:

Levante el pene perpendicular al cuerpo a 90°, retraiga el prepucio, traccionar hacia arriba, introduzca en el meato lidocaína jalea con jeringa aproximadamente 5cc. Luego inserte lentamente el catéter vesical con técnica perpendicular al cuerpo. Gire la sonda para vencer la

resistencia a nivel del esfínter. La respiración profunda ayuda a relajar el esfínter vesical. Si el niño llora, tranquilizarlo. Si es grande, pedirle que tosa y al mismo tiempo intentar introducir y observar que fluya orina (no forzar el pasaje porque podría lesionar la uretra. Ante sangrado o manifestación de dolor, solicite asistencia del médico).

Se introduce hasta la bifurcación de la sonda Foley, se insufla el balón con agua destilada recomendada por los fabricantes registrados en la conexión para insuflar el balón. No utilizar solución fisiológica porque se cristaliza.

Se recomienda recolectar, en frasco estéril, muestra para urocultivo, por ser un paciente con riesgo a adquirir una ITU (más del 90% de las ITU están asociadas a cateterismo vesical)

Realizar tracción tanto en hombre como mujer, hasta notar pequeña resistencia con el propósito de comprobar que el globo esté bien insuflado.

Conectar el catéter al sistema de drenaje cerrado.

Fijación

Mujer – niña:

Fijarlo con cinta hipoalergénica o apósito transparente a la cara anterior del muslo de manera que quede laxo entre el sitio de inserción y el sitio de fijación, protegiendo previamente con gasa la piel del material de la sonda (nunca girar por debajo de la pierna).

Varón – niño:

Luego que reposicione el prepucio a su lugar para evitar edema y/o parafimosis, fijar la sonda y tener en cuenta siempre que el pene debe estar reclinado hacia el pubis fijándolo con cinta hipoalergénica o apósito transparente sobre la zona del pubis (pared del hipogastrio), es para evitar que la uretra reaccione por problemas de roce del tejido uretral con la sonda pudiendo producir hipospadias iatrogénica por decúbito de la sonda (en varones no va fijado sobre el muslo). Cuidar la curvatura que no quede tenso.

Conexión

Conecte el extremo de la sonda a la bolsa colectora de orina que estará rotulada. Asegure la ubicación de la bolsa bajo el nivel de la vejiga en su suporte por debajo de la baranda de la cama, para evitar reflujo de la orina. Controlar que se doble el sistema en ninguno de los trayectos. La tubuladura de drenaje no debe caer por debajo de la bolsa colectora y mantener el sistema cerrado, evitando el contacto de la bolsa con el piso para reducir el riesgo de contaminación intraluminal por microorganismos.

Recambio de la bolsa cada 7 días o cuando se rompe o se observa acumulación de sedimentos en la misma.

Retire los guantes, lavado de manos, con manoplas acondicionar al paciente.

Recomendaciones

El no cumplimiento al 100% de la técnica de colocación de S.V. pone en riesgo la seguridad y la salud del paciente.

Vigilancia para la prevención de infecciones de vías urinarias. Seguir normas infectológicas de la institución.

Informar a todos los miembros del personal de salud que tienen relación con la atención brindada, incluyendo el personal camillero y servicio de limpieza, acerca de su interacción y cuidado de paciente portador de S.V.

Observación escrita

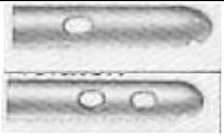
Rotular sonda y bolsa colectora.

Registre fecha, hora de procedimiento, (tipo de sonda, calibre, volumen de agua destilada introducido en el balón de la sonda, características y volumen del líquido drenado, hora de toma de muestra de urocultivo, reacción del paciente)

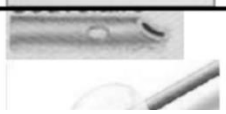
Según el calibre:
Los calibres deben seleccionarse según el sexo, la edad y características del paciente:

EDAD	INTRODUCCION	FRENCH	LONGITUD
RN y LACTANTE	2,5 cm.	5 a 8	10 cm.
	2,5 cm.	14 -18	10 cm.
2 A 7 AÑOS	5 cm.	8a 10	10 cm.
7 A 10 AÑOS	7,5 cm.	10 - 14	20 cm.
> 11 AÑOS	10 cm.	14 - 18	20 cm.

Según el tiempo de permanencia del sondaje:
El sondaje intermitente es el principal tratamiento de la incontinencia causada por daño medular o daño de los nervios que controlan la micción, y que producen incontinencia con mal vaciado de la vejiga. La frecuencia del sondaje dependerá del volumen de orina diario y de la capacidad de la vejiga (3-4 sondajes diarios) y se realiza por el propio paciente o sus cuidadores (autosondaje) Con previa capacitación de enfermería.

Intermitentes (sin balón y 1 vía)				
Sondas	**Imagen**	**Características**	**Indicaciones**	**Material**
NÉLATON (2 ó 4 ojos)		Son rectas, semirrígidas y de una sola vía, sin sistema de fijación.	Para vaciar la vejiga y/o recogida de muestras.	PVC.
COUVELAIRE				

Sondaje permanente, en el que la sonda es mantenida en su lugar por un balón que se hincha con aire o agua al colocarla. Está indicado en casos de intervención quirúrgica, para controlar la diuresis, o cuando es necesario mantener una vía de drenaje o de lavado continúo de la vejiga.
Una Sondapermanente de latex, debe cambiarse cada 7 días, las sondas de silicona 21 días (Respetar normas de Infectologia**)**

Temporales o permanentes (1 balón con 2 ó 3 vías)				
Sondas	**Imagen**	**Características**	**Indicaciones**	**Material**
FOLEY		Son rectas, de dos o tres vías. En ambos casos incluyen un balón de fijación (2ª vía). La tercera vía se utiliza para irrigar la vejiga de forma continua.	Las de dos vías para vaciado vesical y sondajes permanentes sin sospecha de patología urinaria. Las de tres vías se usan en caso de hematuria.	Látex. PVC. Silicona. Silicona estriada.
TIEMANN		Son curvas, con punta olivada y puntiaguda.	En pacientes prostáticos o de vaciado dificultoso.	Silicona. Goma rígida. Poliuretano.
COUVELAIRE		Punta biselada o en pico de flauta.	En pacientes con hematuria o para	PVC. Látex. Silicona.

Extracción de Sonda Vesical

Para extraer una sonda permanente,pinzar la sonda para no derramar orina durante la extracción.
Desinfle el balon extrayendo el agua estéril mediante una jeringa.
Saque con suavidad la sonda de la uretra, deséchelo tan pronto como sea posible.
Limpie el meato si es necesario.
En caso de que la sonda no salga con facilidad después de desinflar balón,avisar al medico para que realice el procedimiento. Evite lesionar al paciente

REALIZADO POR:

Lic. Alfonso Liliana , Jefa se sección Urologia
Colaboracion:
Dra Herrera Marcela,Subjefa Medica Seccion de Urologia.

BIBLIOGRAFIA

- Manual de Normas y Procedimiento-HNRG-CABA-2017
- Albert Mallafré C, Molina Pacheco F, Rumí Belmonte L. Tratado de enfermería en cuidados críticos pediátricos y neonatales, Sección 9: Procedimientos nefro-urológicos, Cap. 141. Sondaje vesical. http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion9/capitulo141/capitulo141.htm Consulta Septiembre 2009
- Normas practicas de control de infecciones –Seccion Epidemiologia-HNRG-2017
- Protocolo CODEINEP.ORG.AR-Infeccion del tracto urinario.
- Hospital italiano.org.ar-Cuidados y mantenimientos de sonda vesical.Revision 2013.

CONTROL SIGNOS VITALES
DEFINICION:
Los Signos Vitales son las mediciones de las funciones más básicas del cuerpo.
Los cuatro signos vitales principales son:
Frecuencia Cardiaca, Temperatura, Frecuencia Respiratoria y Tensión Arterial.
OBJETIVO:
Detectar rápidamente cualquier anomalía en el estado del paciente.
LEGISLACION VIGENTE:
La Ley Nº 24.004 - Normas Para el Ejercicio De La Enfermería- Articulo 3.Cap. III ART. 18.
PERSONAS HABILITADAS
Lic. En Enfermería
Enfermeros Profesionales
Auxiliares de Enfermería
CONTROL DE FRECUENCIA CARDIACA (FC) O PULSO APICAL
Definicion
La Frecuencia Cardiaca es el número de contracciones del corazón. Se mide en condiciones bien determinadas (de reposo o de actividad) y se expresa en pulsaciones por minuto a nivel de las arterias periféricas y en latidos por minuto (lat/min) a nivel del corazón.
Objetivo:
Conocer las características y variaciones del pulso del paciente.
Procedimiento
- Lavado de manos antes y después del procedimiento.
- Colocar el Estetoscopio sobre el lado izquierdo del Tórax a nivel de la tetilla.
- Controlar los latidos en u minuto.
- Informar sobre la Frecuencia, Ritmo, Intensidad y Amplitud del mismo.
- Limpiar el estetoscopio entre paciente y paciente.
- En pacientes con Dextrocardia colocar el estetoscopio del lado derecho del Torax.
- Registrar, En Hoja De Enfermería.

Recomendaciones
•Frecuencia: cantidad de pulsaciones controladas en un minuto.
•Ritmo: pulso rítmico es aquel donde las pulsaciones están separadas entre si por espacios iguales.
•Amplitud: pone en evidencia la altura de la onda pulsátil.
•Tensión o Dureza: depende de la presión y elasticidad arterial, se mide por la fuerza que debe efectuarse para interrumpir las ´pulsaciones.
Terminología
Taquicardia: aceleración del ritmo cardiaco.
Bradicardia: descenso de la frecuencia cardiaca.
Pulso Filiforme: cuando el pulso es débil.
Arritmia: falta de ritmo en el pulso.
CONTROL DE FRECUENCIA RESPIRATORIA
Definicion:
La Frecuencia Respiratoria es el número de reparaciones que efectúa un ser vivo en un lapso especifico (suele expresarse en respiraciones por minuto).
Movimiento rítmico entre inspiración y espiración, está regulado por el Sistema Nervioso.
Objetivo:
- Observar el esfuerzo muscular y el empleo de músculos accesorios de la respiración.Conocer los cambios en la respiración del paciente.
- Frecuencia Respiratoria Normal por edad.
- Recién Nacidos: alrededor de 44 respiraciones por minuto.

- Niños (de 1 a 6 años): 18 a 30 respiraciones por minuto.
- Pre-adolescentes (10-15 años): 20 a 30 respiraciones por minuto.
- Adolescentes (16-20 años): 18-26 respiraciones por minuto.

Procedimiento

- Lavado de manos antes y después del procedimiento.
- Explicar el procedimiento al paciente.
- Controlar el número de respiraciones en un minuto.
- Valorar profundidad, esfuerzo y ritmo de las respiraciones.
- Observar uso de músculos accesorios, tiraje costal y sub-costal, aleteo nasal.
- Dejar registrado en qué condiciones se toma la frecuencia respiratoria (por ejemplo si llora).
- Coloración del paciente (cianosis).
- Registrar.

Terminología

Respiración: Proceso vital en el cual, los seres vivos absorben el oxigeno y eliminan dióxido de carbono.

Ventilacion:es el intercambio gaseoso entre el organismo y el medio ambiente, puesto en evidencia por el ascenso y descenso de las paredes abdominales y torácicas.

Tiene dos ciclos: Inspiración (entrada de aire a los alveolos pulmonares) y Espiración (Salida de aire inspirado).

Disnea: dificultad para respirar**.**

Taquipnea: aumento de la Frecuencia Respiratoria, por encima de los valores normales.

Bradipnea: disminución de la Frecuencia Respiratoria, por debajo de los valores normales.

Apnea: interrupción transitoria de la respiración**.**

CONTROL DE TEMPERATURA AXILAR

Definicion

Determinación del grado de calor del organismo a través de la utilización de un termómetroclínico o control de una incubadora.

Objetivo:

Medir el grado de calor corporal para corroborar posibles signos de infección.

Procedimientos

- Lavado de manos antes y después del procedimiento.
- Explicar el procedimiento al paciente.
- Secar axila.
- Limpiar con torunda de algodón con alcohol antes y después del procedimiento.
- Colocar el termómetro en hueco axilar entre 1 a 3 minutos.
- Utilizar termómetros individual (pacientes Neutropenicos, infecto-contagiosos, recién nacidos, lesiones de la piel).
- Registrar, el procedimiento.

Temperatura Axilar

Normal: 36|°C A 37 ° C.
Alta: 38.8 ° C A 40°C
Muy Alta: 40°C O Más.
Moderada:37,2°C A 37.8°C.
Subnormal:35,5°C A 36.5°C.
Colapso: Menor A 35°C.

Terminología

Fiebre: cuando la temperatura axilar se encuentra entre 37,7°C Y 40°C.

Febrícula:cuando la temperatura axilar se encuentra entre 37,3°C Y 38°C.

Hiperpirexia: cuando la temperatura axilar es igual o mayor a 41°C**.**

Hipotermia: es el descenso involuntario de la temperatura corporal por debajo de los 35°C.

CONTROL DE LA PRESION ARTERIAL (TA)

Definicion

La Presión Arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, que es cuando su presión es más alta. A esto se le llama Presión Sistólica. Cuando el corazón está en reposo entre un latido y otro, la presión sanguínea disminuye, a esto se le llama presión Diastólica**.**

Objetivo:

Obtener las variantes, registrarlas y poder así evaluar el curso de la enfermedad del paciente**.**

Procedimiento

- Lavado de manos antes y después del procedimiento.
- Informar al paciente lo que se le realizara.
- Verificar el correcto funcionamiento del Tensiómetro.
- Emplear el manguito acorde a la edad del paciente. (debe cubrir 3/4 parte de la zona donde se va a controlar , MS o MI) La cámara debe cubrir el 80% del perímetro.
- Recién nacido: 3a5 cm de ancho
- Lactante y 2ª Infancia: 6 cm de ancho.
- Niño > de 7-8 años: 12cm de ancho
- Adolescente: 13 a 15 cm.

- El manguito debe tomar las 3/4 partes del brazo.
- Si surgen dudas utilizar el mango más ancho a fin de evitar registros falsos de Hipertensión.
- Colocar al paciente en una posición comoda y relajado.
- Evitar actividad física previa al control.
- El Brazo o el miembro a utilizar deben estar apoyados.
- Retirar prendas gruesas, evitar todo aquello que comprima.
- Dejar libre la fosa anticubital.
- El centro de la cámara debe coincidir con la arteria braquial.
- El manguito debe quedar a la altura del corazón.
- Insuflar 20mmhgPor encima de la TA Estimada
- Desinflar a ritmo de 2-3mmhg/segundo
- Registrar.

Terminología

Tensión Arterial: se llama a la presión ejercida por la sangre arterial sobre las paredes de la arteria.

MAXIMA (SISTOLICA) MINIMA (DIASTOLICA)

REALIZADO POR:

Lic. Godoy, Mirta; Jefe Sección U 7

BIBLIOGRAFIA

Verri Espinosa, Alejandra. Manual De Procedimientos De Enfermería Del Niño Y Del Adolescente, Escuela De Enfermería Sede Chillan,2012.

CUIDADO AL PACIENTE CON DRENAJE POR DERRAME PLEURAL

DIFINICION:
Es la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural; no es una enfermedad, es el resultado del desequilibrio entre la formación y la reabsorción del líquido como la manifestación de algunas condiciones que incluso puede amenazar la vida del paciente.
Muchas veces es necesario extraer el líquido mediante un drenaje pleural.

DRENAJE PLEURAL
El drenaje Pleural es uno de los procedimientos más frecuentes de la cirugía torácica: Indispensable para la mayoría de las cirugías del tórax y es el tratamiento de elección de una gran parte los neumotórax, distintos tipos de derrames pleurales y de muchos traumatismos torácicos.
Con el drenaje torácico se intenta la evacuación completa de las colecciones pleurales aéreas y/o líquidas y la re-expansión pulmonar. A diferencia de la toracocentesis (que consiste en la punción y evacuación de líquidos con una aguja), aquí se coloca un sistema permanente de drenaje.
El correcto control del drenaje por el personal Médico y de Enfermería, es fundamental para la eficacia del mismo y buena evolución del paciente.

OBJETIVOS:
- **Evacuar el líquido de la cavidad pleural.**
- **Ayudar a la expansión de los pulmones.**
- **Aumentar la eficacia de este procedimiento y de sus cuidados en nuestro medio.**
- **Conocer y manejar los dispositivos Utilizados para el drenaje**
- **Garantizar su correcto funcionamiento, prevenir y detectar las complicaciones que pueden aparecer con su uso.**

LEGISLACIÓN VIGENTE
Según la OMS esta resolución del año 2000/15.
Ley 24004.Normativas para el desempeño de la enfermeríaArt.3 Inciso 18

PERSONA HABILITADAS.
Lic. En Enfermería
Enfermeros/as Profesionales

¿QUE SE DEBE VIGILAR?
Se debe vigilar que el tubo de drenaje, que este bien fijado y oscilando.
Que el Frasco bitubulado, este rotulado: fecha, hora, marcar hasta donde se encuentra el agua.
La altura del frasco nunca debe ester por encima del nivel del paciente

INDICACION
Pacientes ingresados en cualquier Área o Servicio del que, por su patología, precisen un Drenaje Pleural.
- Postoperatorios De Cirugía Torácica
- Neumotórax
- Hemotórax
- Derrames Paraneumónicos Complicados Y Empiemas

PROCEDIMIENTO:
La colocacion del drenaje lo realizara el medico cirujano en quirófano.
Enfermeria se encargara de los cuidados posteriores a la colocación del drenaje.
Curacion de zona de inserción del drenaje
Recambio de Frasco de drenaje

MATERIAL
Para el recambio del Frasco de drenaje:
Frasco bitubulado
Agua destilada
Pinza Kocher
Guantes Material para la fijacion

CUIDADOS DE ENFERMERIA

- **Higiene de mano según normas infectologicas.**
- **Higiene diario y confort del paciente.**
- **Curacion de la zona de inserción.**
- **Control de signos vitales cada 6 hs o según la necesidad del paciente.**
- **Mantener al paciente en posición SemiFowler.**
- **Cambio postulares para facilitar el drenaje del líquido pleural.**
- **Verificar permeabilidad del tubo de drenaje.**
- **Control de balance de ingreso y egreso.**
- **Medir y registrar volumen y característica del líquido drenando.**
- **Observar y registrar la existencia del burbujeo que indica presencia de neumotórax o fistula broncopulmonar, en estos casos no pinzar bajo ningún concepto (salvo para el cambio de frasco).**
- **Observar signos y sintomas de infeccion en zona de insercion del tubo.(Enrojecimiento, hipertemia, Edema)**
- **Evaluar la presencia de dolor en el paciente.**
- **Administrar analgésicos y antibióticos según indicación médica.**
- **Clampear la tabuladora para evitar neumotórax.**
- **Peso diario. Acercar la balanza al lado de la cama del paciente, para controlar el peso corporal.**
- **Registrar todo el procedimiento realizados de las hojas de enfermería con fecha, hora, firma y sello del profesional interviniente.**
- **Explicar al paciente y/o familia el procedimiento que se le va a realizar.**

REALIZADO POR:
Lic.: Berta Soriano: Jefe de la U3.

BIBLIOGRAFIA:
Manual, Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Año 2016
Sección: Neumonología Clínica; Pág., 28 y 29.
Manual de normas y procedimientos –HNRG-2017

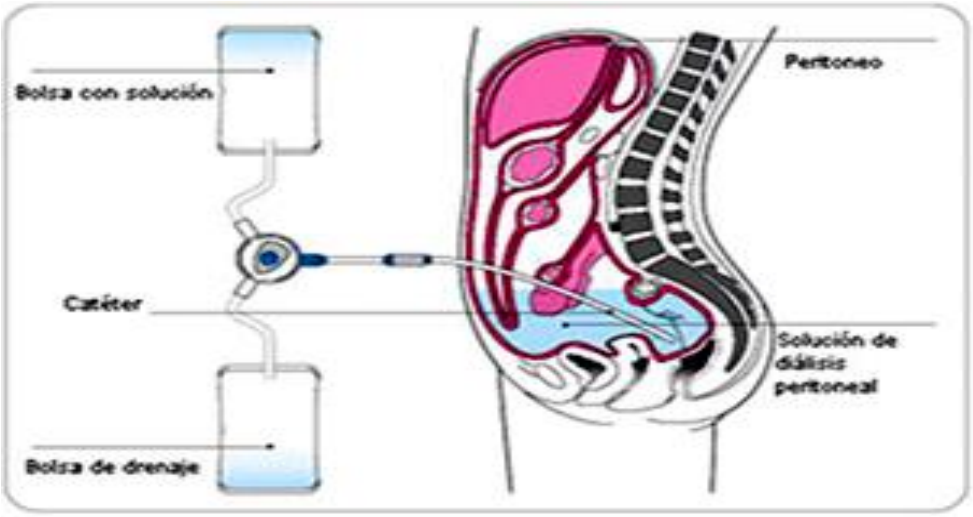
CUIDADOS AL PACIENTE CON DIALISIS PERITONEAL.

DEFINICION

La diálisis peritoneal es un método de depuración sanguínea extra renal de solutos y toxinas. Está basada en la fisiología de la membrana peritoneal, la cual es muy vascularizada, semipermeable

Consiste en infundir en la cavidad peritoneal el líquido dializante, de composición similar al líquido extracelular, que dejándolo una cierta cantidad de tiempo en la cavidad peritoneal, siguiendo el gradiente osmótico, se producirá la difusión y osmosis de tóxicos y electrolitos desde la sangre al líquido introducido.

Los niños tienen una mayor superficie de membrana efectiva por kilo/peso que los adultos (es de 1-1,3 m).



OBJETIVOS

- Eliminar substancias tóxicas y desechos metabólicos del organismo.
- Eliminar el exceso de líquidos corporales.
- Ayudar a la regulación del equilibrio hidroelectrolítico.

LEGISLACION VIGENTE

Ley 24.004-Normativa para el ejercicio de la Enfermeria.

ARTICULO 3.- Es de competencia específica del nivel profesional lo establecido en las incumbencias de los títulos habilitantes de licenciado/a en Enfermería y Enfermero/a. A todos ellos les está permitido lo siguiente: Inciso 18)- Realizar todos los cuidados de enfermería encaminados a satisfacer las necesidades de las personas en las distintas etapas del ciclo vital, según lo siguiente:

M) Participar en los tratamientos quimioterápicos, en diálisis peritoneal y hemodiálisis.

PERSONAS HABILITADAS

- Licenciados en enfermería,Enfermero Profesional,capacitados para DPI.
- Técnicos en DP.
- Medicos especialista (Neforlogo)

INDICACIONES

La diálisis peritoneal intermitente, en pediatría puede utilizarse principalmente en situaciones de:

- Síndrome urémico hemolítico, con Insuficiencia Renal Aguda.
- Insuficiencia renal aguda con oligoanuria.
- Alteraciones hidroelectrolíticas y del PH sanguíneo producidas o no por una insuficiencia renal aguda.
- Intoxicaciones graves por tóxicos dializables a través del peritoneo.
- Cirugia Cardiovascular.

VALORACION Y/O CONTROLES DE ENFERMERÍA EN LAS COMPLICACIONES DE LA DPI AGUDA:

INFECCIOSAS:

PERITONITIS: es una complicación muy frecuente, la incidencia disminuye si se observan estrictas normas de asepsia durante la colocación del catéter y la realización de los intercambios. Generalmente se manifiesta por dolor abdominal, fiebre, vómitos, y la presencia de líquido peritoneal turbio.

El diagnostico se realiza por el hallazgo de más de 100 células/mm en el líquido drenado de la cavidad peritoneal, los neutrófilos predominan en más del 80%. El tratamiento se realiza con ATB intraperitoneal.

RESPIRATORIAS:

- Atelectasias basales.
- Derrame pleural (hidrotórax): debido a un defecto en la pared diafragmática o en linfáticos diafragmáticos, más frecuentemente se produce del lado derecho. Mejora al disminuir la presión intraabdominal: al reducir el intercambio o realizarlos en posición supina.

METABÓLICAS:

- Hiperglucemias.
- Hipernatremia.
- Hipocalcemia.
- Pérdidas proteicas.

MECÁNICAS:

La mayoría se relaciona con la colocación del catéter de DPI. Mencionadas anteriormente.

- Hernias inguinales y umbilicales:

Pueden ponerse de manifiesto por aumento de la presión intraabdominal, especialmente en varones. En general, no es necesario interrumpir la DP, pueden mejorar disminuyendo el volumen infundido y deben corregirse en forma electiva cuando mejore la condición clínica del paciente.

OBSTRUCCIÓN:

La obstrucción del catéter puede deberse a varias causas:

* Coágulos de fibrina: se previene con heparina 250-500 U/L de solución de diálisis,(siempre con indicación del médico).

- Estreñimiento: A veces el intestino se mueve menos por distintos motivos y los fecalomas desplazan o distorsionan los catéteres intraperitoneales dificultando su buen funcionamiento.
- La mayoría de las veces, este problema se soluciona con laxantes y enemas.
- Atrapamiento por el epiplón: que impide el drenaje del catéter y, generalmente, lo desplaza.
- A veces impide incluso la infusión del líquido dializante. Los acodamientos se resolverán con la recolocación de la cánula.
- Migración del catéter: La fuga del líquido peritoneal se manifiesta por caída de la ultrafiltración y aparecerá edema en la pared abdominal El orificio del catéter húmedo, con líquido positivo para glucosa, también es de utilidad diagnostica.
- Acodamiento del catéter. El catéter peritoneal es un dispositivo siliconado flexible, que puede acodarse o doblarse con facilidad, la presencia del manguito disminuye este tipo de complicaciones.

MATERIALES NECESARIOS

- **Bolsa de líquido de diálisis indicado, calentar a temperatura corporal (37ª). Las bolsas de DP. Que se utiliza en el servicio son de Fressenius y contiene una bolsa con líquido dializante, una bolsa vacía para el drenado de líquido peritoneal, una tubuladura y espiga o llave de paso totalmente estéril.**
- Liquido para realizar la asepsia: Clorhexidina-alcoholica2% o Iodopovidona solución al 10%. Alcohol en gel, alcohol al 70% para limpieza de tubuladuras de conexión y desconexión de bolsas.
- Barbijos, cofias, camisolines estériles, campos estériles, guantes estériles, gasas estériles, cintas, Apósito transparente (tegaderm).
- Jeringas, agujas, heparina, CLK, ATB (si están indicados estos fármacos).
- Balanza.
- Recipiente limpio para colocar la bolsa de drenado (recipiente o material plástico y nunca cartones).
- Elementos para mantener la temperatura de la bolsa de líquido de diálisis, almohadilla térmica u otros.
- Todos los materiales y elementos en óptimas condiciones de higiene.
- Controlar la integridad de los materiales que mantienen la esterilidad de los elementos, en especial la bolsa de líquido de diálisis, que no tenga fugas liquidas antes de su apertura, si es así descartar y usar otra.
- Respetar condiciones de asepsia del material a utilizar durante el procedimiento,según normas infectologicas del Hospital

Presentacion de liquidos para diálisis

Bolsas de diálisis		Llave de paso de Bolsa de Diálisis

Conector y Prolongador o set de transferencia Fresseñus

Conector distal de catéter o cánula peritoneal.		Prolongador o set de transferencia entre catéter y tubuladura

TECNICA Y CUIDADOS DE ENFERMERIA, PARA DPI

Curación en sitio de inserción del catéter peritoneal:

- Colocarse cofia, barbijo, camisolín estéril, guantes estériles (en ese orden).
- Se procederá a retirar cintas, la cobertura oclusiva anterior del sitio del catéter, con cuidado de no tirar del catéter peritoneal luego descartar guantes y el vendaje que se retiró en recipiente adecuado.
- Colocarse nuevos guantes estériles.
- Se limpia con gasas estériles, previamente embebidas en Clorhexidina alcohólica o Iodopovidona solución al 10%, el catéter peritoneal se lo sostiene con una mano y a continuación, se realiza una curación plana, con técnica quirúrgica, utilizando movimientos en círculos desde el sitio de inserción del catéter hacia afuera, utilizando gasas estériles previamente embebidas en antiséptico y luego secar con gasas estériles.
- **Se coloca una gasa estéril abajo del catéter y otra arriba, o una que cubra ambos lados, para a continuación colocar apósito transparente. De manera que quede listo el extremo para la conexión a la tubuladura a la espiga o llave de paso que se une al set de transferencia, el cual debe estar conectado a la canula peritoneal.**
- **Rotular con fecha, hora que se realiza el procedimiento.**
- **Registrarel procedimiento realizado y cualquier anomalía detectada, como supuración, enrojecimiento de la zona de injuria en forma adecuada.**
- **Los registros deberán ser firmado por el personal interviniente.Apellido Nombre y Numero de matricula.**

PROCEDIMIENTO:

"LA DPI SE REALIZA EN LA UNDIDAD DEL NIÑO/A O PACIENTE"

- **Realizar Control de signos vitales y Peso corporal al paciente**
- **Controlar que la unidad del paciente este limpia, con ventanas y puertas cerradas**
- **Mantener apagados todos los dispositivos que hagan circular el aire(ventilador,calefacciony/orefrigeracion)**
- **Limpiar la mesa y/o superficie a usar para la realización, conexión de la DPI, con alcohol al 70% y toallas descartables. Utilizando para ello movimientos en círculo desde el centro hacia afuera, pasar una vez más de un extremo a otro.**
- **Verificar que el clamps de la cánula este correctamente cerrado.**
- **Limpiar también con alcohol al 70% la balanza electrónica a utilizar.**
- **REALIZAR CORRECTO LAVADO DE MANOS. (**Ver Normas de Infectologia)
- Colocar todos los elementos en forma prolija y en orden a su utilización.
- **Colocar la bolsa de líquido de diálisis previamente calentado a temperatura adecuada para el procedimiento en la balanza, abrir la apertura de la bolsa exponiendo la parte que se encuentra la tubuladura y el puerto o dispositivo para inyectar heparina y los aditivos indicados.**
- Corroborar la correcta altura de la balanza con respecto a la cama del paciente, ya que de ahí se infundirá el líquido dializante a la cavidad peritoneal.
- Nuevo Lavado De Manos O Utilizamos Alcohol En Gel En Forma Correcta.
- Vestirse en forma estéril y realizar curación de injuria peri catéter peritoneal.(ver punto anterior)

- **Limpiamos el extremo distal del prolongador o set de transferencia, el cual estará con su correspondiente TAPON (Tapa con antiséptico estéril, exclusivo de dicha terminal) dejándolo apoyado en el campo esteril (campo de P.L)**
- **Cambiarse los guantes estériles, y a continuación en forma estéril colocar heparina, electrolitos y/o ATB según indicación médica, a la solución de líquido de diálisis.**
- **Desenrollar con cuidado la tubuladura con su espiga o llave de paso, sacar las tapas de la espiga o llave de paso y la del prolongador del catéter y hacer la conexión.**

- **1° Purgamos tubuladura, de bolsa de diálisis que permanece en la balanza, (verificamos el valor que indica la balanza), movemos la llave en el punto N° 2 llave (purgado según Fig. n° 1) contamos 3 segundos y cerramos (regresando al punto N° 1 de la llave (posición drenado). Observamos y registramos el peso de la bolsa de diálisis.**
- **2° Pesamos la bolsa de drenado y anotamos o registramos el valor observado.**
- **3° Abrimos clamps de prolongador o set de transferencia, para que comience el primer drenado del peritoneo. Contabilizamos lo drenado como drenado inicial. (No siempre se tiene primer drenado)**
- **4° Colocamos la llave en el punto 3, posición de Infusión (con bolsa de diálisis en balanza) previo pinzado con la mano de tubuladura para sobrepasar el punto N° 2 de purgado.) Permanecemos hasta que finaliza dicha infusión (hasta el ingreso de la cantidad de líquido indicado por cada baño), mientras "Observamos cuidadosamente los signos vitales del niño, en especial respiración, y la zona abdominal.**
- **Cerramos el clamps, pinzamos nuevamente la tubuladura de drenado, y regresamos la llave al punto N° 1 Drenado. (Bajamos la bolsa de diálisis a la altura del paciente, nuevamente con la almohadilla térmica para mantener la T°.**
- **5° Dejamos el tiempo de permanencia (baño).**
- **6° Abrimos el clamps, para drenar el peritoneo a la bolsa de drenaje (luego del tiempo de permanencia) Hasta que deja de drenar (entre 10 y 20 minutos).**
- **7° Pesamos la bolsa de drenado, contabilizamos y registramos. (si drenó igual o más cantidad de lo infundido se continua con la siguiente infusión o baño y en caso que no haya drenado lo ingresado realizar masajes en la zona abdominal, cambios de posición del paciente, ejercicios de los miembros inferiores)**
- **8° Para cambiar la bolsa, se procederá de la misma manera que al conectar la primer bolsa**
- **9° Una vez finalizado la diálisis, para el cierre del procedimiento se realizara con técnica estéril. Luego del drenado del último baño indicado se cierra el clamps y colocar un TAPON o Minicap. (Tapa estéril para conectarla con el extremo distal del prolongador o set de transferencia.**
- **10° Pesamos al paciente y controlamos sus signos vitales.**
- **11° Registramos el U.F. (Ultra Filtrado) que todo el líquido egresado**
- **Acondicionamos la unidad del paciente y dejando limpio la balanza, la mesa de procedimientos.**
- **Registrar todo lo realizado, en la hoja de diálisis, en hoja de enfermería y en el Report de la sala.**

Toma de muestra de líquido peritoneal para citoquimicos y/o cultivo

Generalmente se toma del drenado del primer baño, quizá indiquen el tiempo de permanencia de más minutos.

- Se realiza con técnica estéril y tomando los mismos recaudos del entorno que al momento de conectar o desconectar la tubuladura en Y de la bolsa de diálisis.
- Desconectar tubuladura en Y del catéter y colocar un bionector (todo con técnica estéril). De allí se extrae con dos jeringas de 20 ml, llenos de líquido, abrir previamente el clamps del catéter.
- Se retira el bionector, se reconecta la tubuladura a la cánula peritoneal, dejando drenar el contenido del peritoneo, continuando el procedimiento antes descripto.
- El contenido de la segunda jeringa se coloca en sendos frascos estériles.

HOJA DE INDICACIÓN DE DIÁLISIS PERITONEAL INTERMITENTE DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL H.N.R.G.

Apellido y Nombre: …….

Indicación de diálisis: …… (% de líquido de diálisis)

Fecha: …./…./……. Nº de Diálisis: ……

OSM del Paciente: …… Hora de inicio dediálisis:……

Peso Inicial: …… Peso Final…… Diferencia de peso: …….

C.S.V.: T/A: ……../…….. F.C.: ……...x´ F.R.: …….x´ Tº: ……. ºC……

Apellido y nombre del enfermero/a: …… Nº de Matricula: ……

Baños	OSM %	Volumen de ingreso	Tiempo de permanencia	Cl. de K Si / no	Hora de ingreso	Hora de egreso	Volumen de egreso	Observacio-nes

Potasio: …… mEq/L Heparina: 250 U.I. /L Si / No ATB: ……mg/L …… mg/L…….. mg/L …… mg/L

Observaciones de Enfermería: Ej. Se realizó curación pericateter, con enrojecimiento de la zona, o con pérdida de líquido por pericatéter etc. Lo que observo.
U. F. (ultra filtró) 100 + 20 + 60 + 50 = 230 (U.F. 230cc) Nombre, apellido, Nº de matrícula y firma del enfermero/a que realizo la diálisis.
……

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA REALIZAR UNA CORRECTA DPI. PRESENTACION DE LAS SOLUCIONES PARA DPI

La solución de DP ideal debería lograr un adecuado balance de líquidos y electrolitos, eliminar toxinas, permitir una ultrafiltración adecuada a las necesidades del paciente, aportar calcio y calorías para mejorar la nutrición y ser lo más biocompatible posible.

- **Solución 1,5 g/% dx. Monohidrato. Concentración real 1,36 g/% dx. Anhidra equivale a 346 mOsm/l.**

- **Solución 2,5 g/% dx. Monohidrato. Concentración real 2,27 g/% dx. Anhidra. Equivale 396 mOsm/l.**
- **Solución 4,25 g/% dx. Monohidrato. Concentración real 3,86 g/% dx. Anhidra. Equivale 485 mOsm/l.**

En general se comienza con soluciones al 1,5%, si el paciente requiere aumentar la remoción de fluidos (ultrafiltración) y no se dispone de bolsas con mayor osmolaridad, se puede aumentar la osmolaridad del líquido agregando dextrosa Al 50%.

VOLUMEN DE LÍQUIDO DE DIALISIS (DPI):

Es la cantidad de solución de diálisis a infundir en la cavidad en cada intercambio. Inicialmente, debe comenzarse con volúmenes de 10-20 ml/kg- 300-600 ml/m durante las primeras 24 hs para evitar el aumento excesivo de la presión intraabdominal, con el riesgo de dolor y fugas o extravasaciones del líquido peritoneal. Este volumen se aumenta progresivamente hasta llegar a 50ml/kg o 800-1200 ml/m de superficie corporal-

TIEMPO DE INFUSION:

Es el tiempo en el cual se infunde el líquido en la cavidad peritoneal, generalmente se realiza por gravedad y oscila entre 5 a 10 minutos. Se relaciona con el volumen de líquido a infundir y la altura de la bolsa del líquido con respecto a la cama del paciente. La resistencia de la infusión puede deberse a acodaduras del catéter o a la disminución de la motilidad abdominal. La diálisis será más eficiente cuanto menor sea el tiempo de infusión.

TIEMPO DE INTERCAMBIO:

Es el periodo en el cual el líquido de diálisis está en contacto con la membrana peritoneal. En DP agudas se utiliza generalmente un tiempo estándar de 30-45 minutos, que permite una remoción de urea y potasio, y una ultrafiltración adecuada.

TIEMPO DE DRENAJE:

Es el tiempo requerido para el drenaje del líquido desde la cavidad peritoneal. Generalmente es de 20-30 minutos, puede prolongarse debido a acodaduras del catéter, la presencia de fibrinas en el líquido, la disminución de la motilidad intestinal o a poca diferencia de altura entre la bolsa de drenaje y la cama del paciente.

NUMERO DE INTERCAMBIOS:

Dependerá de la ultrafiltración que requiera el paciente y la remoción de solutos a lograr. En DPI (Diálisis Peritoneal Intermitente) en general se hacen 6-8 intercambios.

AGREGADOS AL LÍQUIDO DE DPI:

- **Heparina: entre 250 y 500 U/L de solución. Previene la obstrucción del catéter por fibrina. Debe colocarse en forma profiláctica durante las primeras 48 hs luego de colocado el catéter. No se absorbe a través del peritoneo por lo cual no produce anticoagulación sistémica.**
- **Potasio: dado que en general las soluciones de DP no contienen potasio, cuando la kalemia es menor o igual a 3,5 mEq/l es preferible agregar 3-4 mEq/l d CLK por litro de solución de DP.**
- **Antibióticos (según indicación médica, los cuales se reconstituyen y preparan al momento de conexión)**
- **Insulina: se puede administrar en forma intra-peritoneal en pacientes diabéticos.**

"SE DEBE INFORMAR DE MANERA ESCRITA Y ORAL EL PROCEDIMIENTO EFECTUADO CON FECHA Y HORA, FIRMADO POR EL PERSONAL INTERVINIENTE."

REALIZADO POR:
Lic. en Enfermería -García, Rolando: y Jefe de Sección Nefrología.Revision 2020

BIBLIOGRAFIA:

- Nefrología Pediátrica, segunda edición corregida y actualizada 2008 de la SAP (Sociedad Argentina de Pediatría).
- Terapia Intensiva, tercera edición. LongstonBoggs- Wooldridge- King.
- Manual de Enfermería en Cuidados Intensivos. Ona Gómez Ferrero- Luis Salas Campos.
- Ley 24.004 y su REGAMENTACIÓN - DECRETO 2497/1993
- Ley 26529 Derechos del paciente, Historia Clinica y Consentimiento Informado
- Manual de normas y procedimientos –HNRG-2017
- Guía de Procedimientos para enfermería. Segunda edición. “Jean Smith / Youce Young Johnson.

CUIDADOS AL PACIENTE CON HEMOFILTRACIÓN Y HEMODIAFILTRACIÓN.

DEFINICION

Las TDEC, técnicas de depuración extra-renal continua consisten en eliminar artificialmente de la sangre de los pacientes el exceso de agua y solutos almacenados como consecuencia del fracaso renal.

Esto se consigue haciendo circular la sangre continuamente a través de un filtro (hemofiltro) por cuyo interior discurre, en dirección contraria, un líquido con una composición determinada (dializado). Ambos, sangre y dializado, están separados por una membrana semipermeable que es la que hace posible la perdida de agua y solutos

La capacidad de ultrafiltración de esta membrana es muy elevada, de manera que se hace necesario limitar la perdida de liquido que produce el paciente para evitar el desajuste hemodinámico que podría ocasionar. Esto se consigue mediante la reposición horaria de un porcentaje del volumen ultrafiltrado que ira en consonancia con las necesidades del paciente.

Las TDEC suplen parcialmente la función del riñón mediante eliminación de solutos (diálisis) y/o agua (ultrafiltracion) pero no suplen la función endocrina, metabólica o tubular.

Todo esto se realiza mediante los principios físico-químicos de la difusión y la convección que se establece entre dos compartimientos (sangre y liquido de diálisis) separados por una membrana semipermeable.

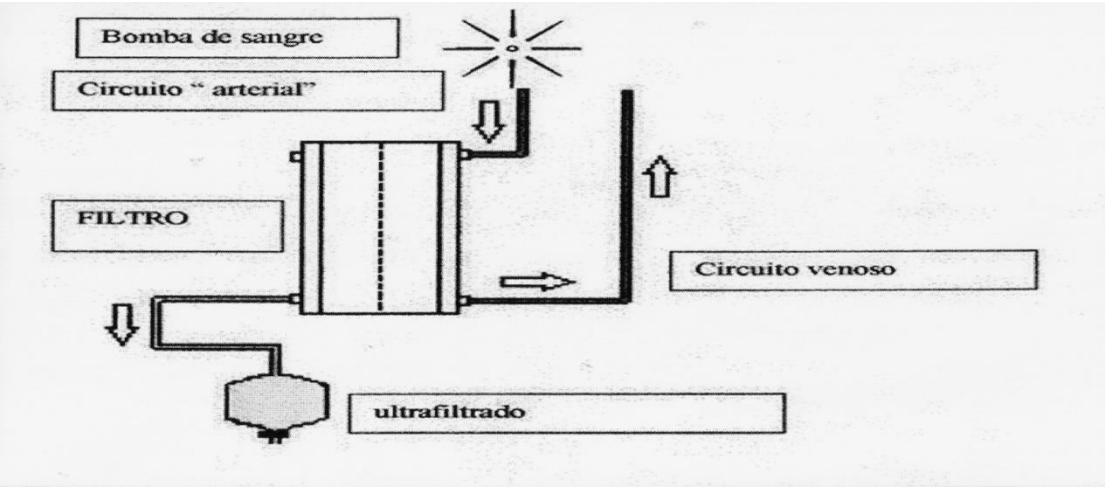
La principal ventaja de las TDEC con respecto a la hemodiálisis es la menor alteración hemodinámica ya que el robo de líquido se realiza de forma continua. Esto permite su utilización en pacientes inestables y en niños muy pequeños, incluso prematuros. La mayor desventaja es su menor capacidad de depuración de urea y creatinina.

Una de las limitaciones son los accesos vasculares que hace que el flujo a través del filtro sea menor y facilite su coagulación. La administración de líquidos de reposición antes del filtro aumenta el volumen de líquido ultrafiltrado y disminuye la hemoconcentración lo que disminuye la posibilidad de coagulación del filtro.

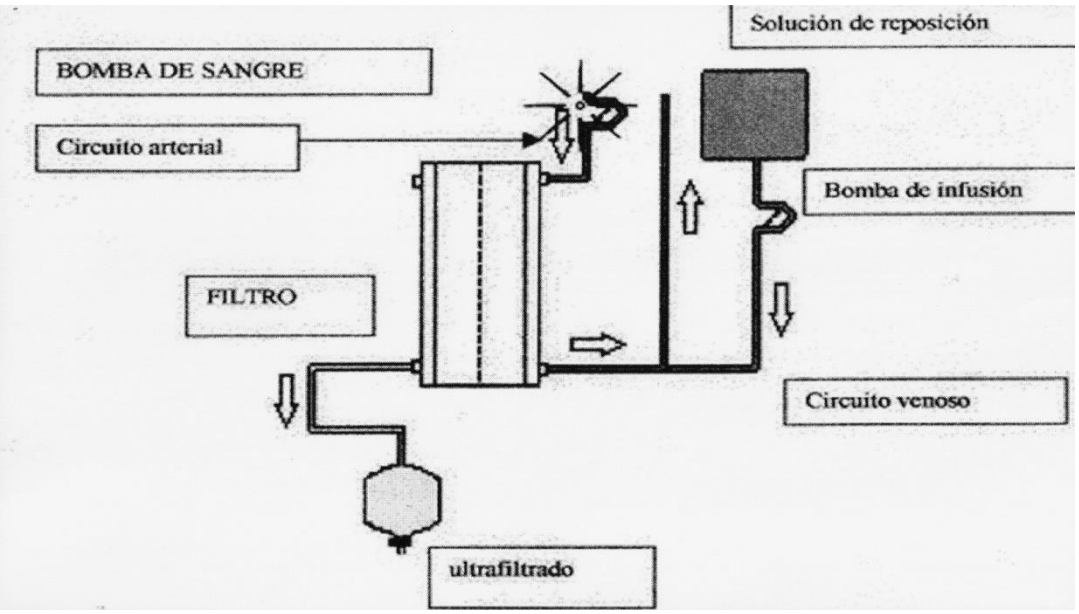
Tipos La Hemofiltración:

- Hemofiltración Arterio-Venosa
- Hemodiafiltración Arterio-Venosa
- Hemofiltración Veno-Venosa Asistida Por Bomba, Que Es De La Que Vamos A Tratar:

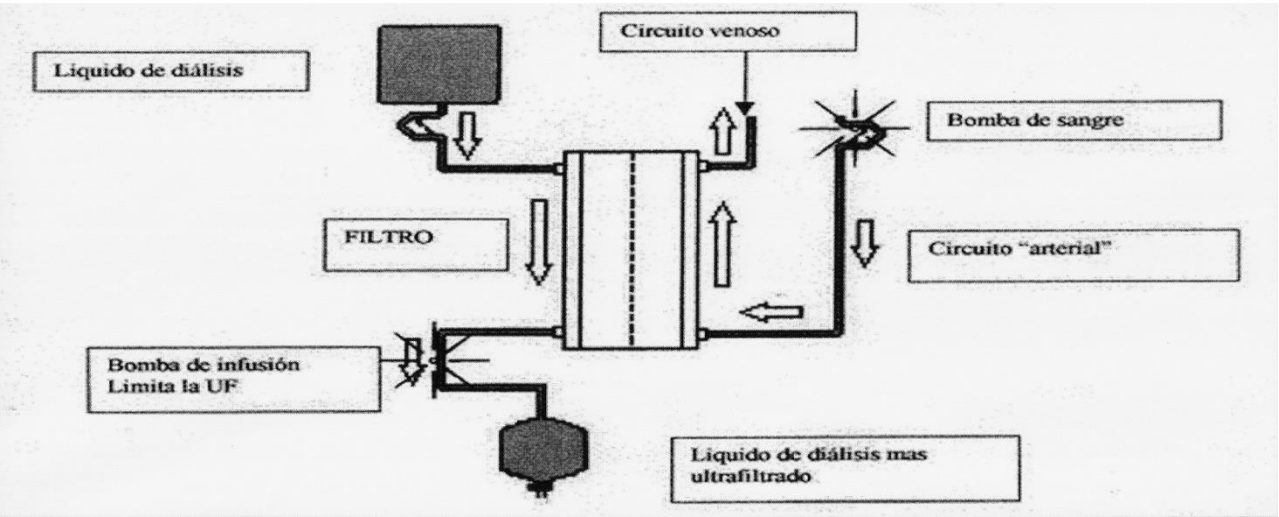
Ultrafiltración Veno-venosa continua (SCUF): se extrae agua y electrolitos sin reponer los mismo. Se utiliza solo en pacientes con hipervolemia y/o insuficiencia cardiaca, y en la cirugía cardiaca tras la salida de la bomba extracorpórea.



Hemofiltración veno-venosa continua (CVVH): se extrae agua y electrolitos, y se reponen los mismos con un líquido de reposición o reinfusión antes del paso de la sangre por el filtro. Se utiliza en pacientes con insuficiencia renal y/o hipervolemia.



Hemodiafiltración veno-venosa continua (CVVHFD): a la hemofiltración se añade la infusión de líquido de diálisis a contracorriente por la cámara externa del filtro. Además de extraer líquido y solutos por diferencia de presión, lo hace por diálisis (diferencia de concentración). Se utiliza en pacientes con insuficiencia renal, hipercatabólicos, con fallo multiorgánico o alteraciones electrolíticas severas.



Hemodiálisis veno-venosa continua (CVVHD): es igual a la hemodiafiltración pero no se administra líquido de reinfusión, solo líquido de diálisis. Se utiliza en pacientes con insuficiencia renal sin hipervolemia.

Todas estas técnicas pueden ser venovenosa o arteriovenosa, de acuerdo al tipo de cateterización del paciente. La hemofiltración arteriovenosa que puede realizarse sin bomba dado el gradiente de presiones esta ya más en desuso debido a que hay un control metabólico del paciente más ineficaz que las terapias continuas, estas permiten también que se puedan manejar mejor el balance de líquidos.

Con esta norma pretendemos dar a conocer las técnicas de depuración extra-renal más utilizadas en nuestro servicio.
Los cuidados de enfermería y su aplicación, así como el estudio de las complicaciones más habituales. En esta terapia son realizadas por la unidad de control Argimed.

OBJETIVOS

- Eliminar sustancia Toxicas
- Corregir alteraciones electroliticas
- Mantener equilibrio acido base

LEGISLACION VIGENTE

Ley24004-Normativa para el Ejercicio de la Enfermeria-Art.3 inciso 18

PERSONAS HABILITADAS

Lic. en Enfermería
Enfermeros Profesionales
Técnicos en hemodiálisis

INDICACIONES

Las técnicas continuas y especialmente la hemofltración continua son actualmente mas indicadas que otras técnicas dialíticas para el tratamiento de pacientes pediátricos. Estas técnicas permiten una remoción de volumen y solutos en forma más lenta y constante permitiendo su uso en pacientes hemodinámicamente inestables.

Usos renales de HFC.

- Insuficiencia renal aguda oligúrica.
- Insuficiencia renal crónica en paciente hemodinámicamente inestable
- Síndrome hepato-renal
- Fallo multiorgánico
- Alteraciones hidroelectrolíticas y acido-bases severas

Usos no renales de HFC

- Insuficiencia cardiaca con sobrecarga de volumen y mala respuesta diurética
- Intoxicaciones(endógenas y exógenos)
- Hiper/hipotermia
- Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica(SIRS)
- Fallo multiorgánico
- Post-ECMO o cirugía cardiaca
- Hiperamoniemias(errores congénitos del metabolismo)
- Hidropsfetalis
- Síndrome de lisis tumoral
- SDRA

EQUIPOS

Los equipos que se usan en el Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutiérrez son de la marca Argimed. Que se encuentranen el servicio de Terapia Intensiva hay dos modelos el HF 1000 y el UF 100 CPP, al cual se visualiza en la siguiente imagen.

PROCEDIMIENTO

PRECAUCIONES PREVIAS

- Estabilidad hemodinámica.
- Sedación previa a la conexión y durante el proceso.
- Canalización vía de grueso calibre con catéter de doble luz o dos de una luz, deben ser al menos, de 4 o 5 Fr. y cortos.
- Aplicar técnicas asépticas al manipular todas las líneas y conexiones del sistema.
- Prestar atención a la posibilidad de fugas en las distintas conexiones durante el purgado, especialmente en las bolsas colectoras y conectores para líquido de diálisis y filtrado. Las fugas pueden provocar perdida de sangre y embolia gaseosa.
- Antes de conectar la línea de retorno de sangre al paciente, verifique la ausencia de aire en el sistema.
- Una vez completado el cebado y durante este no retire las tomas de presión de las capsulas de los sensores.
- Utilizar agujas 20 G o de menor grosor al eliminar aire o extraer sangre del sistema para evitar provocar perforaciones en el mismo, perdidas de sangre e incluso embolia gaseosa.
- Cambiar el set al indicarnos los datos que disminuye su rendimiento y/o se observe coagulación.
- Cambiar todo el sistema OBLIGATORIAMENTE a las 72hs.
- Control exhaustivo de tiempos de coagulación, sobre todo al aumentar dosis de anticoagulación o al cambio de jeringa de heparina.
- Utilizar solamente jeringas de cierre luer de 20cc., otros no aseguran la estanqueidad entre líneas y bomba de heparina.
- Evitar retornar sangre del sistema ante la sospecha de existencia de trombos.
- Minimizar en lo posible, la hipotermia posterior a la conexión consecuente al volumen sanguíneo circulante extracorpóreo.

PREPARACIÓN DE MATERIALES

Canalización vía central

- Elección vía central de grueso calibre: yugular, femoral, umbilical o subclavia. No dejar el catéter situado en aurícula o ventrículo derecho.
- Catéter doble luz o dos de una luz de mínimo 5Fr.
- Material estéril para canalización (batas, guantes, mascarilla, gasas, paños, seda para fijación, set de venoclisis, sol. Desinfectante…
- Solución heparinizada al 0,001% para lavar el catéter previamente a la conexión.
- Set con filtro M10. el circuito tiene un volumen de 50 ml, el filtro un volumen de 3,5.

La elección del catéter será según criterio medico. Los utilizados normalmente son de doble luz, del mayor diámetro posible y cortos para que el flujo de sangre sea mayor. Las dos luces son independientes, pudiendo presentarse como dos tubos huecos unidos o un tubo hueco introducido dentro de otro tubo hueco.

Los más utilizados son los catéteres GamCath de 6,5Fr. Yde 8Fr. insertados en venas umbilicales u otras venas de gran calibre. Otros usados son de 5Fr. y 4Fr.

Catéteres De Hemodiálisis Pediátricos

Indicación	Peso	Característica	Longitud /Cm-	Diámetro/ Fr.
Temporal	7-15	Doble luz, poliuretano radiopaco. Subclavia y yugular	10	6.5
Temporal	10-25	Doble luz, poliuretano blando. Subclavia –yugular-Femoral	12.5	8
Temporal	25-45	Doble luz, poliuretano yugular-Femoral	15	8
Temporal	10-30	Doble luz, poliuretano yugular-Extensión curva	12	11
Permanente	7-12	Silicona yugular interna y otras	18	10
Permanenta	12-30	Silicona yugular interna y otras	24	8
Permanente	12-30	Silicona yugular interna y otras	28	8
Permanente	25-40	Silicona yugular interna y otras	36	13.5
Permanente	30-50	Silicona yugular interna y otras	40	13.5

Cada catéter tiene una luz proximal y otra distal. Cada una de ellas se identifica con un rotulo, con un color, o ambas formas.

ES MUY IMPORTANTEcomo conectamos estas luces a las líneas de entrada (a la maquina) y de retorno (al niño) del sistema Argimed. La luz proximal del catéter debe conectarse a la línea de entrada a la maquina, y la luz distal del catéter debe conectarse a la línea de retorno.

Existe un factor que puede disminuir la masa real de soluto transferido:

LA RECIRCULACION de sangre ya dializada por el circuito extra-corpóreo. Se produce cuando, por error, se conectan al contrario la línea de entrada a la bomba y la de retorno al paciente; es decir se coloca la línea que extrae la sangre del paciente en la luz distal, y el retorno de la sangre purificada en la luz proximal

Descripción del sistema para hemodiálisis

Estos parámetros pueden variar de acuerdo al criterio medico pero, son los indicados generalmente.

Para su funcionamiento necesitaremos: filtro, circuito, sistema colector, liquido de ultrafiltración, acceso vascular, heparenización y liquido de reposición.

Filtro o Dializador

Contiene varios miles de fibras huecas de polisulfona altamente permeables alojadas en un envase de plástico y aseguradas a cada lado con poliuretano

La sangre entra al aparato a través de la apertura de entrada arterial (roja), pasa a través de las fibras huecas y sale al extremo opuesto a través de la apertura de salida venosa (azul). Esta diseñado para hemofiltración y hemodiafiltración.

Los filtros constan de dos cámaras:

- Interna que conecta la arteria y la vena, a través de la cual pasa la sangre. Contiene poros que dejan pasar agua, electrolitos y sustancias de bajo peso molecular.
- Externa que recoge lo que se filtra, conectada a un sistema colector, de gran permeabilidad al agua a través de sus poros de 1 a 10 micras de diámetro.
- Dada la posibilidad de realizar diálisis y ultrafiltración, estos filtros disponen de dos aperturas de salida a cada lado del envase:
- Una próxima al lado venoso donde se conecta el sistema colector cuando solo se realiza hemofiltración.
- Otra próxima al lado arterial donde se conecta el sistema colector cuando se realiza hemodiafiltración.

SE DEBE ELEGIR EL FILTRO SEGÚN LA EDAD Y EL PESO DEL NIÑO

Circuito

Formado por una línea arterial y otra venosa. La primera conecta el acceso arterial del paciente al hemofiltro, tiene una alargadera por donde se va a administrar la perfusión de heparina, en su recorrido tiene varios accesos para permitir extracción de muestras o infusión de medicamentos.
La línea venosa lleva la sangre de retorno desde el hemofiltro al paciente, también posee varios accesos igual que la línea arterial.
El circuito debe ser lo mas corto posible para restringir la salida de sangre del paciente.

Acceso vascular

Se puede utilizar cualquier vía que dé el flujo suficiente para conseguir un buen gradiente arteriovenoso.

Liquido de ultrafiltrado

Se compone de tres tipos de sustancias:

- Agua, Na, k, Cl, P, urea y creatinina a concentración plasmática.
- Glucosa y bicarbonato a mayor concentración que en el plasma.
- Ca. Mg y medicamentos a menor concentración que el plasma.

La relación entre la concentración en el líquido de ultrafiltrado y la existente en el suero sanguíneo se denomina coeficiente de ultrafiltración.
No se eliminan triglicéridos y la perdida de otras sustancias como insulina, vitaminas y oligoelemento es despreciable.

Heparinización

Para evitar la formación de coagulo de sangren el filtro y así preservar su función es indispensable mantener heparinizado el sistema.

- Se realiza purgado del sistema con 2000cc de salino con 10000UI de heparina sódica al 1%.
- Se administra una dosis de ataque de 20UI/Kg de heparina en la línea arterial en el momento de conectar el filtro.
- Durante todo el tratamiento se mantiene una perfusión continua de heparina entre 5/20UI/Kg/h, dependiendo del tiempo de tromboplastina parcial (TTP). Para esta perfusión es preciso conectar una bomba con posibilidad de decimales a la alargadera del circuito arterial.
- Protamina: 1mg neutraliza 100U de heparina, y se coloca en extremo venoso para anticoagulación selectiva del circuito.

Liquido de reposición

El exceso de ultrafiltrado formado, se debe de reponer con un líquido de composición similar al del ultrafiltrado.
Una opción utilizada frecuentemente es la reposición con ringer lactato o un salino al que se le añade glucosa, bicarbonato e iones.

El líquido de reposición puede administrarse antes o después del filtro. Con la administración prefiltro se consigue, por la dilución de los factores procoagulantes, la disminución de la viscosidad sanguínea y de la presión oncótica, mayor duración del filtro con menores necesidades de anticoagulación.

Funcionamiento de la maquina

La maquina tiene tres funciones principales:

- Bombear la sangre y vigilar el flujo para seguridad.
- Filtrar los desechos de la sangre.
- Controlar la presión arterial y la velocidad de la eliminación de líquido del cuerpo.

Todo este proceso es controlado por la maquina de hemodiálisis que cuenta con tres principales componentes:

Dializador

- Circuito extracorpóreo de la sangre
- Circuito del líquido de diálisis

Preparación del paciente

- Aumentar la temperatura antes de comenzar el procedimiento para minimizar la hipotermia secundaria.
- Informar del procedimiento a los padres.
- Sedar para minimizar riesgos de desconexión o extravasación de la vía.
- Posición en decúbito supino para evitar acodamientos del catéter y tener una buena exposición de este.
- Proceder al pesado antes de conectar (si es posible).

Técnica

En nuestra unidad de control Argimed y vamos a detallar todas sus funciones:

- Carga y purgado del set.
- Bombea sangre a través del circuito sanguíneo.
- Suministra solución anticoagulante al circuito sanguíneo.
- Controla la extracción de líquidos del paciente.
- Perfunde la solución de reinyección o líquido de diálisis.
- Monitoriza el sistema y avisa mediante alarma.

En el panel central a un costado de la bomba encontramos tres luces indicadoras sobre las condiciones de funcionamiento.

Verde	Todos los parámetros utilizados son normales
Amarillo	Alarma de advertencia o de información, no esta en peligro la seguridad del paciente pero hay que investigar
Rojo	Alarma de riesgo para el paciente

PURGADO DE LA HEMOFILTRACIÓN ARTERIO-VENOSA

Primera fase:

- Preparar para el purgado del filtro suero fisiológico 2000cc + 10000 unidades de heparina al 1%.
- Preparar campo estéril. Elegir líneas y filtro adecuados a la edad y peso del niño.
- Poner guantes estériles. Limpiar los tapones de caucho de los sueros con alcohol, clorhexidina, o povidona yodada.
- Conectar líneas arterial y venosa al extremo del filtro.
- Conectar línea venosa al suero de purgado, conectar línea arterial a la conexión de la parte venosa del hemofiltro y conectar el sistema colector en la parte arterial.

- Cerrar todos los clamps y llaves. Abrir lentamente el suero de purgado, clamps y llaves del circuito, dándole al filtro ligeros golpes para facilitar la eliminación de burbujas.
- Primero se pone el filtro vertical con la parte arterial hacia arriba y una vez completada esta parte del circuito se pone en sentido contrario hasta la eliminación del aire, luego seguir purgado hasta completar los 2000cc de suero heparinizado y tras finalizar este cerrar todas las llaves y clamps.

Segunda fase

- Desconectar el suero de purgado, conectar la línea arterial a la arteria del paciente y la línea venosa se aboca a una batea.
- Abrir clamps y poner bolo de heparina, cuando en el extremo venoso empiece a salir el líquido teñido de sangre, se cierran todos los clamps y se conecta a la vena del paciente.
- Abrir clamps e iniciar CAVH o CAVH-D.
- En la CAVH se pondría el colector en la parte venosa y en la CAV-D en la parte arterial ya que en la venosa se pondría el liquido diálisis.
- El liquido de reposición seria prefiltro o post filtro según ordenes médicas.

PAUTAS A TENER EN CUENTA

Cuidados de enfermería

- Controles vitales: T°, FR, FC, TA, presión venosa central (PVC), y diuresis.
- Volúmenes: UF, reinfusión y reperfusión.
- Balances: horarios, parciales y globales cada 24 horas.
- Heparinización: ritmo y tipo.
- Pautas medicas relativas a la hemofiltración:
- Reinfusión: volumen, tipo y composición.
- Reperfusión: volumen y composición.
- Anotaciones de enfermería concernientes a las incidencias que hayan podido surgir durante la hemofiltración.
- Asepsia: no debemos olvidar que esa técnicas se suelen aplicar a individuos en estado críticos y que la mayoría de veces se encuentran en fallo multiorgánico, por lo que hay que extremar las medidas de asepsia en:
- Accesos vasculares.
- Conexiones del hemofiltro con el sistema y los accesos vasculares.
- Extracción de muestras de sangre para determinaciones analíticas.
- Control de hemofiltro y el sistema: los cuidados que deberemos aplicar serán: control del color del liquido ultrafiltrado, que debe ser de color amarillento. Si este adquiera una tonalidad rosada indicaría una rotura del hemofiltro.
- Detección de la presencia de burbujas en el circuito que indicaría un mal cebado o alguna fisura en el sistema.
- Control de las presiones venosas de la bomba que nos avisaran del mal funcionamiento de la técnica.
- Prevención de posibles acodaduras de las líneas del sistema que provocarían la coagulación del mismo.
- Revisión de conexiones para evitar cualquier desconexión del sistema que tendría como consecuencia una hemorragia masiva.

Detección de complicaciones: Las complicaciones detectadas a tiempo, pueden ser solucionadas oportuna y efectivamente.

RELACIONADAS CON LA TÉCNICA

- Hemorragia asociada con la anticoagulacion
- Inadecuado balance fluido, hipotensión sobrecarga hídrica
- Hiponatremia
- Hiperglucemia
- Hipotermia

RELACIONADO CON EL CIRCUITO

- Desconexión accidental
- Iandecuadaadministracion de fluidos
- Ruptura del filtro , perdida de sangre
- Embolismo Gaseoso

RELACIONADO CON EL ACCESO

- Hemorragia
- Trombosis
- Embolismo Pulmonar
- Infección , Celulitis, Sepsi
- Oclusión Arterial
- Isquemia distal

Por ser la hemofiltración continua una técnica realizada, fundamentalmente por enfermería, el buen resultado de la misma, dependerá de la calidad de los cuidados, que le brindemos al paciente durante el procedimiento

REALIZADO POR:

Lic. Torreiro, Lorena, Jefe Sección UTIP
Enfermeros asistenciales de laUTIP:
Aguirre Mariana
Torres Gerardo
Nudo Fabian
Esteves Blanca Colman Gladis
Cuesta Carlos
Aragon Leonel
Salazar Luis

BIBLIOGRAFIA

- Técnicas Especiales De U.C.I.-Mj. Álvarez, M.P. González, C. Peña, A. Belaustegi, S. Díaz De-Durana, G. Soleto, Mj. Rodríguez, I. Santos.- Unidad De Medicina Intensiva Del Hospital Txagorritxu, 2004-Edita: Hospital Txagorritxu-Depósito Legal: Vi-264/04
- Manual de Normas HNRG 2015

CUIDADOS AL PACIENTE PREQUIRURGICOS

BAÑO Y PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA

DEFINICION

Los factores de riesgo asociados a la infección quirúrgica derivan del propio paciente, como presencia de diabetes, tratamiento con esteroides, estados de malnutrición, obesidad, coexistencia de infecciones o colonización por microorganismos e inmunodepresión, o bien, de la propia intervención: duración y preparación prequirúrgica de la piel.
Las medidas de prevención de la infección quirúrgica se definen como la acción o grupo de acciones que realiza el personal de enfermería para reducir el riesgo de infección, como por ejemplo el baño y preparación prequirúrgica del niño.

OBJETIVO

Disminuir o eliminar los microorganismos presentes en la piel del paciente que va a ser sometido a algún procedimiento quirúrgico.

Disminuir las infecciones nosocomiales relacionadas con la cirugía

LEGISLACION VIGENTE

Ley 24004-Normativas Para El Ejercicio De la Enfermería-Art. 3 Inciso.18

PERSONAS HABILITADAS

Lic. En Enfermería
Enfermeros Profesionales
Auxiliares De Enfermería

EQUIPO

Digluconato de clorhexidina 0,12%)
Clorhexidina al 4% o iodopovidona al 5% solución jabonosa en caso de alergias).
Apósitos.
Toalla.
Ojotas.

PROCEDIMIENTO

- **Día Anterior A La Cirugía**
  - Baño completo incluido lavado de cabeza, repasar zonas de pliegues.
  - Ducha o bañera dependiendo de la edad y patología de base delpaciente.
  - Lavados orofaríngeos con antiséptico (digluconato de clorhexidina 0,12%) al menos durante 30 segundos en pacientes con alteraciones en la deglución, ej: pacientes ECNE, PC, etc.
  - Uñas de pies y manos cortas, limpias y sin esmalte.
  - Retiro de piercing, anillos y relojes, y en general todo tipo de alhajas.

- **El Día De La Cirugía**
  - El baño de la mañana incluye lavado de cabeza y siempre se repasaran las zonas de pliegues.
  - Entregar a la madre camisolín, después del 2° baño.
  - Control de signos vitales (FC, FR, Sat02, TA).

- Se constatará ayuno prequirurgico (< de 1 año o lactante 4hs de ayuno de leche) y niños mayores ,8hs. (Ver protocolo de ayunos prequirurgico).
- Verificar historia clínica completa del paciente y adicionar hoja de enfermería con los controles de enfermería prequirurgico y hoja de indicación médica, para su actualización postoperatoria a la salida del paciente de quirófano.
- El traslado a quirófano se realiza con el camillero de quirófano quien solicitará al pte con nombre y apellido y debe ir hacia el quirófano en compañía de la madre y padre y/o tutor.
- Colocar Pulsera de identificacion.

RECOMENDACIONES GENERALES

El baño debe hacerse con clorhexidina al 4% y/o iodopovidona al 5% solución jabonosa en caso de alergias.

- Una vez realizado el 2° baño prequirurgico se le entregara un camisolín con la recomendación de ponerse la ropa interior limpia antes y una campera de abrigo (limpia) por arriba del camisolín si hace frio.
- Deben realizarse 2 baños antes de la cirugía. Ejemplo: a la tarde del día que ingresan entre las 18 y 20hs y a la mañana de la cirugía entre las 6 y 7hs. AM.
    - Si es paciente ambulatorio o vespertino debe realizarse un baño en la casa a la noche y otro al ingreso a la sala, serán realizados con la técnica de ‘arrastre” (tipo ducha), teniendo especial cuidado en las zonas de los pliegues del cuello, axila, zonas inguinales y zonas interdigitales.
    - Pediculosis: en caso de encontrar pediculosis en el cuero cabelludo, realizar tratamiento correspondiente y colocar doble gorro al ingresar al quirófano.
- Escabiosis: se avisa a médico pediatra para realizar tratamiento correspondiente y decidirá la suspensión de la cirugía.
- Habitualmente la preparación pre-quirúrgica incluía la eliminación del vello corporal del campo quirúrgico, debido a que su presencia podía interferir con la incisión y los cuidados postoperatorios de la herida quirúrgica. Hoy la eliminación del vello del lugar de la incisión, está totalmente desaconsejada. Sin embargo, si se considera imprescindible, existen tres métodos de eliminación del vello: el rasurado, el corte del vello con maquina eléctrica y la depilación química. Con la evidencia científica disponible, se puede afirmar que la probabilidad de desarrollar una infección quirúrgica es mayor cuando se elimina el vello mediante rasurado que cuando se utiliza maquina eléctrica.

REALIZADO POR:

Lic. Díaz, Evelina,Jefe Sección U12-16

BIBLIOGRAFIA

- Morales L, Albert A. El paciente quirúrgico pediátrico: cuidados pre y postoperatorios. En: Tratado de Pediatría. M Cruz. Barcelona: Publicaciones médicas Espax; 1989.
- Infección del sitio quirúrgico (1ª parte) Recomendaciones actualizadas para el control de las infecciones del sitio quirúrgico. CDC, INTRAMED 08 AGO 11.-

CUIDADOS PREQUIRÚRGICOS EN PACIENTES CON CIRUGÍA PROGRAMADA.

DEFINICIÓN.

Los cuidados pre-quirúrgicos son los procedimientos realizados por el profesional de enfermería al realizar el ingreso a la unidad de cirugía al paciente pediátrico, próximo a someterse a un acto quirúrgico, con el fin de asegurar un óptimo arribo al proceso operatorio.
Los cuidados pre-quirúrgicos incluyen chequeos, controles, suministro de información, educación y procedimientos asistenciales. La internación en pediatría se realiza el paciente junto a la madre, padre o tutor legal.

OBJETIVOS.

- Sistematizar los cuidados de enfermería orientados al paciente pediátrico preoperatorio.
- Brindar cuidados de enfermería centrado en las necesidades del paciente y su familia en lo referente al periodo preoperatorio.
- Supervisar el proceso preoperatorio con el fin de que el paciente pediátrico alcance el acto quirúrgico en estado óptimo, de modo que se eviten las complicaciones relacionadas con la intervención.

LEGISLACIÓN VIGENTE.

Ley nacional 24004 Ejercicio de la enfermería.
Ley 298 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley de ejercicio de la enfermería.

PERSONAS HABILITADAS.

Licenciada/o en enfermería.
Enfermeros Profesionales
Auxiliar de enfermería

MATERIAL NECESARIO.

Normas de la unidad (folleto explicativo).
Bandeja conteniendo:
Torundas de algodón.
Termómetro.
Bolígrafo color negro.
Estetoscopio.
Instrumental:
Oxímetro de pulso (saturómetro).
Tensiómetro.
Balanza.
Documentos:
Hoja de enfermería.- Hoja de indicación médica.

TÉCNICA Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

Informarse de las indicaciones médicas para el paciente.
Presentación del profesional de enfermería ante el paciente pediátrico preoperatorio y su familiar (madre, padre, tutor legal).
Corroborar que en la historia clínica se encuentren los estudios pre-quirúrgicos: radiografía, electrocardiograma, laboratorio, etc.
Entrevista a los padres:
En los días previos padeció infecciones, heridas, diarreas, vómitos, pérdida de peso reciente.

Corroborar si el paciente es alérgico o no a alguna medicación o alimentos.
Interrogar si el paciente posee:

- Patología de base (diabetes, asma bronquial, cardiopatías,etc.).
- Terapias farmacológicas: antibióticos, diuréticos, analgésicos, salicilatos, anticonvulsivantes o sedantes y otros fármacos, que puedan alterar la respuesta a la analgesia.
- Averiguar si hubo intervenciones quirúrgicas anteriores y de ser afirmativo, si presento complicaciones como hemorragias, infecciones, fiebre, o problemas respiratorios, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos, hipotensión, si se le realizo transfusión.
- Hábitos alimentarios: obesidad, anorexia, malnutrición.
- Hábitos de descanso.

Explicar amablemente toda la preparación que se hará según el tipo de cirugía.

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA;

ASPECTO GENERAL:
Observación si presenta trastornos respiratorios, hidratación, coloración de la piel, vaciamiento de la vejiga, hábito intestinal.
Higiene de manos según normas del servicio de infectología, para reducir la flora permanente y eliminar la flora transitoria.
Realizar control de signos vitales (temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, saturación).
Realizar Control del peso Corporal.
Explicar en qué consiste el baño pre-quirúrgico:
Su importancia en la reducción de la flora resistente y eliminación de la transitoria, dado que en el proceso quirúrgico se realiza la apertura de la barrera natural, el baño debe realizarse con digluconato de clorhexidina, solución jabonosa al 4%. Informarle que el baño pre-quirúrgico consta de tres baños realizando el primero al ingreso de la unidad, el segundo previo al descanso nocturno, y el tercero una hora antes del ingreso a quirófano.

PREVIO AL TRASLADO AL QUIRÓFANO:
Comprobar fehacientemente la identidad del niño y que la historia clínica se encuentre con todas las pruebas complementarias, cuente con la hoja de indicaciones médicas, posea la hoja de enfermería. Dado que la historia clínica acompaña al paciente al quirófano.
Control de constantes vitales.
Colocar camisolín y gorro quirúrgico al finalizar el tercer baño pre-quirúrgico.
Evaluar las condiciones físicas del paciente para trasladarse a quirófano sea en camilla, silla de ruedas o en brazos de la madre, padre o tutor legal.
Registrar todos los datos en la hoja de enfermería.

REGISTRO DE ENFERMERÍA.
La historia clínica pertenece al paciente y es un documento legal, los registros de enfermería integran la historia clínica, por ello es un deber realizarlos de forma correcta. Se debe registrar el procedimiento realizado, con fecha, hora, firma, sello y matricula del profesional de enfermería interviniente, inmediatamente posterior a la realización del procedimiento.

AYUNOS PRE-QUIRÚRGICOS.

DEFINICIÓN.
El ayuno previo a la cirugía significa la supresión de alimentos sólidos y líquidos de cualquier especie (no comer golosinas de ningún tipo, no masticar chicle y no beber agua).

OBJETIVOS.
Disminución del volumen de contenido gástrico.
Prevenir el riesgo de regurgitación y bronco aspiración.

LEGISLACIÓN VIGENTE.
Ley nacional 24004 Ejercicio de la enfermería.
Ley 298 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley de ejercicio de la enfermería.

PERSONAS HABILITADOS
Ley 24004. Artículo 3º. Anexo I.
Ley 298. Artículo 5º Se reconocen dos niveles para el ejercicio de la enfermería:

a) Profesional
   Licenciada/o en enfermería.
b) Auxiliar
   Auxiliar de enfermería

TÉCNICA Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA.
Informarse de las indicaciones médicas para el paciente.
Presentación del profesional de enfermería ante el paciente pediátrico preoperatorio y su familiar (madre, padre, tutor legal).
Explicar al paciente y a su familiar (madre, padre, tutor legal) en que consiste el ayuno y concientizar de ello.
Colocar a cada paciente un identificador del ayuno en la unidad.
Verificar horas de ayuno según edad y patología del paciente.La misma estará sujeta según el tipo de alimentación.
Los lactantes la horas varian según el tipo de leche con el que se alimenta (Matena o Formula)
Si hay indicación médica colocar el AVP y su correspondiente PHP.

Edad	**Sólidos y leche**	**Líquidos**
Menores de 6 meses	4 horas	3 horas
Desde los 6 meses hasta los 3 años	5 horas	4 horas
Mayores de 3 años	8 horas	6 horas

Registrar El Procedimiento En La Hoja De Enfermería.

OBSERVACIONES.
Todo paciente de trauma se considera con estómago lleno, como también los pacientes agudos ingresados por patologías intra-abdominal(apendicitis, obstrucción intestinal, colecistitis, etc.)
Se debe implementar el ayuno concientizando al paciente y su acompañante de la importancia del cumplimiento del mismo.
Colocar a cada paciente un identificador del ayuno en la unidad.
Registrar el procedimiento en la hoja de enfermería.
Se debe modificar el tiempo de ayuno según criterio del anestesiólogo responsable del caso.

REALIZADO POR.
Lic. Orellana, Juan Carlos, Jefe SecciónCirugia

BIBLIOGRAFÍA.

- Normas de enfermería H.N.R.G. 2015.
- Ley nacional 24004. Ejercicio de la enfermería.
- Ley de la ciudad autónoma de Buenos Aires 298.
- Aguilar Cordero, M.J. Tratado de enfermería infantil, cuidados pediátricos. Vol.I. Cap. 33. Pag. 580, 581, 582. Ed. Océano. España
- Normas de enfermería H.N.R.G. 2015.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE POSTQUIRURGICO

DEFINICION

Es el tiempo que transcurre desde que el paciente concluye su participación en la cirugía extendiéndose hasta que es dado de alta, para su recuperación total o para que continúe su recuperación en su domicilio, se divide en inmediato y mediato.

***Inmediato.-**Se extiende desde la colocación del apósito en la herida quirúrgica extendiéndose hasta que los signos vitales se encuentren en los estándares establecidos.

***Mediato.-**Parte cuando ya se ha estabilizado los signos vitales del paciente extendiéndose hasta que sea dado de alta o logre su recuperación total.

OBJETIVOS

Mejorar los estándares de calidad en la atención al paciente postquirúrgico.
Optimizar los recursos, físicos y humanos para una atención de enfermería eficaz

LEGISLACION VIGENTE

Ley24004-Normativa Para El Ejercicio De La Enfermería – Art.3 Inciso 18

PERSONAS HABILITADAS

Lic. En Enfermería
Enfermeros Profesionales

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PERIODO POS-OPERATORIO INMEDIATO.

Preparar la unidad del paciente, para la recepción postquirofano.
Recibir al paciente con la Historia clínica correcta.
Valorar estado de Conciencia
Colocar al paciente en la posición indicada o requerida.
Mantener vías respiratorias permeables.
Conectar y mantener el funcionamiento de los equipos de drenaje, succión etc. Rotular
Observar y controlar herida quirúrgica
Control y registro de los signos vitales.
Reposición de líquidos parenterales
Balance Ingresos y Egresos
Evaluar Dolor. Tranquilizar al paciente.
Registrar los procedimientos realizados, estado del paciente y problemas presentados

La organización del equipo de salud influye en el paciente, el tener los conocimientos sobre el estado, en el que es recibido en el servicio el paciente (técnica, duración, fármacos administrados, anestesia utilizada. cuenta con drenaje, apósito etc) contribuye a la realización de plan de cuidado efectivo y oportuno; para el paciente postquirúrgico.

La valoración es cefalocaudal, se enfoca en las vías respiratorias, la circulación, el metabolismo, teniendo en cuenta el tipo de anestesia y en general el aspecto físico que presenta el paciente.

La posición del paciente se determina a partir de dos factores los cuales son; anestesia inducida y el tipo de cirugía que le fue realizado, así que el cambio de posición favorece la respiración y la circulación.

El movilizar incorrectamente al paciente, puede generar trastornos emocionales, respiratorios, gastrointestinales entre otros, todos dolorosos.

El reflejo faríngeo como laríngeo al ser recuperados ,fomenta el control de la lengua, tos y deglución.

La anestesia y la pérdida de los líquidos en el paciente contribuyen en la alteración de los signos vitales, por alteración del volumen circulante.

La movilización, estimulación tusígena y respiratoria favorece el buen intercambio gaseoso, reducen el nivel de dolor y por consecuencia la disminución de las complicaciones posoperatorias.
La restitución hidroelectrolítica, se basa en el estado clínico, peso corporal, hematocrito y química sanguínea primordialmente.
La mayoría de los pacientes requiere de soluciones isotónicas para un equilibrio electrolítico adecuado, razón indispensable por lo que se debe confeccionar;un correcto balance hídrico.
La tranquilidad y el bienestar del paciente va a depender del dolor, por lo cual seguir las normas de sedoanalgesia es importante.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PERIODO POS-QUIRURGICO MEDIATO.
Continuar con los cuidados del posquirurgicoinmediato, y vigilar constantemente la heridaquirurgica, realizar curación de la misma, según normas infectologicas.
Ayudar a la ambulación del paciente.
Participar o colaborar en la dietoterapia, según corresponda.
Controlar diuresis.
Observar signos y síntomas de complicaciones.
Instruir al paciente y al familiar sobre indicaciones específicas según el tipo de intervención, cuidados generales y el proceso de cicatrización.
Registrar los procedimientos realizados, estado del paciente y problemas presentados
La ambulación temprana evita complicaciones futuras, influye en el adecuando funcionamiento gastrointestinal y la correcta circulación sanguínea.
La dieta prescrita depende del tipo de cirugía practicada y de las necesidades que tenga el paciente.
Motivar el restablecimiento de la motilidad intestinal.
La supresión urinaria después de la cirugía es consecuencia del estrés causado por la intervención quirúrgica, la posición y la presencia de espasmo en el meato urinario, por lo cual para evitar complicaciones es importante incentivar la micción.
Las complicaciones, Pueden ser menores (nauseas, vómito, distención abdominal etc.) o mayores (disminución del retorno venoso, embolia etc.).
Valorar La presencia de signos y síntomas de complicaciones, evita que el paciente, prolongue días de internación.
Educar al paciente y a su familia, sobre los cuidados que deberá tener en su domicilio.

REALIZADO POR:
Lic. Orellana, Juan Carlos, Jefe Sección U15

BIBLIOGRÁFIA

- Mtra. Eva Reyes Gómez.“Fundamentos de enfermería”, 3 ª edición 2004. Pág.471-474(Periodo inmediato) y Pág.481-482 (Periodo inmediato).
- Normas de enfermería H.N.R.G. 2015.

CUIDADOS DE LA UNIDAD DEL PACIENTE POSTQUIRURGICO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

DEFINICION:
Es el área física donde se encuentra el mobiliario y equipo necesario para la atención del enfermo, durante su estancia en la institución.

OBJETIVOS:
Contar con un lugar específico para el paciente.
Brindar cuidados seguros y de calidad durante su tratamiento.
Ofrecer bienestar físico al paciente durante su recuperación.

MATERIALES NECESARIOS:

- **Camas o cunas articuladas y con barandales, servo cuna calefaccionada**
- **Ropa de cama adecuada para cuna, cama o servocuna.**
- sistema de oxigeno: flumiter y un soporte respiratorio mecánico, conectado a las tomas de oxígeno y aire comprimido.
- sistema de aspiración.
- Bombas de infusión para administración de medicación
- Monitor cardíaco multiparametrico con sus respectivos cables de conexión
- Material de reanimación.
- Materiales o productos para la higiene personal.
- Materiales descartables.
- Materiales para laboratorio.
- Sueros, drogas necesarias.
- **Hojas para el control del balance de ingresos /egresos**
- **Marcapaso Externo.**
- **Desfibrilador**
- **Cajón porta drenaje**

TENER CERCA DE LA UNIDAD:

- **Carro de paro completo.**
- **Electrocardiógrafo.**
- **Convector de hipotermia.**
- **Carro auxiliar de circulacion extracorpórea con todo el material necesario.**
- **Aparato de óxido nítrico.**
- **Carro de curación.**
- **Equipo de Eco Doppler.**
- **Equipo de gas.**
- **Lámpara cialitica para procedimientos**
- **Equipo de TCA (tiempo de coagulación activada)**

PROCEDIMIENTOS:

- Preparar la unidad donde va a ser ubicado el paciente
- Verificar el funcionamiento de la cama del paciente. Colocar sabanas, colcha y almohada según corresponda.

- Colocar y corroborar el funcionamiento del ventilador mecánico(VM) junto con el set corrugado de acuerdo a la edad del paciente y calentador con carcasa de humidificación activa, ambos enchufados a la corriente eléctrica, calibración del aparato, comprobación del ciclado y fuga, dejarlo en "espera" listo para recibir al paciente.
- Verificar el correcto funcionamiento de las tomas de oxígeno y aire comprimido,
- Comprobar que las dos entradas de aspiración funcionen, establecer una toma para aspiración continua de drenajes y otro para la permeabilidad la vía aérea del paciente con frasco de reservorio descartable
- Preparar monitor multiparamétrico para controlar: FC, FR, PA, PVC, AI, Tº para la vigilancia continua de los signos vitales del paciente, encender y configurar las alarmas del monitor según edad del paciente y revisar que los cables estén completos.
- Alistar una bandeja conteniendo: electrodos, llave de tres vías, jeringas, jeringas heparinizada, gasas, bionectores, guantes estériles, férulas, apósitos transparentes, prolongadores con llave de tres vías, transductores para medir presión arterial (PA) y presión venosa central (PVC), gel oftálmico, apósito coloidal, tela adhesiva,
- Dejar preparada una solución fisiológica heparinizada, para permeabilizar el catéter arterial, 500 ui/ 500 ml solución fisiológica
- Bombas de infusión enchufadas y las baterías cargada.

Los cuidados se adecuaran a cada patología específicamente,según indicación medica .

REALIZADO POR:

Lic. Sassone Pablo, Jefe Sección U 17Cirugia Cardiovascular

BIBLIOGRAFIA

- Mtra. Eva Reyes Gómez."Fundamentos de enfermería", 3 ª edición 2004. Pág.471-474(Periodo inmediato) y Pág.481-482 (Periodo inmediato).
- Manual de Normas y Procedimiento- H.N.R.G. 2017.

CUIDADOS EN PACIENTES POS-QUIRURGICO INMOVILIZADO EN TRAUMATOLOGIA

DEFINICIÓN

Cuidados para la prevención de infecciones en pacientes enyesados, en tracción esqueléticas y con tutores.

OBJETIVOS

Establecer intervenciones de enfermería para disminuir riegos posibles de alteración de la piel.
Mantener la piel seca y sana, para la evitar posibles infecciones.
Evitar presión y roses continuos en punto de apoyos.

LEGISLACION VIGENTE

Ley 24004.Normativas Para El Ejercicio De La Enfermería. Art. 3 Inciso 18.

PERSONAS HABILITADAS

Lic. En Enfermería
Enfermeros Profesionales

EQUIPO

Ropa de cama limpia
Guantes
Protectores (almohadas, aros, barandillas, etc.)
Clorhexidina, respetando normas infectologicas.
Registro de enfermería

PROCEDIMIENTO

Lavarse las manos e informar al paciente y a los familiares del procedimiento a realizar.
Proteger e inspeccionar los hombros, codos, crestas iliacas, rodillas etc. En busca de zonas de presión.
Valorar el estado neurovascular de la extremidad inmovilizada por lo menos cada hora.
Colocar protectores, para brindar seguridad y confianza. (Barandillas, aros, etc.)
Evitar la humedad en todos los pliegues de la piel.
Respetar en todo lo posible la intimidad del paciente.
Mantener una postura adecuada para que la pierna o brazo permanezcan en posición neutral.
Evitar arrugas y deslizamiento del vendaje de tracción.
Comprobar que las cuerdas estén en los carriles de las poleas, que las pesas cuelguen con libertad, que no apoye en ningún lugar.
Realizar Baño en Cama.
Movilizar con ayuda.

EN PACIENTES CON TRACCION Y TUTORES

Se Debe Valorar, En Los Tutores:

- el drenaje de herida quirúrgica.
- el sitio de inserción del tornillo.
- Controlar signos de infección como edema,enrojecimiento,calor, dolor y drenaje purulento; para evitar el desarrollo de osteomielitis.

EN PACIENTES CON YESO:
Se debe Valorar:

- Posición del Miembro afectado,
- Mantenerlo elevado en el post quirúrgico inmediato.
- Controlar el llenado capilar, movilizarlas articulaciones por arriba y por debajo del yeso, Para favorecer el retorno venoso
- Enseñar a deambular con dispositivos (Andador,Muleta,Etc.) de apoyo de forma segura.

REALIZADO POR

Lic.SegoviaNora , Jefe Sección, U13
Lic.De La Vega, Isabel,Jefa sección U14

BIBLIOGRAFIA

- Lewis,S.M. Y Cols: EnfermeríaMédicoQuirúrgico.Valoración Y Cuidados De Problemas Clínicos.Vol I Y II.6 Edición. Madrid. ElSevier Mostdry2004.
- Dra. Ángela Gentile, Dra. Julia Bakir, ECI Lic. Elizabeth Beltrán, ECI. Lic. Mariela Cabrera.Normas Practicas para el control de infecciones-HNRG-CABA-2017

CUIDADO AL PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO

DEFINICION:
La traqueotomía es una intervención quirúrgica que consiste en practicar una abertura en la tráquea. La traqueotomía consiste en canalizar la tráquea mediante un tubo o cánula.

FINALIDAD DE LA TRAQUEOSTOMÍA
Permite la entrada de aire en los pulmones cuando no es posible a través de las vías aéreas superiores.

INDICACION DE LA TRAQUEOSTOMIA
- Obstrucción De Las Vías Aéreas
- Edema De Glotis
- Cuerpos Extraños
- Tumores
- Ventilación prolongada
- Obstrucción de la vía aérea superior
- Lesiones neurológicas (miopatías)
- Malformaciones craneofaciales
- Traumatismos
- Parálisis bilateral de cuerdas vocales.

SITUACIONES URGENTES
- La ventilación artificial.
- Después de laringectomía.
- Ante enfermos en coma en los que ha desaparecido el reflejo tusígeno y presentan un acúmulo de secreciones.
- La traqueostomía es una intervención quirúrgica y, por tanto, siempre que no se trate de un caso de extrema urgencia, debe realizarse en las máximas condiciones de asepsia y en el quirófano.

OBJETIVOS
- Mantener la vía permeable para facilitar el intercambio de gases
- Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas, cuando no es posible por vía orofaríngea.
- Proporcionar ventilación asistida por un lapso de tiempo prolongado.
- Aspiración de secreciones.

LEGISLACION VIGENTE
Ley 24004 Normativa para el ejercicio de la enfermería –Art. 3 Incisos 18.
Resolución 194/1995-Normas de Organización y Funcionamiento de los Servicios de Enfermería en Establecimientos de Atención Médica

PERSONAS HABILITADAS
Enfermeras técnicas profesionales
Licenciadas en enfermería
Medicos-Lic En Kinesiología

SE DEBE VIGILAR, EN EL PACIENTE:
Dolor, eritema, hematomas, signos y síntomas de infección.

SE DEBE VIGILAR DELACANULA:

- La fijación, para evitar desplazamientos
- La desinfección del ostoma debe realizarse cada ocho a doce horas, o por lo menos diariamente, con solución antiséptica.
- Después de haber cicatrizado el tejido de la ostomía, la cánula de traqueotomía debe cambiarse cada dos o cuatro días.
- Al cambiar la cánula emplear la técnica aséptica estricta.
- Mantener la integridad de la zona de traqueotomía libre de traumatismos e infección, y especialmente libre de secreciones.
- Durante las primeras 36 horas de realizada la traqueotomía, ésta no debe ser retirada, ya que el estoma puede colapsarse, haciendo difícil la reintubación.

MATERIAL NECESARIO

- Equipo para aspiración de secreciones.
- Gasas de 5 x 5 y de 10 x 10.
- Hisopos estériles.
- Solución estéril para irrigación o solución fisiológica.
- Solución antiséptica.
- Cintas Hilera, para sujeción de la cánula de traqueotomía.
- Tijera
- Guantes desechables no estériles.
- Guantes quirúrgicos estériles (dos pares).
- barbijo (desechable).
- Bolsa para desechos.
- Tubo Endotraqueal , un numero menor al de la cánula

Fórmula para determinar el Nº de tubo endotraqueal:

Edad en años+16o Edad+ 4
44
Para fijar el tubo en el labio

Numero de tubo X 3

MESA DE PROCEDIMIENTOS

Decontaminar con soluciones enzimáticas (alcohol 70%)

PROCEDIMIENTO

Se utilizan dos operarios : operario 1 EPP esteril – operario 2 EPP limpio

- Lavarse las manos.(ver normas Infectologicas)
- Valorar el estado del ostoma, enrojecimiento, edema, datos de infección y hemorragia.
- Realizar la aspiración de secreciones de tráquea y faringe (con la técnica adecuada).
- Explicar el procedimiento al paciente y así lograr mayor cooperación.
- Colocarlo en posición de Fowler, si no está contraindicado para el paciente. O Decúbito Dorsal
- Utilizar la técnica estéril para colocar y preparar el material de curación, solución para irrigación y antiséptico.
- Colocar una compresa estéril bajo la traqueotomía (sobre el pecho del paciente).
- Colocarse las lentes de protección, Barbijoy guantes (guantes desechables).

- Retirar el apósito de la cánula de traqueotomía y desecharlo según normas infectologicas establecidas en la institucion.
- Quitarse los guantes (desechables) y eliminarlos,conforme a Las Normas.
- Colocarse los guantes estériles.
- Realizar la asepsia del extremo de la cánula con gasas estériles impregnadas con solución antiséptica (utilizando las reglas básicas de asepsia y repitiendo el procedimiento).
- Continuar la asepsia de la zona del ostoma, respetando las (Normas Infectologicas).
- Utilizar hisopos impregnados de solución antiséptica en los bordes y bajo los bordes de la cánula y realizar una asepsia completa y minuciosa.
- Quitar el antiséptico con una gasa de solución para irrigación.
- Secar el exceso de humedad con gasas estériles (la humedad propicia la infección e irritación de la piel).
- Si está indicado, aplicar antiséptico (pomada).
- Colocar el apósito de la traqueotomía. Existen apósitos especiales para la cánula de traqueotomía, o bien pueden acondicionar, desdoblando una gasa de 10 x 10 (alargando en forma horizontal) y formar una especie de corbata, doblando ambos extremos de la gasa, para que exista mayor absorción se puede utilizar doble gasa.
- No utilizar gasa en la cual se realice un corte, ya que puede producir pelusa de algodón e introducirse y posteriormente ocasionar un absceso traqueal.
- Los apósitos deben cambiarse cada vez que se manchen, ya que propician el desarrollo de microorganismos patógenos y laceración de la piel.
- Algunos profesionales prefieren no utilizar apósito en el área de traqueotomía, el apósito conserva la zona húmeda , propiciando infección delostoma.(Seguir normas infectologicas de la institucion)
- Cambiar las cintas de la cánula de traqueotomía, de preferencia contar con ayuda de otra persona para que con las manos dotadas con guantes estériles sujete y mantenga el tubo de traqueotomía en su sitio mientras se cambian las cintas (puede haber expulsión accidental de la cánula si el paciente tose o se mueve).
- De no ser posible la ayuda, las cintas limpias deberán ser atadas antes de retirar las sucias.
- Acondicionar al paciente en una situación cómoda y confortable.
- Mantener disponible el equipo para aspiración de secreciones.
- Lavar el equipo y enviarlo para su desinfección y esterilización.
- Registrar en Hojas de Enfermeria, el procedimiento realizado y las observaciones de las condiciones de la estoma (irritación, enrojecimiento, edema, aire subcutáneo) y las características de las secreciones.

POSIBLES COMPLICACIONES

- Obstrucción traqueal.
- Infección del árbol traqueobronquial.
- Expulsión de la cánula.
- Estenosis del ostoma.
- Lesiones de la mucosa traqueal.
- Constricción traqueal.
- Lesiones de la mucosa.
- Fístula traqueoesofágica.
- Infecciones de la herida.

CUIDADO DE TRAQUEOSTOMÍA:

- Se debe tener siempre preparado una canulade traqueotomía en la unidad del paciente .
- De ser factible, tener otra cánula un número menor para utilizar en situacionesde emergencia en la que no se consiga introducir una cánula del mismo tamaño.
- Se debe realizar cambio del vendaje traqueal las veces necesarias, para que semantenga limpio y seco.
- Evitar colocar demasiadas gasas de relleno,que pueden hacer que la cánula se salga.
- La piel del traqueostoma debe lavarse diariamente con agua y jabón.
- Es importanteinspeccionar esta piel para comprobar la presencia de granulomas, irritaciones, necrosis,etc.
- Procurar que la presión de la cánula sobre la piel del ostoma, no sea excesiva.
- Las cintas deben estar lo suficientemente apretadas como para impedir que sesalga la cánula (especialmente en pacientes con cánulas neonatales que sonmás cortas).
- Las cintas traqueales deben estar suficientemente apretadas para permitir, que solo se pueda introducir un dedo entre ellas y el cuello.
- Las cintas deben mantenersesecas y limpias.
- En una traqueostomía recientemente realizada: La cánula de traqueotomía y lascintas deben ser cambiadas por el cirujano a los 5 a 7 días de la intervención. (Nocambiar las cintas de fijacionhasta que el cirujano haya hecho el primer cambio detraqueotomía y evaluado el ostoma para evitar la decanulación accidental).
- En loscambios de traqueotomía es muy importante extender suficientemente el cuello.
- Se debe calcular la profundidad a aspirar con una cánula del mismo tamaño, calculando ladistancia que existe hasta que el agujero más distal de la sonda de aspiración aparezcapor la punta de la cánula.
- Evitar introducir la sonda de aspiración hasta notar resistencia ydespués aspirar.
- En algunas ocasiones puede ser necesaria esta forma de aspiraciónprofunda, pero debemos saber que ocasiona mayor lesión en la mucosa traqueobronquial.
- Utilizar la sonda de aspiración más grande que se pueda introducir por la cánula. Estohace las aspiraciones más eficaces y por tanto más rápidas y menos agresivas.

SE DEBE INFORMAR EN FORMA ESCRITA Y ORAL EL PROCEDIMIENTO EFECTUADO CON FECHA Y HORA DEL MISMO FIRMADO POR EL PERSONAL INTERVINIENTE.

REALIZADO POR:

Lic. Berta Soriano, Jefe Sección U3

BIBLIOGRAFÍA

- Flint Pw: Complications Of Tracheostomy. Complications In Head And Neck Surgery 1993;40:344-358

• Mcmurray Js, Prescott Caj. Tracheotomy In The Pediatric Patient. PracticalPediatric Otolaryngology 1998;35;575-593.

• Carrillo A. Cricotiroidotomía. En Casado J, Serrano A. Urgencias Y Tratamiento Del Niño Grave:Síntomas Guía, Técnicas Y Procedimientos. Ed Ergón, Madrid. 1999;56-61.

• Isaacs Jh, Pedersen Ad. Emergency Cricothiroidotomy. Ann Emerg1997;63:346-349.

• Sherman Jm, Davis S, Albamonte-Petrick S, Et Al. Care Of The Child With A Chronic Tracheostomy.Am J Respir Crit Care Med 2000;161:297-308.

• Conlon A, Kopec Se. Tracheostomy In The Icu. Journal Of Intensive Care Medicine. 2000;15:1-13.

CUIDADOS AL PACIENTE CON TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO CON CATÉTER DE PIC.

DEFINICION

El traumatismo cráneo encefálico (TEC) directo o indirecto, fundamentalmente es una injuria focal o difusa del parénquima encefálico (cerebro, tronco cerebral y cerebelo); asociada frecuentemente a una injuria secundaria como la hipotensión arterial o la hipoxia.
La incidencia pediátrica y la mayor morbimortalidad es en: niños menores de 4 años ocasionados por accidentes domiciliarios y, preferentemente, por caídas (de altura menor a la talla del paciente) en relación a precipitaciones (de altura mayor a la talla del paciente).

LEGISLACION VIGENTE

Ley 24004 Normativa para el desempeño de la Enfermeria Art.3 Inciso 18

PERSONAS HABILITADAS

Lic. En Enfermería
Enf. Profesionales

OBJETIVOS:

- Mejorar la calidad de atención de los pacientes.
- Implementar una herramienta de gestión que permita conocer los pasos a seguir y predecir los cambios oportunos para mejorar el servicio prestado.
- Integración en el trabajo entre el equipo de salud.

RECEPCIÓN EN U.T.I.P-PREPARACIÓN DE LA UNIDAD:

- Box centralizado.
- Cama móvil.
- Respirador armado.
- Monitor multiparamétrico completo.
- FC
- FR
- Tºcentral
- TA (No invasiva e invasiva)
- Capnografía
- Saturometría
- En caso de TEC medición de PIC
- Ambú y máscara.
- Colchón de aire.
- Colchón térmico o caloventor.
- Bombas de infusión continúa.
- Laringoscopio completo.
- Aspiración central con circuito completo.
- Carro de paro COMPLETO.
- Circuito de PAI y PVC preparado.
- En caso de TEC circuito de medición de PIC.
- Salida de O2 y Aire Comprimido.

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA:

- Pacientes período agudo y crítico
- Dependientes
- Requieren observación continúa
- Son vulnerables a cualquier procedimiento
- La tecnología nos ayuda pero no nos reemplaza
- Requieren medidas terapéuticas continúas
- Valoración conjunta con el equipo de salud
- Seguir una secuencia ordenada y lógica para las intervenciones
- Realizar las mismas entre dos operadores
- Control de los parámetros vitales horario
- Conexión a monitor multiparamétrico
- Valorar mecánica respiratoria
- Valorar estado hemodinámico
- Colocar cabecera de la cama a 30º
- Control de drenajes (cantidad y calidad)
- Cabeza en línea media
- Control de balance de ingresos y egresos (evaluar intervalo, horario las primeras hs)
- Control de diuresis (cantidad y calidad) y ritmo diurético
- Control de débito de SOG (cantidad y calidad)
- Colocación de vendas elásticas en miembros inferiores
- Identificar las soluciones parenterales en el extremo proximal al acceso venoso
- Identificar las mismas según droga, concentración y velocidad de infusión
- Rotular los accesos venosos y arterial especificando fecha de colocación y curación

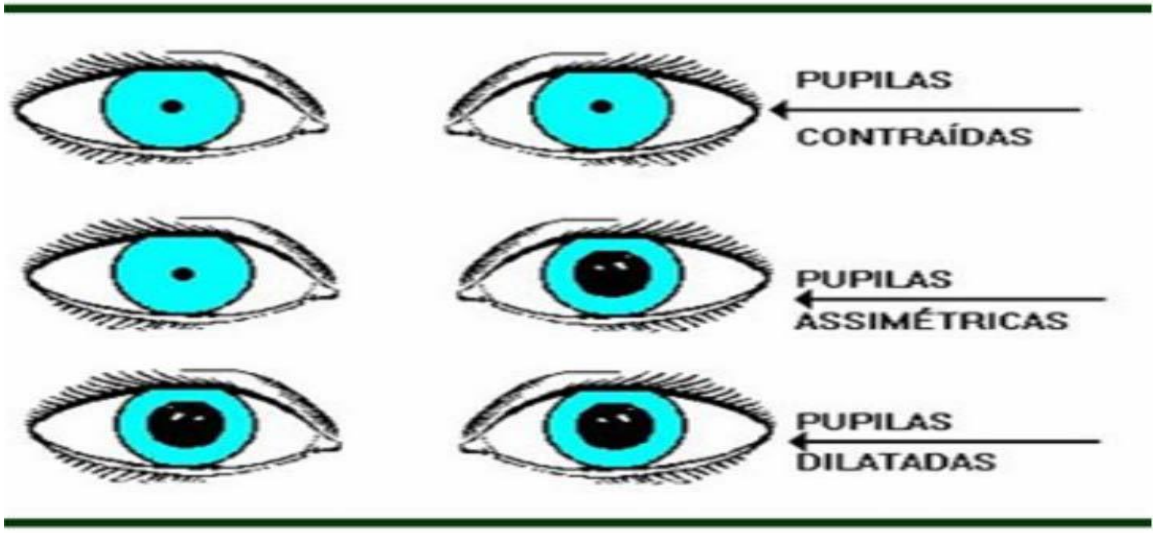
PLUS DE RUTINA:

- Higiene corporal diaria
- Higiene bucal una vez por turno
- Protección de los sitios de apoyo (aceite de siliconas, apósito hidrocoloide, piel médica, colchón de aire)
- Higiene ocular y protección con ungüento oftálmico
- Rotación de sensor de saturometría
- Valoración del dolor
- Valoración de las pupilas

VALORACIÓN DE LAS PUPILAS.

- Tener presente que el orden de las intervenciones deberán ser evaluadas por la enfermera/o de acuerdo a la evolución del paciente
- Evitar estímulos sonoros ajustando los límites de alarmas de monitores, aparatos de ARM y bombas de infusión
- Realizar las prescripciones médicas según indicaciones y horarios establecidos
- Evitar la movilización en las primeras horas del ingreso
- Si el paciente se encuentra intubado constatar fijación del TET
- Colocar en lugar visible un TET similar al colocado
- Previo a las intervenciones administrar medicación prescripta
- Agrupar las mismas estableciendo las prioridades
- Evaluar la respuesta a los fármacos
- Recordar que aún sedado y/o paralizado el paciente escucha y siente

- Seguir las recomendaciones del servicio de control de infecciones del hospital respetando los cinco momentos del lavado de manos.



REGISTRO:

- Registrar cada una de las intervenciones realizadas
- Realizar el registro de la evolución del paciente desde el ingreso hasta la entrega de guardia
- Acondicionar la unidad

REALIZADO POR:
Lic. Beltrán Héctor Ramón, Jefe sección U18

BIBLIOGRAFÍA

- Técnicas Especiales De U.C.I.- Mj. Álvarez, M.P. González, C. Peña, A. Belaustegi, S. Díaz DeDurana, G. Soleto, Mj. Rodríguez, I. Santos. Unidad De Medicina Intensiva
- Del Hospital Txagorritxu, 2004- Edita: Hospital Txagorritxu- Depósito Legal: Vi-264/04

DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO

DEFINICIÒN:

La ventriculostomia o también llamada drenaje ventricular externo, es un procedimiento quirúrgico que permite el drenaje continuo de lìquidocefaloraquideo (LCR) desde el sistema ventricular al exterior.

Este tipo de cirugía se indica en aquellos pacientes que presentan algún tipo de obstrucción en la circulación del LCR y en quienes por diversas causas, generalmente infecciosas o hemorragicas, no puede efectuarse una derivación definitiva al sistema circulatorio o al peritoneo.

El drenaje se realiza por medio de la colocación de un catéter temporario- colocado por el neurocirujano- que drena hacia un sistema de recolección cerrado y estéril.

La infección sistémica, el defectuoso cuidado de las conexiones del sistema de drenaje, las hemorragias intracraneanas, y la apertura del sistema cerrado, son los factores de riesgo más importantes para la infección de la ventriculostomía.

OBJETIVOS:

- Aportar una asistencia de calidad.
- Capacitar al personal de enfermería sobre la técnica de colocación de los dispositivos y su manejo.
- Evitar complicaciones asociadas a un manejo inadecuado de los dispositivos.
- Reconocer los riesgos que conlleva la manipulación y mantenimiento del DVE.
- Conocer los factores de riesgo relacionados con la infección del LCR paraprevenirla y disminuir su tasa de incidencia.
- Mantener el dispositivo DVE aséptico y permeable para evitar alteracioneslocales y sistémicas en el individuo.

El sistema está compuesto por:

- El cateter ventricular.
- Una llave de tres vias que conecta el cateter ventricular con una tubuladura.
- Un cilindro de recolección, cuya altura regula la presión de funcionamiento del sistema.
- Una tubuladura que comunica el cilindro con la bolsa colectora final, que presenta un pico para su desagote.

LEGISLACIÒN VIGENTE

Ley 24004. Normativas para el desempeño de la enfermería.

PERSONAS HABILITADAS
Enfermeros Profesionales
Lic. En Enfermería

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES:
Las medidas de control de infecciones están relacionadas a:

- Preparación del paciente previo a la colocación del catéter (baño prequirurgico)
- Colocación del catéter.
- Manejo del catéter y del sistema.
- Capacitación del personal.

Preparación del paciente previo a la colocación del catéter
Antes de ir al quirófano, el paciente debe recibir 3 baños prequirurgicos (según normas del servicio)

- Con solución antiséptica; en caso de cirugía programada, realizar los baños el día anterior y antes de la cirugía.
- El baño se debe realizar en la sala dónde el paciente se encuentra internado.
- Al realizar el baño prequirurgico se deberá controlar la integridad de la zona a intervenir.

Colocación del catéter

- Se debe colocar en quirófano, con técnica quirúrgica.
- Si por alguna razón se rompe la bolsa colectora, se debe cambiar todo el sistema.

Manejo del catéter y del sistema de drenaje:

Curación del sitio de inserción del catéter

- El sitio de salida del catéter, generalmente se realiza una curación en quirófano.
- Esta curación debe permanecer en todo momento limpia, seca y cubriendo el sitio de salida.
- Solamente debe ser cambiada si se observa sucia, mojada o despegada y fundamentalmente si hay signos o síntomas de infección.
- Luego de las 72 hs dicha curación deberá ser retirada y se colocará gasa estéril previa limpieza de la zona con iodopovidona al 10 %.
- Respetar normas infectologicas de la Institución.

Equipo para manejo del catéter:

- Un par de manoplas limpias;
- Solución de iodopovidona;
- Gasas estériles;
- Tela adhesiva y/o apósito transparente;
- Venda adecuada;
- Guantes estériles.

Procedimiento:

- Dos operadores, uno realizara la técnica limpia y el otro operador la técnica estéril.
- Realizar lavado de manos según normas;
- Colocarse manoplas para retirar la curación; retirar la curación.
- Colocarse guantes estériles;
- Limpiar el sitio de salida del catéter con una gasa estéril embebida en iodopovidona al 10%;
- Cubrir con gasa estéril y fijar con apósito transparente.
- Colocar la venda si es necesario.

Manejo de llave de tres vías:

- La llave de tres vías debe permanecer cerrada y tapada;
- Cada vez que se necesite extraer LCR o colocar medicación, se debe contar con el equipo necesario.

Equipo para manejo de llave de tres vías:

- Un par de manoplas limpias;
- Alcohol al 70%;
- Gasas estériles;
- Guantes estériles;
- Jeringa estéril;
- Medicación adecuada.

Procedimiento para extraer LCR o administrar medicación:
La administración de medicación y extracción de LCR debe realizarla el médico.

- El procedimiento debe realizarse entre dos personas, conservando estricta técnica aséptica.
- Realizar lavado de manos según norma;
- Colocación de manoplas;
- Retirar la gasa que cubre la llave de tres vías;
- Realizar la antisepsia de la tapa de la llave de tres vías antes de desenroscarla, con gasa embebida en alcohol al 70%;
- Destapar la llave de tres vías y colocar la tapa sobre una gasa esteril, cuidando no contaminarla;
- Colocarse los guantes estériles;
- Colocar la jeringa estéril y retirar LCR;
- Si se coloca medicación; el enfermero debe prepararla previamente en la estación de enfermería con técnica aséptica;
- Extraerel mismo volumen de LCR que el de la medicación a inyectar;
- Cambiar la jeringa y administrar la medicación;
- Cerrar la llave de tres vías con su tapa;
- Cubrir completamente la llave de tres vías con gasas estériles.

Drenaje de la bolsa al exterior:
Para drenar la bolsa al exterior se debe contar con el equipo necesario.

Equipo:

- Recipiente tipo riñonera estéril (para vaciar la bolsa)
- Un par de guantes estériles (para manipular el pico vertedor de la bolsa)

Procedimiento:

- Clampear la tubuladura;
- Llevar el equipo necesario al lado de la cama del paciente;
- Limpiar el pico vertedor de la bolsa colectora con la gasa embebida en iodopovidona, antes de abrirla;
- Colocarse los guantes estériles. A partir de este momento se deberá tener cuidado de no contaminarlos;
- Abrir la bolsa y dejar que drene en la riñonera estéril;
- Finalizado el vaciado, el operador, con guantes estériles, tapa nuevamente el pico

vertedor;
- Verifica el correcto cerrado del sistema; observando que el clamp ajuste el pico vertedor;
- La bolsa no debe quedar abierta ni perder LCR;
- Desclampear la tubuladura.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Manipular el sistema de forma aséptica, y evitándo hacerlo siempre que se pueda, por el riesgo de infección.
- Es importante realizar una adecuada higiene de manos, utilizar guantes estériles y barbijo quirùrgico previo a su manipulación.
- Que la cámara de goteo esté colocada correctamente.
- La posición del paciente suele ser decúbito supino con cabecera en 25º a 30º y el sistema suele estar a la altura del paciente si no hay contraindicación médica.
- Vigilancia neurológica estrecha.
- Para poner el sistema a cero, se toma como referencia el Conducto Auditivo Externo (CAE) del paciente, ya que anatómicamente coincide con el orificio de Monro y los ventrículos cerebrales.
- La bolsa de recogida debe estar por debajo del nivel del paciente.
- El punto de inserción se cura cada 24h y siempre que el apósito esté manchado o despegado. Se realiza una cura plana de forma estéril.
- Es importante vigilar la posición del catéter, el punto de inserción (que no drene LCR alrededor), la permeabilidad, esterilidad del drenaje y sus conexiones.
- Registrar el volumen, aspecto y color del LCR diariamente o según protocolo de cada unidad.
- Hay que avisar al médico responsable si drena más de 20 ml/h. Reponer volumen a volumen o según prescripción médica.
- Registrar en hoja de balance ,volumen extraído y volumen repuesto
- Tras la movilización o higiene del paciente hay que volver a hacer el cero en el sistema comprobando que todo está correctamente alineado.
- Si el paciente tiene que hacerse alguna prueba diagnóstica se suele cerrar el sistema, salvo que haya contraindicación médica.
- El vaciado de la bolsa colectora se realiza cuando el lìquido ocupe las tres cuartas partes de la misma.

No Tocar La Llave Innecesariamente Y No Horizontalizar Ni Invertir La Posición Del Cilindro Evitando Mojar El Filtro.
Registrar en hoja de enfermería el procedimiento realizado, sello y firma del agente actuante .

Realizado por: Lic Héctor Beltrán, Jefe de sección de neurocirugía

Bibliografía

- Técnicas Especiales De U.C.I.- Mj. Álvarez, M.P. González, C. Peña, A. Belaustegi, S. Díaz DeDurana, G. Soleto, Mj. Rodríguez, I. Santos. Unidad De Medicina Intensiva
- Del Hospital Txagorritxu, 2004- Edita: Hospital Txagorritxu- Depósito Legal: Vi-264/04

HIGIENE DE MANOS

DEFINICION
La higiene de manos es el más simple, económico e importante procedimiento en la prevención de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), logrando reducir su incidencia cuando se realiza de manera adecuada.
Existen varias técnicas de higiene de manos, dependiendo de la situación clínica, el lugar y los recursos disponibles.

OBJETIVO
- Remover o eliminar la flora microbiana resistente o transitoria de la piel en forma mecánica, adquirida por contactoreciente con los pacientes o material contaminado.
- Prevenir la aparición de las infecciones nosocomiales y evitar las infecciones cruzadas.

LEGISLACION VIGENTE
Ley 24004.Normativa para el ejercicio de la enfermeriaArticulo 3 Inciso 18.
Ley Seguridad E Higiene En El Trabajo 19557,Art.118 Al 203.

PERSONAS HABILITADAS:
El equipo de salud, pacientes y familiares

MATERIALES
- Agua
- Jabón normal (con dispensador automático)
- Toalla de papel
- Jabón antiséptico (si corresponde)
- Tener Presente las normas Infectologicas de la Institución.

PROCEDIMIENTO
Lavado Básico:
- Abrir el agua, regular el flujo y mojar las manos.
- Aplicar jabón antiséptico.
- Enjabonar manos y muñecas friccionar enérgicamente los espacios interdigitales, pulgares y uñas (no utilizarcepillo), durante 15-30 segundos como mínimo.
- Enjuagar minuciosamente frotando las manos bajo el agua.
- Secar perfectamente manos y muñecas sin olvidar espacios interdigitales con otra toalla de papel.
- Cerrar el grifo con toalla de papel que se desechará.

OBSERVACIONES
En el lavado de manos básico se debe tener las manos más altas que las muñecas para que el agua fluya,desde las puntas de los dedos hacia los antebrazos.
El empleo de guantes no excluye la necesidad del lavado de manos.

INDICACIONES
- Al empezar y terminar la jornada de trabajo.
- **Antes y después de**:
  - El Contacto Directo con el paciente
  - Entre tareas y procedimientos con el mismo paciente, para evitar la contaminación entre distintas partes del cuerpo.

- Extracciones sanguíneas.
- Revisar vías urinarias, vasculares y respiratorias.
- Distribuir la comida.
- Preparar la medicación.

➢ **Después de**:

- Manipular Fluidos Corporales.
- Tener contacto con superficies y objetos contaminados.
- Usar guantes estériles.
- Realizar técnicas invasivas.

LAVADO ANTISÉPTICO

➢ **Antes de**:

- Uso guantes estériles.
- Manejo de enfermos inmunosuprimidos.
- Realizar técnicas invasivas con el enfermo como: manipulación de catéteres centrales, inserción de catéteres urinarios, práctica de curas especiales, aspiración bronquial por TET, etc.

➢ **Después de** :

- Quitarse los Guantes

HIGIENE EN SECO DE LAS MANOS

➢ Las soluciones de alcohol con emolientes (glicerina) han demostrado ser eficaces como el lavado de manos convencional.

➢ La OMS señala que la disponibilidad de preparaciones alcohólicas para la fricción de las manos es fundamental para fomentar prácticas eficaces de higiene de las manos entre los profesionales sanitarios, lo cual ha reducido las infecciones relacionadas con la Atención en Salud.

➢ La utilización de preparados de alcohol ha demostrado que mejora el cumplimiento de lavado de manos, tiene beneficios en cuanto costo y efectividad para la disminución de infecciones nosocomiales, hay un mejor apego al uso de soluciones alcoholadas, ahorra tiempo y causa menos dermatitis en las manos.

➢ No Sustituye al lavado de Manos convencional

PROCEDIMIENTO

➢ Aplicar la dosis (3 click) 3 ml aproximadamente de la solución antiséptica sobre las manos libres dematerias orgánicas y secas.

➢ Friccione y frote sus manos, espacios interdigitales y dedos durante 15 segundos o más.

➢ Espere que se absorba o evapore la solución.

➢ No enjuague las manos después de la aplicación

RESPETAR NORMAS DE INFECTOLOGIA HNRG 2017

REALIZADO POR:

Lic.Torreiro, Lorena; Jefe Sección UTIP

BIBLIOGRAFIA

➢ Dra. GentileAngela-Lic. Beltran, Elizabeth-Lic Cabrera, Mariela .Normas Practicas para el control de Infecciones 2017,HNRG –Servicio de Epidemiologia

➢ Verri Espinosa, Alejandra.Manual De Procedimientos De Enfermería Del Niño Y Del Adolescente, Escuela De Enfermería Sede Chillan,2012.

HIGIENE DE LOS PACIENTES EN CAMA

El baño en cama es el conjunto de actividades dirigidas a proporcionar el aseo corporal y comodidad del paciente; incluye la superficie corporal y mucosas externas, es el cuidado que se le proporciona al paciente cuando está incapacitado para hacerlo por sí mismo.

OBJETIVO

- Satisfacer las necesidades de higiene y confort del paciente durante su hospitalización.
- Evitar infecciones.
- Proporcionar bienestar.
- Disminuir la temperatura en caso de hipertermia.
- Prevenir las úlceras por presión.
- Mejorar la calidad de vida de la persona que lo recibe.
- Recoger datos que permitan visualizar el estado general del paciente, así como el estado de su piel.
- Activar la circulación sanguínea.
- Evitar las enfermedades de la piel más comunes, manteniendo una adecuada higiene.

LEGISLACIÓN VIGENTE

La Ley 26.529, Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.Art. 2° y el 10° se refieren al derecho y obligaciones del paciente.

Art. 2º, Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se trate, los siguientes:

a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente;

b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes, le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes;

c) Intimidad. Toda actividad médico - asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley Nº 25.326;

d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente;

e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley Nº 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud;

f) Información Sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información.
g) Interconsulta Médica. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud.

PERSONAS HABILITADAS
Lic En Enfermería
Enf. Profesionales
Aux. De Enfermería

MATERIALES
Equipo de protección personal (bioseguridad).
Paño para higiene corporal activado con clorhexidina.
Agua a temperatura adecuada.
Ropa de cama.
Jarra y palangana.
Toalla o sábana limpia.
Guantes o manoplas.
Pañal.
Bolsa para ropa sucia.
Material a aportar por el paciente.
Jabón, se utilizará en caso de que el paciente sea alérgico al antiséptico.
Peine.
Toallas de baño.
En caso que no hubiese paño para realizar la higiene se utilizará:
Clorhexidina al 4%.
Gasas no estériles.

PROCEDIMIENTO
- Realizar lavado de manos.
- Preparar todo lo necesario, poniéndolo a mano y ordenado.
- Informar al paciente sobre el procedimiento a realizar.
- Comprobar que la temperatura de la sala sea adecuada y haya intimidad.
- Colocarse equipo de bioseguridad, barbijo si es necesario, camisolín y guantes.
- Retirar la ropa de cama tapando a la persona cuidada.
- Retirar electrodos, cables de electrocardiograma y sensor de temperatura.
- Situarse a un lado de la persona cuidada
- Llenar la jarra de agua, comprobando que la temperatura sea adecuada, y verter sobre la palangana.
- Limpiar los ojos del canto interno al externo con una gasa humedecida distinta para cada ojo. Si hay secreciones irrigar con solución fisiológica.
- Secar bien los ojos, usando gasas.
- Limpiar la nariz con una gasa, si hay costras reblandecerlas con vaselina antes de retirarlas.
- Lavar, enjuagar y secar la cara y las orejas sólo con agua.
- Cambiar el agua de la palangana por agua limpia.
- Introducir gasas no estériles en la palangana.

- Una será utilizada para jabonar y la otra para enjuagar; teniendo cuidado de no intercambiarlas.
- En el momento en el que el agua de la palangana esté sucia o se llene de jabón, la cambiaremos por agua limpia de la jarra.
- Echar el antiséptico en la palangana.
- Poner la palangana de jabón sobre la cama e introducir la mano de la persona cuidada en ella, jabonar muy bien, haciendo hincapié en las uñas y entre los dedos. Enjuagar y secar muy bien entre los dedos; realizar la misma maniobra con la otra mano.
- Sosteniendo el brazo por encima de la muñeca, lavar el hombro, la axila y el brazo; jabonando, enjuagando y secando. Secar bien las axilas. Realizar la misma maniobra con el otro brazo.
- Jabonar el pecho, enjuagar y secar.
- Enjabonar, enjuagar y secar el abdomen con movimientos circulares para estimular los movimientos intestinales, hacer hincapié en el ombligo.
- Descubrir totalmente la pierna más cercana a nosotros, enjabonar, enjuagar y secar muslo y pierna.
- Colocar la palangana con jabón a los pies y si la persona cuidada puede doblar la rodilla, introducirle el pie dentro para jabonarlo. Hacer enfasis en las uñas y entre los dedos, jabonar y secar muy bien. Si los pies o las uñas de los pies de la persona están en muy mal estado, se recomienda hacer un aseo especial de ellos.
- Repetir la operación completa con la otra pierna y con el otro pie.
- Colocar al paciente en posición de Sims; enjabonar, enjuagar y secar la region dorso-lumbo-sacra, utilizando movimientos circulares.
- Colocar al paciente en posición supino y lavar la región genital, bastará con jabonar, enjuagar y secar muy bien la ingle y la zona genital externa.
- Lavado de cabeza
- Colocar la palangana seca sosteniendo la cabeza del paciente hiperextendiendolo, colocar antiséptico realizando suaves movimientos generando espuma, luego de eso enjuagar con agua limpia en forma de lluvia desde la coronilla hacia atrás de manera en que arrastre la solución antiséptica hacia la palangana protegiendo ojos y oídos. Secar con suaves movimientos.
- Terminado el aseo, secar si hubiese colchón de aire y realizar cambio de ropa de cama.
- Peinar si es necesario.
- Acondicionar al paciente.
- Este procedimiento se realizará de esta manera cuando no haya paño de higiene personal activado con clorhexidina.
- **Registrar el procedimiento en la Hoja de Enfermería**

OBSERVACIONES

- Observar y evitar que los accesos vasculares, arterial y tubo orotraqueal durante el baño, se desplacen y/o retiren de manera accidental.
- Procurar que el baño no dure más de treinta minutos.
- Observa cuidadosamente la piel de la persona en busca de signos de úlceras por presión.
- Controlar los signos vitales para evaluar la condición del paciente previo a realizar la higiene.
- Revisar las prescripciones médicas para ver si no hay alguna contraindicación para la movilización del paciente.
- Suspender el baño si el paciente presenta alteraciones e informar lo observado.
- Descubrir al paciente lo menos posible para evitar enfriamiento.

HIGIENE DE LA CAVIDAD BUCAL

La cavidad bucal es un excelente medio de cultivo para las bacterias, no sólo por las zonas en las que se pueden alojar, sino porque en pacientes críticos se produce la pérdida de la sustancia protectora del diente llamada fibronectina, lo cual provoca que los bacilos gramnegativos se adhieran a su superficie.

El objetivo, por tanto, para disminuir las neumonía asociada a ventilación mecánica sería reducir la carga bacteriana con la aplicación tópica de clorhexidina en la cavidad oral.

La clorhexidina es un antimicrobiano con acción sobre los grampositivos y gramnegativos. Una clara ventaja de esta técnica es que no afecta a la flora intestinal normal. Sin embargo, no previene la infección por organismos multirresistente como pseudomona o acinetobacter.

En cuanto a la temporalidad se debe realizar cada 6 horas, aunque un exceso en el cuidado oral puede eliminar los beneficios previos.

MATERIALES

Equipo de protección personal (bioseguridad).
Guantes.
Gasa estéril.
Baja lengua.
Cinta de seda.
Clorhexidina 0,12%.

PROCEDIMIENTO

Lavado de manos.(Ver normas infectologicas)
Preparar el material adecuado.
Colocarse equipo de bioseguridad.
Explicar al paciente el procedimiento
Colocar al paciente en posición supino.
Abrir la boca y observar lengua y mucosas, en caso de percibir anomalías avisar al médico.
Colocar gasa en un extremo del baja lengua y fijarlo con cinta de seda (preparar cinco).
Embeber la gasa en clorhexidina 0,12%.
Introducir la gasa embebida dentro de la cavidad oral comenzando por uno de los lados de la mejilla en forma de arrastre desde adentro hacia afuera y descartar.
Repetir maniobra en la otra mejilla.
Higienizar la lengua y el paladar, descartar la gasa.
Lavar los de dientes de manera circular, descartar la gasa.
Registrar el procedimiento en la hoja de Enfermería

HIGIENE OCULAR

Es la limpieza de las secreciones de los ojos en los pacientes con parálisis o coma que trastornan o suprimen el reflejo corneal.

Conjunto de actividades realizadas para la protección y prevención de la conjuntiva.para Mantenerlas libres de infecciones, que pueden desencadenar un daño temporal o permanente.

Cuando las glándulas lagrimales funcionan de una manera normal, los ojos se lavan continuamente con su secreción y no necesitan limpieza adicional. Si sobreviene una enfermedad ocular (irritación, infecciones), o cuando el mecanismo neuromuscular que protege los ojos mediante el parpadeo no funciona en forma adecuada, el enfermero puede necesitar proteger y/o limpiar los ojos del paciente.

Si se pierde el reflejo del parpadeo, como la inconsciencia profunda en la parálisis o el coma, debe mantenerse el cuidado frecuente de los ojos.

OBJETIVO

- Mantener, proteger y/o sustituir la hidrataciónfisiológica de la mucosa ocular atraves de un agente químico
- Cuidar con frecuencia los ojos de los pacientes con parálisis parpebrales o inconscientes,para evitar que se produzcan úlceras o inflamación en la córnea expuesta.

MATERIALES

- Equipo de bioseguridad.
- Guantes.
- Gasa estéril.
- Solución fisiológica 0,9%.
- Jeringa de 5 ml.
- Gel oftálmico estéril (ácido poliacrilico 0,2%).

PROCEDIMIENTO

- Lavado de manos, (Ver normas infectologicas)
- Preparar el material necesario.
- Colocase equipo de bioseguridad.
- Explicar al paciente el procedimiento.
- Llenar la jeringa de 5 ml, con suero fisiológico.
- Doblar una gasa por la mitad y la colocar debajo del ojo que vamos a limpiar.
- Con una mano abrir el parpado y con la otra colocar la Solución Fisiológica, desde la zona interna hacia la externa.
- Secar el ojo con la gasa de abajo, colocar gel oftálmico, y aplicar con el ojo abierto sobre el parpado inferior.
- Cerrar el ojo.
- Cada 6 horas realizar la técnica.
- Quitarse los guantes y lavarse las manos.
- Ocluir el ojo si se encontrase abierto para evitar lesiones.
- Registrar el procedimiento en la hoja de enfermería.

REALIZADO POR:

Lic. Vazquez, Laura, Enfermera asistencial UTIP
Lic. Torreiro, Lorena, Jefe de seccion UTIP

BIBLIOGRAFIA

- http://tareasbasicasdeenferemria.blogspot.com.ar/2015/02/tipos-de-banos-del-paciente.htmlcentrohttp://www.hospitaldejove.com/archivos/enlaces_1437728273.pdf
- http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/norma.htm
- http://www.buenosaires.gob.ar/hospitalargerich/informacion-para-pacientes/derechos-y-obligaciones-del-paciente
- http://www.hospitaldejove.com/archivos/enlaces_1437728273.pdf
- https://www.bse.com.uy/wps/wcm/connect/3c525e66-03b8-42a6-860e-018cb8cecb43/CLORHEXIDINA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3c525e66-03b8-42a6-860e-018cb8cecb43
- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130239916300748
- http://basicaucv.blogspot.com.ar/2013/10/pacientes-con-necesidad-de-higiene-y.html
- http://anestesiar.org/rear/volumen-4/numero-06/357-enfermeria-del-critico-manejo-del-paciente-intubado-parte-1-
- http://www.who.int/gpsc/5may/Poster_Pediatric_consultation_Sp.pdf?ua=1

INDUCCION AL PERSONAL DE RECIENTE INGRESO

DEFINICION:
Proceso de inducción del personal, Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los trabajadores de reciente ingreso (puede aplicarse así mismo a las transferencias de personal de un sector a otro de la institución), durante el período de desempeño inicial ("periodo de prueba").
Con el Objetivo, de mejorar la adaptación de todos los enfermeros nuevos que llegan a nuestro hospital, se solicita Realizar un acompañamiento, durante el proceso de inducción profesional, mediante la formación Continua.

OBJETIVOS

- Favorecer la adaptación del personal entrante para mejorar la calidad de atención, mediante la capacitación continua.
- Elaborar y diseñar programas y planes de trabajo basados en necesidades detectadas, flexibles de cambio y constante actualización, para favorecer el desarrollo humano y académico indispensable para la atención.
- Favorecer la preparación, desarrollo humano y académico del personal de enfermería por medio de programas de educación continua, que contribuyan al fortalecimiento y cohesión del grupo.
- Desarrollar los programas de educación continúa para personal profesional de enfermería fortaleciendo su preparación y liderazgo académico en la práctica de enfermería con el fin de que la atención que se brinda al paciente sea adecuadamente ensamblada entre los miembros de salud.
- Reducir el nivel de ansiedad y nerviosismo a que se exponen, las personas al ingresar por primera vez a su lugar de trabajo.
- Ofrecer la información necesaria para trabajar en forma cómoda y eficaz.
- Ayudar al nuevo trabajador a comprender los aspectos específicos de su trabajo en la organización.
- Facilitar al personal de nuevo ingreso, los aspectos sobre procedimientos, organización, marco jurídico-laboral propios de la organización.
- Promover la adaptación de los nuevos empleados con los demás empleados de la organización.

LEGISLACION VIGENTE
Ley 24004-Normativa para el ejercicio de la Enfermería- Cap.III De los derechos y obligaciones (art. 9 y 10)
Art. 9. - d) Contar, cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia laboral o en la función pública, con adecuadas garantías que aseguren y faciliten el cabal cumplimiento de la obligación de actualización permanente a que se refiere el inciso
Art. 10. - d) Ejercer las actividades de la enfermería dentro de los límites de competencia determinados por esta ley y su reglamentación;
e) Mantener la idoneidad profesional mediante la actualización permanente, de conformidad con lo que al respecto determine la reglamentación.

PERSONAS HABILITADAS
Jefe de división
Jefe de Sección
Personal de enfermería de la Sección Asignada
Lic. En Enfermería
Enfermeros Profesionales

PROCEDIMIENTO
El personal de reciente Ingreso al hospital:
- Realizara una pasantía por el turno mañana.
- Un mes,Por una Sección de Clínica General.
- Un mes, por una Sección de Cuidados Críticos.
- La rotación por las diferentes secciones , será designada por Sub-Gerente de Enfermería, Sub- Jefe De Departamento y Jefe de Sección Docencia e investigación
- Sera evaluado, por el jefe de la sección, por donde efectuara su pasantía.O por el personal al que le fue asignado. Antes de pasar a su turno definitivo.
- La Evaluación se elevara por escrito a este Departamento.
- Se tendrá en cuenta el desempeño y la experiencia que el agente tenga en el cargo, lo que determinara que la pasantía fuese de más o menos tiempo.

Información que debe conocer el nuevo integrante de la organización.
  - Conocer la historia de la organización
  - Visión, misión y sus objetivos
  - Perfil del desempeño
  - Horarios, Días de pago, Vacaciones, Francos,etc.
  - Estructura de la organización
  - Políticas de personal
  - Prestaciones y Beneficios.
  - Recursos Humanos entrega una hoja con información el día que pasa a su horario definitivo al personal de reciente ingreso, con datos administrativos.

- El departamento de Enfermeria le entregara un Instructivo, con material bibliográfico, con informaciónAdministrativay Teórica, al pasar al turno definitivo.
- El Jefe de división del Turno, le asignara la sección donde desempeñara su trabajo.
- El jefe de Sección, le asignara la persona que lo acompañara en el proceso de inducción.
- Los doce primeros meses no se rotara al personal de reciente ingreso.(Bajo ninguna circunstancia)
- Se lo evaluara a los tres meses de estar en su horario definitivo.
- La Evaluación será Conceptual, actitudinal, procedimental y de Conocimientos teóricos prácticos. La misma estará a cargo del jefe de división, quien la elevara a este departamento por escrito.
- El Jefe de división o El jefe de sección, le establecerá los objetivos que deberá alcanzar para la próxima evaluación que se efectuara a los tres meses de realizada la primera.
- La capacitación continua al personal de reciente ingreso, estará a cargo del Jefe de sección y el jefe de división, en forma conjunta con la Jefa De Sección Docencia e investigación, durante un año.
- Se deberá Instruir sobre normas de Bioseguridad de la Institución.
- Se entregaran, Normas y Protocolos que se aplican en la sección donde efectuara su inducción laboral.
- Se informara sobre riesgos laborales y el marco legal que lo protege.
- La Evaluación deberá ser entregada en forma escrita al Subjefe de Enfermeria y elevada a la Subgerente de Enfermeria del HNRG-CABA.

REALIZADO POR:

Lic. Aydee Carrasco, SubGerente de Enfermeria – HNRG-CABA

Lic. Aguirre, Estela M. ; Jefe Sección Docencia e Investigación-HNRG-CABA

BIBLIOGRAFIA

- Dra. GentileAngela- Licbeltran, Elizabeth-Lic Cabrera, Mariela .Normas Practicas Para El Control De Infecciones 2017,HNRG –Servicio De Epidemiologia
- Verri Espinosa, Alejandra. Manual De Procedimientos De Enfermería Del Niño Y Del Adolescente, Escuela De Enfermería Sede Chillan, 2012.
- Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo ley 19.587 • Decreto Reglamentario 351/97 Decreto 1338/96 Resolución 295/03
- Ley de Riesgo del Trabajo 24.557 Resolución 43/97 SRT
- Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051 • Decreto 831/93
- Ley de Residuos Patogénicos 154/99, Decreto 1886/01, Decreto 706/05, Norma IRAM 80.059
- http:/www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/ar/mdroGuideline2006.pdf.
- www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm
- De la O de Cruz, Reina Emperatriz. Administración de los Servicios de Enfermería Tomo I. Colección de Libros de Texto para Estudiantes de Enfermería, Proyecto Fortalecimiento en la Educación para Enfermería, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El Salvador, 2003.
- Marriner-Tomey, Ann. Administración y Liderazgo en Enfermería, 5ª. Edición HarcourtBrace S.A. Madrid, España, 1996. 67 Documento Derogado
- Manual Administrativo Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) Septiembre/2002, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
- Documento Análisis FODA. Supervisión de los Servicios de Enfermería en Hospitales del Ministerio de Salud. Enfermeras Supervisoras Hospitalarias, Mayo 2003.

MANEJO DE ROPA DE CAMA DE PACIENTESEN TRATAMIENTO CON CITOSTÁTICOS.

DEFINICION:

Se entiende por Bioseguridad al conjunto de medidas que van a prevenir la ocurrencia de eventos, que resulten en daños a la salud de las personas; basándonos en esta definición de Bioseguridad podremos afirmar en lo referido al manejo de ropa de cama de pacientes con tratamiento de citostáticos lo siguiente:

- Los fluidos biológicos y excretas de pacientes en tratamiento citostático pueden tener un alto contenido de estos medicamentos o sus metabolitos.
- El personal en contacto con los mismos debe adoptar las medidas de precaución adecuadas a cada caso. La manipulación se debe realizar siempre con guantes de látex, mascarilla, y gafas y bata impermeable en el caso de riesgo de salpicadura.
- La ropa y lencería de paciente que haya recibido medicación citotóxica en los últimos 7 días, y que este contaminada de excretas, (orina, vómitos,...) se coloca dentro de una bolsa para material lavable, y esta dentro de otra impermeable señalizada, para una vez en lavandería retirar la bolsa impermeable y hacer un primer lavado con lejía, para después proceder a un lavado habitual. Todo el personal en contacto con estas ropas debe usar guantes y bata.
- No se deberían eliminar a través de la red de alcantarillado común productos que lleven más de 0,01 de sustancias mutagénicas, teratogénicas, y/o carcinogénicas.
- Para la eliminación de las excretas de los pacientes tratados con estos medicamentos, se debería disponer de sistema de evacuación independiente y dirigido a un colector para materiales peligrosos hospitalarios, con arqueta de registro. Asimismo se debería disponer de estación depuradora propia en los centros sanitarios.
- Las excretas de los pacientes tratados con estos medicamentos pueden tener un contenido elevado de la droga original o de sus metabolitos por ello es necesario tomar precauciones durante el periodo de tratamiento y hasta 48 horas después de la finalización del mismo. Dada la dificultad de desagüe, las excretas deben ser siempre diluidas con gran cantidad de agua. Las personas que vayan a tener contacto con estas excretas o fluidos biológicos deberán adoptar medidas protectoras (guantes dobles, bata impermeable) siendo importantes estas medidas cuando se atiende a pacientes con incontinencia o vómitos.
- La ropa de cama y personal del paciente que pueda estar contaminada con excretas debe almacenarse en bolsas especiales lavables y trasportarse a la lavandería en bolsas impermeables resistentes y convenientemente etiquetadas, extrayéndolas de las bolsas impermeables cuando se vaya a realizar su prelavado con solución de hipoclorito de sodio (ropa + bolsas lavables). El personal de lavandería utilizará guantes de látex y batas desechables mientras que manejen el material prelavado.
- En Hospital de Día, no se aconseja usar ropa de tela sino cobertores descartables y hemorrepelentes. Para los vómitos se aconseja el uso de recipientes con bolsa de micronaje adecuado y luego se descarta en bolsa roja en el contenedor de material biológico.)

OBJETIVOS.

- Evitar la contaminación del medio ambiente con desechos procedentes del uso de drogas Citostáticas.
- Evitar la contaminación tóxica del personal a cargo de la manipulación de la ropa de cama del paciente con tratamiento de citostáticos.

- Dar a conocer las normas vigentes en la Argentina sobre el manejo de desechos y excretas contaminadas con material citostáticos.

LEGISLACION VIGENTE.

- El Instituto Nacional del Cáncer (INC) y el Ministerio de Salud bajo la Precedencia de la Nación han elaborado un conjunto de normas llamadas Procedimientos para la preparación, administración y desecho de drogas citostáticas.
- Ley 24004 .Normativas para el Ejercicio de la Enfermería Anexo I Articulo 1º incisos C y D , de los Deberes del profesional.
  Articulo 3º Incisos 1,2,6,9,18: a, b, c, d, j, m, ñ. Sobre las competencias especificas del nivel profesional. C: 1, 2, 3, 4,5, 6, 17. Sobre las competencias especificas del nivel de Auxiliar de Enfermería.

PERSONAS HABILITADAS

Equipo de salud en su totalidad.

SE DEBE VIGILAR EN EL PACIENTE.

- Una correcta forma de evacuación orgánica, para evitar la presencia de sabanas contaminadas con orina, heces, vómitos o impregnación de drogas Citostáticas.

SE DEBE VIGILAR EN EL MANEJO DE ROPA DE CAMA.

- Proveer a la sala de internación de todo el material necesario para evitar riesgos por contacto con material contaminado
- Aplicar el protocolo de manejo de ropa de cama contaminada por un periodo de 7 días posteriores a la última administración de drogas Citostáticas.
- Usar camisolines impermeables, delantales plásticos, guantes de látex, barbijos y antiparras en el manejo de toda Ropa de cama contaminada con secreciones.
- Usar en primera instancia un bolsa para material lavable para enviar la Ropa de Cama contaminada al lavadero y colocar está, dentro de una segunda bolsa impermeable.
- Rotular las bolsas con la frase “Material Contaminado”.
- La recolección de la Ropa se cama se hará en un horario establecido.
- No se deberá arrastrar la ropa de cama contaminada por los pasillos.

MATERIAL NECESARIO.

- Lugar fijo dentro de la sala de internación.
- Contenedor Plástico con ruedas con capacidad suficiente para colocar la ropa de cama usada de toda la sala de internación.
- Bolsas de color verde. Rotulada
- Bolsas de color rojo.Rotulada
- Precintos para el cierre de bolsas.
- Gorro-barbijo
- Guantes de Látex.
- Antiparras.
- Cuaderno de registro de egreso e ingreso de ropa de cama.

LUGAR DEL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION.

- Se deberá usar el mismo lugar previsto para la recolección de ropa de cama diariamente.

TÉCNICA Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

- Vestirse adecuadamente al ingresar a la habitación del paciente, para realizar el cambio de ropa de cama a la hora prevista, previo al retiro de toda la ropa por el personal de lavadero.(ver normas infectologicas)
- Colocar la ropa de cama usada y contaminada con secreciones o drogas Citostáticas en una primera bolsa de color verde siendo de preferencia una bolsa para lavar ropa.
- Sellar con precinto.
- Colocar esta primera bolsa verde dentro de una segunda de color rojo.
- Sellar con precinto.
- Rotular la bolsa con la frase "Material Contaminado" indicando la cantidad de las piezas que contiene.
- Llevar la ropa contaminada al lugar de acopio de toda la ropa usada de la sala.

REALIZADO POR.

- Lic. Marcela Melián, Jefe Division turno noche
- Lic. Gustavo SingStipanicich, Jefe Sección U 9

BIBLIOGRAFÍA.

- Ley 24004/93 Reglamentación Sobre el Ejercicio de la Enfermería.
- Procedimientos para la Preparación, Administración y Desecho de DROGAS CITOSTACICAS Instituto Nacional del Cáncer y Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Noviembre de 2011 Revisado por Lic. Nelson Kohen y Dra. María Viniegra.
- Bioseguridad y Manejo de Citostáticos.http://www.um.edu.uy/docs/bioseguridad_rcb.pdf
- Instituto Nacional del Cáncer. https://www.cancer.gov
- Enfermería Global. Los Citostáticos.http://revistas.um.es/eglobal/article/viewFile/687/719
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España. NTP 740: Exposición Laboral a citostáticos en el ámbito sanitario. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_740.pdf

OXIGENOTERAPIA

DEFINICION:
La oxigenoterapia es una medida terapéutica que consiste en la administración de deoxígeno a concentraciones mayores que las que se encuentran en aire del ambiente, con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. Administrado por vías aéreas. Puede ser de Bajo Flujo de Alto Flujo.
Bajo Flujo
No nos permiten administar una concentración exacta de oxígeno, se regula por la cantidad de litros por minuto. Son:
Canula Nasal: Constan de dos pequeñas cánulas que se introducen por ambos orificios nasales, lo normal es que administremos de 2-4 litros por minuto. Las usaremos en aquellos pacientes que no revistan gravedad. Son más cómodas de usar que otros dispositivos como las mascarillas. La FiO2 oscila entre el 24-40%.
Mascarilla facial simple: Dispositivo de plástico blando que cubre boca y nariz, posee orificios laterales que permiten la salida del aire espirado. El flujo a administrar oscila entre los 5-8 litros, la FiO2 oscila entre el 40-60%. Debe adaptarse bien a la nariz por una banda metálica maleable para evitar fugas, la ajustaremos a la cabeza mediante una banda elástica.
Mascarilla con reservorio: Dentro de los sistemas de bajo flujo, es la que más concentración de oxígeno proporciona. Se trata de un mascarilla facial simple con una bolsa de reservorio en su extremo inferior, esta bolsa tiene una capacidad de unos 700ml aproximadamente. El flujo que administremos puede ir de 6-10 litros y la FiO2 oscilará entre el 60-99%.
OXIGENO TERAPIA POR CÁNULA NASAL DE BAJO FLUJO
Pequeña canuladeplastico blando o poliuretanoque se introducen en los orificios nasales para administrarO2
Debe adaptarse bien a la nariz por una banda metálica maleable para evitar fugas, la ajustaremos a la cabeza mediante una banda elástica

OBJETIVOS:
Administrar oxigeno en concentración inferior al 45 %.
Mantener la saturación adecuada a la patología del paciente.

LEGISLACION VIGENTE
Ley 24004-Normas para el ejercicio de la enfermeria-Art.3 Inciso 18

PERSONA HABILITADA.
Lic. En Enfermería
Enfermeras/os.
MATERIAL NECESARIO
- Cánula nasal o bigotera de acuerdo a la edad del paciente.
- Protector de piel, que puede ser apósito coloidal.
- Tela adhesiva hipoalergica o Apósito transparente.
- Guantes de látex.
- Fuente de O2 con medidor de flujo (flumiter).
- Tubuladuras, prolongadores y adaptadores.
- Agua destilada estéril.
- Humidificador de oxígeno.
- Equipo de aspiración.

PROCEDIMIENTO:
- Informar a los padres y/o al paciente sobre el procedimiento.

- Higiene de manos (según normas) conectar la tabuladora a la fuente de oxigeno.
- Verificar el valor de flujo de oxigeno en el Flumiter según (indicación médica) o la necesidad del paciente verificar la permeabilidad de las narinas diariamente.
- Ubicar la cánula nasal con los orificios o tutores enfrentados a las narinas.
- Colocar protector en la piel en la zona a fijar la cánula.
- Fijar a la cánula con tela adhesiva tipo alergenica o con Apósito transparente.
- Realizar el control de saturación.
- Controlar los signos vitales: FC, FR.
- Registrar e informar los hallazgos en planilla de enfermería.
- Rotular con fecha y hora de colocación.

Ventajas de uso de la cánula.

Confortable permite al paciente hablar y comer.
Ideal para pacientes crónicos estables que deben ser enviados a sus casas con O2.
Utilizar para la administración prolongada de O2 en pacientes con bajón requerimientos.
Se debe vigilar:
Flujo: Es la cantidad de gas a administrar según indicación médica o necesidad del paciente.
Que el Flumiter sea adecuado con medición adecuada al paciente y este bien conectado a la boca del Oxigeno central.

CUIDADOS DE ENFERMERIA.

Controlar que se administre el flujo necesario de O2 en el paciente.
La enfermera/o debe verificar que la cánula siempre este bien fijada.
Observar ambos pómulos del rostro que no presente laceraciones.

SISTEMA DE ALTO FLUJO

La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) consiste en aportar un flujo de oxígeno, solo o mezclado con aire, por encima del flujo pico inspiratorio del paciente, a través de una cánula nasal.
El gas se humidifica (humedad relativa del 95-100%) y se calienta hasta un valor cercano a la temperatura corporal (34- 38ºC). Se expone el mecanismo por el que el alto flujo obtiene mejores concentraciones de O_2, en comparación con sistemas de bajo flujo.
Nos permiten administrar oxígeno a diferentes concentraciones, correspondiendo a cada concentración una cantidad determinada de litros por minuto.
Son:
Mascarilla venturi (Ventimask): permite la administración de una concentración exacta de oxígeno, permitiendo niveles de FiO2 de entre el 24-50%, con una cantidad de litros por minuto que oscila entre 3-15 litros. Este sistema sigue el principio de Bernoulli, es decir, el dispositivo mezcla el oxígeno con el aire ambiental a través de orificios de distinto diámetro.
Mascarillas para aerosoles nebulizados: éstas nos permiten que administremos al paciente fármacos broncodilatadores que se inhalan con la inspiración. Tienen un reservorio donde introduciremos el medicamento indicado por el medico, con 3 o 4 ccSolución fisiológica. El flujo al que se administra suele ir entre los 6-8 litros y tiene una duración de unos quince minutos aproximadamente. Los aerosolos nebulizados también los podemos administrar sin medicamentos, es decir, sólo con Solución fisiológica, siendo muy efectivo para los pacientes con disnea.
Canula nasal de alto flujo:mejora el patrón ventilatorio, disminuyendo la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y las necesidades de oxígeno.
Los dispositivos son fácilmente aplicables, permiten comer, hablar y movilizar a los niños.

CANULA NASAL DE ALTO FLUJO

DEFINICION:

La tendencia a usar CNAF se debe en parte a una percepción de mayor facilidad para su empleo además de una mejor tolerancia por parte del paciente consiguiendoasí mayores beneficios.

Las cánulas nasales son de diferente tamaño según los flujos empleados, deberían tener un diámetro externo menor al interno de la nariz para no ocluir completamente esta y prevenir excesos de presión.

Habitualmente, se utilizan flujos de oxígeno mezclados con aire, aunque también se ha empleado para administrar gases medicinales (p. ej., heliox 70/30, óxido nítrico [NO]) y fármacos en aerosol.

En la actualidad, y a la espera de estudios que confirmen su utilidad, no se recomienda la administración de estos fármacos por estos sistemas.

Es útil en pacientes con hipoxemia pero sin hipercapnia que precisan $FiO_2 > 0,4$ en mascarilla facial (fracaso respiratorio tipo I).

No se considera útil en el fracaso respiratorio tipo II, ya que no reduce los niveles de $PaCO_2$ y no está indicado en retenedores de CO_2 porque reduce el estímulo respiratorio desencadenado por la hipoxia que se produce en la hipoventilación.

OBJETIVOS

Corregir Hipoxia, mediante la administración de O2 con flujo

Administrar concentraciones de oxígeno exactas en pacientes con Insuficiencia Respiratoria (hipoxia)

Mantener una oxigenación adecuada.

INDICACIONES

Niños de 1 a 18 mesescon fracaso de oxigeno terapia de bajo flujo(menor a 4 L/min)

EQUIPO

Cánula Nasal

Equipo de CNAF

Fuente de O2 con medidor de flujo (flumiter)

Humidificador de oxígeno.

Tubuladuras, adaptadores.

Sistema de humidificación, en el flujímetro (medidor de flujo)

Agua destilada estéril.

Equipo de aspiración.

Apósito transparente para la fijación o lo que se utilice según normas infectologicas.

PROCEDIMIENTOS

Lavado de manos (según recomendaciones del Servicio de Control de Infecciones)

Informar al paciente y/o familiar del procedimiento.

Colocar la tabuladora a la fuente de oxígeno y al sistema de humidificación.

Graduar los litros de oxigeno que requiere el paciente de acuerdo lasindicacionesmedicas de Se iniciara con una de FIO2 90 % , recordar que el flujo de la necesidad del paciente (2 L/Kg./min.)

El descenso se realizara de a 5% (0.05)

El destete de la CNAF se realizara cuando el paciente mantenga por 4 Hs. una SaO2 MAYOR del 95% con una FIO2 21 %

El aumento o el descenso de de la FIO2, la realizara el medico.

Verificar la permeabilidad de las narinas.

Colocar la cánula nasal al paciente.
Rotular colocando fecha y horario de colocación.
Registrar los signos vitales: saturación, frecuencia respiratoria, frecuenciacardíaca.
Valorar la tolerancia al procedimiento.
Registrar en la hoja de Enfermería.

VENTAJAS:
Permite variar la FiO2 según la necesidad del paciente.
Dicha variación es exacta independientemente del patrón respiratoriodel paciente.

DESVENTAJAS:
Incomodidad e irritación facial (por fijación).
Laceración de las narinas

RECOMENDACIONES
Valorar del Paciente:
FC
FR
Saturación de O2
Signos de inestabilidad hemodinámica (Sepsis, Shock, Hipotensión)
Deterioro del nivel de conciencia
Convulsiones
Realizar una valoración continua de la tolerancia al tratamiento.
Valorar la necesidad de aumento o disminución del requerimiento real de oxígeno
(Con oximetría o evaluar el trabajo respiratorio.)
Los controles se realizaran cada tres horas .
El medico Evaluara a las 3 hs el estado del paciente

Con SaC2 mayor o igual a 94, durante cuatro Hs. iniciar el descenso de la FiO2

Valorar del Equipo
Controlar:
Conexión adecuada del equipo
Limites de Alarmas adecuados
Flumiter en buen funcionamiento
Nivel de agua del Humidificador
Volumen del Baxter de agua para el humidificador
Recambio por turno de ser necesario.

REGISTRAR EL PROCEDIMIENTO EN LA HOJA DE ENFERMERÍA DESDE EL INICIO DE LA CONEXIÓN CNAF HASTA EL DESTETE DE LA MISMA
NEBULIZACIONES
DEFINICION
Procedimiento que consiste en la administracionde un farmacomediantevaporizacion, a traves de las vias respiratoria.

OBJETIVOS
- Fluidificar las secreciones de la vía aérea.
- Prevenir la sequedad y/o lesión de la mucosa que tapiza la vía superior.
- Administrar fármacos.

EQUIPO

- Fuente de oxígeno o de aire (dependiendo de la patología del paciente) conmedidor de flujo (flumiter)
- Máscara con reservorio para nebulizar. (oro-nasal) o boquilla (bucal)adecuada al paciente (estéril e individual).
- Tabuladoras necesarias.
- Solución fisiológica estéril.
- Medicación según indicación médica.

PROCEDIMIENTOS

- Lavado de manos (según recomendaciones del Servicio de Control de Infecciones)
- Informar al paciente y/o familiar del procedimiento a realizar.
- Adaptar la tubuladura por un extremo al flumiter y el otro extremo a la máscara.
- Controlar la solución a nebulizar, según indicación médica.
- Abrir lentamente el flumiter, verificar su funcionamiento.
- Adaptar la mascara (oro-nasal) o la boquilla (bucal) al paciente.
- Continuar con el procedimiento hasta que finalice durante 10 a 15 minutos.
- Al finalizar el procedimiento, cubrir con el envoltorio que trae de esterilización.
- Registrar el procedimiento.
- Rotular circuito colocando fecha y hora cuando se le habilitó el sistema.

RECOMENDACIONES

Examinar que las condiciones y adaptadores no tengan pérdidas de fluidos.
Evitar realizar uniones de la tubuladura y/o máscara con tela adhesiva.
Aspirar secreciones según necesidad.
Nebulizar antes de la Kinesio- terapia o de drenaje postural con soluciónfisiológica, facilitando así la fluidificación de las secreciones.
Sustituir máscara y tubuladura (según Normas Infectologicas)
Luego de la nebulización enjuagar el reservorio del nebulizador.
Si el paciente tuviera traqueotomía, se aplicará con la boquilla sobre el ostoma.
Enjuagar entre nebulización y nebulización con agua destilada estéril elnebulizador, pasarle alcohol al 70%, (asegúrese que quede limpio yseco) y cubrir con el envoltorio de esterilización o con una bolsa cristal.
Al alta del paciente, Descartar o lavar y esterilizar antes de ser utilizada con otropaciente.

REALIZADO POR:

Lic.: Soriano Berta, JefeSeccionU3
LicGodoy, Magali; JefeSeccion U8
Lic.Godoy, Mirtha; JefeSeccion U7

BIBLIOGRAFIA.

- Manual de Enfermería del 2014. De Organización Panamericana de la salud.
- Manual del Laboratorio; Rocimex, srl.
- Spentzas T, Minarik M, Patters AB, Vinson B, Stidham G. Childrenwithrespiratorydistresstreatedwithhigh-flow nasal cánula. J IntensiveCareMed. 2009;24:323-8.Spentzas et al. estudian la aplicación de oxigenoterapia de alto flujo (OAF) en 46 niños con dificultad respiratoria moderada-grave.
- Schibler A, Pham TM, DunsterKR, Foster K, Barlow A, Gibbons K, HoughJLReducedintubationratesforinfantsafterintroduction of high-flow nasal prongoxygendelivery. IntensiveCareMed. 2011;37:847-52.

- Schibler et al estudiaron a lactantes con bronquiolitis que fueron tratados con OAF y encontraron que menos del 5% de los tratados con OAF se deterioró y requirió intubación.
- Dysart K, Miller TL, WolfsonMR, Shaffer TH. Research in highflowtherapy: Mechanisms of action. RespirMed. 2009;103:1400-5.
- Revisión de los mecanismos propuestos de la eficacia de la terapia de alto flujo, que incluyen lavado nasofaríngeo de espacio muerto, la atenuación de la resistencia inspiratoria asociada a la nasofaringe, la mejora en la conductancia y la distensibilidad pulmonar, la presión de distensión leve y la reducción en el gasto de energía para el acondicionamiento de gas.
- Cuquemelle E, Pham T, Papon JF, Louis B, Danin PE, Brochard L. Heated and humidifiedhigh-flowoxygentherapy reduces discomfortduringhypoxemicrespiratoryfailure. RespirCare. 2012;57:1571-7.
- Cuquemelle et al confirman en este trabajo que el uso de la terapia de oxígeno mediante OAF calentado y humidificado disminuye significativamente la sequedad nasal y confort de los pacientes, la tolerancia y la aceptación de la terapia.
- Ronan O"Driscoll. Emergencyoxygen use. BMJ 2012;345:e6856. doi: 10.1136/bmj.e6856.
- Kallstrom TJ. AARC ClinicalPracticeGuideline: oxygentherapyforadults in theacutecarefacility 2002 revision&update. RespirCare. 2002;47:717-20.
- L"Her E, Deye N, Lellouche F, Taille S, Demoule A, Fraticelli A, et al. Physiologiceffects of noninvasiveventilationduringacutelunginjury. Am J RespirCritCareMed. 2005;172:1112-8.
- Dysart K, Miller TL, Wolfson MR, Shaffer TH. Research in highflowtherapy: Mechanisms of action. RespirMed. 2009;103:1400-5.
- Spentzas T, Minarik M, Patters AB, Vinson B, Stidham G. Childrenwithrespiratorydistresstreatedwithhigh-flow nasal cánula. J IntensiveCareMed. 2009;24:323-8.
- Groves N, Tobin A. High flow nasal oxygengenerates positive airwaypressure in adultvolunteers. AustralianCriticalCare. 2007;20:126-31.
- Schibler A, Pham TM, Dunster KR, Foster K, Barlow A, Gibbons K, Hough JL. Reducedintubationratesforinfantsafterintroduction of high-flow nasal prongoxygendelivery. IntensiveCareMed. 2011;37:847-52.

PASE DE GUARDIA

DEFINICION

El pase de guardia es el relevo del personal de Enfermería, (entre quien se retira y quien lo asume durante su turno), donde se realiza la transferencia de información de índole clínica, (referida a los pacientes), y de índole administrativa,(referida a inasistencia,falla de equipos, falta de insumos,préstamos,etc).

OBJETIVOS

- Permitir la continuidad de atención a los pacientes a través de la transferencia de información relevante de los mismos.
- Posibilitar la optimización de los tiempos y recursos disponibles en relación a las necesidades específicas del paciente.

LEGISLACIÓN VIGENTE

Ley 24004- Normativa para el ejercicio de la enfermería-Art 3 Inciso
Ley 14250resolución 671/2006 reg. 650/2006-Ministerio de trabajo empleo y Seguridad-Misión y función del personal de enfermería.
No hay legislación que contemple el pase de guardia sino que éste se adecua a la normativa vigente en cada institución y pone de manifiesto el compromiso ético de cada profesional en este acto.

QUÉ TENER EN CUENTA

- Permanecer en la unidad o sector hasta que se produzca el relevo con uniforme, al igual que el que recibe la guardia.
- Realizar el pase 10 minutos antes del horario de salida del turno anterior.
- Quien pasa la guardia deberá hacerlo acompañado del chasis de cada paciente, donde se encuentran registrados los datos y novedades de los mismos.(Hoja de Evolucion)
  - **Datos mínimos a informar en cada relevo:**
  - **Nombre y apellido de cada paciente**
  - **Edad**
  - **Motivos de la internacion**
  - **Antecedentes clínicos**
  - **Estado actual**
  - **Alimentacion**
  - **Cuidados realizados/cuidados pendientes**
  - **Situación clínica relevante:**
- **Cómo se recibe al paciente/Cómo se observa al paciente.**
- **Señalar cualquier cambio importante en el estado del paciente.**
- **Al informar sobre los cambios enumerar: la evaluación diagnóstica,el diagnóstico de Enfermería, Planificación de los cuidados, intervenciones y evaluación de resultados.**
- **Situacion del sector (Recurso físico-Recurso material)**
- Relevar el carro de paro completo y notificar las faltas del mismo si las hubiera.
- El área de preparación de medicación limpia y ordenada.
- La unidad del paciente limpia y ordenada
- Informar las altas transitorias,los traslados a estudios o a otras unidadesla fuga de pacientes y los óbitos.

A Destacar:
Participar del pase de guardia con el resto del equipo de salud,permite aportar datos del estado y evolución del paciente durante el transcurso de las 24 horas, como así también conocer los pasos a seguir en el tratamiento del mismo.

REALIZADO POR:

Lic. Godoy Magali, Jefe Sección Unidad 8

BIBLIOGRAFÍA.

- -Actualización de norma vigente.
- -www.madredeus.com.arhttp://hdl.handle.net/123456789/3644
- -Arch Argent.Vol 12 NªBsAs -2014
    - http/dx.doi.org/105546/aap.2014.119

PREPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO DE PARO

DEFINICION

El carro de paro o de emergencias vitales es aquel que contiene todos los elementos necesarios para afrontar una situación de riesgo vital. Contempla una serie de fármacos, insumos y equipos necesarios para afrontar las maniobras de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar).
Un carro de paro es un conjunto de cajones y bandejas sobre ruedas que se emplea en los hospitales para el transporte de medicamentos y dispositivos necesarios para dar una respuesta rápida ante un paro cardíaco u otro tipo de emergencia médica.

JUSTIFICACION INSTITUCIONAL

A partir de la revisión de las guías internacionales, la Asociación Americana del Corazón, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y el Consenso Europeo de Reanimación se busca a través de este documento acordar para:
Brindar una atención adecuada a la víctima clínicamente inestable o en paro cardiorespiratorio.
Realizar la revisión sistemática del carro de paro a intervalos de tiempo establecidos por el servicio, evitando pérdidas de tiempo innecesarias al requerir el uso de dicho carro.

OBJETIVOS

GENERALES

Establecer y estandarizar el manejo adecuado, la integración y suministro de los carros de paro de los servicios del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con el fin de asegurar de manera oportuna y eficiente, la utilización de los equipos, insumos y medicamentos que permitan una adecuada atención de la emergencia.

ESPECIFICOS

Contar con todos los elementos necesarios para recurrir a ellos en el momento de la urgencia.
Corroborar el buen estado de todo el material incluyendo la caducidad de medicamentos y dispositivos.
Facilitar el rápido acceso a fármacos y material necesario para el tratamiento de un paro cardiorespiratorio.

LEGISLACION VIGENTE

Decreto 2497/93 Reglamentación de la Ley de Ejercicio de Enfermería. Buenos Aires, diciembre 9,1993. Anexo 1: Reglamentación de la Ley 24.004
Articulo 3. Inciso 6. Establecer normas de previsión y control de materiales y equipos para la atención de enfermería.
Articulo 3. Inciso 16. Elaborar las NORMAS de funcionamiento de los servicios de enfermería en sus distintas modalidades de atención y auditar su cumplimiento.
Articulo 3. Inciso 18. Letra c. controlar las condiciones de uso de los recursos materiales y equipos para la prestación de cuidados de enfermería.
RESOLUCION 194/95. NORMA 18: Se fijarán los criterios para el uso razonable de cada recurso de manera que se encuentren en condiciones para los procedimientos que corresponden.

PERSONAS HABILITADAS

Lic. en Enfermería
Enfermeros Profesionales
Personal de Farmacia

CONSIDERACIONES GENERALES / CUIDADOS DE ENFERMERIA

El carro de paro debe encontrarse en todos los servicios, cerca de los offices de enfermería o en la sala de Shock Room.

Asegurarse que el carro esté en su lugar.
Solo debe abrirse para la atención del paro cardíaco, revisión periódica de control y auditoria.
Es importante que, al momento de utilizarse el carro de paro, quien asuma la responsabilidad de su manejo lo deje registrado en el libro de novedades de enfermería.
Solicitar reposición de drogas lo más pronto posible, limitando el tiempo que el mismo esté incompleto.
Dentro de las buenas prácticas es importante realizar el monitoreo de medicamentos de forma permanente, en este caso mediante señalización de medicamentos e insumos.
Controlar que el carro cuente con el tanque de oxigeno, revisar el manómetro que deberá indicar que se encuentra lleno o al menos al 50%. Si no es así; notificarlo y pedir la reposición de este, por otro lleno al oxigenero.
Al abrir el carro por una situación crítica, una sola persona se responsabilizará de su manejo en el momento de la emergencia.
El carro debe ser revisado tras su uso y según protocolo del servicio y deben reponerse a la brevedad todos los insumos utilizados.
Asegurarse de que todos los elementos se encuentran en condiciones operativas.

RECOMENDACIONES
El carro de paro debe estar situado en un lugar visible y de fácil acceso dentro de la unidad.
Es importante que esté limpio, ordenado y acondicionado para su uso.
Todo el personal del área debe estar familiarizado con sus elementos.
Debe contener solo el material imprescindible, la acumulación de material dificulta su accesibilidad en el momento de atender una verdadera emergencia.
Los controles deberán ser:
Diario: personal de enfermería controla que el precinto esté intacto y el desfibrilador funcionando correctamente.
Mensual por enfermería: Jefe de Sección de enfermería o enfermero asignado por éste, realiza la apertura del carro de RCP, solicita la limpieza y verifica que el número de precinto sea el último registrado en la planilla de control de apertura, la ubicación y la cantidad de los elementos en el carro, el correcto funcionamiento del laringoscopio controla la fecha de vencimiento de los elementos que corresponda y que no haya elementos ajenos al carro. Por último, revisa el libro de actas con el control diario del cardiodesfibrilador.
Mensual por farmacia: el personal de farmacia verifica que el número de precinto sea el último registrado en la planilla de control de apertura y que ésta esté firmada por el responsable del carro.
El Control Mensual, Se Realizará De Manera Conjunta Entre Farmacia Y Jefe de Sección de Enfermería

Todos Los Registros Se Realizarán En La Hoja De Control De Carro De Paro.

<u>LOS ELEMENTOS DEL CARRO DE PARO NO DEBEN SER USADOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE RUTINA.</u>

CARRO DE PARO-DESFIBRILADOR
En la parte superior del Carro de paro se encuentra el desfibrilador, el mismo debe estar siempre conectado a una fuente eléctrica.
Asegurarse que tenga cargada la batería, marque apagado y tenga papel la impresora. Notificar en caso contrario.
Asegurarse de contar con todos los accesorios del mismo; cables, electrodos y el gel para DEA.
La prueba de funcionamiento se realiza cada 7 (siete) días, pegándose el resumen del test impreso en el libro de novedades de enfermería, con nombre de quien lo realiza, fecha y hora.

AREAS CUIDADOS CRITICOS
CAJON 1
Drogas de reanimación, de uso inmediato
Solución Glucosada Hipertónica al 25% (2 ampollas)
Solución Glucosada Hipertónica al 50% (2 ampollas)
Adrenalina 1 o/oo en ampollas (30 unidades) Mejora la perfusión cerebral y coronaria, por su acción vasoconstrictora
Lidocaína al 1% sin epinefrina (2 ampollas) anestésico local
Atropina 1o/oo en ampollas (10 unidades). anticolinérgico y antiarrítmico.
Adenosina (4 ampollas) Restaurador del ritmo sinusal
Amiodarona (4ampollas) Disminuye la presión Arterial y la poscarga, vasodilatador arterial Periférico. (Cuidados críticos)

MEDICACIÓN PARA SEDOANALGESIA
No es indispensable que estén en el carro de paro, en el sector de guardia se guardará en el carro por ser medicación de uso restringido y para preservar la misma.
Midazolam (5 ampollas) Sedante, inducción y mantenimiento de la anestesia
Fentanilo (5 ampollas) analgésico y Sedante, inducción y mantenimiento de la anestesia
Ketamina (2 frascos) Anestésico General de acción Rápida. Con conservación del reflejo faríngeo - laríngeo y estimulo cardiorrespiratorio
Vecuronio (2 frascos). Coadyuvante de de anestesia general para facilitar la intubación endotraqueal
Morfina (4 ampollas) analgésico agonista de los receptores opiáceos. Ejerce efecto sobre el SNC

CAJON 2
Drogas de sostén, de soporte.
Dopamina (4 ampollas) Agente inotrópico
Dobutamina (EN HELADERA 2 ampollas)
Nitroprusiato de Na (2 frascos) Agonista de los receptores Beta. inotrópico positivo.
Milrinona Lactato (4 ampollas) Aumenta la fuerza de la contracción del musculo cardiaco
Naloxona (2 ampollas) Revierte total o parcialmente la depresión respiratoria inducido por opioides.
Flumazenil (2 ampollas) Sobre dosis benzodiacepinas.
Bicarbonato 1 Mol
Gluconato de Calcio 10%
Cloruro de Calcio 10%
Solución de Ringer
Solución de Manitol
Dextrosa al 10%

CAJON 3
Vía aérea, elementos de accesos venosos
Bolsa de ventilación manual tipo ambú con reservorio tamaño adulto, pediátrica y neonatal (1 de cada tamaño).
Máscara para ambú de todos los tamaños (2 de cada uno).
Cánula de mayo o Guedel varias (1 de cada tamaño)
Sondas de aspiración varias (2 de cada tamaño)
Tubos endotraqueales de todos los tamaños con y sin balón (al menos 2 de cada calibre), todos con su envoltorio íntegro y correctamente identificado el tamaño.
Lubricante.
Tubo de oxígeno portátil con flumiter (se encuentra en sala de Shock Room con carro propio)

Jeringas de 5 y 10 ml. para inflar balón de tubo ET. y máscara de ambú.
Tela adhesiva (1 rollo)
Sugerencia: Máscara laríngea 1 de cada tamaño para pacientes de intubación dificultosa.

EQUIPO PARA ACCESO VENOSO
Catéter de teflón tipo Abocath de diferentes calibres (varias unidades).
Aguja para acceso intraóseo trócar o tipo Jamshidi de diferentes calibres / pinza tipo kocher para fijación /presurizador.
Guías para administración de soluciones parenterales macrogotero, llaves de tres vías (varias unidades).
Prolongadores cortos y largos (varias unidades).
Jeringas de 1, 3, 5, 10 y 20 ml. (varias unidades de cada una).
Agujas 25/8 o similar (varias unidades).
Solución Fisiológica sachet de 500ml. (2 unidades)
Ampollas de: Agua destilada, Solución Fisiológica (varias)
Contenedor para material corto punzante.

CAJON 4
Accesorios. Laringoscopios
Laringoscopios con ramas rectas y curvas en tamaño neonatal, pediátrico y adulto (En sala de Shock Room) O lugar accesible del servicio.
Pilas de repuesto para los laringoscopios
Pinza de Magill tamaño pediátrico y neonatal y/o mandriles en diversos tamaños (para pacientes de intubación dificultosa).
Antiparras (al menos 2)
Guantes de exanimación (1 caja)
El laringoscopio debe ser probado con cada rama, y en cada control (manipularlo con guantes durante la RCP)
Conocer e identificar cada rama (recta, curva, número)
En caso de NO FUNCIONAR una rama: notificar. Registrar en el libro de novedades de enfermería.

AREAS DE CLINICA GENERAL
Drogas de reanimación, de uso inmediato
Solución Glucosada Hipertónica al 25% (2 ampollas)
Solución Glucosada Hipertónica al 50% (2 ampollas)
Adrenalina 1 o/oo en ampollas (30 unidades). Mejora la perfusión cerebral y coronaria, por su acción vasoconstrictora
Lidocaína al 1% sin epinefrina (2 ampollas) anestésico local
Atropina 1o/oo en ampollas (10 unidades). anticolinérgico y antiarrítmico.
Adenosina (4 ampollas) Restaurador del ritmo sinusal

MEDICACIÓN PARA SEDOANALGESIA
No es indispensable que estén en el carro de paro, en el sector de guardia se guardará en el carro por ser medicación de uso restringido y para preservar la misma.
Midazolam (5 ampollas) Sedante, inducción y mantenimiento de la anestesia
Fentanilo (5 ampollas) Analgésico y Sedante, inducción y mantenimiento de la anestesia
Ketamina (2 frascos) Anestésico General de acción rápida. Con conservación del reflejo faríngeo-laríngeo y estimulo cardiorrespiratorio
Vecuronio (2 frascos). Coadyuvante de de anestesia general para facilitar la intubación endotraqueal

CAJON 2
Drogas de sostén, de soporte.
Dopamina (4 ampollas) Agente Inotrópico
Naloxona (2 ampollas) Revierte total o parcialmente la depresión respiratoria inducido por opioides.
Morfina (4 ampollas) Analgésico agonista de los receptores opiáceos. Ejerce efecto sobre el SNC
Flumazenil (2 ampollas) Sobre dosis benzodiacepinas.
Bicarbonato 1 Mol
Gluconato de Calcio 10%
Cloruro de Calcio 10%
Solución de Ringer
Solución de Manitol
Dextrosa al 10%

CAJON 3
Vía aérea, elementos de accesos venosos
Bolsa de ventilación manual tipo ambú con reservóreo tamaño adulto, pediátrico y neonatal (1 de cada tamaño).
Máscara para ambú de todos los tamaños (2 de cada uno).
Cánula de Mayo o Guedel varias (1 de cada tamaño)
Sondas de aspiración varias (2 de cada tamaño)
Tubos endotraqueales de todos los tamaños con y sin balón (al menos 2 de cada calibre), todos con su envoltorio íntegro y correctamente identificado el tamaño.
Lubricante.
Tubo de oxígeno portátil con flumiter (se encuentra en sala de Shock Room con carro propio)
Jeringas de 5 y 10 ml. para inflar balón de tubo ET. y máscara de ambú.
Tela adhesiva (1 rollo)
Sugerencia: Máscara laríngea 1 de cada tamaño para pacientes de intubación dificultosa.

EQUIPO PARA ACCESO VENOSO
Catéter de teflón tipo Abocath de diferentes calibres (varias unidades).
Aguja para acceso intraóseo o trócar o tipo Jamshidi de diferentes calibres / pinza tipo kocher para fijación /presurizador.
Guías para administración de soluciones parenterales macrogotero, llaves de tres vías (varias unidades).
Prolongadores cortos y largos (varias unidades).
Jeringas de 1, 3, 5, 10 y 20 ml. (varias unidades de cada una).
Agujas 25/8 o similar (varias unidades).
Solución Fisiológica sachet de 500ml. (2 unidades)
Ampollas de: Agua destilada, Solución Fisiológica (varias)
Contenedor para material corto punzante.

CAJON 4
Accesorios. Laringoscopios
Laringoscopios con ramas rectas y curvas en tamaño neonatal, pediátrico y adulto (En sala de Shock Room) O lugar accesible del servicio.
Pilas de repuesto para los laringoscopios
Pinza de Magill tamaño pediátrico y neonatal y/o mandriles en diversos tamaños (para pacientes de intubación dificultosa).
Antiparras (al menos 2)
Guantes de exanimación (1 caja)

El laringoscopio debe ser probado con cada rama, y en cada control (manipularlo con guantes durante la RCP) Conocer e identificar cada rama (recta, curva, número)
En caso de NO FUNCIONAR una rama: notificar.

REGISTRAR EN LA HOJA DE CONTROL DE CARRO DE PARO.

ANEXO PANDEMIA
Dado el contexto de pandemia global por Sars-Cov 19 el equipo de salud debe resolver un nuevo dilema, entre las necesidades de soporte vital de los pacientes y su propia seguridad
Para resolver esta situación la Sociedad Argentina de Pediatría a dado recomendaciones para tratar el PCR en niños con sospecha o confirmación de Covid-19 basada en la opinión de expertos, y que deberán adecuarse a los recursos locales y a las normativas de la autoridad sanitaria jurisdiccional.
La RCP implica un riesgo para el equipo de salud dada que sus maniobras son generadoras de aerosoles, sumado al contacto estrecho del equipo de salud entre sí y con el paciente
Las recomendaciones de los referentes internacionales de RCP en Pediatría (AHA; NHS,OMS,OPS,MSAL,SAC entre otros) son las siguientes:
EPP máximo (no es necesario que se encuentre dentro del carro de paro)
Uso de bolsa autoinflable con filtro Viral /Bacteriano (deberá haber al menos 2 en el carro de paro)
Uso(opcional) de sábana de plástico transparente que cubra cabeza y torso del paciente para reducir la contaminación de los operadores (deberá haber en el carro de paro al menos 2), dicho cobertor se descartará en bolsa roja al terminar el procedimiento teniendo sumo cuidado en su manipuleo(enrollarlo sobre si mismo, para que la parte en contacto con el paciente no toque en ningún momento a los operadores o el entorno del paciente)
Uso opcional de tapón de extremo proximal de TET

REALIZADO POR:
Lic. Belmonte, Liliana; Jefa Sección Guardia

BIBLIOGRAFÍA
American HeartAssociation. AVAP “Manual para proveedores” Edición en español 2015. Ultima versión.
Decreto 2497/93. Reglamentación de la Ley de Ejercicio de enfermería en la Republica Argentina.
Ley de Ejercicio Profesional de Enfermería 24.004.Resolución 194/95 del Min Salud de la Nación.
Declaración del consejo español de resucitación cardiopulmonar. Octubre, 2015
www.sites.google.com/site/calidadhosla
Sociedad Argentina de Pediatría. Comité Nacional de Emergencias y Cuidados Críticos.Programa de Emergencias y Reanimación Avanzada/Recomendaciones en RCP en la Pandemia por Covid-19
Normativa consensuada con la Dra. Ana Nieva. Jefa de División Internación en UTI

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

DEFINICION

La RCP comprende el conjunto de medidas que deben aplicarse para el tratamiento del paro cardiorespiratorio hasta el restablecimiento de las funciones cardiaca y respiratoria. Para ello se optimiza al máximo el transporte de oxígeno, mientras se efectúa el diagnóstico y tratamiento específico de la causa de la PCR.
Durante esta fase se completan los pasos A, B,C de la RCP básica con ayuda de equipo auxiliar, continuando con los pasos D (vías venosas, drogas, fluidos), E (monitorización estable y diagnóstico ECG) y F (tratamiento de las arritmias cardiacas). Precisa de equipamiento y debe ser efectuada por personal con formación específica en estas técnicas.

LEGISLACION VIGENTE

Ley 24004- Normativa para el desempeño de Enfermería –Art. 3 Inciso 18

PERSONAS HABILITADAS

Lic. En Enfermería
Enfermeros Profesionales

OBJETIVOS

- *Una atención inicial coordinada, ordenada y eficaz (entre medico y enfermera).
- *Proveer oxigeno a órganosvitales como el corazón y el cerebro hasta que se restablezca la circulación normal.
- Obtener un registro durante y al finalizar la reanimación cardiopulmonar de:
  - Las maniobras efectuadas
  - Las drogas administradas
  - Los resultados obtenidos

Se Deben Seguir Los Siguientes Pasos

- Vía aérea
- Ventilación
- Circulación
- Accesos vasculares y drogas

A. VÍA AÉREA

Objetivo:

- mantener la vía aérea permeable
  - Ubicar la cabeza en línea media en ligera extensión (no híper extender).Posición de Olfateo
  - Traccionar mandíbula hacia delante.
  - Aspiración orofaringea.
  - Si a pesar de todas estas maniobras, la ventilación es inadecuada, se debe comenzar con el apoyo ventilatorio de bolsa y mascara.
  - Colocar sonda orogastrica o sonda nasogastrica.

B. VENTILACIÓN

Objetivo:

- Restablecer la ventilación.
  - Equipo necesario: mascara adecuada a la edad y una bolsa autoinflable con reservorio (brinda una concentración de O2 al 100%) con válvula de PEEP.

- Colocar al niño con ligera extensión de la cabeza: se coloca la mascara sujetando, sobre la rama de la mandibula, formando un sello contra la piel del rostro.(Tecnica de la CE y de la E)
- Iniciar bolseo y corroborar la efectividad observando los movimientos del tórax.
- Asistir al medico durante el procedimiento de intubación.

Fórmula para determinar el Nº de tubo endotraqueal:

Edad en años+16 % 4 o $\frac{\text{Edad}}{4}$+ 4

Para fijar el tubo en el labio

Numero de tubo X 3

BOLSEO ACORDE A LA EDAD

Lactantes: 30 insuflaciones X minuto
Niños: 20 insuflaciones X minuto
Adultos: 8-12insuflaciones X minuto

C. CIRCULACIÓN.

Objetivos:

- Restablecimiento de la circulación y corrección de las alteraciones metabólicas.
- Conectar al niño al monitor multiparametrico.
- Confirmar la bradicardia extrema o ausencia de pulso.
- Comenzar con masaje cardiaco, bolseo, y previamente colocar al pte sobre tabla de reanimación.
- La zona de compresión para el masaje cardiaco: es el tercio medio del esternon.
- Posición de la mano según la edad del paciente
- Lactantes: Un dedo por debajo de la línea intermamilar (una mano).
  Ambas manos rodeando el tórax, los pulgares presionan en el punto mencionado antes.
  Profundidad +/- 2 cm.
- Niños: Un dedo por arriba del apófisis xifoides con el talón de una mano o dos manos.
  Profundidad 2,5 cm. – 4 cm.

Importante "libere la presión entre las compresiones para permitir el rellenado cardiaco pero no retire las manos del tórax", esto evita lapsos erróneos entre las compresiones.

D. ACCESOS VASCULARES

- Colocar vía periférica permeable y segura,Cateter grueso y corto, este procedimiento debe durar el menor tiempo posible y si fracasara en el tercer intento; se asistirá al medico en la colocación de una vía intraosea.
- Vía intraosea es muy segura y efectiva se puede administrar todo tipo de soluciones hemoderivados, sangre, drogas de reanimación y estabilización, antibióticos, anticonvulsivantes **.** Las soluciones deben ser presurizadas para lograr su paso o se utilizaran bombas de infusión, el tiempo de uso debe ser lo mas corto posible, una vez pasado el momento crítico debe ser reemplazado por otro acceso venoso.Acceso vascular de Urgencia para la infusión de Farmacos y Liquidos. Se utilizanlos huesos largos, la cavidad medular de los mismos esta ocupada por una red capilar sinusoide que drenan a un gran seno venoso central, que no colapsa jamas
- Es una via segura y rápida.
- No se recomienda que permanezca mas de 24hs.

- **Material y equipo**
- Bandeja para medicamentos.
- Jeringa de 3 ó 5 ml con aguja 21 / 8
- Solución antiséptica.
- Gasas ó torunda de algodón.
- Guantes (es recomendable utilizarlos, sin embargo se circunscribe a las normas de la institución).Ver manual de Infectologia 2017
- Las agujas para el acceso IO son: aguja para punción lumbar, aguja de aspirado medular, aguja intraósea Sur-Fast (Cook CriticalCare. Bloomington, IN), aguja para aspirado medular e infusión Illinois modificada por Jamshidi (AllegianceHealthcare. McGraw Park, IL), eldispositivo SAVE (Sternal Access Venous Entry) y eldispositivo FAST (First Access for Shock and Trauma)
- También se han utilizado con éxito agujas de tipo mariposa número 18 y agujas comunes para proporcionar reanimación con líquidos a niños con deshidratación severa, pero no se ha recomendado rutinariamente

Procedimiento

- El Medico Localiza el sitio de inserción.
- Se identifica por palpación la tuberosidad anterior de la tibia y el borde interno de la misma, en la línea media de ambos puntos a 1-2 cm,por debajo de la tuberosidad tibial anterior y 1 cm. hacia la cara medial, en un sitio libre de músculos. Se encuentra el sitio de punción en caso de utilizar la tibia proximal.
- Se realizara Lavado las manos, según normas Infectologicas.
- Colocarse guantes y limpiar la piel con solución antiséptica.La infusión por via intraósea requiere asepsia y antisepsia de la Zona
- Colocación de campos estériles en el sitio de inserción
- Colocar la pierna en rotación externa, semiflexionada y apoyada sobre una superficie dura colocada a nivel del hueco poplíteo.
- Insertar la aguja en un ángulo de 90º respecto al hueso.
- En el caso de la tibia proximal, que es el sitio más utilizado, el punto de inserción se localiza a 1-2 cm. Se introduce la punta de la aguja perpendicularmente a la metáfisis tibial con una inclinación de 15 a 30° con respecto de la vertical y en dirección hacia el pie del paciente, para no afectar el núcleo de osificación). Se punzan la piel y el tejido celular subcutáneo hasta llegar al periostio; se introduce la aguja con un movimiento firme, rotatorio si es necesario, hasta que disminuya la resistencia del periostio, lo que indica que se ha llegado al canal medular.

Para asegurarnos de la adecuada colocación deberemos:

  - Aspirar el material medular.
  - Ausencia de movilidad del sistema.
  - Infundir líquido libremente.
  - Ausencia de aumento de partes blandas, la aguja se mantiene inmóvil y no hay signos de extravasación.
- Inyectar lentamente un bolo de 10ml de SoluciónFisiológico, comprobando la permeabilidad de la vía.
- Fijar la aguja a la extremidad, almohadillando el punto de punción y protegiéndolo con gasa y a la extremidad.
- Pueden administrarse los mismos fármacos que por vía endovenosa, cualquier medicamento o líquido necesarios durante el proceso de resucitación consiguiéndose niveles similares a los de la vía intravenosa.
- La administración de medicamentos debe ser seguido de un bolo por lo menos 5 ml de solución salina para asegurar su llegada a la circulación sistémica.
- Cuando se requiera infusión de líquidos en grandes volúmenes debe aplicarse presión para vencer la resistencia de las venas.

- Permite además, la obtención de muestras de sangre para algunas determinaciones analíticas como sodio, potasio, magnesio, lactato, y calcio. También puede utilizarse para la determinación de gases en sangre, hematocrito y hemoglobina.

Complicaciones.

Las complicaciones de esta técnica invasivapueden ser:

- Mecánicas:
  - Extravasación debido a la mala colocación de la aguja. Es la más frecuente.
  - Fracturas óseas tras varias tentativas de colocación.
  - Perforación completa del hueso.
  - Lesiones de los grandes vasos o del corazón en caso de colocación a nivel esternal.
  - Punción articular.
- Infecciosas:
  - Celulitis.
  - Accesos subcutáneos.
  - Osteomielitis en un 0.6% de los casos. La frecuencia de aparición aumenta con el tiempo de permanencia de la vía.
- Embolismos:
  - Embolia grasa.

Otras complicaciones son: el síndrome compartimental, necrosis, lesión al cartílago de crecimiento, sepsis, rotura del catéter.

Cuidados de enfermería

Controlar distintos signos: sangrado, presencia de pulsos distales, color, temperatura, aspecto y tamaño del miembro.

Hay que señalar que esta vía es temporal, no se recomienda, más de 24 horas por el aumento de la tasa de complicaciones. Se deberá retirar tan pronto haya sido posible canalizar otra vía venosa segura.

Desinfectar cada 4-6 horas la zona de punción para evitar infecciones.

Todas las actuaciones que se realicen sobre esta vía deberán quedar registradas en la hoja de evolución de enfermería.

E. DESFIBRILACIÓN

La fibrilación produce la despolarización de una masa crítica del miocardio para que alguna célula del tejido de conducción cardiaca asuma el ritmo.

Este procedimiento se realiza cuando el paciente presenta fibrilación ventricular (actividad eléctrica ineficaz).

Se debe continuar con las maniobras de reanimación (oxigenación, ventilación y masajes)mientra se realizan los preparativos para las descargas.

PROCEDIMIENTO DURANTE LA ASISTENCIA AL MEDICO

- El desfibrilador debe estar próximo a la cama del paciente.
- El niño debe estar conectado al monitor multiparametrico
- Asegurarse que el interruptor de poder este en off.
- El indicador de energía debe estar en 0 (cero).
- Conectar el “cable de poder” a la corriente y el “cable a tierra”.
- Prender el interruptor de poder.
- Asegurase de que este el la modalidad asincrónica.
- Asegurarse que las paletas externas sean del tamaño adecuado, que estén en buen estado y conectadas al aparato. Ejemplo: menores de 10Kg de 4 -6 cm. de diámetro, mayores de 10Kg de 8 – 10 cm. de diámetro.
- Recordar que las paletas deben permanecer separadas (no deben tocarse entre ellas).

- Aplicar gel conductor a la superficie de las paleteas o a la superficie del tórax (diminuye la resistencia a la corriente que se va a aplicar) y se evitan las quemaduras a la piel (evitar que gel se deslice por el tórax y se unan en lo que se formaría el arco eléctrico).
- El medico operador se colocara preferentemente a la izquierda, asegurándose que ningún elemento este tocando al niño ni al el mismo.
- Aplicara las paletas sobre el tórax: una en el hemitórax derecho, debajo de la clavícula; y la otra paleta en el hemitórax izquierdo, justo debajo y a la izquierda de la areola mamaria. (en las niñas y adolescentes no se recomienda colocar las paletas sobre las mamas, se las ubicara en la línea axilar anterior o axilar media).
- **Volver a asegurarse que ningún profesional este tocando la cama del niño.**
- **Suspender la ventilación.**
- Apretar ambos botones de descarga de las paletas simultáneamente y mantenerlos apretados hasta que el indicador de energía llegue a 0(cero).
- Se sueltan los botones inmediatamente después y se retiran las paletas para:
    - ventilar nuevamente al paciente.
    - Observar la respuesta al procedimiento.
    - Permitir la recargad del desfibrilador.
- **Registrar todo el procedimiento en la hoja de enfermería: hora, dosis de descarga, drogas administradas previamente, respuesta.**
- **Tener Presente que se necesitan Cuatro PROFESIONALES para realizar el procedimiento:**

- **Uno Para Ventilación**
- **Uno Para Masaje**
- **Uno para prepararLamedicacion**
- **Uno Administrar Medicación(Enfermero a Cargo del Paciente)**

MEDICACION

Adrenalina 1 mg. x ml. =1 amp. en 10ml./Agua destilada EV y /o IO
Gluconato de Calcio al medio /Agua Destilada
Bicarbonato De Sodio Al Medio/Agua Destilada
Sedo analgesia,según normas - acorde a la necesidad

Lo importante es saber cual fue la causa desencadenante
SH: Hipovolemia, Hipoxemia, Acidosis, Hipotermia, Hipo o Hiper kalemia
ST: Neumotorax, Taponamiento cardiaco, Tóxicos, Trombosis Pulmonar o trombosis Coronaria

REALIZADO POR:

Lic.Torreiro, Lorena, Jefe sección UTIP
Enf. Profesional. De la Vega, Isabbel, Jefe sección U14

BIBLIOGRAFÍA

- Verri Espinosa, Alejandra. Manual De Procedimientos De Enfermería Del Niño Y Del Adolescente, Escuela De Enfermería Sede Chillan,2012.
- RCP. Manual De Soporte Vital Avanzado (4ª Ed.) J. Lopez Mesa; N. Perales Y Rodriguez De Viguri; M. Ruano Campos , 2007Orgiler P, Navarro JM, De Haro S. La vía intraósea. Cuando las venas han desaparecido. Enferm. Intensiva. 2001; 12 (I): 31-40.
- García N, Cepeda JM.Vía intraósea en enfermería de emergencias. Rev. EnfermCyL. 2009; Vol 1 – Nº2. 48-56.

RECEPCION DEL PACIENTE AL INGRESO EN SALA

DEFINICIÓN
Conjunto de actividades que se aplican de forma individualizada al paciente y familia a su llegada a la Unidad de hospitalización.

OBJETIVO
Facilitar la integración del paciente, familia y/o acompañante en el entorno hospitalario con un trato personalizado, humano y respetuoso:
Proporcionar la información mínima necesaria, manteniendo una comunicación efectiva.
Realizar la valoración de enfermería al ingreso del paciente que permita identificar problemas de salud para la elaboración del plan de cuidados, en las primeras 24h.
Proporcionar un entorno de seguridad al paciente, familia y/o acompañante.

LEGISLACION VIGENTE
SALUD PUBLICA-Ley 26.529. Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.Sancionada: Octubre 21 de 2009 Promulgada de Hecho: Noviembre 19 de 2009.
Ley 24004.Normativa Para El Ejercicio De La Enfermeria

PERSONAS HABILITADAS
Licenciados en Enfermeria
Enfermeros Profesionales
Médicos.

PROCEDIMIENTO
Cuando nos comunican que va a ingresar un paciente:
Preparamos la documentación y material clínico
Documentación clínica:

- Hoja de Evolución de Enfermeria, hoja de Indicaciones Medicas
- Registros específicos de cada unidad.

Equipo de signos vitales: Tensiometro, Estetocopio y termómetro.
Prepara la Unidad del Paciente
Se realiza Tendido de Cama
Material de uso personal del paciente.
Asegurar el correcto funcionamiento de las tomas de oxígeno, aspiración y luz de cabecera.
Procedimiento de recepción al Ingreso

- Confirmar, antes de la llegada del paciente, que la habitación y el material necesario estén preparados.
- Paciente ingresa a sala de procedimiento. Si el servicio no contara con una realizarlo en un consultorio o resguardar la intimidad del paciente con un Biombo si los procedimientos del ingreso se realizaran en sala común.
- Controlar signos vitales, peso corporal
- Higienizar al paciente antes de un procedimiento invasivo, de ser posible baño corporal.
- Colocarle ropa limpia, si no la tuviese; camisolín limpio.
- El personal de enfermería que realiza la recepción al paciente, deberá presentarse. Mostrar una actitud positiva y cordial, utilizando un lenguaje claro y conciso con un tono de voz empático y dirigiéndose al paciente por su nombre.

- Preservar, en todo momento, la intimidad del paciente, utilizando para ello los recursos disponibles a nuestro alcance.
- Seguir las indicaciones médicas, en caso de no estar escritas debido a la gravedad del evento, se pedirá al médico que lo registre cuando la situación se estabilice.
- Proporcionar la atención al paciente y su familia, en un entorno seguro.
- Comprobar la identidad del paciente, colocar identificación en la unidad del paciente en forma visible. En caso de ir a quirófano colocar la pulsera identificadora.
- Comunicar al paciente y/o tutor legal, que la información clínica relativa a la evolución y tratamiento del paciente, le será facilitada a él y a los familiares directos, de acuerdo a las normas vigentes en materia de información y documentación clínica.
- Informar de la estructura física de la Unidad. Horarios de visitas, modalidad de funcionamiento delaSala,para una buena convivencia
- Acompañar e instalar al paciente en su habitación.
- Presentar al compañero si su estado lo permite.
- Brindar al paciente, familiar, tutor legal o acompañante mayor de edad, la información según el estado del paciente y ofrecerle la posibilidad de aclarar cualquier duda que surja sobre la información recibida.
- Comunicar al paciente y/o familia que el hospital no se hace responsable de Losobjetos/pertenencias de valor que se depositen en la habitación.
- Corroborar que se hayan realizado los trámites pertinentes al ingreso:Admisión de Paciente, Alimentación, etc.
- Identificar factores de riesgo para la seguridad del paciente.
- Asegurarse que el paciente no necesita nada y se encuentra cómodo antes de abandonar la habitación.
- Cumplimentar los registros de enfermería: valoración al ingreso, gráfica de signos vitales, hoja de tratamiento, plan de cuidados y observaciones de enfermería. Estudios realizados al ingreso.
- Registrar claramente la presencia o ausencia de alergias/intolerancias que presente el paciente.

Situaciones especiales

En caso de ingresos de urgencia, sin estar avisados, se seguirán las normasvigentes, el paciente y un familiar esperaran en saladeprocedimiento hasta que se prepare la unidad asignada al mismo.

RESPETAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN NORMAS INFECTOLOGICAS VIGENTES EN LA INSTITUCIÓN

REALIZADO POR:

Lic. Magali Godoy, Jefe Sección U8
Lic. Marcelo Alancay, Jefe Sección U6
Lic. Mirta Godoy, Jefe Sección U7

BIBLIOGRAFÍA

- Alfieri P, Benítez M, Cardozo N, Escobar S, Luaces C, Merlo O, et al. Manual de procedimientos. Recepción, Acogida y Clasificación (RAC). Viviana S, Rivas F, editores. MSPBS. Paraguay; 2011.
- MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1616/2007 Créase la Comisión Nacional Asesora para la Seguridad de los Pacientes. Objetivos. Bs. As., 3/12/2007. Expediente Nº 2002-15554/07-1 del registro del MINISTERIO DE SALUD.

REGISTROS DE ENFERMERIA.

DEFINICIÓN.
Los registros de enfermería son documentos específicos que forman parte de la historia clínica: Documento legal, profesional y autónomo.
Describen cronológicamente la situación, evolución y seguimiento del estado de salud del paciente, las intervenciones sobre el tratamiento, rehabilitacion y promoción de la salud que el profesional de enfermería brinda a los sujetos de cuidado, a la familia y a la comunidad.

OBJETIVOS.
- Comunicar los datos importantes del paciente.
- Planificar la continuidad de los cuidados.
- Instrumento educativo.

LEGISLACIÓN VIGENTE.
Ley 26529: Derechos del paciente,historia clínica y consentimiento informado.
Incluye en la historia clínica todos los documentos que hagan referencia a información de salud del paciente; incluyendo los consentimientos informados, hojas de indicaciones, hojas de Enfermería, estudios complementarios,incluyendo las prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas.
La historia Clínica,es responsabilidad profesional,documento de carácter técnico legal y administrativo.
Ley 24.004 del ejercicio de Enfermería.
Ley 298 de C.A.B.A.

MATERIAL NECESARIO.
Hojas de Enfermería, donde se registran:
- Datos del paciente
- Signos Vitales - Peso
- Medicación administrada
- Balance de ingresos-egresos
- Todo procedimiento que se realice al paciente.
- Evolucion del paciente o complicaciones del tratamiento.
- Las interconsultas y procedimientos que le practica cualquier integrante del equipo de salud.
- También debe registrarse el traslado,fuga,alta u óbito del paciente.
- Fecha,firma y sello del Enfermero a cargo del paciente.

QUE CONSIDERAR AL REALIZAR LOS REGISTROS.
- Incluir todas y cada una de las acciones en relación al paciente.
- Respetar el orden cronológico.
- Registrar siempre con tinta negra y letra clara,de ser posible en imprenta.(LEGIBLE)
- Registrar siempre con siglas universalmente aceptadas.
- No dejar espacios en blanco ni escribir entre líneas.
- No borrar, no tachar, no usar corrector; en caso de error poner paréntesis entre las palabras, trazando una línea y aclarando con la palabra error.
- Colocar siempre fecha y hora en que se intervino en la atención al paciente.
- **Identificarse con fecha, firma y sello del Enfermero a cargo del paciente.**

REPORT DE ENFERMERÍA
De carácter Obligatorio
Se lo considera documentación complementaria a la historia clínica.
Tiene valor para los fines estadístico y control epidemiologico**.**

QUE SE REGISTRA:

- Enfermeros presentes en el turno , Apellido y Nombre
- Nombre,Apellido Y Edad Del Paciente.
- Diagnostico de Base - Motivo de Internacion
- Estudios Realizados –Estudios Pendientes
- Interconsultas, traslado de sala o derivación a otra institución, alta, fuga u óbito del paciente.
- Datos relevantes, de importancia para el paciente o para el servicio.

REGLA DE ORO:

LO QUE NO ESTA ESCRITO NO ESTA HECHO.

Un registro claro y completo es la herramienteque tiene el profesional enfermero como defensa ante una demanda por responsabilidad profesional.
La inexactitud, (no registrar fecha y hora)y la falta de registro de la información de manera clara son las razones mas comunes de juicios por mala praxis, que surgenmucho tiempo,es factible no recordar los hechos como ocurrieron tiempo atrás con exactitud.
Los borrones pueden ser interpretados como falsificación de registros y calificados como una prueba de negligencia consciente desde el punto de vista legal.
Las indicaciones médicas deben ser siempre claras y actualizadas a la fecha:
NO aceptarlas si no cumplen estos requisitos.
NOse deben recibir ni realizar indicaciones medicas verbales, **SOLO en caso de urgencia, podrá realizar procedimientos, con ordenes verbales, posteriormente se solicitará al profesional actuante elregistro correspondiente**.

REALIZADO POR:

Lic. Godoy Magali, Jefa Division Turno Noche

BIBLIOGRAFÍA.

- Actualización de norma vigente.
- www.madredeus.com.ar
- http://hdl.handle.net/123456789/3644
- Ley 26529 Sobre Derechos Del Paciente En Su Relacion Con Los Profesionales E Instituciones De La Salud promulgada de hecho el 19 de noviembre de 2009 se sanciona la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado.

VENTILACIÓN MECÁNICA.

DEFINICIÓN.

La VM es un procedimiento de respiración artificial que sustituye o ayuda temporalmente a suplir o colaborar con la función respiratoria de una persona, que no puede hacerlo por si mismo o que por fines terapéuticos, se requiera que no lo haga, con el objetivo de mejorar la oxigenación e influir en la mecánica pulmonar.

Es una intervención de apoyo, una prótesis externa y temporal queventila al paciente mientras se corrige el problema que provocó su instauración.

Un paciente que se encuentra en ventilación mecánica posee una serie de complejidades y para que sea capaz de acoplarse a este sistema, requiere además mantenerse sedado, sometido a múltiples factores de estrés ambiental, compromiso del estado general y/o de conciencia, lo que implica la multiplicidad de cuidados que requieren en este periodo.

OBJETIVOS.

Objetivos fisiológicos:

- Mantener, normalizar el intercambio gaseoso:
- Proporcionar una ventilación alveolar adecuada.
- Mejorar la oxigenación arterial.
- Incrementar el volumen pulmonar:
- Abrir y distender la vía aérea y unidades alveolares.
- Aumentar la capacidad residual funcional, impidiendo el colapso alveolar y el cierre de la vía aérea al final de la espiración.
- Reducir el trabajo respiratorio:
- Descargar los músculos ventilatorios.

Objetivos clínicos:

- Revertir la hipoxemia.
- Corregir la acidosis respiratoria.
- Aliviar la disnea y el sufrimiento respiratorio.
- Prevenir o resolver atelectasias.
- Revertir la fatiga de los músculos respiratorios.
- Permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular.
- Disminuir el consumo de O_2 sistémico o miocardio.
- Reducir la presión intracraneal.

LEGISLACION VIGENTE

Ley 24004-Normativa para el ejercicio de la Enfermeria-Art.3 Inciso 18

PERSONAS HABILITADAS

Lic. En Enfermería
Enfermeros Profesionales
Enfermería colabora con los médicos en el proceso de intubación orotraqueal

INDICACIONES.

Se valoran principalmente los siguientes criterios:

- **Estado mental:** agitación, confusión, inquietud.
- **Excesivo trabajo respiratorio:** Taquipnea, tiraje, uso de músculos accesorios, signos faciales.
- **Fatiga de músculos inspiratorios:** asincronía toracoabdominal, paradoja abdominal.
- **Agotamiento general de paciente:** imposibilidad de descanso o sueño.
- **Hipoxemia:** Valorar $SatO_2$ (<90%) o PaO_2 (< 60 mmHg) con aporte de O_2.

- **Acidosis:** pH < 7.25.
- **Hipercapnia progresiva:** PaCO**2** > 50 mmHg.
- **Capacidad vital baja.**
- **Fuerza inspiratoria disminuida.**

EQUIPO NECESARIO PARA LA VM.

- **Para la intubación**
  - Tubo endotraqueal (TET): el tamaño depende de la edad y de la vía deentrada (boca, nariz). Tiene balón en adultos y algunos pediátricos.
  - Fiadores de distinto calibre.
  - Laringoscopio con Ramas de distintos tamaños, curvas y rectas.
  - Pinza de Maguill.
  - Jeringa para insuflar el balón.
  - Sistema de fijación del tubo.Cinta adhesiva (Tenso Plast)
- **Equipo de apoyo**
  - Ambú con reservorio, conectado al oxigeno.
  - Dos fuentes de O**2;** Una para el ventilador y otra para el ambú.
  - Equipo de aspiración (estéril) y aspirador.
  - Cánula de Guedell.
  - Manómetro de balón: inflable para medir la presión del mismo.
  - Pilas de repuesto para el laringoscopio.

Existen diversas alternativas y su elección debe considerar:

- Objetivo preferente de la VM.
- Causa y tipo de IR.
- Naturaleza obstructiva o restrictiva de la patología pulmonar.
- Estado CV.
- Patrón ventilatorio del enfermo.

Tener en cuenta la causa por la que surge necesidad de suplir total oParcialmente la función ventilatoria. Acorde a esto se seleccionará la modalidad másapropiada.

VM CONTROLADA

Soporte ventilatorio Total.
VM con relación I:E invertida
VM diferencial o pulmonar independiente.

Modos Asistidos

V mandatoria intermitente
Soporte ventilatorio parcial P de soporte
P (+) continua en vía aérea

VM CONTROLADA (VMc)

El nivel de soporte ventilatorio es completo, las respiraciones se inician automáticamente y el patrón de entrega de gases está programado.
El ventilador dispara toda la energía necesaria para mantener una ventilación alveolar efectiva.
Las variables necesarias para conseguirlo son prefijadas por el operador y controladas

INDICACIONES

- Insuficiencia respiratoria aguda por patología pulmonar o de vías aéreas graves
- Insuficiencia grave
- Inestabilidad Hemodinamica
- Disminución del impulso ventilatorio:

- Paro respiratorio.
- Intoxicación por drogas que deprimen el SNC.
- Coma.
- Muerte cerebral.
- Necesidad de suprimir el impulso ventilatorio:
- Anestesia general.
- Imposibilidad de adaptar al paciente.

Alarmas

Presión en vías aéreas: Nos informa sobre cambios en las impedancias respiratorias (resistencia física de los tejidos al paso de aire), fugas o desadaptación.

Volumen minuto bajo: desconexiones y fallo de alimentación.

Limitaciones

Hay que eliminar el impulso ventilatorio del paciente para evitar asincronías con el respirador.

VM ASISTIDA-CONTROLADA (VMa/c)

En esta forma de ventilación cada impulso respiratorio por parte del paciente es seguido por un ciclo respiratorio sincronizado por parte del ventilador.

Si este esfuerzo respiratorio del paciente no ocurre en un período de tiempo (P.control) el respirador envía automáticamente un flujo de gas.

Para llevar a cabo este tipo de VM hay que hacer sensible el respirador a los esfuerzos respiratorios del paciente. El mecanismo que se activa para detectarlo se llama **trigger**y tiene distintos grados de sensibilidad. Consiste en unos sensores que se activan cuando detectan una caída de presión o un cambio de flujo en el circuito respiratorio. El trigger puede ser manipulado por el operador para que el paciente genere mayor o menor esfuerzo (es decir, generar un cambio de presión o de flujo).

♦ **Alarmas**

- Presión en vías aéreas.
- Volumen minuto espirado (máximo y mínimo).

♦ **Ventajas**

Combina:

- Seguridad de la VMC
- Posibilidad de sincronizar ritmo respiratorio del paciente en elrespirador.
- Asegura soporte ventilatorio en cada respiración.
- Disminuye la necesidad de sedación.
- Previene la atrofia de músculos respiratorios (por su carácter asistido).
- Facilita el destete.
- Mejora la tolerancia hemodinámica.

♦ **Inconvenientes**

- Trabajo excesivo si el impulso respiratorio es alto y el pico de flujo o sensibilidad no es adecuado.
- En pacientes despiertos la duración de los ciclos respiratorios puede no coincidir con la programada en el respirador, por lo que a veces hay que sedar al paciente. Luego de descartar causas de desadaptación (secreciones, acodamiento TET, modalidad ventilatoria inadecuada, etc.)
- Cuando se usa en pacientes taquipneicos puede desarrollarse situación de alcalosis respiratoria.
- Puede aumentar la autoPEEP.

VENTILACIÓN CON PRESIÓN DE SOPORTE (PSV).
Es un método de VM limitado por presión y ciclado por flujo, en el cual cada ciclo respiratorio debe ser disparado por el paciente, venciendo con su esfuerzo inspiratorio el nivel de trigger establecido.
Se usa como ayuda a la respiración espontánea, por lo tanto, el paciente debe conservar un adecuado impulso respiratorio.
El tiempo inspiratorio y el volumen corriente dependerán del esfuerzo respiratorio del paciente y del nivel de presión establecido.
Ventajas
El enfermo tiene el control sobre la frecuencia respiratoria y el volumen, por tanto mejora la sincronía del paciente con el respirador.
Disminuye el trabajo respiratorio espontáneo y el trabajo adicional.
Inconvenientes
Es muy importante monitorizar estrictamente el volumen corriente porque depende;del esfuerzo del sistema respiratorio. Monitorizando este parámetro evitamos la hipoventilación.
Mucho cuidado con la administración de fármacos depresores del centro respiratorio ya que el impulso respiratorio debe estar conservado.
¡CONTRAINDICADOS LOS RELAJANTES MUSCULARES!.
Indicaciones Básicas
- Como destete por sí solo o asociado al SIMV.
- Como modo primario de ventilación.

Alarmas
- Volumen minuto (alto y bajo).

PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN VIA AEREA (CPAP).
La CPAP es una forma de elevar la presión al final de la espiración por encima de la atmosférica con el fin de incrementar el volumen pulmonar y la oxigenación.
Siempre se utiliza en respiración espontánea: el aire entra en los pulmones de forma natural por acción de los músculos respiratorios y gracias a una válvula en la rama espiratoria se evita que el pulmón se vacíe del todo al final de la espiración.
La CPAP es conceptualmente idéntica a la PEEP, la diferencia radica en que la primera se Utiliza en respiración espontánea y la segunda exclusivamente en respiración artificial.
Formas de aplicación
- Con un ventilador a través del TET.
- Con una mascarilla facial o nasal.

♦ **Indicaciones**
- Insuficiencia respiratoria aguda (en fase inicial).
- Destete en EPOC.
- Apnea obstructiva del sueño.
- Enfermedad respiratoria crónica avanzada.

♦ **Limitaciones**
- En general las mismas que en la PEEP.
- Si se usa mascarilla suele generar intolerancia ya que debe estar hermética.
- Aerofagia y vómito.
- Los efectos suelen ser los mismos que en la PEEP pero al existir ventilación espontánea lapresión es menor que en la VM con presión positiva por tanto también es menor el índicecardíaco y el riesgo de barotrauma.

ANALGESIA Y SEDACIÓN PARA ADAPTACIÓN DEL PACIENTE A LA VM.

Analgesia

Desaparición de la sensibilidad al dolor sin pérdida de los restantes modos de sensibilidad. Ausencia de toda sensación dolorosa.

Sedación

Describe un estado que le permite al paciente tolerar un procedimiento o situación desagradable, mientras mantiene una adecuada función cardiorespiratorio y capacidad de respuesta, ante una orden verbal o estimulación táctil.

. **Indicaciones de la sedación:**

- Ayudar en la adaptación a la VM.
- Aliviar el dolor.
- Disminuir ansiedad y agitación.
- Mejorar comodidad general.
- Facilitar el sueño.
- Premedicación para exploraciones y técnicas invasivas.

Además, existen otras posibilidades de intervención que contribuyen a la sedación y adaptación:

- Soporte emocional.
- Comunicación e información pertinente.
- Apoyo familiar.
- Respuesta a las necesidades humanas
- **Desadaptación del enfermo a la VM:**

Cómo diagnosticarlo:

- No hay sincronización entre paciente – respirador.
- El paciente lucha contra la máquina.
- Respiración paradójica.
- Inquietud, agitación
- **Dolor**
- Hiperactividad simpática (HTA, taquicardia, sudoración).
- Saltan las alarmas continuamente.

Cuáles son las consecuencias, estas se reflejan a distintos niveles:

- **Mecánica pulmonar**: Taquipnea, aumento de ventilación, disminución del tiempo espiratorio, dificultad de vaciado pulmonar, aumentan PEEP, Ppico y Pmeseta.
- **Músculo respiratorio**: Aumenta trabajo respiratorio, fatiga diafragmática.
- **Hemodinámica**: Hay un aumento de las presiones que dificultan el retorno venoso y producen una disminución del GC. Se produce hiperactividad adrenérgica como consecuencia de la lucha con el respirador.
- **Intercambio gaseoso**: Hay un aumento de la producción de CO_2 y del consumo de O_2 que provocan hipercapnia, desaturación y acidosis mixta (respiratoria y metabólica).

Todo esto provoca:

- Empeoramiento del cuadro general.
- Mayor riesgo de complicaciones.
- Prolongación de la VM y del destete.

Cuáles son las causas:

Es habitual recurrir a los fármacos para conseguir la adaptación del paciente a la VM; pero es muy importante averiguar las causas de la desadaptación porque a veces no es necesario el uso de sedantes para corregirla.

Podemos clasificar las causas en cuatro categorías principales:

Programación inadecuada de la VM: Volumen minuto bajo, FiO_2 límite, Trigger mal ajustado...

Complicaciones: Barotrauma, Atelectasia, EAP, Obstrucción de TET por tapón Mucoso.

Modificaciones fisiológicas del paciente: Dolor, ansiedad, fiebre, cambios posturales, traslados (cambio de respirador).
Disfunción del respirador: Fallo de alarma, rotura de circuitos internos.
Es importante destacar la necesidad de seguir un protocolo de actuación cuando se produce desadaptación de la VM.
Para valorar el nivel de sedación del paciente se recomienda utilizar una escala: la de **Ramsay** valora la necesidad del paciente de incrementar o disminuir la sedación.
Pautas farmacológicas:
Las pautas más habituales que se utilizan en enfermos críticos son:
Sedación pura: Uno de los más usados es el Midazolam: BZD de Acción rápida que además tiene propiedades ansiolíticas, anticonvulsivantes y miorrelajantes. Crea tolerancia y dependencia física y psíquica; su eliminación es principalmente renal.
A**nalgesia**: Casi todos los enfermos críticos necesitan, además de la sedación, analgesia; ya que sufren dolor, molestias propias del TET, técnicas invasivas, etc.
Para aliviar el dolor se suelen utilizar Agonistas puros de la Morfina, Meperidina y Fentanilo. Tienen en común la sedación, analgesia central e hipnosis, así como los efectos adversos (náuseas, vómitos, depresión respiratoria,...).
Relajación muscular (añadida a los puntos anteriores):
Si la sedación y laanalgesia no bastan para adaptar al paciente, entonces se recurre a los relajantesmusculares: Vecuronio, Atracurio, Pancuronio, Bloquean la placa motora y producen parálisis muscular; producen relajación muscular completa *sin* efectos sobre SNC, por lo tanto el paciente entra en apnea estando consciente. Es imprescindible tener preparado la inducción anestésica y la asistencia respiratoria. Hay que tener en cuenta que el uso derelajantes musculares dificulta el destete, por lo que sólo se utilizan en caso de urgencia y en períodos cortos de tiempo (menos de 48 horas de VM).
Tener en Cuenta que solo paraliza y no duerme por lo que se puede paralizar estando despierto.
Vecuronio 10mg.=1mg.=1 ml.
Ketamina 500mg. /10ml. =1mg.= 1ml.
En Adolescentes = 10mg = 1ml.
Fentanilo 250gamas/5 ml. =1 ml = 10 gamas
Midazolan 15 mg. / 3 ml.
Infusión de Fentanilo
2gamas/kg/hora - completando una dilución de 24ml totales en Dx 5% p/infusión contìnua.
Infusión de Midazolan
0.1mg/kg/hora - completando una dilución de 24ml totales en Dx 5% p/infusión contìnua.

VER NORMA DE SEDOANALGESIA

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CONVENTILACIÓN MECÁNICA
Éstos son:
Los generales; que seaplican a pacientes con reposo (total o parcialmente)
Los derivados de padecerpatologías concretas que han puesto al paciente en una situación crítica para su vida.
Los específicos que surgen de la situación en la que se encuentra el paciente, es decir, totalmente dependiente de una máquina y de nosotros, el equipo sanitario.
Objetivos:
- Conseguir la máxima comodidad física y psíquica del paciente
- Prevenir o tratar precozmente, la aparición de cualquier complicación".

- Recordar que en muchas ocasiones el paciente sometido a vm está total o parcialmente sedado e incluso con tratamiento relajante, con lo que su nivel de independencia para las actividades de la vida diaria se ve afectado.
- Debemos enfocar nuestros cuidados a conseguir un estado de bienestar biopsicosocial pero siempre favoreciendo el máximo nivel de independencia que tenga el paciente; implicarlo en su autocuidado.

OBSERVACIÓN, INTERPRETACIÓN Y REGRISTO DE:
Valores monitorizados. Normalmente existirá monitorización cardíaca y pulsioximetría.

- Signos clínicos.
- Comportamiento del paciente, que nos indicarán la correcta tolerancia al tratamiento ventilatorio y la detección de
- Complicaciones. (Cambios de presiones , desaturación, etc.)

HUMANIZACIÓN EN TODOS LOS CUIDADOS
Un paciente sedado y "conectado" a una máquina sigue siendo una persona.
No hay quecaer en el error de despersonalizar nuestros cuidados.
Además hay que tener en cuenta las circunstancias que rodean al paciente;la propia enfermedad; el aislamiento físico e incapacidad para comunicarse; la alta tecnología, luces , ruidos , la dependencia de una máquina y del profesional lo cual legenera un alto grado de estrés .

ACTUACIONES GENERALES

- Comprobar el correcto ajuste de los límites de alarma y el buen acoplamiento, máquina-tubuladura- paciente.
- Registro de los valores más significativos con periodicidad predeterminada (c/hora, c/2h...) y parámetros del ventilador:
- Signos vitales: FC, TA, Tª, FR (espontáneas).
- Medición de pérdidas: Diuresis, deposiciones, drenaje SNG...
- Saturación de oxígeno.
- Parámetros del ventilador:
- Volúmenes (Vc, Vesp, Vinsp).
- Presiones (Ppico, Pmeseta, Presión al final de la espiración).
- Flujos (Vminuto y FR asistidas).
- Modalidad.
- FiO**2.**
- PEEP.
- Registrar cualquier actuación, técnica o incidencia. Por ejemplo: describir aspecto de secreciones, cambio de sonda vesical...
- Seguimiento de normas higiénicas y asepsia. Reducir las técnicas invasivas a
- las estrictamente necesarias.
- A continuación, nombraremos una serie de cuidados que hemos clasificado en:
- Cuidados generales derivados del reposo prolongado.
- Cuidados específicos derivados de la VM.

CUIDADOS GENERALES DERIVADOS DEL REPOSO
Cualquier paciente en reposo prolongado sufre el riesgo de deterioro de sus sistemas corporales ya que existe una inactividad musculoesquelética total o parcial.
"La inmovilidad es contradictoria con la vida humana". "La movilidad nos proporciona control sobre nuestro entorno. Sin movilidad, uno está a merced del entorno". (Christian, 1982).

Cuanto más se prolongue esta situación, mayor riesgo de que se presenten complicaciones.
A continuación nombraremos las posibles complicaciones según los sistemas corporales y algunas actividades generales a llevar a cabo.

SISTEMA CARDIOVASCULAR

Controles que alertan la presencia de complicaciones
FC/TA
Riesgo de TVP
Reducir o eliminar la compresión venosa externa:
Evitar almohadas debajo delas rodillas, movilización de MM.SS. y MM.II., valorar lapresencia de edemas en MM.II. o zona caliente y enrojecida

SISTEMA RESPIRATORIO

Los cambios posturales ayudan a modificar presiones en la caja torácica, lo que favorece el aumento de perfusión en determinadas zonas pulmonares y el drenaje de secreciones.
Aplicar fisioterapia respiratoria según circunstancias y necesidades del paciente.
Aspiración de secreciones según precise y no por rutina.

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

- Atrofia muscular.de la fuerza / tono. Los músculos pierden aproximadamente el 3% de su fuerzaoriginal cada día que están inmóviles.
- Degeneración articular. Las articulaciones sin movilización desarrollan contracturas
- en 3-7 días.
- Mantener la movilidad de las extremidades y evitar contracturas.
- Realizar ejercicios de movilización activa y/o pasiva, mantener la correcta alineacióncorporal cada cambio postural y ayudarse de almohadas para ello.

SISTEMA ENDOCRINO

- Hipercalcemia.
- Alteración de los niveles de creatinina.
- Anorexia.
- Eliminación de nitrógeno.
- Obesidad.
- Factores que se vigilan y controlan en colaboración con el médico y mediante analíticas seriadas.

SISTEMA GASTROINTESTINAL

- Estreñimiento.
- Formación de fecalomas.
- Garantizar un adecuado aporte hídrico, vía enteral o por víaparenteral.
- Auscultación del abdomen.
- Identificar en el paciente su patrón habitual de eliminación intestinal.
- Realizar masaje abdominal en el momento del baño si no está contraindicado.
- Registrar frecuencia, cantidad y aspecto de deposiciones.

SISTEMA GENITOURINARIO

- Retención urinaria.
- Cálculos.
- Existe mayor riesgo de infección, no sólo por lo anteriormente citado, sino también por la presencia de sonda vesical.
- Aporte hídrico adecuado.
- Valorar color, olor y aspecto de la orina.

PIEL

- De la circulación capilar.
- Úlceras por presión (UPP).Prevenir la formación de UPP:

- Establecer un programa de cambios posturales, inspeccionando la piel en cadacambio y observando la aparición de enrojecimiento o palidez.

IMPORTANTE: Emplear el personal suficiente para mover al paciente.

- Utilizar almohadas o gomaespuma para mantener la alineación corporal pero sin hacer presión directa sobre las zonas más vulnerables.

CUIDADOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA VM
CUIDADOS EN EL MOMENTO DE INTUBAR

La decisión de intubar a un paciente es tomada por el médico, hay que tener en cuenta que hablamos siempre de equipo y que en esta situación se requiere rapidez, destreza y sobre todo coordinación por cada uno de los miembros del equipo. Normalmente las funciones de cada profesional están muy bien delimitadas.
Los agentes actuantes deberán utilizar el EPP adecuado y las medidas de bioseguridad según normas infectologicas de la institucion
A continuación citaremos algunos aspectos que se deben cumplir para la intubación:

- Preparación del material a utilizar. En las unidades de críticos y emergencias suele estar preparado ("Set de intubación")
- Comprobar la luz del laringoscopio y la impermeabilidad del balón.
- Paciente correctamente sedado, relajado y con analgesia (según prescripción de
- Fármacos por el médico).
- Respirador enchufado con parámetros prefijados: FiO**2,** modalidad, FR, VC y tipo de flujo.
- El paciente debe estar en todo momento con monitorización cardiaca ypulsioxímetro.

CUIDADOS DE LA INTUBACIÓN
ASPIRACIÓN DE SECRECIONES

Ha de realizarse bajo la máxima asepsia y con el menor traumatismo posible.
No se debeemplear más de 15 sg. en cada aspiración.
Hacer vacío sólo durante la retirada del catéter. Aveces es necesario lubricar la sonda de aspiración para facilitar la penetración. En pacientes más inestables es conveniente administrar O**2** al 100% antes de aspirar.

TECNICA DE ASPIRACION DE SECRECIONES POR TUBO ENDOTRAQUIAL
DEFINICION:

Es la succion de secreciones atraves de un cateter, conectado a una toma de succion aspirativa
OBJETIVO:
Mantener la permeabilidad de la vía aérea
Valoración Clínica de la Necesidad de Aspiración:
La misma debe basarse en la evaluación de los signos clínicos del paciente y no en el cumplimiento de una norma.
Se debe prestar atención a la presencia de los siguientes indicadores.

- Auscultaciónde secreciones, o disminución de la entrada de aire.
- Secreciones visuales en el tubo endotraqueal
- Alteración del patrón respiratorio o cambios en la expansión torácica
- Modificaciones en la saturación de oxigeno
- Bradicardia
- Agitacion
- Cianosis
- Aumento de la CO2 con disminución del PH en el estado acido base.

Equipo:

- Guantes estériles
- Sonda de aspiración estéril del tamaño adecuado
- Tubuladura de aspiración
- Bolsa de reanimación conectado a fuente de oxigeno
- Antiparras
- Soluciónfisiológica
- Jeringa para instilar

Modalidades de aspiración:

Para realizar esta técnica existen dos tipos de sistemas.

El circuito abierto de aspiración o convencional y el circuito cerrado de aspiración

Principales características y diferencias de cada modalidad de aspiración.

CIRCUITO ABIERTO:

- Al interrumpir la ventilación, favorece la perdida del volumen pulmonar provocando colapso alveolar.
- Aumenta el riesgo de hipoxia por mayor tiempo de desconexión de la ventilación
- La técnica requiere de dos operadores

PROCEDIMIENTO DE ASPIRACIÓN CON CIRCUITO ABIERTO.

- Lavarse las manos con antiséptico
- Valorar la presencia de secreciones
- Determinar el calibre de la sonda de aspiración necesaria según el TET
- Disponer todos los elementos necesarios en la unidad del paciente
- La técnica se debe realizar entre dos personas para evitar la extubación del paciente, mantener su estabilidad y favorecer la esterilidad del procedimiento.
- Colocarse los guantes en ambas manos recordando que la mano que tocara la sonda de aspiración debe permanecer estéril.
- Recibir el catéter y sostenerlo manteniendo las condiciones de esterilidad
- Tomar la sonda de aspiración con ambas manos y marcar la medida a introducir colocando una marca.
- Conectar la sonda de aspiración con la tubuladura (T 63) o similar dependiendo de cada servicio hospitalario
- Monitorear los signos vitales del paciente antes de comenzar el procedimiento FC;FR;TA si se cuenta con monitoreo de tensión arterial invasiva y valores de saturación de O2 a fin de evaluar su respuesta y tolerancia.
- Desconectar el TET del circuito del respirador e introducir la sonda de aspiración hasta la marca establecida previamente
- Una vez introducida la sonda ,aplicar presión negativa y retirar la sonda suave y rápidamente
- Evaluar la respuesta al procedimiento.
- Auscultar campos pulmonares para evaluar la necesidad de repetir el procedimiento
- Si se requiere instilación desconectar el respirador e instalar solución fisiológica por TET
- Registrar cantidad y características de las secreciones.
- Descartar la tubuladura de aspiración y realizar higiene del frasco de aspiraciónsegún normativas del servicio

CIRCUITO CERRADO

- No se suspende la ventilación
- Disminuye los efectos adversos
- En pacientes con patología aguda que requieren presiones elevadasdel respirador o alta frecuencia y óxido nítrico previene el colapso de las vías aéreas y de los alveolos.
- Requiere de un solo operador

- El circuito cerrado de aspiración mejora la eficiencia de la técnica,disminuyendo el tiempo de enfermería y los costos, debido a que requiere menos recambio del circuito.

Descripción del circuito cerrado de aspiración:

El sistema de circuito cerrado consta de un dispositivo o boquilla en "Y "que remplaza al adaptador o boquilla del tubo endotraqueal. Esta se conecta por una de las entradas al circuito del respirador y por la otra parte en paralelo, se inserta un dispositivo con un catéter de aspiración que permanece limpio envuelto dentro de una cobertura plástica flexible.

La unión entre el sistema que cubre la sonda de aspiración y el tubo en Y se denomina domo, en la parte distal del catéter hay una ventana por donde se visualiza las secreciones aspiradas y una valvula de control de aspiración que se conecta a la presión negativa. El catéter de aspiración esta numerado y marcado con distintos colores que facilitan la medición antes de introducirlo en el T.E.T

Del lado del dispositivo de la aspiración hay una entrada con tapóna través de la cual se Puede instilar solución fisiológica una jeringa.

Procedimiento de aspiración con circuito cerrado:

- Auscultar ambos campos pulmonares a fin de evaluar presencia de secresiones
- Seleccionar la medida adecuada del catéter de aspiración y dispositivo en Y según medidas del T.E.T
- Retirar el adaptador o boquilla original del T.E.T y reemplazarlo por el dispositivo en Y
- Reconectar nuevamente al circuito del respirador
- Conectar el circuito del respirador a la segunda entrada de la pieza en Y
- Monitorear los signos vitales del paciente.
- Comprimir y rotar la válvula de control
- Liberar la compresión de la válvula de control
- Sujetar la pieza en Y con una mano e introducir el catéter de aspiración con el dedo índice y el pulgar de la mano opuesta hasta la medida estipulada a la altura de la bifurcación de la Y
- Liberar el catéter y comprimir la válvula de control para aplicar aspiración por un periodo máximo de 3 segundos
- Retirar el catéter suave y rápidamente hasta que la marca de color negro en la punta del catéter quede dentro del domo
- Rotar la tapa de control para asegurar que cierre la aspiración
- Auscultar ambos campos pulmonares y repetir procedimiento según necesidad
- Evaluar la respuesta del paciente al procedimiento
- De ser necesaria la instilación, la misma se realiza con solución fisiológica.

Según DisposicionInfectologica De Cada Hospital Este Dispositivo Debe Cambiarse Cada 7dias .Siempre Que Conserve Su Integridad

HUMIDIFICACIÓN, CALENTAMIENTO Y FILTRACIÓN DEL AIRE INSPIRADO

Los filtros intercalados en el circuito inhiben el crecimiento de hongos y bacterias.

El sistema de cascada humidifica y calienta el aire, mientras que la llamada nariz artificial sólo humidifica.

MANTENER UNA COLOCACIÓN ÓPTIMA DEL TUBO

Fórmula para determinar el Nº de tubo endotraqueal:

$$\text{Edad en años}+16\ \%\ 4 \text{ o } \frac{\text{Edad}}{4}+4$$

Para fijar el tubo en el labio
Numero de tubo X 3

Existe una regla nemotécnica que puede ayudar a guiarnos en la correcta posición del tubo: la regla de las tres "T": El TOT suele estar apoyado sobre los dientes en su número **T**ube (tubo), **T**heeth (diente) y **T**wentytwo (veintidós) (Para Adolescentes Y Adultos)
Pero para asegurarnos de la correcta colocación del tubo debemos comprobarlo con la radiografía de Tórax su localizacion(D2-D3 en niños 4 cm. por encima de la carina en adultos).

MANTENER Y COMPROBAR LA PRESIÓN DEL BALON

Se controla a través de un manómetro cada turno. Suele estar entre 20 y 30 cm. de agua.

EVITAR EROSIONES EXTERNAS

Cambiar el punto de apoyo del TET para evitar ulceraciones una vez al día al menos.
Hidratar los labios, higiene bucal.(Ver normas de higiene de paciente en cama, higiene bucal e higiene ocular)
Pulsoximetría, Comprobar la correcta colocación del sensor y rotación del mismo una vez por turno. Ajustar el límite inferior de alarma (90% habitualmente).

NECESIDAD DE ELIMINACIÓN, NUTRIENTES Y AGUA

Anotar estrictamente aportes y pérdidas del paciente y realizar balances hídricosdiarios.
Favorecer la tolerancia a la nutrición enteral.
Comprobar dicha tolerancia poniendoa drenar a bolsa la conexión de la SNG c/6 horas y valorar contenido (alimenticio ogástrico).

NECESIDAD DE SEGURIDAD Y BIENESTAR FÍSICO Y PSÍQUICO

Promover la comunicación verbal y no verbal.
Enseñar al paciente y familiasistemas de comunicación de símbolos.
Estimularlo a que se mantenga entretenido en función de sus hábitos y nivel cultural (TV, libros..) y facilitarle gafas o audífonos si precisa.
Hablarle aunque parezca dormido, informarle clara y concisamente de la evolución de su patología, función de alarmas, Etc.
Comunicarle cómo puede identificarnos y llamarnos.
Evitar tomar decisiones acerca de él y usar tecnicismos en su presencia.
Integrar en lo posible a la familia en los cuidados y explicarle la importancia de suColaboración.
Orientar al paciente de su situación temporoespacial (Colocar Reloj, Calendario,Habitación con ventana).
Fomentar el descanso nocturno respetando el sueño nocturno en lo posible.
Proporcionar un ambiente agradable y tranquilo y respetar su intimidad ante actuaciones que lo precisen.

Valorar el nivel de dolor, ansiedad y adecuar pautas de sedación y analgesia.
Respetar Normas de Bioseguridad e Infectologia en todos los cuidados
Registrar en la hoja de enfermería todos los procedimientos, Según normas

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

Auto PEEP: Presión positiva espiratoria final intrínseca.
BZD: Benzodiacepina.
CV: Cardiovascular.
EAP: Edema Agudo de Pulmón.
EKG: Electrocardiograma.
EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
FC: Frecuencia Cardiaca.
FiO2: Fracción Inspiratoria de Oxígeno.
FR: Frecuencia respiratoria.
GC: Gasto Cardiaco.

IET: Intubación Endotraqueal.
IR: Insuficiencia respiratoria.
IRA: Insuficiencia respiratoria Aguda.
PAW: Presión de Vía Aérea.
PCP: Presión Capilar Pulmonar.
PEEP: Presión Positiva Espiratoria final.
PIC: Presión Intracraneal.
Pmeseta: Presión de Pausa Inspiratoria.
Ppico: Presión de Insuflación Máxima o Pico.
PS: Presión de Soporte.
PSV: Ventilación con Presión de soporte.
PVC: Presión Venosa Central.
RCP: Reanimación Cardiopulmonar.
rpm: Respiraciones por minuto.
Sat O2: Saturación de oxígeno.
SNC: Sistema Nervioso Central.
SR: Sistema respiratorio.
SVP: Soporte Ventilatorio Parcial.
SVT: Soporte Ventilatorio Total.
TAC: Tomografía axial computerizada.
TCE: Traumatismo Craneoencefálico.
TEP: Tromboembolismo Pulmonar.
TET: Tubo Endotraqueal.
TOT: Tubo Ootraqueal.
UCSI: Unidad de Cuidados Semiintensivos.
UVI: unidad de vigilancia intensiva.
Vc: Volumen Corriente o Volumen Tidal.
VM: Ventilación mecánica.
VMA: Ventilación Mecánica Asistida.
VMC: Ventilación Mecánica Controlada.

REALIZADA POR:

Enfermeros asistenciales UTIP
Lic. Salvatierra, Liliana.
Lic. Coronel, Alejandro
Lic. Abasto, Mónica
Lic Morales, Eugenia
LicRasjido, Roxana

BIBLIOGRAFÍA.

- Esteban A., Martín C. Barcelona 1.996. “Manual De Cuidados Intensivos Para Enfermería”. Springer – Verlog Ibérica 3ª Edición.
- Herrera Carranza M. Barcelona 1.997. “Medicina Crítica Práctica”. Iniciación A La V M. Puntos Clave. EdikaMed.
- Carpenito L J., “Diagnóstico De Enfermería”. Interamericana Mc Graw-Hill 5ªedición 1995
- Lake Tailor -Insuficiencia Respiratiria -Fisiologia , Signos Y Síntomas -Mayo 1984 Pag.32-36
- Guyton.A-Tratado De La Fisiología Medica 6ta Edición .Editorial Interamericana
- Cuidados De Enfermería Hospital Garrahan 2012
- Normas De Técnicas Y Procedimientos HNRG-2015
- Normas Infectologicas HNRG-2017Dra. Gentile Angela- LicBeltran, Elizabeth-Lic Cabrera, Mariela .Normas Practicas Para El Control De Infecciones 2017,HNRG –Servicio De Epidemiologia

TÉCNICA DE TENDIDO DE CAMA

Como la comodidad, el reposo y el sueño son factores de gran importancia, tanto para el mantenimiento de la salud como para la convalecencia de una enfermedad, se debe poner especial atención en el arreglo adecuado de la cama, para atender de la mejor manera posible estos factores esenciales.
La cama es de especial importancia para toda persona enferma; si está hospitalizada, la identifica como algo enteramente suyo. Aun cuando se considera un procedimiento común y corriente, el cambio diario y el arreglo periódico de la ropa de cama fomentan la comodidad del paciente y previenen el daño cutáneo. Además, si esta tarea va precedida del lavado de manos, se efectúa con limpieza y se complementa con la manipulación y disposición correcta de la lencería sucia, ayuda a controlar las infecciones nosocomiales.
El arte de vestir la cama para el individuo hospitalizado, con una buena técnica, proporciona comodidad y brinda un aspecto pulcro y agradable a la unidad del paciente.

LEGISLACION VIGENTE
Ley 24004-Normativa para el ejercicio de la Enfermeria- Art. 3 Inciso 18

PERSONAS HABILITADAS
Lic. En Enfermeria
Enfermeros Profesionales
Auxiliares de Enfermeria

OBJETIVOS:
- Realizar una técnica adecuada en el tendido de camas para contribuir a la estética y pulcritud de la unidad del paciente.
- Facilitar un ambiente agradable al paciente, los familiares y el equipo de salud mediante el ordenamiento e higiene de las camas.

CLASIFICACIÓN DE LAS CAMAS.
Las camas se clasifican según su utilización:
- Cama cerrada (sin paciente).
- Cama abierta (con paciente).
- Cama ocupada (con paciente encamado).
- Cama postanestésica (paciente postquirúrgico).

PRECAUCIONES GENERALES PARA EL ARREGLO DE LAS CAMAS:
- Desinfección concurrente o terminal de la cama, para evitar la contaminación de las ropas de cama.
- Evite la diseminación de microorganismos mediante el tendido de cama sin sacudir las sábanas.
- Evite las molestias al paciente, eliminando las arrugas de las sábanas.
- Protéjase de contaminación, evitando el contacto con la ropa sucia.
- Evite alteraciones musculoesqueléticas de su organismo, manteniendo la mecánica corporal.
- Utilizar Guantes o Manoplas no esteriles.
- Lavarse las manos al quitárselos
- Registrar el procedimiento

PROCEDIMIENTO DE LA CAMA CERRADA

Cama Cerrada: Es la cama que se encuentra desocupada en espera del nuevo ingreso, la cual se prepara después de su desinfección terminal por haber ocurrido un egreso.

OBJETIVO:

- Ahorrar tiempo y facilita la recepción del paciente.

PRECAUCIONES:

Se tendrán presentes las precauciones generales.

EQUIPO:

- Una bandeja.
- Dos sábanas.
- Una funda. (Si hubiese)
- Un dispositivo o recolector de ropa sucia.

PROCEDIMIENTOS:

- Coloque cerca de la cama el dispositivo recolector de ropas sucias.
- Lávese las manos. (Ver Normas infectologicas)
- Doble las sábanas a lo largo, cuidando de que una de ellas quede con el dobladillo al derecho y la otra con el dobladillo al revés.
- Gire al revés la funda hasta la mitad de su extensión y dóblela.
- Coloque en la bandeja las ropas de cama en el orden inverso al que han de ser usadas.
- Lleve el equipo junto a la cama.
- Retire la almohada y colóquela en la silla.
- Retire la ropa sucia y échela ordenadamente en el cesto.
- Coloque la sábana que protege el colchón (sábana clínica) a lo largo de la línea media del mismo.
- Desdóblela de modo que el dobladillo quede al derecho, al ras del colchón, y deje el sobrante en la cabecera.
- Introduzca debajo de la cabecera del colchón el extremo sobrante de la sábana.
- Doble la esquina en forma de sobre, sosteniendo la sábana contra el colchón con una mano y levantando con la otra mano la orilla, de modo que forme un triángulo.
- Introduzca debajo del colchón el resto de la sábana clínica que colgaba por los laterales desde la cabecera hasta los pies.
- Pase al otro lado y proceda con la sábana clínica, como ya hemos señalado.
- Estire bien la sábana para que al fijarla bajo el colchón quede bien alineada.
- Coloque la sábana cubierta (sábana que cubre al paciente) a lo largo de la línea media del colchón. El dobladillo quedará al revés y estará al borde del colchón en la cabecera de la cama, debe colgar en igual forma en ambos lados y el sobrante hacia los pies del paciente.
- Introduzca la sábana por debajo del colchón. Realice el sobre en ambos lados.
- Introduzca la almohada en la funda que está doblada a la mitad.
- Estire la funda sobre la almohada agarrándola por el dobladillo, para evitar que toque su cuerpo.
- Coloque la almohada de modo que la abertura de la funda quede del lado opuesto a la puerta, lo cual favorece la estética.
- En aquellas instituciones donde exista el cubrecama, esta debe quedar tendida de la misma forma que la sábana cubierta.
- Estire el cubrecama para evitar arrugas y favorecer la estética.

- Invariantes funcionales de los tipos de camas:
- Retire el dispositivo o recolector de ropas sucias.
- Recoja la bandeja y colóquela en la vitrina o closet.
- Lávese las manos. (Ver Normas infectologicas)

PROCEDIMIENTO DE LA CAMA ABIERTA

Cama abierta. Es la cama que se prepara para recibir a un paciente, o cuando está ingresado o deambulando.

OBJETIVO:

- Proporcionar comodidad al paciente.

PRECAUCIONES:

- Se tendrán presentes las precauciones generales.
- Voltear el colchón para cambiar las áreas presionadas por el cuerpo.

EQUIPO:

- Una bandeja.
- Dos sábanas.
- Una funda. (**Si Hubiese**)_
- Un dispositivo o recolector de ropa sucia.
- Un hule tirante.
- Sábana tirante (ambos doblados a la mitad).
- Una frazada (si fuera necesario).

PROCEDIMIENTOS:

- Coloque cerca de la cama el dispositivo o recolector de ropas sucias.
  Lávese las manos.
- Doble las sábanas a lo largo, cuidando que una de ellas quede con el dobladillo al derecho y la otra con el dobladillo al revés.
- Gire al revés la funda hasta la mitad de su extensión y dóblela.
- Coloque en la bandeja las ropas de cama en el orden inverso al que han de ser usadas.
  Lleve el equipo junto a la cama.
- Retire la almohada y colóquela en la silla. Retire las ropas sucias y échelas ordenadamente en el cesto.
- Coloque la sábana que protege el colchón (sábana clínica) a lo largo de la línea media del mismo.
- Desdóblela de modo que el dobladillo quede al derecho, al ras del colchón, y deje el sobrante en la cabecera.
- Introduzca en la cabecera del colchón el extremo sobrante de la sábana.
- Doble la esquina en forma de sobre, sosteniendo la sábana contra el colchón con una mano y levantando con la otra mano la orilla, de modo que forme un triángulo.
- Introduzca debajo del colchón el resto de la sábana clínica que colgaba por los laterales desde la cabecera hasta la pielera.
- Pase al otro lado y proceda con la sábana clínica, como ya hemos señalado anteriormente.
- Estire bien la sábana para que al fijarla bajo el colchón quede bien alineada.
- Coloque el hule y la sábana tirante en dependencia de la región afectada; introduzca ambos extremos debajo del colchón, teniendo en cuenta que el tirante quede por encima del hule.

- Trasládese al lado opuesto de la cama, realice la misma operación, cuidando de que estos queden bien estirados.
- Coloque la sábana cubierta a lo largo de la línea media del colchón; el dobladillo quedará al revés y estará al borde del colchón en la cabecera de la cama; debe colgar de igual forma en ambos lados y el sobrante hacia Los Pies.
- Introduzca la sábana por debajo del colchón. Realice el sobre en ambos lados, teniendo en cuenta hacer un pliegue para la comodidad de los pies.
- Baje la sábana cubierta a la altura de los hombros del paciente, haciendo un doblez sobre sí misma.
- Introduzca la almohada en la funda que está doblada a la mitad.
- Estire la funda sobre la almohada cogiéndola por el dobladillo para evitar que toque su cuerpo.
- Coloque la almohada de modo que la abertura de la funda quede del lado opuesto a la puerta, lo cual favorece la estética.
- Coloque la almohada según la comodidad del paciente.
- Coloque la frazada de igual forma que la sábana cubierta, si fuera necesario.
- Retire el dispositivo o recolector de ropas sucias.
- Recoja la bandeja y colóquela en la vitrina o closet.
- Lávese las manos. (Ver Normas infectologicas)

PROCEDIMIENTO PARA ARREGLAR LA CUNA

Cuna: Es la cama con barandas, construida con materiales de diferentes tipos (metal, plástico, madera y otros) que se prepara para los niños, fundamentalmente recién nacidos y lactantes.

OBJETIVOS:

- Mantener la higiene del recién nacido y el lactante.
- Brindar comodidad.
- Brindar protección y seguridad.

PRECAUCIONES:

- Desinfección concurrente y terminal de la cuna para evitar la contaminación de las ropas de cama.
- Voltee el colchón antes de tender la cuna.
- Evite la diseminación de microorganismos: la cama se tenderá sin sacudir la sábana.
- Evite las molestias al niño, eliminando las arrugas de la sábana.
- Protéjase de la contaminación, evitando el contacto con la ropa sucia.

EQUIPO:

- Una bandeja.
- Dos sabanitas.
- Pañal Grande
- Tres funditas.
- Dispositivo o recolector de ropas sucias.

PROCEDIMIENTOS:

- Coloque cerca de la cuna el dispositivo recolector de ropas sucias.
- Lávese las manos. (Ver Normas infectologicas)
- Doble las sábanas a lo largo, cuidando que una de ellas quede con el dobladillo al derecho y la otra con el dobladillo al revés.
- Gire al revés las funditas hasta la mitad de su extensión y dóblelas.

- Lleve el equipo junto a la cuna.
- Retire las almohaditas, colóquelas en la silla.
- Retire la ropa sucia y póngala ordenadamente en el cesto.
- Coloque la sábana que protege al colchón (sábana clínica) a lo largo de la línea media del mismo.
- Introduzca la sábana por debajo de la cabecera del colchón.
- Doble la esquina en forma de sobre, sosteniendo la sábana contra el colchón con una mano y levantando con la otra la orilla, de modo que forme un triángulo.
- Introduzca debajo del colchón el resto de la sábana que cuelga por los laterales: proceda primero por el lado distal y después por el proximal.
- Estire la sábana para que no queden arrugas.
- Coloque la sábana cubierta a lo largo de la línea media del colchón; el dobladillo quedará al revés y estará al borde del colchón en la cabecera de la cama, debe colgar de igual forma en ambos lados.
- Introduzca la sábana por debajo de la pielera del colchón. Realice el sobre en ambos lados y el resto de la sábana colóquela por debajo del colchón. Haga un pliegue en la pielera para la comodidad de los pies. Si fuera necesario, la frazada se colocará igual que la sábana cubierta.
- Baje la sábana cubierta a la altura de los hombros del niño y haga un doblez sobre sí misma. Si el niño es un lactante, la sábana cubierta no se introduce debajo del colchón para que este tenga libertad de movimientos. En este caso se considerará si debe ser doblada y colocada en una esquina o no se pondrá la sábana cubierta.
- Introduzca las almohaditas en las fundas que están dobladas a la mitad, y colóquelas en los laterales y en la cabecera de la cuna para evitar traumatismos.
- Coloque las almohadas de modo que las aberturas de las fundas queden del lado opuesto a la puerta para favorecer la estética.
- Retire el depósito recolector de ropas sucias.
- Lávese las manos. (Ver Normas infectologicas)

- **PROCEDIMIENTOS PARA DESVESTIR LAS CAMAS:**
- Retire la almohada y quite la funda.
- Coloque la almohada en el asiento de la silla y eche la funda en el dispositivo o recolector de ropas sucias, de no existir, se colocará la funda usada en el espaldar de la silla en forma de bolsa, destinada para este fin.
- Afloje las ropas de cama alrededor de todo el colchón.
- Retire pieza por pieza, doblándola sobre sí misma y colocándola en el dispositivo o recolector de ropas sucias.
- Retire el depósito o recolector de ropas sucias.
- Registrar el procedimiento

Recordar Que Tanto El Tendido De Cama Como El Destendido De La Misma, Se Realiza Con Guantes, Al Quitarse Los Mismos Lavarse Las Manos. (Ver Normas Infectologicas)

REALIZADO POR:
Enfermera Profesional, Isabel, de la Vega, Jefe Sección U14

BIBLIOGRAFIA
Manual de Normas de Enfermería- HNRG-CABA-,-2015-
El Manual Moderno –Fundamento De Enfermería, Tendido De Cama .Pág. 272-283

Anexo

Derechos del niño hospitalizado
Convención sobre los Derechos del Niño.
Ley 23.849, UNICEF Argentina.

1. Los niños serán internados en el Hospital sólo si el cuidado que requieren no puede ser igualmente provisto en su hogar o en un tratamiento ambulatorio.
2. Los niños en el hospital tienen el derecho de estar junto a sus padres o a un sustituto de los padres, todo el tiempo que permanezcan internados.
3. Los padres deben ser ayudados y alentados para que compartan el cuidado de sus hijos, y deben ser informados acerca de la rutina de la sala.
4. Los niños y sus padres deben tener el derecho de estar informados de manera apropiada para su edad y entendimiento.
5. Deben ser tomadas todas las precauciones posibles para evitar en los niños el stress físico y emocional.
6. Los niños y sus padres tienen derecho a la participación informada en todas las decisiones que tengan que ver con el cuidado de su salud.
7. Cada niño debe ser protegido del dolor, de tratamientos y procedimientos innecesarias.
8. En caso de ser invitados a participar en ensayos clínicos o pruebas, los padres deben ser informados detalladamente sobre el procedimiento y, una vez comprendido, deberán autorizarlo por escrito (consentimiento informado). Si el niño tiene capacidad de comprensión, deberá decidir por sí mismo si quiere participar de dichas pruebas.
9. El niño tiene derecho a compartir su internación con otros niños que tengan las mismas necesidades de desarrollo y, salvo en casos de necesidad extrema, no deben ser internados en sala de adultos.
10. Los niños deben tener oportunidad de jugar, recrearse y educarse de acuerdo con su edad y condiciones de salud y posibilidades del hospital.
11. Los niños deben ser cuidados por personal capaz de responder a las necesidades físicas y emocionales de los niños y sus familias.
12. Debe disponerse por todos los medios posibles, la continuidad del tratamiento y el cuidado, tanto por el equipo de salud como el grupo familiar a cargo del niño.
13. Cada niño debe ser tratado con tacto y comprensión y su privacidad debe ser respetada en toda circunstancia. Esto incluye los medios de comunicación masiva.
14. Debe tratarse por todos los medios de que el niño se sienta protegido y acompañado, cualquiera sea la circunstancia por la que se halla internado.

EJERCICIO DE LA ENFERMERIA

Decreto 2497/93

Apruébase la reglamentación creada por Ley Nº 24.004.

Bs. As., 9/12/93
VISTO la Ley Nº 24.004 que establece las normas del Ejercicio de la Enfermería, y
CONSIDERANDO:
Que para el funcionamiento del Ejercicio de la Enfermería, resulta necesario proceder a su reglamentación.
Que el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL ha proyectado la correspondiente reglamentación.
Que en la elaboración del presente se ha contemplado la regulación de aquel artículo que resulta imprescindible para la vigencia del nuevo ordenamiento.
Que el presente decreto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 86, inciso 2º de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º – Apruébase la reglamentación del EJERCICIO DE LA ENFERMERIA creado por Ley Nº 24.004, que forma parte integrante del presente decreto como Anexo I.
Art. 2º – Facúltase a la SECRETARIA DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL para dictar las normas complementarias que requiera la aplicación del Reglamento que se aprueba por el presente Decreto.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Alberto J. Mazza. — Jorge A. Rdríguez.

ANEXO I

Reglamento de la Ley Nº 24.004
ARTICULO 1º — El ejercicio libre y autónomo de la enfermería queda reservado al nivel profesional establecido en el artículo 3, inciso a), pudiendo desarrollarse en gabinetes privados, en el domicilio de las personas, en locales, instituciones o establecimientos públicos o privados, y en todos aquellos ámbitos donde se autorice el desempeño de sus competencias, exigiéndose en todos los casos habilitación de los lugares y la pertinente autorización para ejercer.
Los locales o establecimientos dedicados a las actividades de enfermería, deberán contar con un enfermero/a profesional a cargo, debidamente matriculado, cuyo diploma o certificado será exhibido convenientemente.
Son deberes de dicho profesional, los siguientes:
a) Controlar que los que se desempeñen como profesionales o auxiliares, estén matriculados, autorizados para ejercer por la autoridad sanitaria de aplicación y que realicen sus actividades dentro de los límites de su autorización.
b) Velar porque los pacientes reciban el más correcto, adecuado y eficaz tratamiento, garantizando por parte del personal, actitudes de respeto y consideración hacia la personalidad del paciente y sus creencias.
c) Adoptar las medidas necesarias a fin que el establecimiento reúna los requisitos exigidos por las autoridades, controlando las condiciones de higiene y limpieza de cada dependencia.
d) Adoptar los recaudos necesarios para que se confeccionen los registros adecuados para la documentación de las prestaciones.
e) Denunciar hechos que pudiesen tener carácter delictuoso, accidentes de trabajo, enfermedades o cualquier circunstancia que, según las normas vigentes, pudieran comprometer la salud de la población, adoptando las medidas necesarias para evitar su propagación.
La responsabilidad del profesional a cargo de los locales o establecimientos no excluye la de los demás profesionales o auxiliares ni la de las personas físicas o ideales propietarias de los mismos.
La habilitación de locales o establecimientos y la aprobación de su denominación deberá estar sujeta a: condiciones de planta física, higiénico-sanitarias y de seguridad, contar con equipos, materiales y sistemas de registros adecuados a las prestaciones que se realicen y en general se ajustará a las normas mínimas del organismo de aplicación.

ARTICULO 2º — La docencia, la investigación, el asesoramiento y la administración de servicios estarán a cargo de los profesionales incluidos en el nivel establecido en el inciso a) del artículo 3º de la Ley Reglamentada.
ARTICULO 3º — Es de competencia específica del nivel profesional lo establecido en las incumbencias de los títulos habilitantes de licenciado/a en Enfermería y Enfermero/a. A todos ellos les está permitido lo siguiente:
1) Planear, implementar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar la atención de enfermería en la prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.
2) Brindar cuidados de enfermería a las personas con problemas de salud de mayor complejidad asignando al personal a su cargo acciones de enfermería de acuerdo a la situación de las personas y al nivel de preparación y experiencia del personal.
3) Realizar la consulta de enfermería y la prescripción de la atención de enfermería.
4) Administrar servicios de enfermería en los diferentes niveles del sistema de servicios de salud utilizando criterios tendientes a garantizar una atención de enfermería personalizada y libre de riesgos.
5) Organizar y controlar el sistema de informes o registros pertinentes a enfermería.
6) Establecer normas de previsión y control de materiales y equipos para la atención de enfermería.
7) Planificar, implementar y evaluar programas de salud juntamente con el equipo interdisciplinario y en los niveles nacional y local.
8) Participar en la programación de actividades de educación sanitaria tendientes a mantener y mejorar la salud del individuo, familia y comunidad.
9) Participar en los programas de higiene y seguridad en el trabajo en la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y del trabajo.
10) Participar en el desarrollo de la tecnología apropiada para la atención de la salud.
11) Planificar, organizar, coordinar, desarrollar y evaluar los programas educacionales de formación de enfermería en sus distintos niveles y modalidades.
12) Participar en la formación y actualización de otros profesionales de la salud en áreas de su competencia.
13) Realizar y/o participar en investigaciones sobre temas de enfermería y de salud.
14) Asesorar sobre aspectos de su competencia en el área de la asistencia, docencia, administración e investigación de enfermería.
15) Participar en comisiones examinadoras en materias específicas de enfermería, en concursos para la cobertura de puestos a nivel profesional y auxiliar.
16) Elaborar las normas de funcionamiento de los servicios de enfermería en sus distintas modalidades de atención y auditar su cumplimiento.
17) Integrar los organismos competentes de los MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL y de CULTURA Y EDUCACION relacionados con la formación y utilización del Recurso Humano de enfermería y los organismos técnico-administrativos del sector.
18) Realizar todos los cuidados de enfermería encaminados a satisfacer las necesidades de las personas en las distintas etapas del ciclo vital, según lo siguiente:
A) Valorar el estado de salud del individuo sano o enfermo y diagnosticar sus necesidades o problemas en el área de su competencia e implementar acciones tendientes a satisfacer las mismas.
B) Participar en la supervisión de las condiciones del medio ambiente que requieren los pacientes de acuerdo a su condición.
C) Controlar las condiciones de uso de los recursos materiales y equipos para la prestación de cuidados de enfermería.
D) Supervisar y realizar las acciones que favorezcan el bienestar de los pacientes.
E) Colocar sondas y controlar su funcionamiento.
F) Control de drenajes.
G) Realizar control de signos vitales.
H) Observar, evaluar y registrar signos y síntomas que presentan los pacientes, decidiendo las acciones de enfermería a seguir.
I) Colaborar en los procedimientos especiales de diagnósticos y tratamientos.
J) Planificar, preparar, administrar y registrar la administración de medicamentos por vía enteral, parental, mucosa, cutánea y respiratoria, natural y artificial, de acuerdo con la orden médica escrita, completa, firmada y actualizada.
K) Realizar curaciones simples y complejas, que no demanden tratamiento quirúrgico.
L) Realizar punciones venosas periféricas.
LL) Controlar a los pacientes con respiración y alimentación asistidas y catéteres centrales y otros.
M) Participar en los tratamientos quimioterápicos, en diálisis peritoneal y hemodiálisis.
N) Brindar cuidados de enfermería a pacientes críticos con o sin aislamiento.

Ñ) Realizar y participar en actividades relacionadas con el control de infecciones.
O) Realizar el control y el registro de ingresos y egresos del paciente.
P) Realizar el control de pacientes conectados a equipos mecánicos o electrónicos.
Q) Participar en la planificación, organización y ejecución de acciones de enfermería en situaciones de emergencia y catástrofes.
R) Participar en el traslado de pacientes por vía aérea, terrestre, fluvial y marítima.
S) Realizar el registro de evolución de pacientes y de prestaciones de enfermería del individuo y de la familia, consignando: fecha, firma y número de matrícula.
Es de competencia del nivel de auxiliar de enfermería, de acuerdo a lo dispuesto en el inc. B):
1) Realizar procedimientos básicos en la internación y egresos de los pacientes en las instituciones de salud.
2) Preparar y acondicionar los materiales y equipos de uso habitual para la atención de los pacientes.
3) Ejecutar medidas de higiene y bienestar del paciente.
4) Apoyar las actividades de nutrición de las personas.
5) Aplicar las acciones que favorezcan la eliminación vesical e intestinal espontánea en los pacientes.
6) Administrar enemas evacuantes, según prescripción médica.
7) Realizar los controles y llevar el registro de Pulso, Respiración, Tensión Arterial, Peso, Talla y Temperatura.
8) Informar a la enfermera/o y/o médico acerca de las condiciones de los pacientes.
9) Aplicar inmunizaciones previa capacitación.
10) Preparar al paciente para exámenes de diagnóstico y tratamiento.
11) Colaborar en la rehabilitación del paciente.
12) Participar en programas de salud comunitaria.
13) Realizar curaciones simples.
14) Colaborar con la enfermera en procedimiento especiales.
15) Participar en los procedimientos postmortem de acondicionamiento del cadáver, dentro de la unidad o sala.
16) Informar y registrar las actividades realizadas, consignando Nombre, Apellido, Número de Matrícula o Registro.
17) Aplicar procedimientos indicados para el control de infecciones.
Únicamente las personas contempladas en el Capítulo VII, artículo 23 inciso A) Disposiciones Transitorias podrán continuar en el ejercicio de las funciones de enfermería en el plazo establecido por el inciso B) del mismo artículo, sin poseer título, diploma o certificado habilitante o Auxiliares de Enfermería que estén ejerciendo actividades fuera de su nivel.
ARTICULO 4º — SIN REGLAMENTAR.
ARTICULO 5º —
Inciso a): Los títulos habilitantes son enfermero/a universitario, licenciado/a en enfermería y los que en el futuro se obtengan a partir del título de grado.
Inciso c): La reválida de títulos estará a cargo del Estado.
1) Una Universidad Nacional realizará la reválida para el inciso a).
2) Los Organismos pertinentes establecerán las condiciones de reválida en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la aprobación de la Reglamentación para el inciso c). Dicha reválida deberá ajustarse a las normas, planes y programas vigentes y/o convenios de reciprocidad.
ARTICULO 6º — La reválida de los certificados auxiliares de enfermería será realizada, por el Organismo Estatal competente, de acuerdo a las condiciones que establezcan en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la aprobación de la presente Reglamentación. La reválida deberá ajustarse a las normas, planes y programas vigentes y/o convenios de reciprocidad.
ARTICULO 7º — Podrán emplear el título de especialista o anunciarse como tales aquellos profesionales que acrediten alguna de las siguientes condiciones:
a) Poseer certificación otorgada por Comisiones Especiales de Evaluación designadas por la autoridad de aplicación, conformadas por enfermeros/as profesionales con funciones de conducción en establecimientos públicos o privados reconocidos, las que tendrán en cuenta: antigüedad no menor de CINCO (5) años de graduación y TRES (3) de ejercicio de la especialidad, títulos, trabajos y el resultado de una prueba de evaluación.
b) Ser profesor universitario de la materia, en actividad obtenido por concurso, en el nivel de titular, asociado o adjunto, o denominación similar.
c) Poseer certificado de Residencia en la especialidad, de una duración no menor de TRES (3) años, reconocida por la autoridad sanitaria nacional.

d) Poseer título de especialista universitario otorgado o revalidado por Universidad Nacional o Privada reconocida.
e) Poseer certificado otorgado por Entidad científica, asociaciones profesionales, escuelas o instituciones reconocidas para tal fin por la autoridad sanitaria nacional, acumulando no menos de CINCO (5) años de graduación como profesional y no menos de TRES (3) en ejercicio de la especialidad y un curso de no menos de OCHOCIENTAS (800) horas teórico-prácticas.
Por única vez y dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de publicada la presente Reglamentación podrán obtener el reconocimiento de la especialidad mediante el sistema del inciso a) aquellas personas que acrediten CINCO (5) o más años como auxiliar de enfermería y DOS (2) o más como enfermero/a profesional, documentando CINCO (5) años de ejercicio de la especialidad.
La autoridad de aplicación, con la colaboración de la Comisión del artículo 17, elaborará una nómina de especialidades, la que se actualizará periódicamente de la misma forma.
Cada CINCO (5) años la autorización para emplear el título de especialista será revalidada en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación, con la participación de la Comisión del artículo 17.
ARTICULO 8º — Los profesionales comprendidos en el artículo Reglamentado:
a) Limitarán sus actividades para las que hayan sido especialmente requeridos, no pudiendo ejercer la profesión libre o en relación de dependencia en otras funciones.
b) Los contratos no podrán exceder el término de UN (1) año, no renovable.
c) Las instituciones deberán comunicar a la SECRETARIA DE SALUD PUBLICA y a la ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE ENFERMERIA la identidad del contratado y acreditar su idoneidad.
d) Deberán inscribirse en un registro especialmente habilitado para tal fin en la DIRECCION NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL. La inscripción caducará automáticamente con la finalización del contrato.
ARTICULO 9º — Para gozar del derecho establecido en el inciso C) del artículo 9º de la Ley, el profesional o auxiliar de enfermería deberá justificar su negativa e informar a su superior jerárquico con la adecuada anticipación para que éste adopte las medidas de sustitución para que la asistencia de enfermería no resulte afectada.
ARTICULO 10.— El Personal de enfermería deberá realizar periódicamente actividades o cursos de actualización de acuerdo a los avances científico-técnicos de la medicina en general y de su profesión en particular. Para ello deberán las instituciones garantizar el cumplimiento del artículo 9º, inciso d) de la Ley y su Reglamentación.
ARTICULO 11.— SIN REGLAMENTACION.
ARTICULO 12. — Matriculación: el personal dependiente de instituciones públicas o privadas tanto en el nivel profesional como auxiliar que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Reglamentación no hubiera cumplido con el requisito de matriculación, tendrá un plazo improrrogable de NOVENTA (90) días para regularizar su situación.
ARTICULO 13.— SIN REGLAMENTACION.
ARTICULO 14.— SIN REGLAMENTACION.
ARTICULO 15.— SIN REGLAMENTACION.
ARTICULO 16.— SIN REGLAMENTACION.
ARTICULO 17.— La SECRETARIA DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL procederá a designar la Comisión Permanente de Asesoramiento y Colaboración establecida por el artículo 17º de la Ley en un plazo de TREINTA (30) días a partir de la publicación en el B. O. de la presente Reglamentación, la que tendrá las siguientes funciones:
a) Evaluar periódicamente el cumplimiento de la Ley y su Reglamentación promoviendo las modificaciones que considere pertinentes.
b) Asesorar sobre la interpretación en cuanto a derechos, deberes y obligaciones enunciados y las eventuales transgresiones a los mismos.
c) Promover la actualización de las competencias de los niveles del artículo 3º de la Ley.
d) Elaborar estándares y normas sobre el ejercicio individual e institucional de la actividad.
e) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y promover la creación de subcomisiones.
f) Auditar la aplicación de las disposiciones relativas a la protección de la salud y de la seguridad del personal de enfermería.
ARTICULO 18. — SIN REGLAMENTACION.
ARTICULO 19.— SIN REGLAMENTACION.
ARTICULO 20.— SIN REGLAMENTACION.

ARTICULO 21.— SIN REGLAMENTACION.
ARTICULO 22. — A los efectos de establecer las condiciones cuyo déficit o incumplimiento haría aplicable el artículo 22º de la Ley, la autoridad sanitaria nacional, con la participación de la Comisión creada por el artículo 17º de la Ley, elaborará las normas correspondientes, en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días de publicada la presente Reglamentación, como así también el procedimiento para que los profesionales y/o auxiliares las denuncien, para la prevención de eventuales daños a la salud de la población.
ARTICULO 23. — Para continuar en el ejercicio de sus funciones por los plazos que fija el artículo 23º de la Ley el interesado deberá:
a) Inscribirse por medio de la declaración jurada, que a ese efecto elaborará la SECRETARIA DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL.
b) Adjuntar a la documentación:
UNA (1) fotocopia del título o certificado de auxiliar de enfermería (si es el caso).
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
A los CUATRO (4) años de entrada en vigencia de la presente Reglamentación el Organismo de aplicación, a través de la Comisión creada por el artículo 17º de la Ley, evaluará el cumplimiento de los plazos a fin de determinar las modificaciones pertinentes.
Los plazos comenzarán a tener vigencia a partir del inicio del ciclo lectivo 1994.
ARTICULO 24. — SIN REGLAMENTACION.
ARTICULO 25. — SIN REGLAMENTACION.
ARTICULO 26.— SIN REGLAMENTACION.
ARTICULO 27. — SIN REGLAMENTACION.
ARTICULO 28.— SIN REGLAMENTACION.
ARTICULO 29. — SIN REGLAMENTACION.

LEY 26529 PODER LEGISLATIVO NACIONAL (PLN)

Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. Sanción: 21/10/2009; Promulgación de Hecho: 19/11/2009; Boletín Oficial 20/11/2009.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA CLINICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

Artículo 1º.- Ambito de aplicación. El ejercicio de los derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica, se rige por la presente ley.

Capítulo I DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACION CON LOS PROFESIONALES E INSTITUCIONES DE LA SALUD

Art. 2º.- Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se trate, los siguientes:
a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente;
b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes, le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes;
c) Intimidad. Toda actividad médico - asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley Nº 25.326;
d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente;
e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley Nº 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud;
f) Información Sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información.
g) Interconsulta Médica. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud.

Capítulo II DE LA INFORMACION SANITARIA

Art. 3º.- Definición. A los efectos de la presente ley, entiéndase por información sanitaria aquella que, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueren menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos.

Art. 4º.- Autorización. La información sanitaria sólo podrá ser brindada a terceras personas, con autorización del paciente. En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico o psíquico, la misma será brindada a su representante legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente, o la persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Capítulo III DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Art. 5º.- Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a: a) Su estado de salud; b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; c) Los beneficios esperados del procedimiento; d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.

Art. 6º.- Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente.

Art. 7º.- Instrumentación. El consentimiento será verbal con las siguientes excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito: a) Internación; b) Intervención quirúrgica; c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos; d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la presente ley; e) Revocación.

Art. 8º.- Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento del paciente o en su defecto, el de sus representantes legales, y del profesional de la salud interviniente ante exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la realización de dicha exposición.

Art. 9º.- Excepciones al consentimiento informado. El profesional de la salud quedará eximido de requerir el consentimiento informado en los siguientes casos: a) Cuando mediare grave peligro para la salud pública; b) Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la salud o vida del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes legales. Las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformidad a lo que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con carácter restrictivo.

Art. 10.- Revocabilidad. La decisión del paciente o de su representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimientos de los riesgos

previsibles que la misma implica. En los casos en que el paciente o su representante legal revoquen el rechazo dado a tratamientos indicados, el profesional actuante sólo acatará tal decisión si se mantienen las condiciones de salud del paciente que en su oportunidad aconsejaron dicho tratamiento. La decisión debidamente fundada del profesional actuante se asentará en la historia clínica.

Art. 11.- Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes.

Capítulo IV DE LA HISTORIA CLINICA

Art. 12.- Definición y alcance. A los efectos de esta ley, entiéndase por historia clínica, el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud.

Art. 13.- Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica, puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin, debe adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. La reglamentación establece la documentación respaldatoria que deberá conservarse y designa a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la misma.

Art. 14.- Titularidad. El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, salvo caso de emergencia.

Art. 15.- Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar: a) La fecha de inicio de su confección;
b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar; c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad; d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes; e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere; f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas. Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e) y f) del presente artículo, deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que la autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria.

Art. 16.- Integridad. Forman parte de la historia clínica, los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas,

debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario del acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante.

Art. 17.- Unicidad. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio de una “clave uniforme”, la que deberá ser comunicada al mismo.

Art. 18.- Inviolabilidad. Depositarios. La historia clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en su calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquélla, y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas. A los depositarios les son extensivas y aplicables las disposiciones que en materia contractual se establecen en el Libro II, Sección III, del Título XV del Código Civil, “Del depósito”, y normas concordantes. La obligación impuesta en el párrafo precedente debe regir durante el plazo mínimo de DIEZ (10) años de prescripción liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho plazo se computa desde la última actuación registrada en la historia clínica y vencido el mismo, el depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que determine la reglamentación.

Art. 19.- Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica: a) El paciente y su representante legal; b) El cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no de distinto sexo según acreditación que determine la reglamentación y los herederos forzosos, en su caso, con la autorización del paciente, salvo que éste se encuentre imposibilitado de darla; c) Los médicos, y otros profesionales del arte de curar, cuando cuenten con expresa autorización del paciente o de su representante legal. A dichos fines, el depositario deberá disponer de un ejemplar del expediente médico con carácter de copia de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías que las debidas al original. Asimismo podrán entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente médico, dejando constancia de la persona que efectúa la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás consideraciones que resulten menester.

Art. 20.- Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 19 de la presente ley, frente a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá del ejercicio de la acción directa de “habeas data” a fin de asegurar el acceso y obtención de aquélla. A dicha acción se le imprimirá el modo de proceso que en cada jurisdicción resulte más apto y rápido. En jurisdicción nacional, esta acción quedará exenta de gastos de justicia.

Art. 21.- Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones previstas en el título VIII de la Ley 17.132 - Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas- y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en cada una de ellas.

Capítulo V DISPOSICIONES GENERALES

Art. 22.- Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación de la presente ley en la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, y en cada una de las

jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima autoridad sanitaria local. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley en lo que es materia del régimen de sanciones y del beneficio de gratuidad en materia de acceso a la justicia.

Art. 23.- Vigencia. La presente ley es de orden público, y entrará en vigencia a partir de los NOVENTA (90) días de la fecha de su publicación.

Art. 24.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días contados a partir de su publicación.

Art. 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los 21 dias del mes de octubre del año dos mil nueve. Registrada bajo el Nº 26.529

PRESENTACIÓN DE LOS LÍQUIDOS O BOLSAS DE DIÁLISIS DE FRESENIUS

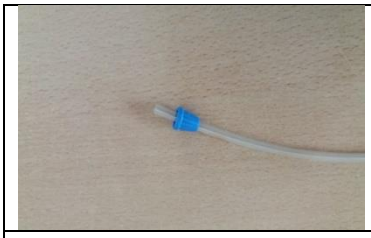
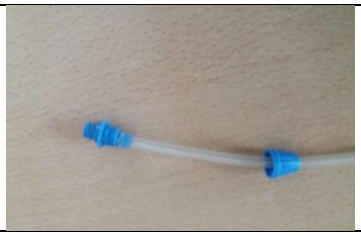
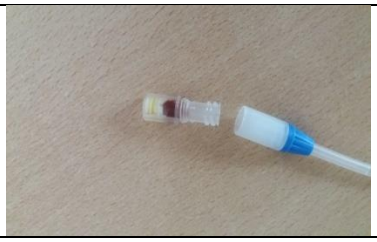
- Solución 1,5 g/% dx. Monohidrato. Equivale a 358 mOsm/l.= pH 5,5
- Solución 2,3 g/% dx. Monohidrato. Equivale a 396 mOsm/l. = pH 5,5
- Solución 4,25 g/% dx. Monohidrato. Equivale a 511 mOsm/l. pH 5,5

En general se comienza con soluciones al 1,5%, si el paciente requiere aumentar la remoción de fluidos (ultrafiltración) y no se dispone de bolsas con mayor osmolalidad, se puede aumentar la osmolalidad del líquido agregando dextrosa Al 50%.

Tapón desinfectante • Función: Tapón con reservorio interno de solución de Iodopovidona para proteger el extremo distal de la extensión del catéter y asegurar que no hay crecimiento bacteriano por el contacto con el exterior.
De un solo uso. Se cambia en cada intercambio de solución de diálisis peritoneal.
Extensión de catéter (prolongador o set de transferencia). Es una extensión de silicona de 40cm de longitud, para el catéter de diálisis peritoneal, con pinza o clamp integrado.
Es de uso exclusivo con el sistema andy•disc, para adaptar el catéter de diálisis peritoneal del paciente al disco del sistema de doble bolsa.
Adaptador de catéter. Es utilizado para conectar o unir el extremo abdominal externo del catéter de diálisis peritoneal del paciente con la extensión que se adapta al sistema de seguridad del Andy Disc.

Soluciones de D.P: de 1.5%, 2.3% y 4.25% Es un producto diseñado para realizar diálisis peritoneal La bolsa de solución está conectada a la bolsa de drenaje y a la vez se unen a un disco o llave que regula todos los pasos del tratamiento para hacer el procedimiento más fácil
El producto posee un exclusivo sistema de disco o llave giratorio que permite regular todos los pasos del procedimiento: drenaje, purgado, infusión y finalización. Se regula todos los pasos del tratamiento girando el disco en una única dirección.

DIÁLISISPERITONEAL INTERMITENTE solo llegamos al punto tres (3) infusión y de allí regresamos al punto uno (1) Posee un exclusivo cierre automático con la tecnología PIN que provee seguridad y garantiza que la conexión al catéter del paciente se mantenga totalmente cerrada y de esta forma proteger al paciente de infecciones. Usos: pacientes con insuficiencia renal terminal en tratamiento en el hogar

		
Catéter Peritoneal con Rosca de ajuste		Catéter Peritoneal con Conector y Rosca de ajuste
Prolongador o set de transferencia		Catéter Peritoneal, con prolongador o set de transferencia
		
Espiga o llave de paso		Tapa para cierre de prolongador o set de transferencia

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Salud

Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez"

Protocolo de Caída De PACIENTE

Realizado por:	Revisores	Autorizado por
Dr. Fiorentino,Jorge Jefa De División Lic. Negrete, Graciela Jefa Sección Guardia Lic. Belmonte,Liliana Jefa Sección Docencia Lic Aguirre Estela M. Enero/2017	Sub-comité de Seguridad Dra. Berrondo Claudia CODEI Subsecretaria académica Dra. Christian Elias Costa Febrero/2017	Dirección Medica Dra. Galopo, Cristina Sub-Gerencia De Enfermería Lic.CarrascoCandia, Aidee SubJefa de Departamento de Enfermería Lic. Saavedra Quisbert Edith, Marzo/2017

Protocolo de caídas
Definición
Caída:
Desaceleración vertical Brusca, repentina no intencional del cuerpo hacia el suelo u otra superficie, excluyendo caídas resultantes de golpes violentos o acciones deliberadas.

Caídas con consecuencias:
Son aquellas en las que se constata una lesión o trauma grave, moderado o leve con secuelas físicas o psicológicas. Consideradas como un Evento Adverso

Objetivo
Protocolizar medidas de Prevención de caídas
Estandarizar medidas de prevención y reacción frente a estos eventos

Alcance
Enfermería
Médicos
Kinesiólogos
Camilleros
Mucamas
Personal de limpieza
Cuidadores

Cuando Aplicarlo
Este protocolo se debe aplicar desde el ingreso del paciente a la institución, ya sea como ambulatorio o internado, hasta su egreso

Instancias
- Evaluar pacientes con riesgo de caída
- Medidas de Prevención A aplicar
- Mecanismos a activar ante eventuales caídas de Pacientes

A. Criterio de Inclusión
Son determinados por el juicio profesional y la escala de valoración de DOWNTON
1. Menores de 6 años
2. Todo paciente que haya tenido caídas los últimos tres meses
3. Paciente que estén bajo tratamiento neurológico
4. Paciente que reciban habitualmente, ansiolíticos , Psicofármacos u otro medicamento que altere el estado de la conciencia
5. Paciente con déficit del sensorio
6. Paciente con excitación Psicomotriz
7. Paciente con dificultad para deambular

Clasificación
Bajo: 0a2 puntos, Observación y evaluación Diaria
Medio:3 a 4 puntos, Observación y Evaluación diaria. Barandas elevadas
Alto: 5 a 9 puntos, Observación y Evaluación diaria. Barandas Elevadas y contención
Nota se considera de Alto Riesgo a todo paciente con excitación Psicomotriz
Todo paciente internado en UTIP, Cardio/UTIP.Por lo que las medidas preventivas deberán estar siempre presente

Escala de Riesgo de DOWNTON

Criterio De Evaluación	Variables	Puntajes
Caídas Previas	Si	1
	No	0
Medicamentos	Sedantes	1
	Antidepresivos	1
	Anticonvulsivantes	1
Déficit del Sensorio	Ninguno	0
	Alteraciones, Visuales,, Auditivas u otras	1
Estado Mental	Normal	0
	Confuso	1
	Excitación Psicomotriz	1
Deambulación	Normal	0
	Asistida c/apoyo	1
	Reposo Absoluto, Postrado	1

Clasificación
Bajo: 0a2 puntos, Observación y evaluación Diaria
Medio: 3 a 4 puntos, Observación y Evaluación diaria. Barandas elevadas
Alto: 5 a 9 puntos, Observación y Evaluación diaria. Barandas Elevadas y contención

B- Medidas Preventivas a Aplicar

- Orientar Sobre espacio y ambiente físico de la Unidad en la que se Encuentra
- Mantener ordenada y limpia la Unidad del paciente, retirar todo aquello que pueda ocasionar una caída.
- Elevar Barandas de la cama a todos los pacientes < de 6 años y a todo los pacientes ,que presenten compromiso de Conciencia
- Colocaren altura mínima la cama con posibilidad de variar altura , excepto, en el momento de algún procedimiento
- Verificar que el freno de la cama este colocado
- Si lo hubiera ,El Llamadordeberá estar al alcance de los pacientes , ser funcional y operativo
- De ser posible, En todos los baños deberá haber llamador , un brazo de seguridad y cintas antideslizantes en el piso
- En pisos Húmedos colocar señales de prevención de riesgo de caída
- Mantener luz tenue durante la noche y los dispositivos de ayuda para deambular del paciente, a su alcance
- Instruir al paciente y a sus familiares/acompañante la necesidad de levantarse con ayuda por su familiar/acompañante y en caso de que este no se encuentre,lo ayudara el personal del equipo de salud
- Solicitar a los familiares, un acompañante responsable mayor de 18 años, para el cuidado del paciente. Recordar que ningún paciente puede permanecer solo en la Institución
- Cuando el acompañante deba ausentarse,deberá avisar al equipo de salud y pactar horarios con el profesional a cargo del paciente.
- En ausencia del acompañante, el profesional a cargo, pondrá en práctica las medidas de prevención que correspondan según la clasificación de riesgo, hasta que el acompañante se haga presente

- En Caso De Realizarse La Contención FarmacológicaYFísicaDel Paciente, Debe Ser Indicada Por El Médico Y Quedara Registrada Como Corresponde En La Hoja De Indicaciones Médicas Y En La Hoja De Registro De Enfermería
- El Medico evaluara la colocación de la faja de contenciónfísica acorde a la patología del paciente y el riesgo que presente. Las misma se encontraran en el Office limpio de Enfermería
- Registrar en la Hoja de Enfermería, razón por la cual se realizo la contención, por orden de quien, tiempo que duro la sujeción y respuesta del paciente mientras estuvo contenido.
- Evaluar por escrito el riesgo de caída, Utilizando escala Downton y aplicar algoritmo para determinar la necesidad de contención.
- la evaluación deberá repetirse cada vez que las condiciones del paciente varíen o impliquen un cambio en el nivel de riesgo.

C- Indicadores

Proceso: <u>Número de pacientes c/medidas adecuadas</u>x100

Total de Pacientes Internados

<u>Número de pacientes de riesgo(planilla DOWNTON)</u> x100

Total Pacientes Internados

Resultados: <u>Número de pacientes que sufrieron caídas</u> x100

Total Pacientes Internados

D- Grupo de Implementación

Jefa de Sección

Enfermeros Asistenciales

E-Capacitación

Se realizará charla de capacitación al personal involucrado en la prueba piloto, se informará a los pacientes y a los familiares/acompañantes sobre las normas de seguridad del paciente (Folleto con Información)

G-ChekList

Fecha: **Sector:** **Cama:**

	Si	No
Barandas Presentes y Funcionales		
Frenos de Camillas adecuados		
Luces habilitadas Funcionando		
Baños en condiciones de seguridad		
Antideslizantes en pisos		
Llamadores Presentes y Funcionando		
Acompañante Presente		

H- Mecanismos a activar Ante una Caída

1. Informar al médico a cargo de Inmediato el evento acontecido
2. Comunicar al Jefe de división de Enfermería , del Turno y del Área en caso de que no se encuentre el Jefe de Sección
3. Analizar el motivo/causa del evento con los profesionales del sector
4. Registrar en la Hoja de Enfermería El evento y Completar la segunda parte de la ficha de recolección de datos
5. Realizar examen Clínico y Neurológico, ni bien acontece el evento.
6. Estudios complementarios Rx y eventualmente si la clínica lo amerita Tomografía

Bibliografía

DocumentaciónConsultada:
Protocolo y Procedimiento, ClínicaMayor,COD CM/012 Versión: Nº 2.1 Elaboración: 2015
Manual de Procedimientos y Protocolos de Enfermería, Hospital Universitario, Reina Sofía, Córdoba,2010
Referencia
http://www.hgdz.gob.ec/por/EVALUACION%20DE%20RIESGO%20-%20ESTRETEGIAS%20DE%20PREVENCION%20DE%20CAIDAS.pdf

Colaboradores:
Dr.JorgeFiorentino
Dra. Claudia Berrondo
Lic. Liliana Belmonte
Lic. Estela, Aguirre

Planilla de recolección de Datos
Prevención de caída de Paciente
Nombre y Apellido;
Edad: **Sexo:**
Servicio: **Cama:**
Fecha: **Hora:**

Factores de Riesgo

Criterio De Evaluación	Variables	Puntajes
Caídas Previas	Si	1
	No	0
Medicamentos	Sedantes	1
	Antidepresivos	1
	Anticonvulsivantes	1
Déficit del Sensorio	Ninguno	0
	Alteraciones, Visuales,, Auditivas u otras	1
Estado Mental	Normal	0
	Confuso	1
	Excitación Psicomotriz	1
Deambulacion	Normal	0
	Asistida c/apoyo	1
	Reposo Absoluto, Postrado	1

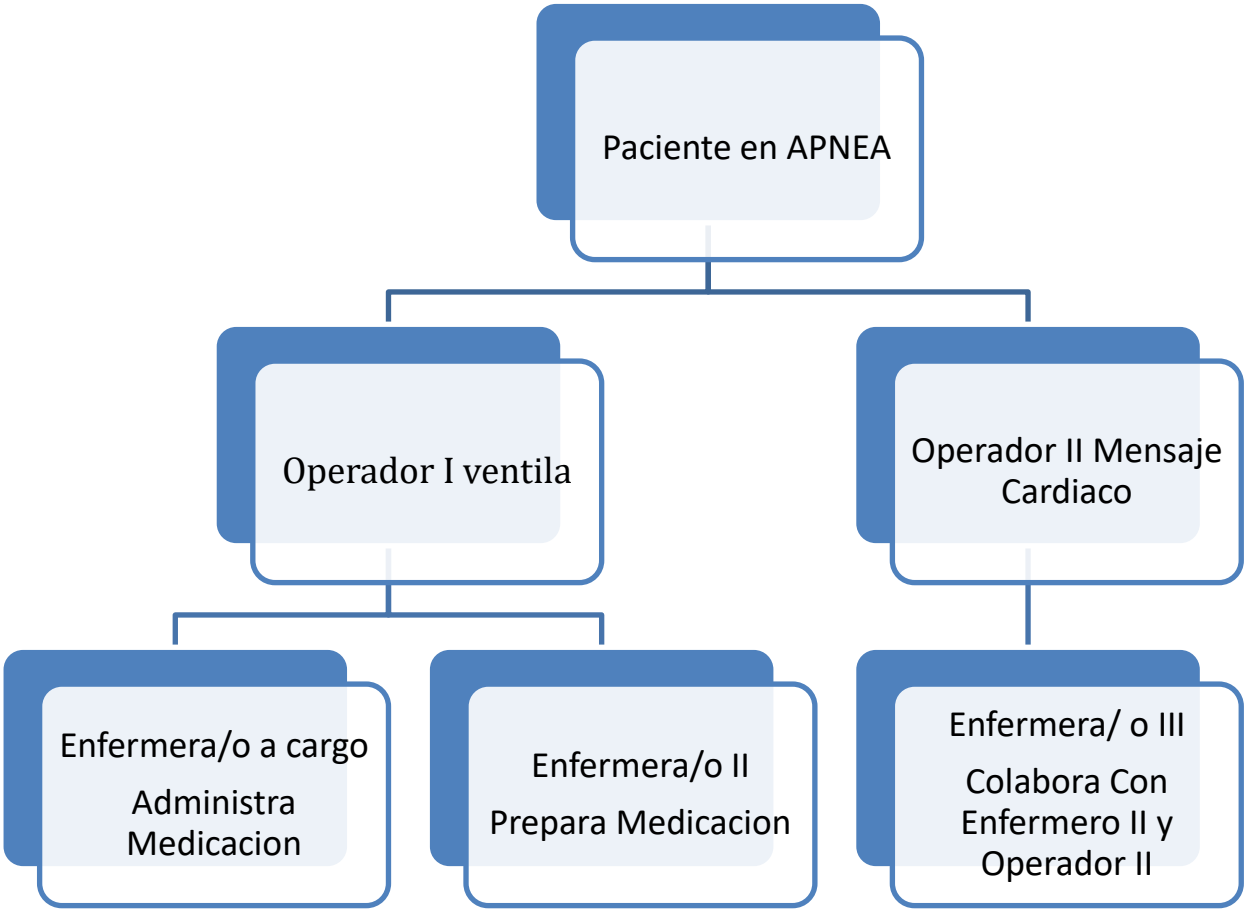
Nota: Tildar lo que corresponda en la columna de Puntaje
Clasificación **Acciones a tomar**
Bajo: 0a2 puntos, Observación y evaluación Diaria
Medio: 3 a 4 puntos, Observación y Evaluación diaria.Barandas elevadas
Alto: 5 a 9 puntos, Observación y Evaluación diaria.Barandas Elevadas y contención Física o
Farmacológica
Nota: Paciente con excitación psicomotriz, se considera directamente de Alto Riesgo

Planilla II
Lugar Donde Ocurrió el evento
Barandas Colocadas SI ( ) NO ( ) PORQUE?
Medidas de sujeciónSI( ) NO ( ) PORQUE?
Acompañado por familiares SI ( ) NO ( ) PORQUE?
Se Aviso al medico de Guardia SI ( ) NO ( ) PORQUE?

Descripción del Evento:----------

Firma y Sello del Profesional A Cargo

RCP



Recuerde que , los otros pacientes deber continuar siendo atendido, por lo que el personal afectado a la Urgencia se hara acorde al numero del personal presente .

Ministerio De Salud
Hospital Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires
General De Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez"

Medicación	Cant.	Vto.Próx.	Vto.Alejado	Reposición	Material Descartable	Cant.	Vto.Próx.	Vto.Alejado	Reposición
Adenosina (2 amp.)					Agujas (18G, 21G, 25G)				
Adrenalina (8 amp)					Antiparras				
Lidocaina al 1% s/epi(3 amp)					Antisépticos				
Atropina (3 amp,)					Apósitos Transparente				
Agua destilada (10amp.)					Apósitos Coloidal				
Bicarbonato 1 MOL-					Barbijos				
Diazepan(2 amp)					Catéter AVP(18,20,22,24)				
Dopamina (5 amp)					Cinta Hipoalergenica				
Cloruro de K 3M(4amp)					Cinta Hilera				
Gluconato de Calcio(2 amp.)					Electrodos				
Cloruro de Sodio(10 amp.)					Gasas				
Sulfato de magnesio 25%(2 amp)					Guantes Estériles				
Fentanilo (5 amp.)					Jeringas (1, 3, 5, 10, 20 ml.)				
Flumiazenil (2 amp.)					Manoplas				
Ketamina (1 amp)					Mascaras Laríngeas				
Midazolan (3 amp)					Laringoscopio(Ramas Curva y Recta)				
Lorazepan(4 amp) heladera					Bolsa de resucitación(Ambu)				
Fenitoina (15 amp)					Pilas				
Naloxona(2 amp)					Pinza De Maguil				
Nitropusiato(2 amp)					Set De Catéter Arterial				
Vecuronio(2 amp)					Set Cateter Venoso Central				
Sol.GlucosadoHipertón. 25%(2 amp)					Sondas de Aspiración				
Sol.Dx 10% (1 baxter)					Sondas de Aspiración				
Sol.Manitol(1 baxter)					Circuito Cerrado de Aspir.				
Sol.Ringer(1 baxter)					Tubo De Mayo				

Sala:……..Fecha:…….Apellido y Nombre Encargado:……

Firmay Sello
Firma y Sello
Personal Enfermería
Personal de Farmacia

Ministerio De Salud
Hospital Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires
General De Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez"
Departamento De Enfermería

Planilla de control de apertura

Sala:…… Fecha:…… Apellido y Nombre Jefe de Sección:……

Fecha	Nº Precinto	Motivo de la apertura				Turno	Laringoscopio			Observaciones
		RCP	Control	Reposición	Otros		Funciona	No funciona	Recambio de pilas	

Firmay Sello
Firma y Sello
Personal Enfermería
Personal de Farmacia

Realizado por:	**Revision Realizada por:**	**Autorizado por**
Jefes De División Jefes De Sección Enfermeros/Asistenciales. HNRG-GCBA-CABA	CODEI **Subsecretaria académica** Dra. Christian Elias Costa	Dirección Medica Dra. Galoppo, Cristina
	Jefe Seccion Docencia E Investigacion Lic.Prof. Aguirre, Estela M.	**Sub-Gerencia De Enfermería** Lic.CarrascoCandia, Aydee
		Sub-Jefe de Departamento de Enfermería Lic. Saavedra Quisbert, Edith.
Mayo/2017 Actualizacion : Noviembre /2020	Julio-Agosto/2017 Actualizacion : Noviembre /2020	Agosto/2017 Actualizacion : Noviembre /2020